



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN BULAN APRIL
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG
2026**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

DAFTAR ISI	
Daftar Isi	i
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	1
Bab II Gambaran Umum Rumah Sakit Prima Husada Malang	2
2.1 Visi	2
2.2 Misi	2
2.3 Motto	2
2.4 7 Nilai Budi Utama	2
2.5 Struktur Organisasi	3
Bab III Laporan Kinerja Pelayanan	4
3.1 Kinerja RS Prima Husada (TT, BOR, ALOS, BTO, TOI)	4
3.1.1 Tabel Capaian BOR,LOS,TOI,BTO	4
3.1.2 Grafik Capaian BOR,LOS,TOI,BTO	4
3.1.3 Analisa dan Tindak Lanjut	4
3.1.4 Terkait BPJS Kesehatan	5
3.2 Pengembangan Pelayanan RS Prima Husada	6
3.3 Kinerja Bidang Pelayanan	13
3.3.1 Rawat Jalan Poliklinik	13
3.3.2 Rawat Inap	17
3.3.3 Intensive Care Unit (ICU)	26
3.3.4 High Care Unit (HCU)	27
3.3.5 Instalasi Gawat Darurat (IGD)	28
3.3.6 Instalasi Kamar Operasi (IKO)	29
3.4 Kinerja Bidang Penunjang	30
3.4.1 Instalasi Farmasi	30
3.4.2 Laboratorium	43
3.4.3 Rekam Medis - Pendaftaran	47
3.4.4 Radiologi	54
3.4.5 Gizi	60
3.4.6 CSSD - Laundry	66
3.5 Kinerja Bidang Umum	69
3.5.1 SDM	69
3.5.2 IPSRS	78
3.5.3 Security	87
3.5.4 Parkir	90
3.5.5 Humas Marketing	90
3.5.6 Penjaminan	112
3.5.7 PIPP – MOD – MPP	113
3.5.8 <i>Cleaning Service</i>	122
3.5.9 Pengadaan dan Gudang Umum	123
3.5.10 IT - SIMRS	124
3.5.11 Driver	135
3.5.12 PRIMANTARA	136
3.6 Komite dan Tim	137
3.6.1 Komite Mutu	137
3.6.2 Komite PPI	172
3.6.3 Tim PKRS	191
3.6.4 Tim Prognas	192
3.6.5 Tim PPRA	233
3.6.6 Tim Review RM (E-RM)-IT	240
3.7 Permasalahan Rumah Sakit	242
3.8 Profil SDM	245
Bab IV Kesimpulan dan Saran	249
Bab V Penutup	250

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan rumah sakit dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja rumah sakit dalam hal ini Rumah Sakit Prima Husada Malang adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban Rumah Sakit Prima Husada Malang untuk mempertanggungjawabkan kinerja, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi misi Rumah Sakit Prima Husada Malang dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja juga sebagai alat ukur keberhasilan Rumah Sakit dalam mencapai tujuan dan/atau sasaran atau kegiatan utama yang dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja dimasa datang, kuncinya adalah penekanan pada tujuan dan sasaran atau program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan.

Rumah Sakit Prima Husada Malang adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan dibidang kesehatan berkelanjutan secara paripurna dengan mengutamakan pengobatan dan pemulihan tanpa mengabaikan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui penyediaan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, penunjang dan tindakan medik.

1.2 TUJUAN

Tujuan penyusunan Laporan Bulan April Tahun 2026 adalah untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan pelayanan antar unit untuk meningkatkan kinerja rumah sakit

BAB II

GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG

2.1 VISI

Menjadi Rumah Sakit berkualitas prima pilhan seluruh lapisan masyarakat

2.2 MISI

1. Memberikan Pelayanan Kesehatan dengan Aman, Tepat, Cepat dan Akurat
2. Mengutamakan Kepuasan dan Keselamatan Pasien
3. Meningkatkan Mutu Pelayanan yang Berkelanjutan

2.3 MOTTO

Sahabat Menuju Sehat

2.4 7 NILAI BUDI UTAMA

1. Jujur Dipercaya
2. Tanggung Jawab
3. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adil
7. Peduli

2.5 STRUKTUR ORGANISASI

Susunan struktur Organisasi Rumah Sakit Prima Husada Malang sebagai berikut :



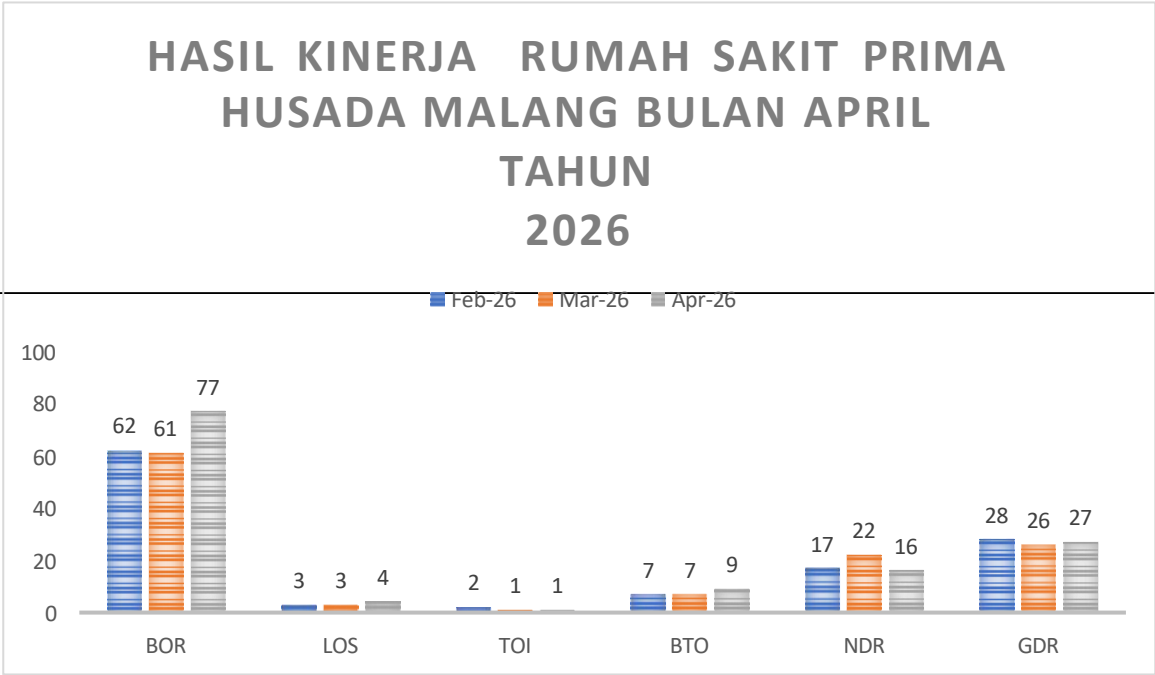
BAB III
LAPORAN KINERJA PELAYANAN

3.1 Kinerja RS Prima Husada (TT, BOR, ALOS, BTO, TOI)

Tabel Capaian BOR, LOS, TOI, BTO

INDIKATOR	Feb 2026	Maret 2026	April 2026
BOR	62	61	77
LOS	3 hari	3 hari	4 hari
TOI	2 hari	1 hari	1 hari
BTO	7 kali	7 hari	9 hari

Grafik Capaian BOR, LOS, TOI, BTO

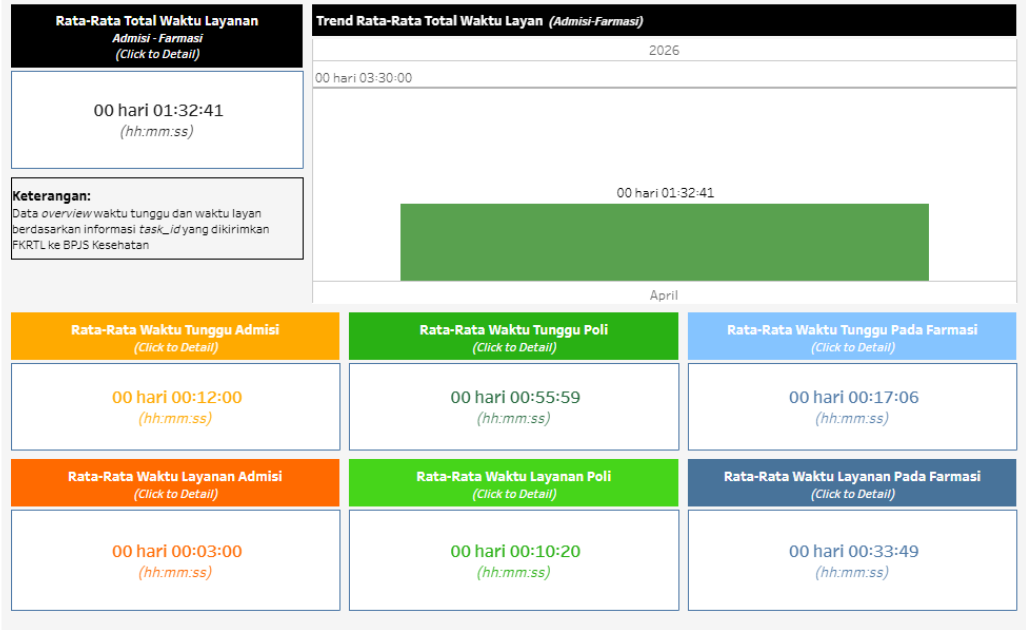


3.1.1 Tabel Analisa, Masalah dan Tindak Lanjut

INDIKATOR	ANALISA	MASALAH	RTL (RENCANA TINDAK LANJUT)
BOR Total 77%	Pemanfaatan TT baik, masih dalam standar ideal 60–85%	Beberapa ruangan overload, beberapa ruangan rendah okupansi	Redistribusi pasien antar unit, evaluasi kelas/peruntukan kamar
ALOS Total 4 hari	Lama rawat relatif singkat	Kemungkinan dominan kasus ringan / pulang cepat / one day care	Evaluasi case mix dan clinical pathway
TOI Total 1 hari	Pergantian TT sangat cepat, efisien	Turnover tinggi dapat membebani cleaning & admisi	Perkuat koordinasi discharge planning dan housekeeping
BTO Total 9/bln	Frekuensi pemakaian TT tinggi	Beban kerja perawat tinggi pada unit sibuk	Penyesuaian SDM dan monitoring mutu pelayanan
NDR 16‰	Mortalitas setelah >48 jam masih perlu perhatian	Kasus berat / keterlambatan penanganan / komplikasi	Audit kematian, review manajemen kasus
GDR 27‰	Mortalitas umum masih di atas target ideal	Banyak pasien datang kondisi berat	Tingkatkan early warning system & rujukan cepat

3A BOR 32%	Utilisasi tempat tidur rendah	Bed tidak optimal terpakai	Evaluasi fungsi ruangan, promosi layanan, regrouping bed
NICU BOR 20%	Pemanfaatan sangat rendah	Kasus bayi rawat intensif sedikit / rujukan rendah	Bangun jejaring rujukan maternal-neonatal
ICU BOR 39% + GDR tinggi	Occupancy rendah namun kematian sangat tinggi	Pasien masuk kondisi kritis berat	Audit ICU, triase, respon cepat, evaluasi ventilator/sepsis bundle
6A & 8A BOR 87%	Hunian sangat tinggi	Risiko penuh, waiting list, infeksi nosokomial	Tambah TT / buka buffer room / percepat discharge planning
4A BOR 78%	Baik dan stabil	Perlu monitoring bila tren naik	Pertahankan mutu layanan
MTS BTO 11	Turnover sangat tinggi	Pasien singkat/rawat cepat	Pastikan administrasi & cleaning cepat
TOI beberapa unit = 0	Bed langsung terisi kembali	Tidak ada waktu persiapan bed	Perkuat bed management system
Data indikator	Ada potensi salah hitung di beberapa unit	TOI negatif / ALOS tidak sinkron	Validasi rumus Excel dan sumber sensus harian

3.1 Terkait BPJS Kesehatan



NO	KETERANGAN		BULAN (2026)						
			Rata - rata Tahun 2025	1	2	3	4	5	6
1	Total Waktu Layanan	2:12:37	01:46:32	1:46:40	1:41:56	1:43:59	1:32:41		
2	Waktu Tunggu Admisi	0:11:52	0:08:14	0:12:00	00:12:00	0:12:00	0:12:00		
3	Waktu Layanan Admisi	0:07:49	0:06:01	0:03:00	0:03:00	0:03:00	0:03:00		

4	Waktu Tunggu Poli	1:03:51	0:58:16	00:56:31	00:53:52	00:50:51	00:55:59		
5	Waktu Layanan Poli	0:14:56	0:09:55	0:10:13	0:10:01	0:09:30	0:10:20		
6	Waktu Tunggu Farmasi	0:14:47	0:09:02	0:09:57	0:14:48	0:16:30	0:17:06		
7	Waktu Layanan Farmasi	0:54:42	0:36:47	0:32:48	0:36:36	0:31:05	0:33:49		

Analisis :
 Pada bulan ini masih Lebih rendah dari rata-rata tahun 2024 dan tahun 2025. Namun ada peningkatan pada waktu tunggu farmasi yang disebabkan data waktu pelayanan resep error. Konfirmasi dari programmer.

Plan	Menyampaikan hasil evaluasi ke programmer PT Disa Prima Medika
Do	Koordinasi dengan unit terkait dan factor yang mempengaruhi.hasil dari identifikasi programmer
Study	Data rekap bulan sebelumnya yang menjadi acuan dalam perbandingan perbaikan.
Action	1. Menghubungi programmer 2. Monitoring evaluasi 3. Lakukan Tindak lanjut sesuai hasil Monev

3.2 Pengembangan Pelayanan RS Prima Husada

3.2.3 Bidang Pelayanan dan Keperawatan

NO	UNIT	PENGEMBANGAN PELAYANAN	PROGRESS PENGEMBANGAN	KENDALA
BIDANG PELAYANAN DAN KEPERAWATAN				
1	IRJA	Poli Harmoni	1. Bulan April 2026 ada 1 pasien untuk poli harmoni. 2. Pengembangan stifin tidak hanya untuk individu saja, targetnya adalah keluarga, pasangan, corporate dan tim 3. Mempromosikan kembali stifin di poli harmoni dengan update flyer : Rp. 750.000 free cek Golda, free konsultasi gizi,free konseling terapi wicara	1. Kunjungan pasien masih sedikit 2. Dengan standart harga yang cukup tinggi, dibutuhkan untuk marketing lebih konsisten dan mengenalkan ke masyarakat luas tidak hanya lewat sosmed melainkan grup komunitas atau organisasi.
2	IRJA-Poli MCU	Penerimaan MCU corporate	1. Humas menghubungi Perusahaan untuk penawaran MCU 2. Surat penawaran untuk Perusahaan sudah di acc PT dengan tarif margin	1. MCU Perusahaan BSI masih belum bisa terlaksana karena ada kendala IKS dengan Mandiri Inhealth.

			yang paling rendah	2. BSI menggunakan Mandiri inhealth untuk general check up 38 karyawannya 3. Karena di malang hanya ada 3 RS yang di tetapkan untuk MIH, sehingga PHM belum bisa menerima MCU tsb tahun ini, bisa pengajuan untuk tahun depan 4. Koordinasi dan follow up kembali terkait pengajuan RSPHM sebagai RS penerima layanan MCU Perusahaan
4	IRJA-IRNA	Meningkatkan kewaspadaan pelaporan kasus PD31	1. Karena wabah KLB campak di berbagai daerah, dinkes menghimbau RS untuk waspada terhadap peningkatan kasus campak 2. Pelaporan dan pengambilan sampel harus real time dan dilaporkan ke puskesmas agar dipantau dan di petakan daerah yang positif terpapar 3. Meningkatkan komunikasi dengan puskesmas baik di grup maupun tata laksana pelaporan kasus	1. Kasus pelaporan yang sulit ada di rawat jalan, karena pasien sudah KRS dan kesulitan dalam pengambilan sampel 2. Koordinasi dengan PKM agar diteruskan ke Perawat desa untuk ditindaklanjuti
5	IKO	Pelayanan SMF orthopedi -- tindakan TKR	1. Identifikasi tarif dan BMHP kasus TKR dari segi klaim inacbg's 2. Koordinasi dengan pak pugu dan keuangan PT untuk menentukan tarif proporsi apabila tindakan tersebut dikerjakan	1. Untuk saat ini masih belum ada kendala pelayanan 2. Monitoring terkait penginputan dan pengklaiman karena bulan ini baru mengerjakan TKR pasien BPJS

			3. Sudah ada 2 pasien yang dikerjakan oleh dr Oka, SpOT untuk kasus TKR , yang sebelumnya harus dirujuk	Kesehatan
--	--	--	---	-----------

3.2.2 Bidang Penunjang

NO	UNIT	PENGEMBANGAN PELAYANAN	PROGRESS PENGEMBANGAN	KENDALA
INSTALASI FARMASI RUMAH SAKIT				
1.	Depo Farmasi	1. KPO Elektronik (E-KPO)	a. Fitur cetak KPO sudah terlaksana pada tanggal 17 Desember 2025. b. Belum tersedia cover untuk arsip KPO pasien. c. Jumlah KPO tertinggal : 116.	Cover KPO tidak acc oleh managemen. Rencana menggunakan scan barcode untuk melihat data e-kpo.
		2. Perluasan ruang Depo Farmasi sesuai standart	a. Pengajuan perluasan ruangan di depo farmasi untuk penggantian lemari pendingin yaitu penyimpanan obat ke lemari pendingin yang lebih besar dan vaksin di letakkan dalam vaccine refirigerator disertai Log tag. b. Tersedia cctv dan smart door lock.	Koordinasi dengan kepala bidang terkait rencana lokasi penyimpanan showcase 2 pintu (785 liter) dan vaccine refirigerator.
		3. Pendaftaran pengantaran obat primantara di Farmasi	Fitur “antar obat” di SIMRS sudah tersedia dan ada laporan penjualan obat diantar. Namun kekurangannya tidak ada kolom asal poli, jam pemesanan, obat selesai, biaya, cara bayar, jarak pengiriman dan serah terima farmasi dan kurir primantara sehingga pendataan pasien menggunakan google spreadsheet primantara.	Pendataan secara manual, belum bridging dengan SIMRS. Sementara menggunakan spreadsheet.
		4. Rencana pemisahan penyiapan obat kronis dan non kronis	a. Sudah dilakukan pemisahan penyiapan obat kronis dan non kronis namun masih terkendala tenaga vokasi farmasi kurang (jika ada staf yang sakit). b. Meminimalisir waktu tunggu pasien non kronis dengan obat yang tidak banyak.	Pengajuan fitur ke progamer.

			c. Masih ada komplain pasien terkait waktu tunggu. d. Belum ada fitur pemisahan resep masuk kronis dan non kronis.	
		5. Pengambilan obat dengan TTD elektronik	a. TTD elektronik pengambilan obat rawat jalan sudah berjalan dan memudahkan untuk mengecek retriaksi kelengkapan obat kronis, namun terkendala pada jaringan yang lemah. b. TTD elektronik pengambilan obat IGD rawat jalan dan pasien rawat inap pulang masih belum bisa dan tahap koordinasi dengan progamer.	Dalam antrian progamer. Monitoring dan evaluasi sistem elektronik.
		6. Pelayanan retriaksi obat kronis: penambahan fitur Centang "Perlu Hasil Hasil Pemeriksaan Lab di Fitur Penjualan Farmasi.	Pengajuan form penambahan fitur agar DPJP input resep dan penjaminan pelayanan obat bagi peserta JKN sesuai dengan ketentuan retriaksi dan/atau peresepan maksimal obat, memudahkan Farmasi mengecek kesesuaian hasil penunjang dan obat yang diresepkan sesuai retriaksi obat kronis.	Pengajuan fitur ke progamer.
		7. Penambahan Fitur Laporan Rekap Penjualan Obat Kronis Per Nota, Laporan Resep Iter, Dan Laporan Resep PRB Di SIMRS	Pengajuan form penambahan fitur laporan di SIMRS yaitu: a. Format "Laporan Rekap Penjualan Obat Kronis Per Nota", berisi: nomor, nomor registrasi, tanggal registrasi, no. rm, nama pasien, nama dokter unit asal, no. kartu, no. sep, no. nota, tgl. Nota, nama obat, jumlah obat, hasil pemeriksaan penunjang. b. Format laporan resep iter, berisi: nomor, tanggal kunjungan, nama pasien, no. rm, no. kartu, no. SEP, unit asal, nama dokter, jumlah iter, nama obat, aturan pakai, jumlah	Pengajuan fitur ke progamer.

			obat, tanggal kunjungan berikutnya, status iter (terlayani/belum). Tujuan untuk memudahkan farmasi, verifikator, DPJP untuk melihat laporan resep iter dan target iter. c. Format laporan resep PRB, berisi : nomor, nama dokter, tanggal kunjungan, nama pasien, no. rm, no. kartu, no. SEP, alamat, no. telp, diagnosa PRB, asal FKTP perujuk, asal SRB (FKRTL/RS), nama obat, aturan pakai, jumlah obat. Tujuan untuk memudahkan farmasi, verifikator, DPJP untuk melihat laporan resep PRB dan target PRB.	
		8. Rekam medis beralih ke E-RM	Fitur E-RM yang sudah tersedia di SIMRS : - Rekonsiliasi obat - Daftar pemberian obat - Catatan Riwayat Penggunaan Obat - Daftar Tilik Serah Terima Obat Farmasi - Rawat Inap - Fitur E-RM yang belum tersedia di SIMRS : - Pemantauan Terapi Obat Fitur E-RM yang belum tersedia: - Pemantauan Terapi Obat	Fitur E-RM yang belum tersedia di SIMRS : Pemantauan Terapi Obat. Dalam antrian progamer.
		9. ERM :Pemberian edukasi penggunaan obat pulang (Pasien rawat inap)	Penambahan fitur Pemberian Edukasi Penggunaan Obat Pulang. Data “Resep Final” langsung muncul sesuai obat yang ada di “Ringkasan Pulang” bagian “Obat Pulang” sehingga farmasi bisa langsung ttd serah terima obat di depo farmasi.	Pengajuan fitur ke progamer.
		10. Pemberian informasi tentang obat	Pemberian informasi tentang obat yang akan diberikan kepada pasien	Pengajuan fitur ke progamer.

		yang akan diberikan kepada pasien rawat jalan	rawat jalan sudah tersedia di resep namun belum ada keterangan di kolom penerima obat "Pasien telah menerima KIE serta instruksi obat oleh petugas farmasi". Mengajukan fitur di SIMRS agar langsung tercetak di kolom penerima obat	
		11. Penambahan fitur potensi PRB	Belum tersedia fitur identifikasi obat-obatan rutin dinotifikasi dalam SIMRS farmasi untuk dijadikan data potensi PRB dan disampaikan ke DPJP.	Pengajuan fitur ke progamer.
		12. Penambahan fitur validasi resep di poli untuk obat yang ditinggal dan ditunggu	a. Belum tersedia fitur validasi resep di poli untuk obat yang ditinggal dan ditunggu b. Meminimalisir waktu tunggu pasien yang menunggu di farmasi dan mengurangi complain pasien.	Pengajuan fitur ke progamer.
		13. Penambahan fitur obat near ed muncul di SIMRS saat dokter input resep	Belum tersedia fitur obat near ed muncul di SIMRS saat dokter input resep, agar DPJP mengetahui obat yang akan habis kurang dari 6 bulan	Pengajuan fitur ke progamer.
		14. Penambahan fitur kelas terapi/ golongan obat saat input resep	Belum tersedia fitur kelas terapi/ golongan obat saat input resep untuk memudahkan DPJP jika terjadi kekosongan obat bisa langsung substitusi obat yang lain sesuai kelas terapi tanpa perlu konfirmasi ke farmasi.	Pengajuan fitur ke progamer.
		15. Penambahan fitur warning di SIMRS saat DPJP input resep yang sama	1. Tersedia fitur warning di SIMRS saat DPJP input resep yang sama. 2. Memudahkan DPJP saat input resep agar tidak terjadi input resep yang sama dan mempercepat farmasi proses resep.	Pengajuan fitur ke progamer.
2.	Gudang Farmasi	1. Pengembangan fitur scan barcode gudang farmasi dan depo farmasi untuk pemasukan dan pengeluaran stok.	a. Proposal scan barcode sudah diajukan ke PT pada tanggal 01/10/2024. b. Sudah dilakukan presentasi pada tanggal 04/10/2024. c. Alat scanner barcode, barcode printer, thermal paper sudah	Monitoring dan evaluasi system elektronik

			tersedia pada tanggal 16/11/2024. d. Scan barcode di SIMRS sudah di trial. Hasil evaluasi : - Tidak hemat waktu. - Proses tidak efisien - Error karna master barcode belum ada sehingga butuh waktu untuk menambah master. - Jika barcode belum terdaftar tidak bisa search memakai nama, harus discroll jadi membutuhkan waktu untuk menambahkan master. - Jumlah yang sudah diinput menggunakan scan barcode tidak muncul di bagian tabel keluar, harus di klik nama barang baru muncul jumlah keluar, sehingga susah untuk monitoring barang yang belum disiapkan. - Tidak terbukti efisien tenaga dan jam kerja	
		2. Perluasan Gudang Farmasi	a. Pengajuan katrol untuk penurunan buffer dari lantai 2.	Follow up pengadaan katrol.
Instalasi Rekam Medis				
1.	Rekam Medis	1. Aplikasi ERM IRJA	1. Poli Gizi dan Poli KIA belum menjalankan ERM 2. Kendala teknis sistem 3. Keterbatasan SDM dan adaptasi pengguna	Sebagian besar poli telah menggunakan ERM, namun Poli Gizi dan Poli KIA belum menjalankan ERM
		2. Pengiriman data kunjungan dan diagnosis pasien rawat jalan (ERM maupun non-ERM) ke SATU SEHAT	Pengiriman data ke satu sehat (untuk data kunjungan dan diagnosis) dilakukan setiap hari. Temuan dan TL : a. ERM yang belum lengkap dan valid. TL : Koordinasi dengan Tim Pendaftaran terkait identitas pasien yang tidak lengkap.	Monitoring dan Evaluasi.

			b. Bayi baru lahir yang belum mempunyai NIK. TL : Kie ke keluarga pasien agar segera pengurusan KK. c. Pasien yang tidak membawa identitas dengan lengkap. TL : KIE ke keluarga pasien untuk mengirimkan identitas melalui chat WA.	
		1. APM (Pendaftaran pasien BPJS yang sudah reservasi melalui mobile JKN)	Pasien BPJS yang sudah reservasi Mobile JKN tidak dapat diproses di APM masih harus diarahkan ke loket. TL: Memaksimalkan petugas menjaga APM dan memberikan arahan pada pasien.	Sebagian pasien BPJS sudah menggunakan APM, namun masih terdapat kegagalan proses pendaftaran.
		2. ERM IRNA secara menyeluruh.	1. Masih terdapat form rawat inap yang belum tersedia dalam ERM. 2. Beberapa form ERM belum muncul pada proses validasi.	Masuk antrian progamer

3.3 Kinerja Bidang Pelayanan

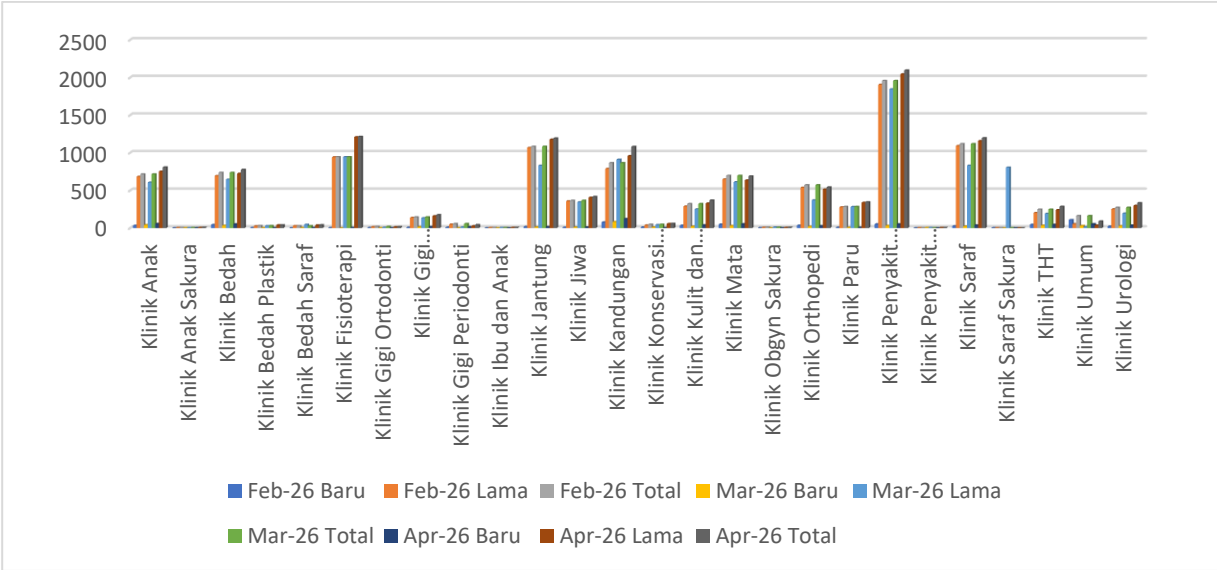
3.3.3 Rawat Jalan Poliklinik

3.3.3.1 Kunjungan Pasien Lama dan Baru

Nama Unit	Feb-26			Mar-26			Apr-26		
	Baru	Lama	Total	Baru	Lama	Total	Baru	Lama	Total
Klinik Anak	32	683	715	40	606	715	56	752	808
Klinik Anak Sakura	0	3	3	2	2	3	1	5	6
Klinik Bedah	43	693	736	32	645	736	52	723	775
Klinik Bedah Plastik	4	25	29	2	28	29	1	38	39
Klinik Bedah Saraf	0	28	28	3	45	28	3	37	40
Klinik Fisioterapi	2	941	943	0	943	943	4	1209	1213
Klinik Gigi Ortodonti	4	14	18	2	7	18	1	13	14

Klinik Gigi Pedodontis	7	137	144	14	133	144	15	159	174
Klinik Gigi Periodonti	8	48	56	1	12	56	14	27	41
Klinik Ibu dan Anak	0	3	3	0	4	3	0	5	5
Klinik Jantung	16	1067	1083	13	830	1083	15	1177	1192
Klinik Jiwa	7	357	364	12	344	364	10	405	415
Klinik Kandungan	77	788	865	82	909	865	122	958	1080
Klinik Konservasi Gigi	10	37	47	10	42	47	2	56	58
Klinik Kulit dan Kelamin	33	288	321	21	250	321	39	328	367
Klinik Mata	48	648	696	29	610	696	53	635	688
Klinik Obgyn Sakura	2	6	8	0	9	8	2	5	7
Klinik Orthopedi	34	537	571	20	369	571	28	514	542
Klinik Paru	6	277	283	6	281	283	6	338	344
Klinik Penyakit Dalam	51	1905	1956	30	1844	1956	51	2045	2096
Klinik Penyakit Dalam Sakura	0	2	2	3	4	2	0	3	3
Klinik Saraf	26	1092	1118	22	830	1118	37	1158	1195
Klinik Saraf Sakura	1	1	2	0	804	2	0	0	0
Klinik THT	45	202	247	33	190	247	45	240	285
Klinik Umum	108	54	162	29	15	162	53	36	89
Klinik Urologi	21	251	272	27	194	272	35	297	332

Grafik Pasien Lama dan Baru Bulan (Februari 2026 – April 2026)



Analisis :

- 1 Total kunjungan bulan April 2026 sebanyak 12.820 pasien dengan rata-rata ±427 pasien/hari. Menunjukkan volume pelayanan cukup tinggi.
- 2 Kunjungan didominasi BPJS Kesehatan Lama 75,67% dari total pasien.
- 3 Pasien lama mencapai 92,67%, sedangkan pasien baru hanya 7,33%.
- 4 Poli dengan kunjungan tertinggi adalah Penyakit Dalam (16,35%).
- 5 Poli Fisioterapi (9,46%), Saraf (9,32%), Jantung (9,30%) juga tinggi.
- 6 IGD 1.007 pasien (7,86%) menunjukkan utilisasi gawat darurat tinggi.
- 7 Klinik Kandungan 1.080 pasien (8,42%) menunjukkan layanan ibu dan anak cukup diminati.
- 8 Poli bedah dan mata cukup tinggi (Bedah 775, Mata 688).
- 9 Poli dengan kunjungan sangat rendah: Saraf Sakura (0), Gigi Umum (1), Harmoni (1), Gizi (3).
- 10 Poli Sakura masih rendah: Anak Sakura (6), Obygn Sakura (7), Penyakit Dalam Sakura (3).
- 11 Kunjungan pasien umum (baru+lama) sebanyak 2.290 pasien (17,86%).
- 12 Asuransi swasta, perusahaan, TASPEN masih sangat kecil (<2%).
- 13 Banyak poli didominasi pasien lama kontrol berulang.
- 14 Sebaran kunjungan tidak merata antar poli.
- 15 Secara umum rumah sakit memiliki loyalitas pasien tinggi karena dominasi pasien lama.

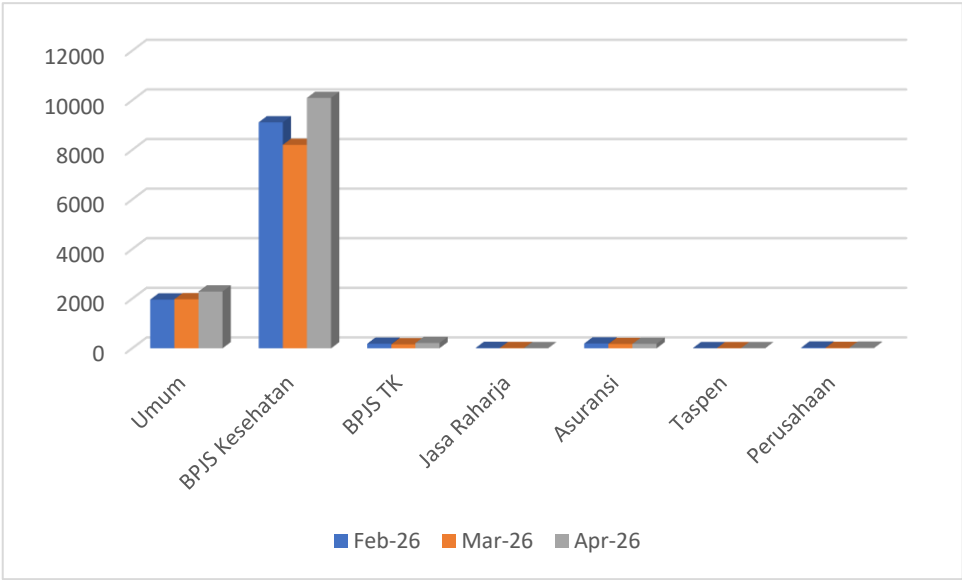
Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Koordinasi dengan pendaftaran penjangkaran pasien umum dan asuransi untuk memperkenalkan pelayanan poli Sakura
- 2. Menginformasikan kepada seluruh unit rawat inap wajib edukasi saat krs untuk pasien umum, asuransi tentang pelayanan poli Sakura
- 3. Memisahkan pasien BPJS dengan pasien non BPJS. Pasien Non BPJS di daftarkan di poli Sakura.
- 4. Koordinasi dengan Humas dan Marketing untuk penjangkaran asuransi dan perusahaan.
- 5. Sosialisasi pada faskes dengan pelayanan baru yang ada di rumah sakit prima husada
- 6. Koordinasi dengan humas marketing untuk rutin menampilkan promo di media sosial
- 7. Koordinasi dengan pendaftaran untuk sellau menanyakan pasien yang mendaftar apakah memiliki asuransi komersil.

1.3.1.2 Kunjungan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Status Pembayaran

No	Jenis Pembayaran	Feb-26	%	Mar-26	%	Apr-26	%
1	Umum	1966	17%	1978	19%	2290	17,86%
2	BPJS Kesehatan	9112	79%	8204	78%	10099	78,78%
3	BPJS TK	185	2%	161	2%	213	1,66%
4	Jasa Raharja	15	0%	11	0%	7	0,05%
5	Asuransi	194	2%	175	2%	178	1,39%
6	Taspen	5	0%	5	0%	6	0,05%
7	Perusahaan	29	0%	17	0%	27	0,21%
TOTAL		11506	100%	10551	100%	12820	100%

1.3.1.2.1 Grafik Kunjungan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Status Pembayaran



Analisis :

- 1 Total kunjungan pasien poli mengalami peningkatan berturut-turut: Februari 11.506, Maret 10.551, April 12.820. April naik 21,5% dibanding Maret.
- 2 Kunjungan bulan Maret sempat menurun dibanding Februari (-8,3%), kemudian meningkat signifikan di April.
- 3 Pasien BPJS Kesehatan mendominasi seluruh kunjungan: Feb 9.112, Mar 8.204, Apr 10.099. Kontribusi April sekitar 78,8% dari total pasien.
- 4 Pasien Umum meningkat konsisten: Feb 1.966, Mar 1.978, Apr 2.290. Naik 15,8% dari Maret ke April.
- 5 Pasien BPJS TK meningkat pada April menjadi 213 pasien dari Maret 161 pasien.
- 6 Jasa Raharja menurun terus: Feb 15, Mar 11, Apr 7 pasien.
- 7 Asuransi Swasta relatif stabil: Feb 194, Mar 175, Apr 178 pasien.
- 8 TASPEN stagnan rendah: 5, 5, 6 pasien.
- 9 Perusahaan menurun dari 29 (Feb) menjadi 17 (Mar), naik ke 27 (Apr) namun belum kembali seperti Februari.
- 10 Semua segmen pasien meningkat pada April, terutama BPJS dan Umum.
- 11 Struktur pasar rumah sakit masih didominasi pembayar pemerintah/jaminan sosial.
- 12 Tren April menunjukkan momentum pertumbuhan positif.

Rencana Tindak Lanjut :

Untuk meningkatkan kunjungan pasien rawat jalan adalah dengan meningkatkan pelayanan terbaik serta berkoordinasi dengan marketing untuk melakukan kunjungan dan menawarkan beberapa pelayanan baru seperti poli sakura yang bisa bekerjasama dengan berbagai asuransi, poli bedah saraf dan poli gigi anak. bekerjasama dengan humas marketing terutama MCU haji dan vaksin internasional (meningitis, polio dan influenza)

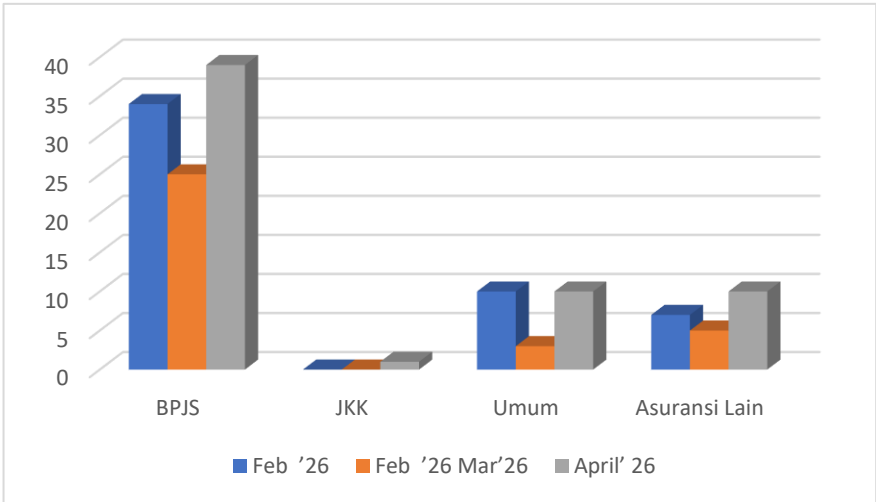
3.1.3 Rawat Inap

3.1.3.1 Kunjungan Rawat Inap 2C

3.1.1.1.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Februari - April 2026)

NO	Hal	Feb . '26	Mar'26	April' 26	Persentaser terhadap bulan sebelumnya
1	BPJS	34	25	39	56%
2	JKK	0	0	1	100%
3	Umum	10	3	10	233,33%
4	Asuransi Lain	7	5	10	100%
Total Pasien		51	33	60	81,81%

3.1.1.1.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Februari - April 2026)



1.3.2.1.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

No.	Bulan	RAWAT INAP				Total Pasien
		BPJS	Umum	JKK	JR/Asuransi	
1	Feb. 2026	34	10	0	7	51
	Analisa	Bulan Februari pasien BPJS mengalami penurunan lagi dari 36 menjadi 34	Bulan Februari pasien Umum turun dari 12 menjadi 10	Pasien JKK bulan Februari kosong. Karena tidak ada pasien JKK yg naik kelas	Untuk pasien asuransi di bulan Februari mengalami penurunan juga karena pasien banyak yg	Total bulan Februari jumlah pasien mengalami penurunan dari 57 menjadi 51

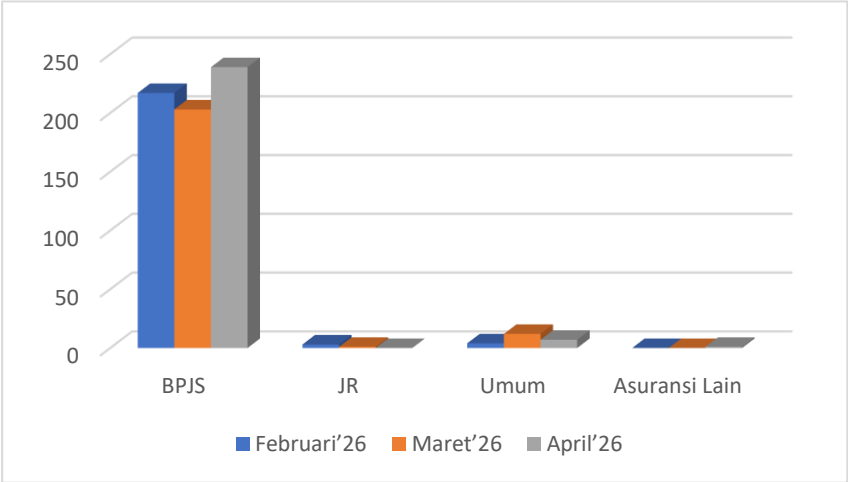
					memakai BPJS dan COB	
	RTL	Mempertahankan dan meningkatkan capaian dengan memperbaiki alur proses naik kelas ke VIP/VVIP yg dilakukan di awal pendaftaran, memperbaiki sarana prasarana VIP/VVIP dengan memberikan fasilitas tambahan seperti baju pasien khusus VIP/VVIP dan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai kelanjutan perawatan pasca rawat inap				
2	Mar. 2026	25	3	0	5	33
	Analisa	Bulan Maret pasien BPJS mengalami penurunan drastis dari 34 menjadi 25	Bulan Maret pasien Umum turun drastic dari 10 menjadi 3	Pasien JKK bulan Maret kosong	Untuk pasien asuransi di bulan Maret mengalami penurunan juga karena pasien banyak yg memakai BPJS dan COB	Total bulan Maret jumlah pasien mengalami penurunan drastic dari 51 menjadi 33
	RTL	Meningkatkan capaian dengan memperbaiki alur proses naik kelas ke VIP/VVIP yg dilakukan di awal pendaftaran, memperbaiki sarana prasarana VIP/VVIP dengan memberikan fasilitas tambahan seperti baju pasien khusus VIP/VVIP dan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai kelanjutan perawatan pasca rawat inap				
3	APRIL 2026	39	10	1	10	60
	Analisa	Bulan APRIL pasien BPJS mengalami kenaikan agak banyak dari 25 menjadi 39	Bulan April pasien umum mengalami kenaikan drastic dari 3 menjadi 10	Pasien JKK bulan April ada 1 dikarenakan px JKK naik kelas ke VIP	Untuk pasien asuransi di bulan APRIL mengalami kenaikan dari 5 menjadi 10	Total bulan APRIL jumlah pasien mengalami kenaikan drastis dari 33 menjadi 60
	RTL	Mempertahankan dan meningkatkan capaian dengan memperbaiki alur proses naik kelas ke VIP/VVIP yg dilakukan di awal pendaftaran, memperbaiki sarana prasarana VIP/VVIP dengan memberikan fasilitas tambahan seperti baju pasien khusus VIP/VVIP dan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai kelanjutan perawatan pasca rawat inap				

3.1.1.1 Kunjungan Rawat Inap 3C Anak

3.1.1.1.3 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar Bayar
(Februari - April 2026)

NO	Hal	Februari'26	Maret'26	April'26	Prosentase terhadap bulan sebelumnya
1	BPJS	217	203	239	↑15%
2	JR	3	1	0	↓100%
3	Umum	4	12	7	↓71%
4	Asuransi Lain	0	0	1	↑100%
Total Pasien		225	216	247	↑13%

Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Februari – April 2026)



3.3.2.2.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

No	Bulan	RAWAT INAP				Kesimpulan
		BPJS	Umum	JR	Asuransi	
	Analisis capaian 3 bulan terakhir	Pasien BPJS mengalami peningkatan di bulan februari dan mengalami penurunan sebesar 7% di bulan maret, serta meningkat lagi sebebsar 15% di bulan april	Pasien umum mengalami peningkatan sebesar 66% pada Maret dan mengalami penurunan sejumlah 71% di bulan April, dikarenakan semua orang mempunyai BPJS	Pasien JR mengalami penurunan 200% pada bulan maret dan mengalami penurunan lagi di bulan April sebanyak 100%	Pasien Asuransi sama dengan bulan sebelumnya dan mengalami penurunan 100% di bulan April karena hanya beberapa orang saja yang mempunyai jaminan asuransi	Jumlah pasien di aBPJS di bulan Februari mengalami peningkatan sebanyak 6% dan mengalami penurunan di bulan maret sebesar 7% dan penurunan 200% pada pasien umum pada bulan februari dan mengalami peningkatan 66% di bulan maret dan kenaikan 66% pasien JR pada bulan februari serta mengalami penurunan sebesar 200% di bulan maret Dan pada bulan April pasien BPJS mengalami peningkatan sebebsar 15% serta jumlah keseluruhan mengalami peningkatan
	RTL	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya Mempromosikan RS prima Husada Melalui media Sosial				

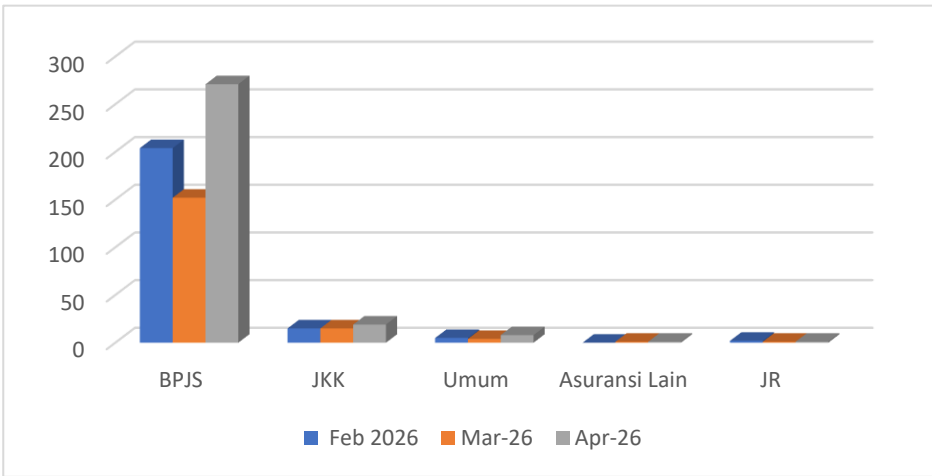
			sebesar 13%
--	--	--	-------------

3.1.1.1 Kunjungan Rawat Inap 2,3,4 A

3.1.1.1.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Februari – April 2026)

NO	HAL	Feb 2026	Mar 2026	Apr 2026	Persentase 2026
1	BPJS	204	152	271	↑ 78, 28 %
2	JKK	15	15	19	↑ 26,6 %
3	Umum	5	4	8	↑ 100 %
4	Asuransi Lain	0	1	1	0 %
5	JR	2	1	1	0 %
Total Pasien		242	226	173	-

3.1.1.1.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Februari – April 2026)



3.1.1.1.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

No	Bulan	RAWAT INAP				Kesimpulan
		BPJS	Umum	JKK	JR/Asuransi	
1	Analisis capaian April 2026	Pasien BPJS mengalami peningkatan pada bulan April 2026 sebanyak 119 pasien dikarenakan kunjungan IGD dengan penjamin kelas 1,2,3	Pasien Umum pada bulan April 2026 mengalami peningkatan sebanyak 4 pasien karena tidak mempunyai BPJS maupun asuransi	Jumlah Pasien JKK pada bulan April 2026 Meningkat sebanyak 4 pasien dikarenakan terjadi KLL saat bekerja	Jumlah Pasien JR atau asuransi bulan April 2026 sama dengan bulan sebelumnya (1 Pasien)	Peningkatan jumlah pasien selama 3 bulan terakhir banyak pada bulan April dengan jumlah pasien sebanyak 119 pasien

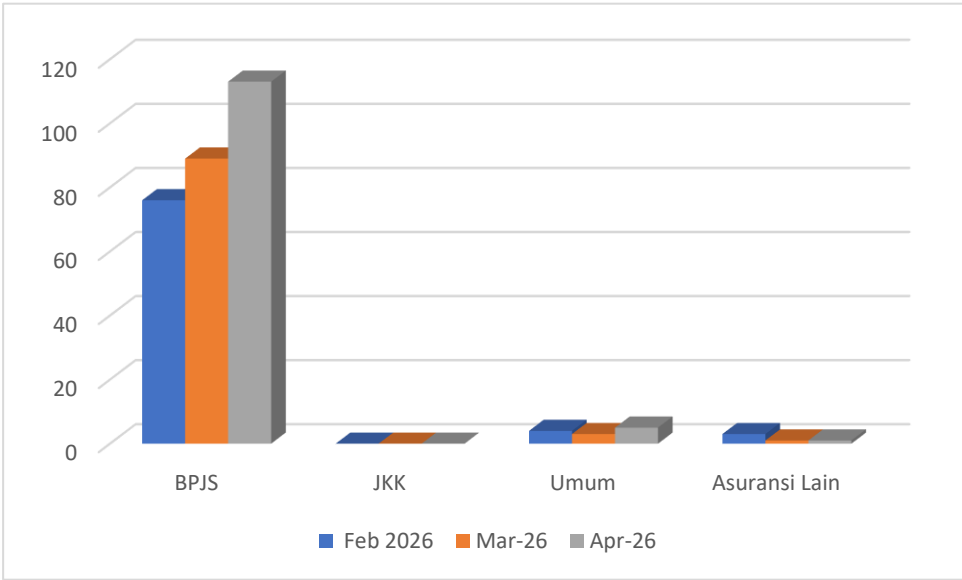
2	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap 3. Evaluasi antrian operasi elektif 4. Mempercepat waktu antrian operasi elektif 5. Untuk Irna 3A sementara tutup dan dialihkan ke Irna 2A dikarenakan TT dilantai 2A 15 TT serta terdapat ruang transit 6. Lantai 3A dibuka jika memang disemua lantai penuh.	
---	-----	---	--

3.1.1.2 Kunjungan Rawat Inap 5C

3.1.1.2.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Februari – April 2026)

NO	HAL	Feb 2026	Mar 2026	Apr 2026	Prosentase terhadap bulan sebelumnya
1	BPJS	76	89	113	↑ 21,23%
2	JKK	0	0	0	0
3	Umum	4	3	5	↑ 40%
4	Asuransi Lain	3	1	1	0
Total Pasien		113	83	93	↑ 22%

3.1.1.2.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Februari - April 2026)



3.1.1.2.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

No	Bulan	RAWAT INAP				Kesimpulan
		BPJS	Umum	JKK	JR/Asuransi	
1	Analisis capaian Februari 2026	Total Pasien BPJS mengalami penurunan sebanyak	Total Pasien Umum mengalami peningkatan sebanyak	Pasien JKK tidak mengalami penurunan ↓100% dari bulan sebelu	Pasien Asuransi / JR mengalami penurunan sebanyak ↓36,14% dari	Pada bulan Februari 2026 untuk total kunjungan pasien mengalami Penurunan dari

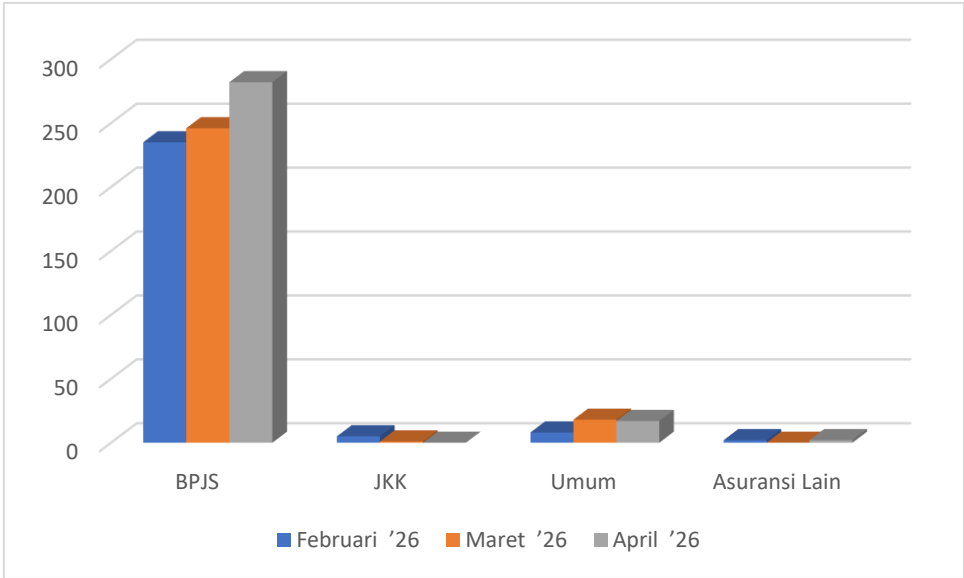
		↓40,78% dari bulan sebelumnya	↑50% dari bulan sebelumnya	mnya.	bulan sebelumnya	bulan sebelumnya sebesar ↓26,54%
	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya				
2	Analisis capaian Maret 2026	Total Pasien BPJS mengalami peningkatan sebanyak ↑14,60% dari bulan sebelumnya	Total Pasien Umum mengalami penurunan sebanyak ↓33,33% dari bulan sebelumnya	Pasien JKK sama dengan kunjungan bulan sebelumnya.	Pasien Asuransi / JR mengalami penurunan sebanyak ↓66,66% dari bulan sebelumnya	Pada bulan Maret 2026 untuk total kunjungan pasien mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya sebesar ↑10,75%
	RTL	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya				
3	Analisis capaian April 2026	Total Pasien BPJS mengalami peningkatan sebanyak ↑21,23% dari bulan sebelumnya	Total Pasien Umum mengalami peningkatan sebanyak ↑40% dari bulan sebelumnya	Pasien JKK sama dengan kunjungan bulan sebelumnya.	Pasien Asuransi / JR sama dengan kunjungan bulan sebelumnya	Pada bulan April 2026 untuk total kunjungan pasien mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya sebesar ↑22%
	RTL	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya				

3.1.1.3 Kunjungan Rawat Inap 6, 7, 8 A

3.1.1.3.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Februari – April 2026)

NO	HAL	Februari '26	Maret '26	April '26	Prosentase terhadap bulan sebelumnya
1	BPJS	235	246	282	↑ 6,4%
2	JKK	5	1	0	↓ 100%
3	Umum	8	18	17	↓ 5,5%
4	Asuransi Lain	2	0	2	↑100 %
Total Pasien		268	250	265	↑ 5,6%

3.1.1.3.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Februari - April 2026)



3.1.1.3.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

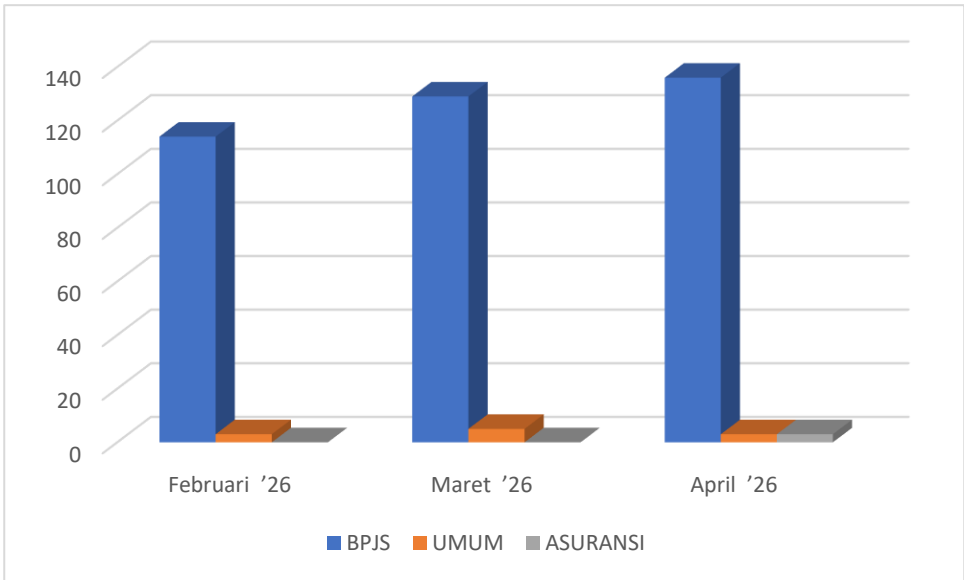
Bulan	Rawat Inap				Kesimpulan
	BPJS	Umum	JKK	JR/Asuransi	
Analisis pencapaian jumlah pasien 3 bulan terakhir	Pasien BPJS mengalami terjadi peningkatan pada bulan april 2026 yaitu sebanyak 36 pasien disebabkan banyaknya kunjungan pasien di IGD dengan penjamin kelas 3	Pasien Umum mengalami penurunan pada bulan april 2026 yaitu sebanyak 1 pasien, yang datang ke IGD rata rata menggunakan penjamin BPJS untuk kelas 3	Pasien JKK mengalami penurunan pada bulan april 2026 yaitu sebanyak 0 pasien	Jumlah pasien Asuransi / JR mengalami peningkatan 100% pada bulan april 2026	Peningkatan jumlah pasien selama 3 bulan terakhir banyak pada bulan maret dengan jumlah pasien sebanyak 36 pasien
RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap 3. Evaluasi antrian operasi elektif 4. Mempercepat waktu antrian operasi elektif 5. Meningkatkan MOU dengan perusahaan				

3.1.1.4 Kunjungan Rawat Inap Maternitas

3.1.1.4.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Februari - April 2026)

NO	HAL	Februari '26	Maret '26	April '26	(Persentase terhadap bulan sebelumnya)
1	BPJS	114	129	136	↑25%
2	UMUM	3	5	3	↓40%
3	ASURANSI	0	0	3	0%
Total Pasien		137	137	117	5,6%

3.1.1.4.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Februari-April 2026)



3.1.1.1.1 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

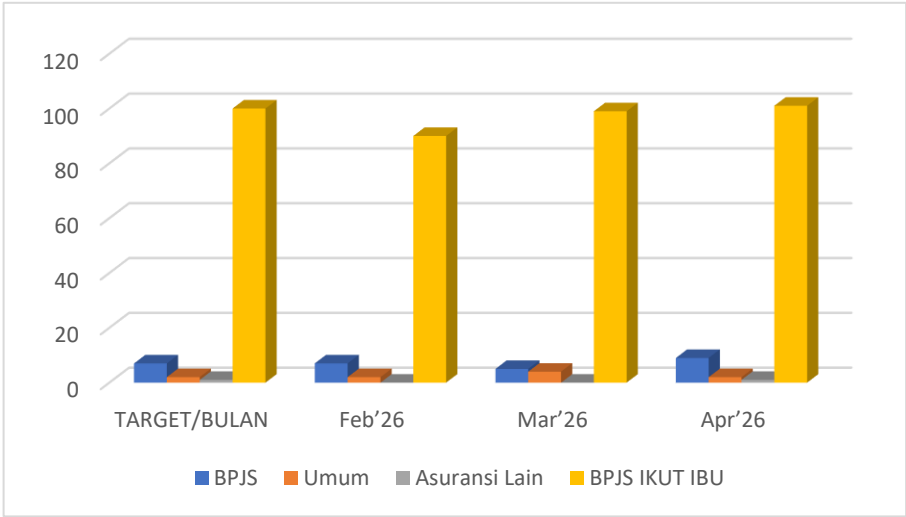
No	Bulan	RAWAT INAP			Kesimpulan
		BPJS	Umum	JR/Asuransi	
	Analisis capaian Bulan Januari-Maret	Pasien BPJS pada bulan Maret mengalami Kenaikan 25%	Pasien umum pada bulan Maret mengalami Penurunan 40%	Terdapat Pasien Asuransi pada bulan April yaitu 3 pasien	Kunjungan turun dengan bulan sebelumnya. Selalu melakukan Upaya peningkatan dan evaluasi program telusur sederhana
	RTL	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target disetiap bulan	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target disetiap bulan	Meningkatkan pelayanan serta koordinasi dengan tim IGD	

3.1.1.2 Kunjungan Rawat Inap Neonatologi

3.3.2.7.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Februari – April 2026)

NO	HAL	TARGET/BULAN	Feb'26	Mar'26	Apr'26	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	7	7	5	9	↑7,96%
2	Umum	2	2	4	2	↓1,77%
3	Asuransi Lain	1	0	0	1	↑0,9%
4	BPJS IKUT IBU	100	90	99	101	↑89,38%
Total Pasien		110	107	99	108	↑4,63%

1.3.2.7.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Februari - April 2026)



3.3.2.7.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

No	Bulan	Rawat Inap				Total Pasien
		BPJS	UMUM	ASURANSI	BPJS IKUT IBU	
1	Februari 2026	7	2	0	90	99
		Untuk pasien BPJS mengalami kenaikan dengan bulan sebelumnya sebanyak 7,1%	Untuk pasien Umum mengalami kenaikan dengan bulan sebelumnya sebanyak 2%	Tidak ada pasien asuransi	Pasien BPJS Ikut Ibu mengalami penurunan sebanyak 11,76%	
		Meningkatkan pelayanan agar bisa mencapai peningkatan di setiap bulannya	Meningkatkan pelayanan agar bisa mencapai peningkatan di setiap bulannya	Bekerjasama dengan IGD untuk promosi kesehatan	Meningkatkan pelayanan khususnya pada pasien bayi baru lahir, Koordinasi dengan tim Maternitas dan poli untuk promosi Kesehatan ibu dan bayi melalui senam hamil.	
2	Maret 2026	5	4	0	99	108
		Untuk pasien BPJS mengalami penurunan dengan bulan sebelumnya sebanyak 4,63%	Untuk pasien Umum mengalami kenaikan dengan bulan sebelumnya sebanyak 3,7%	Tidak ada pasien asuransi	Pasien BPJS Ikut Ibu mengalami kenaikan sebanyak 91,7%	
		Meningkatkan pelayanan agar bisa mencapai peningkatan di setiap bulannya	Meningkatkan pelayanan agar bisa mencapai peningkatan di setiap bulannya	Bekerjasama dengan IGD untuk promosi kesehatan	Meningkatkan pelayanan khususnya pada pasien bayi baru lahir, Koordinasi dengan tim Maternitas dan poli untuk promosi Kesehatan ibu dan bayi melalui senam hamil.	
3	April 2026	9	2	1	101	113

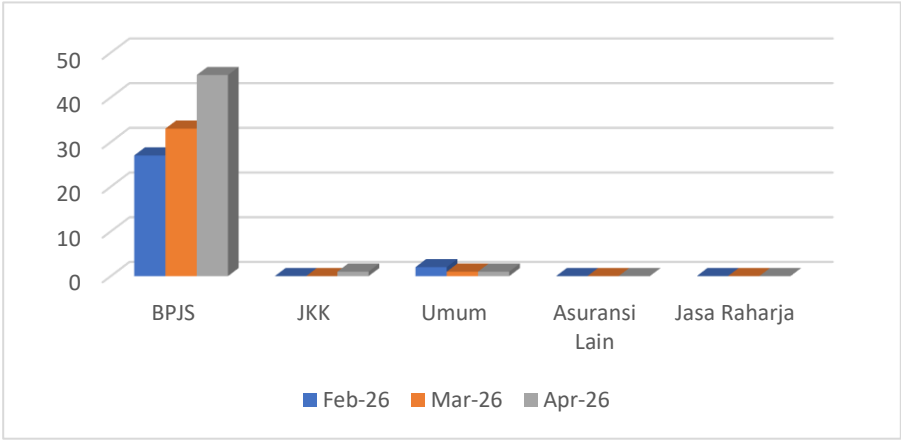
		Untuk pasien BPJS mengalami kenaikan dari bulan sebelumnya sebanyak 7,96%	Untuk pasien Umum mengalami penurunan dengan bulan sebelumnya sebanyak 1,77%	ada 1 pasien asuransi	Pasien BPJS Ikut Ibu mengalami kenaikan sebanyak 89,38%	
		Meningkatkan pelayanan agar bisa mencapai peningkatan di setiap bulannya	Meningkatkan pelayanan agar bisa mencapai peningkatan di setiap bulannya	Bekerjasama dengan IGD untuk promosi kesehatan	Meningkatkan pelayanan khususnya pada pasien bayi baru lahir, Koordinasi dengan tim Maternitas dan poli untuk promosi Kesehatan ibu dan bayi melalui senam hamil.	

3.1.2 Intensive Care Unit (ICU)

3.1.2.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Februari - April 2026)

NO	Cara Bayar	Feb 2026	Mar 2026	Apr 2026	Prosentase terhadap bulan sebelumnya
1	BPJS	27	33	45	↑0,36%
2	JKK	0	0	1	↑100%
3	Umum	2	1	1	Tetap
4	Asuransi Lain	0	0	0	Tetap
5	Jasa Raharja	0	0	0	Tetap
Total Pasien		29	34	47	↑0,38%

3.1.2.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Februari - April 2026)



3.1.1.1 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO.	BULAN	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis 3 bulan terakhir	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan April 2026 mengalami peningkatan 0,36% dibandingkan bulan sebelumnya	Pasien umum dalam 3 bulan terakhir jumlahnya tetap di bulanapril ada 1 pasien	Pasien JKK dalam 3 bulan terakhir ada 1 di bulan april	Tidak ada pasien penjamin asuransi lain selama 3 bulan terakhir	Kunjungan pasien rawat inap ICU RS Prima Husada mengalami penurunan sebesar 0,38 % dibandingkan dari bulan sebelumnya.
2	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai				

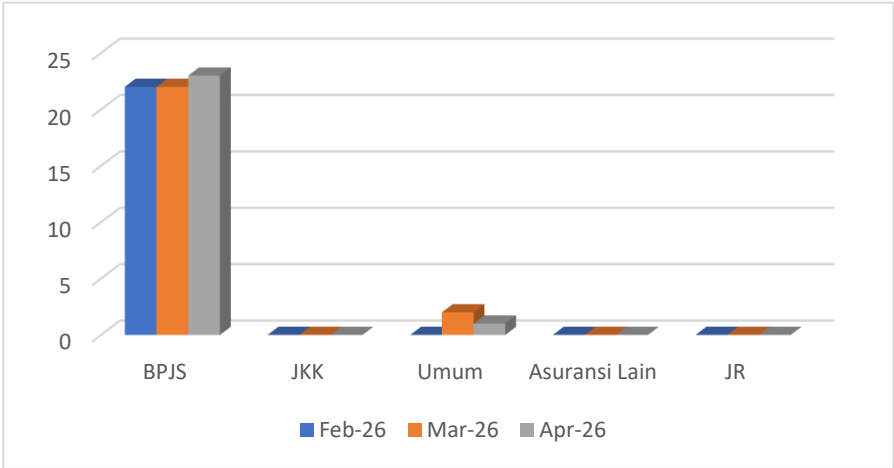
		target setiap bulannya	
		2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap terutama ICU	
		3. Meningkatkan kualitas fasilitas di unit	
		4. Menerima pasien dari IGD dengan cepat	
		5. Meningkatkan kualitas SDM yang ada di ICU	

3.1.2 High Care Unit (HCU)

3.1.2.3 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Februari - April 2026)

NO	HAL	Feb 2026	Mar 2026	Apr 2026	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	22	22	23	↑0,04
2	JKK	0	0	0	Tetap
3	Umum	0	2	1	↓0,5%
4	Asuransi Lain	0	0	0	Tetap
5	JR	0	0	0	Tetap
Total Pasien		22	24	24	Tetap

3.1.1.1 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Februari - April 2026)



3.1.2.1 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO.	BULAN APRIL	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis 3 bulan terakhir	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir belum stabil,untuk bulan april 2026 mengalami peningkatan 0,04% dibandingkan bulan lalu	Pasien umum dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan April 2026 turun 0,5% dari bulan sebelumnya	Tidak ada pasien JKK selama 3 bulan terakhir	Tidak ada Pasien JR/ Asuransi bulan April 2026	Kunjungan pasien rawat inap HCU RS Prima Husada sama dari bulan sebelumnya
2	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap terutama HCU				

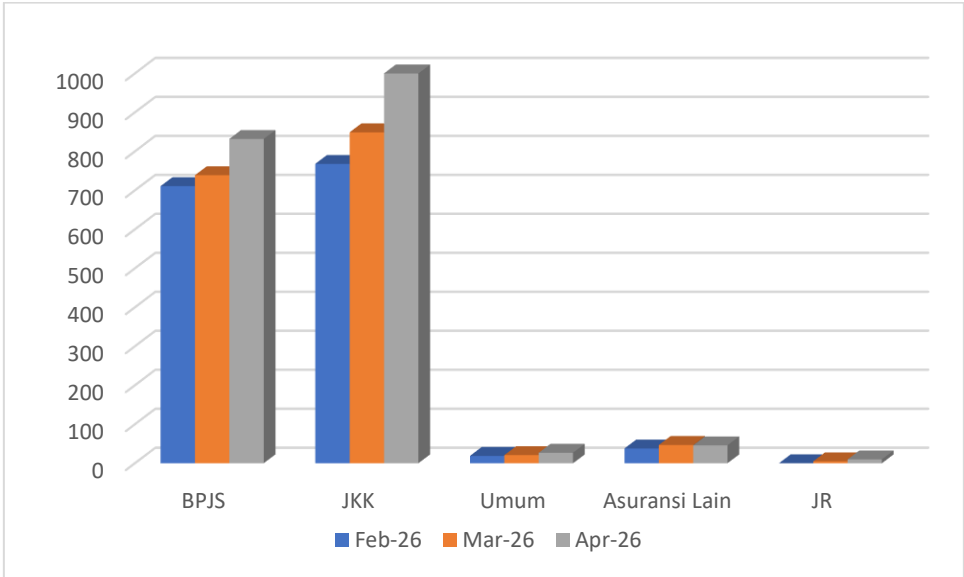
		3. Meningkatkan kualitas fasilitas di unit	
		4. Menerima pasien dari IGD dengan cepat	

3.1.3 Instalasi Gawat Darurat (IGD)

3.1.3.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Februari - April 2026)

NO	HAL	Feb 2026	Mar 2026	Apr 2026	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	711	739	832	↑11,17%
2	JKK	768	849	1.000	↑15,1%
3	Umum	19	21	27	↑22,2%
4	Asuransi Lain	38	47	46	↓2,1%
5	JR	0	5	10	↑50%
Total Pasien		1.536	1.661	1.915	↑13,2 %

3.1.3.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Februari – April 2026)



3.1.3.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

No	BULAN	INSTALASI GAWAT DARURAT					
1	April	BPJS	UMUM	JKK	ASURANSI	JR	TOTAL PASIEN
	Analisis	Kunjungan pasi en BPJS di bulan April mengalami peningkatan 11,17%	Kunjungan pasien UMUM dari bulan April mengalami peningkata n 15,1%	Kunjungan pasien dengan jaminan JKK mengal ami peningkatan sebanyak 22,2% dari bulan Maret 2026	Kunjungan pasien dengan jaminan Asuransi lain pada bulan Maret 2026 mengalami penurunan 2,1% dari bulan Maret 2026	Kunjungan pasien dengan jaminan JR bulan Maret meningkat 50% dari bulan Maret 2026	Total kunjungan pasien IGD semua jaminan di bulan April 2026 mengalami peningkatan 13,2%
	RTL	Meningkatk an capaian kunjungan jaminan pasien BPJS IGD	Memperta hankan dan meningkat kan capaian	Mempertaha nkan dan meningkatka n capaian kunjungan IGD jaminan	Meningkatka n capaian kunjungan jaminan Asuransi swasta IGD	Meningkatk an capaian kunjungan jaminan JR IGD bekerjasam	Meningkatkan capaian kunjungan IGD dengan memperbaiki pelayanan dan

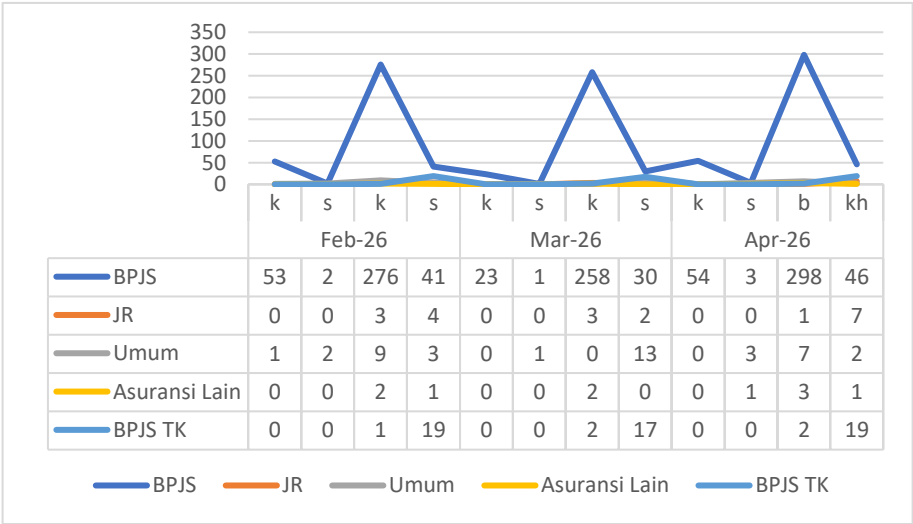
		bekerjasama dengan marketing untuk menambah kerja sama dengan beberapa faskes I area kabupaten Malang	kunjungan IGD dengan jaminan UMUM dengan memberikan pelayanan kesehatan yang prima dan maksimal	JKK dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan marketing untuk memperluas kerjasama dengan beberapa Perusahaan Kabupaten Malang	bekerjasama dengan marketing untuk memperluas kerjasama dengan perusahaan asuransi	a dengan marketing untuk memperluas kerjasama dengan perusahaan asuransi	bekerjasama dengan pihak terkait (marketing, asuransi centre)
--	--	---	---	--	--	--	---

3.1.4 Instalasi Kamar Operasi (IKO)

3.1.4.1 Jumlah Operasi Berdasarkan Jenis Operasi dan Penjamin (Februari-April 2026)

NO	HAL	Feb 2026				Mar 2026				Apr 2026			
		k	s	k	s	k	s	k	s	k	s	b	kh
1	BPJS	53	2	276	41	23	1	258	30	54	3	298	46
2	JR	0	0	3	4	0	0	3	2	0	0	1	7
3	Umum	1	2	9	3	0	1	0	13	0	3	7	2
4	Asuransi Lain	0	0	2	1	0	0	2	0	0	1	3	1
5	BPJS TK	0	0	1	19	0	0	2	17	0	0	2	19
	Total Pasien	417				352				447			

Grafik Jumlah Operasi Berdasarkan Jenis Operasi dan Penjamin (Februari April 2026)



3.1.4.2 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

No.	BULAN	Instalasi Kamar Operasi			
1	April	Kecil	Sedang	Besar	Khusus
	Analisis	Jumlah pasien ODC Pacho meningkat karena antrian pasien yang matur kataraknya juga meningkat	Pasien Iridectomy meningkat	Operasi besar meningkat karena jumlah lodingan meningkat	Operasi khusus meningkat karena banyak kasus trauma dan tindakan op ortopedi

	RTL	Tingkatkan capaian dengan mengawal pasien-pasien yang menunda tindakan.	Meningkatkan capaian dengan sosiali ke pihak luar tindakan apa saja yang dapat di lakukan di IKO RSPHM	Meningkatkan capaian dengan sosiali ke pihak luar tindakan apa saja yang dapat di lakukan di IKO RSPHM	Tingkatkan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan.
--	-----	---	--	--	--

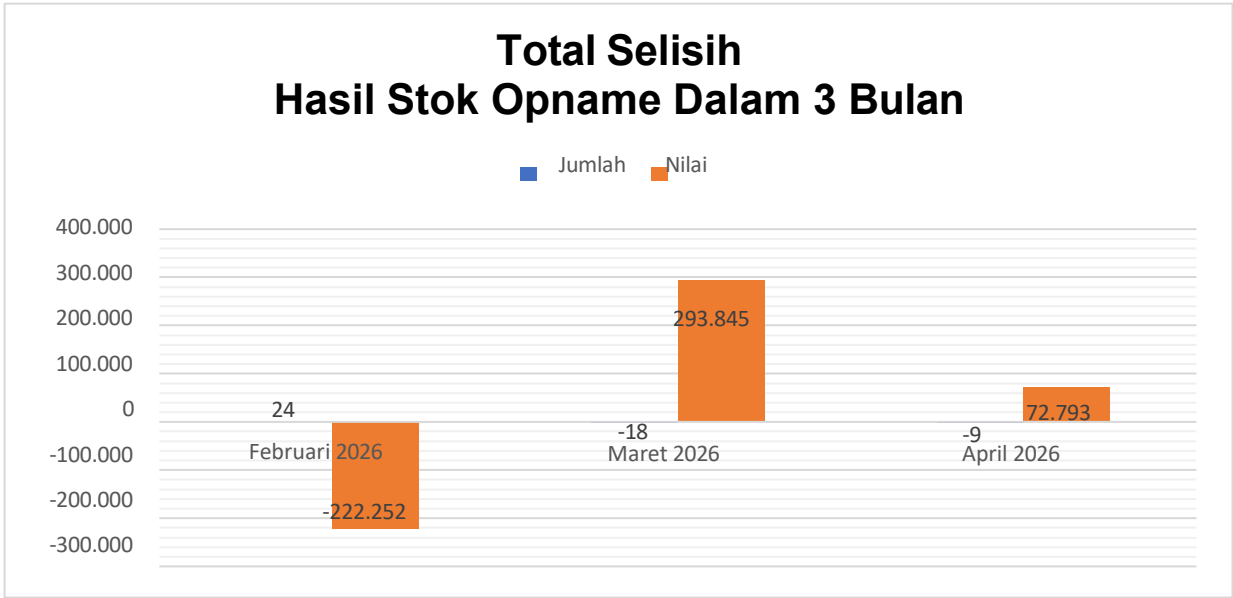
3.2 Kinerja Bidang Penunjang

3.2.1 Instalasi Farmasi

3.2.1.1 Tabel Hasil Stok Opname Instalasi Farmasi Februari - April 2026

Unit	Stok	Februari 2026		Maret 2026		April 2026	
		Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
GUDANG	Fisik	858.275	1.683.188.894,52	858.275	1.683.188.894,52	670.702	1.360.931.713,52
	Sistem	858.275	1.683.188.894,52	858.275	1.683.188.894,52	670.702	1.360.931.713,52
	Selisih	0	0	0	0	0	0
DEPO FARMASI	Fisik	241.864	643.787.152,87	241.864	643.787.152,87	212.376	606.900.154,96
	Sistem	241.841	644.009.405,22	241.841	644.009.405,22	212385	606.827.362,35
	Selisih	24	-222.252,35	24	-222.252,35	-9	72.793
IKO	Fisik	3.370	80.672.655,09	3.370	80.672.655,09	3.081	79.179.236,02
	Sistem	3.370	80.672.655,09	3.370	80.672.655,09	3.081	79.179.236,02
	Selisih	0	0	0	0	0	0
Total Selisih		666	24	-222.252	24	-9	72.793

3.2.1.2 Grafik Hasil Stok Opname Instalasi Farmasi Februari - April 2026



Analisis:

Dari hasil diatas tampak bahwa hasil stok opname Gudang farmasi dan IKO mencapai target “0”. Hal tersebut dapat dikarenakan penandaan nama pada rak sudah tertata dan kartu stok sudah rutin berjalan. Selain itu perawat unit juga sudah patuh melakukan input resep yang sesuai. Namun pada depo farmasi hasil stok opname masih jauh dari target yaitu – Rp. 222.252 hal ini dapat disebabkan karena:

1. Ketidaksesuaian antara jumlah obat yang di input dan jumlah obat yang disiapkan.
2. Ketidaksesuaian antara barang yang diambil perawat IGD dan inputan resep di SIMRS.
3. Ketidaksesuaian antara Input resep BMHP poli dan jumlah yang di ambil.

-
4. Hutang input resep saat SO berjalan.
 5. Ketidaksesuaian penyiapan obat LASA

Rencana Tindak Lanjut:

1. Melakukan supervise secara berkala.
2. Double check wajib di lakukan dengan alur kerja ISEP obat yang sudah di tentukan.
3. Supervisi oleh kains farmasi terkait penyiapan obat hingga alur penyerahan secara berkala.
4. Monitoring dan evaluasi oleh Kabid terkait dengan proses Input hingga penyerahan obat. Jika ada kesalahan dalam proses langsung di tegur dan langsung diperbaiki.
5. Perbaiki alur ERM khususnya peresepan IGD diinput terlebih dahulu dan resep manual hanya untuk pasien KLL (case emergency) jika ada yang belum terinput maka akan dishare di Grup dan meminta bukti inputan.
6. Petugas farmasi wajib double crosscheck sebelum obat atau BMHP di serahkan → supervise oleh kains farmasi.

3.1.1.1 Tabel Daftar Obat-obat Near ED <6 bulan (Bulan April - Oktober 2026)

6. Depo Farmasi

No.	Kode	Nama Barang	Satuan	Harga Beli	Tgl. Expired	No. Batch	Jumlah Fisik Baik			Total Harga	Laporan Penjualan Jan 25 — Apr 26 (Depo+IKO)
							Feb 26	Mar 26	Apr 26		
1.	F00244	Diazepam rectal 10 mg / 25 ml - actavis	Pcs	17.903	30/05/2026	C2670201	-	1	1	17.903	49
2.	F00292	Ethambutol tab 400 mg (hibah)	Tab	0	30/05/2026	SL515	19	153	153	0	228
3.	F01314	Delta dry 10cmx2.4m - bsn	Pcs	140.400	30/06/2026	006	4	4	4	561.600	0
4.	F03236	Topsy cream 5 g	Tub	40.664	30/06/2026	F24002	1	3	3	121.992	3
5.	F00812	Vaksin vaxigrip tetra - sanofi	Vial	149.625	30/06/2026	5dfn0d3	2	2	2	299.250	149
6.	F00606	Phenobarbital inj 50 mg/ml - phapros	Amp	1.532	30/07/2026	76803001	25	25	23	35.236	18
7.	F00672	Rifampicin tab 450 mg (hibah)	Tab	0	30/08/2026	TSJ02853	129	36	144	0	1.005
8.	F00678	Rixone inj 1 gr - yarindo	Vial	200.000	30/08/2026	E01801HB	-	15	15	3.000.000	2
9.	F00695	Sanoskin oxy 30 g - interbat	Tub	422.750	30/08/2026	215	2	2	2	845.500	1
10.	F00951	Benang t-plain 4-0 p119 - triton	Pcs	60.500	30/09/2026	210918IN	14	12	9	544.500	23
11.	F00119	Cairan inf mgso4 20% 25 ml - otsuka	Flash	4.928	30/09/2026	B82B54A	5	5	2	9.856	69
12.	F00546	Nutrisi lactogen lactose free 400 g - nestle	Klg	116.036	30/09/2026	50790346AE	1	1	1	116.036	1
Sub Total Depo Farmasi										5.551.873	

7. Gudang Farmasi

No.	Kode	Nama Barang	Satuan	Harga Beli	Tgl. Expired	No. Batch	Jumlah Fisik Baik			Total Harga
							Feb 26	Mar 26	Apr 26	
1.	F00968	Benang t-vio 2-0 v9 - triton	Pcs	83.000	30/07/2026	230701BV	24	24	24	1.992.000
2.	F01372	Feeding tube fr no 3.5 - terumo	Pcs	19.250	30/04/2026	230520B	17	7	7	134.750
3.	F00672	Rifampicin tab 450 mg (hibah)	Tab	0	30/06/2026	TSG75153	1.282	1.282	1.082	0
4.	F01413	Guedel airway 50 mm/no 00 - forsch	Pcs	10.800	30/07/2026	2114423h	2	2	2	21.600
5.	F00696	Sanprima forte kaps - sanbe	Tab	2.100	30/07/2026	CG2905	300	300	300	630.000
6.	F04497	Vaksin formening - mersi	Vial	113.526	26/07/2026	8202301002	0	79	68	7.719.768
7.	F00806	Vaksin rotateq - gsk	Vial	245.395	30/07/2026	z007996	9	9	9	2.208.555
8.	F00182	Cendo tonor mds - cendo	Pcs	6.934	30/08/2026	3TR60816	40	40	40	277.360
9.	F00695	Sanoskin oxy 30 g - interbat	Tub	422.750	30/08/2026	214	7	6	6	2.536.500
10.	F05117	Skycellflu quadrivalent - dextra medica	Vial	167.200	30/08/2026	Q0225009	4	10	3	501.600
11.	F00455	Lovenox 60 mg/0.6 ml - sanofi	Amp	120.000	30/09/2026	5K5125FB	-	-	52	6.240.000
12.	F00494	Miconazole cr 2% 10 g - kimia farma	Tub	3.407	30/09/2026	14171700	122	102	92	313.444
Sub Total Gudang Farmasi										22.575.577

8. IKO

No.	Kode	Nama Barang	Satuan	Harga Beli	Tgl. Expired	No. Batch	Jumlah Fisik Baik			Total Harga
							Feb 26	Mar 26	Apr 26	
1.	F01389	Foley cath no 18 - rusch	Pcs	19.250	30/07/2026	T21H05	5	5	3	57.750
2.	F00972	Benang t-vio 5-0 v38 - triton	Pcs	85.000	30/08/2026	230801RA	13	10	12	1.020.000
3.	F01370	Extension tube 75 cm - terumo	Pcs	16.800	30/08/2026	210909B	2	2	2	33.600
4.	F01400	Foley cath silicon no 8 - rusch	Pcs	222.000	30/08/2026	KME20J1263	4	4	4	888.000
5.	F00944	Benang t-mono 6-0 m54 - triton	Pcs	144.000	30/09/2026	230902MA	10	9	7	1.008.000
6.	F01382	Foley cath 3 way no 20 - rusch	Pcs	66.150	30/09/2026	KMA20KI055	10	10	10	661.500
7.	F01394	Foley cath silicon no 10 - rusch	Pcs	110.000	30/09/2026	KME20K30008	1	1	1	110.000
Sub Total IKO										3.778.850
Grand Total										31.906.300

3.2.1 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

Analisis	Tindak Lanjut
Berdasarkan rekap obat dan alkes near expired date (Near ED) periode April–Oktober 2026, ditemukan beberapa item obat dan alat kesehatan dengan masa kedaluwarsa kurang dari 6 bulan. Kondisi ini sebagian besar disebabkan oleh penggunaan slow moving dan dead moving, penerimaan hibah dengan ED pendek, serta stok emergency yang jarang digunakan. Beberapa item seperti obat TB, phenobarbital injeksi, benang operasi, dan alkes gips mengalami perputaran lambat sehingga berpotensi tidak habis sebelum masa kedaluwarsa. Selain itu terdapat produk dengan penggunaan terbatas karena harga mahal atau tidak tercover klaim asuransi, seperti Sanoskin oxy. Secara umum, kondisi near ED menunjukkan perlunya pengendalian stok yang lebih optimal agar mengurangi risiko obat dan alkes kadaluarsa serta meminimalkan kerugian rumah sakit.	1. Sediaan farmasi, bahan medis habis pakai, dan alat kesehatan near ED dilakukan koordinasi dengan PHS jika barang lebih berjalan di PHS akan diberikan ke PHS untuk lainnya akan dilakukan koordinasi dengan DPJP untuk peresepan. 2. Membuat surat edaran ke DPJP untuk meresepkan obat/ bmhp/ alkes yang near ed. 3. Koordinasi dengan karu untuk menggunakan alkes yang near ed. 4. Koordinasi dengan PT. DPM untuk melakukan retur ke distributor. 5. Koordinasi dengan DPJP obat yang <i>death moving</i> di <i>stop order</i> dan dikeluarkan dari Formularium RS. 6. Floorstok IKO yang slow moving di tukar dengan ED jauh.

3.2.1.6 Tabel Jumlah Pelayanan Resep pada Bulan 2026

No	Instalasi	Umum	BPJS Kesehatan	BPJS Ketenagakerjaan	Asuransi Swasta	Jasa Raharja	Total
1	Instalasi Rawat Inap						
	Jumlah Resep Obat Racikan	15	255	0	1	1	272
	Jumlah Resep Obat Jadi	582	8163	0	336	68	9149
	Jumlah Resep Obat	597	8418	0	336	69	9421
2	IGD						
	Jumlah Resep Obat Racikan	103	29	0	0	0	132
	Jumlah Resep Obat Jadi	1508	2857	0	196	38	4599
	Jumlah Resep Obat	1611	2886	0	196	38	4731
3	Instalasi Rawat Jalan						
	Jumlah Resep Obat Racikan	311	1558	0	0	0	1869
	Jumlah Resep Obat Jadi	1036	7047	0	293	3	8379
	Jumlah Resep Obat	1347	8605	0	293	3	10.248
4	IKO						
	Jumlah Resep Obat Racikan	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Resep Obat Jadi	29	1115	0	86	32	1262
	Jumlah Resep Obat	29	1115	0	86	32	1262
TOTAL		3584	21.024	0	912	142	25.662

Analisis:

1. Kunjungan pasien Umum pada bulan April 2026 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bulan Maret 2026, dengan total resep yaitu : bulan Maret 2026 sebanyak 3.183 resep umum dan bulan April 2026 sebanyak 3.584 resep umum.
2. Kunjungan pasien BPJS Kesehatan pada bulan April 2026 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bulan Maret 2026, dengan total resep yaitu : bulan Maret 2026 sebanyak 17.222 resep BPJS Kesehatan dan bulan April 2026 sebanyak 21.024 resep BPJS Kesehatan.
3. Kunjungan pasien Asuransi Swasta dan Jasa Raharja pada bulan April 2026 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bulan Maret 2026, dengan total resep yaitu : bulan Maret 2026 sebanyak 887 resep Asuransi Swasta dan Jasa Raharja, sedangkan bulan April 2026 sebanyak 1.054 resep Asuransi Swasta dan Jasa Raharja.
4. Secara keseluruhan total resep pada bulan April 2026 mengalami peningkatan :
 - Adanya pembatasan kunjungan pasien per poli untuk pasien rawat jalan,
 - Adanya target PRB dimana pasien rujuk balik ke FKTP jika pasien sudah stabil di poli,
 - Retur obat tertinggal rawat jalan yang tidak diambil pasien di poli,
 - Kurangnya promo tarif vaksin di poli,
 - Kurangnya promo tarif poli sakura untuk poli lain,
 - DPJP tidak praktek karena libur lebaran,

Rencana Tindak Lanjut:

- 1. Meningkatkan promosi tarif dan tindakan RS di sosial media RS agar kunjungan pasien meningkat.
- 2. Meningkatkan pelayanan resep yang tepat, cepat, dan akurat sehingga meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan di Farmasi.
- 3. Kolaborasi dengan Petugas Pendaftaran untuk menjangir pasien-pasien yang mempunyai jaminan kesehatan lebih dari 1 untuk menggunakan asuransi swasta terlebih dulu.
- 4. Koordinasi dengan programmer menciptakan website primantara untuk memudahkan pendaftaran pasien.
- 5. Kebijakan pengambilan obat maksimal 2x24 jam menghindari penumpukan obat tertinggal yang mengakibatkan retur penjualan.
- 6. Mengadakan promo pelayanan pengantaran obat untuk pengguna baru.
- 7. Farmasi tiap hari menghubungi pasien jika sudah melewati 1x24 jam obat ditinggal untuk mengurangi penumpukan obat tertinggal.

3.2.1.7 Tabel Hasil Kinerja Instalasi Farmasi Rumah Sakit Prima Husada Bulan Februari - April 2026

No	Kegiatan	Standard	Pencapaian			Keterangan
			Feb 26	Mar 26	Apr 26	
1	Pengkajian resep	100%	99,47%	98,87%	99,28%	Jumlah pengkajian resep yaitu Februari 2026 = 22.472 Maret 2026 = 21.292 April 2026 = 25.662 Jumlah ketidاكلengkapan penulisan resep yaitu Februari 2026 = 118 Maret 2026 = 240 April 2026 = 185
2	Dispensing Sediaan Steril	100%	100%	100%	100%	Dispensing sediaan steril dilakukan oleh apoteker di ruang pencampuran obat steril.
3	Pemantauan Terapi Obat (PTO)	100%	100%	100%	100%	Form PTO sudah terlaksana dimana apoteker melakukan seleksi pasien berdasarkan kriteria PTO. Form PTO diletakkan dalam RM.
4	Kejadian Efek Samping Obat	0	1	0	0	Terdapat kejadian pelaporan efek samping obat
5	Edukasi Obat pada pasien dan keluarga	100%	100%	100%	100%	Data berdasarkan rekam medis dan resep yang di ttd penerima obat
6	Konseling	100%	100%	100%	100%	Konseling sudah dilakukan apoteker dibuktikan dengan bukti edukasi di form edukasi (pasien rawat inap) dan ttd penerima obat di resep (pasien rawat jalan)
7	Pemantauan Kadar Obat Dalam Darah	TDD	TDD	TDD	TDD	Tidak punya alat untuk pemantauan kadar obat dalam darah. TTD RS tipe C tidak wajib.
8	Visite Ronde Besar	100%	0%	0%	0%	Tidak ada visite ronde besar
9	Visite Pasien/ Farmasi Klinik	100%	100%	100%	100%	Seluruh pasien rawat inap dilakukan visite mandiri dibuktikan dengan pengisian CPPT oleh apoteker di RM.

10	Pelayanan Informasi Obat (PIO)	100%	100%	100%	100%	Data berdasarkan map informasi obat, MIMS, aplikasi medscape
11	Obat tertinggal yang tidak diambil pasien	0	12	39	35	Obat tertinggal yang tidak diambil pasien dilakukan Penerimaan Hibah Lainnya ke gudang retur

Analisa :

1. Pengkajian resep :

Penulisan resep yang lengkap bulan April 2026 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bulan Maret 2026, dengan prosentase resep yang tidak lengkap yaitu : bulan Maret 2026 sebanyak 98,87% dan bulan April 2026 sebanyak 99,28%. Dari data di atas ditemukan pengkajian resep :

- Dari segi telaah adminitrasi : sudah lengkap karena menggunakan e-resep melalui SIMRS.
- Dari segi telaah farmasetik : ditemukan 185 resep dimana dokter salah input dosis dan jumlah obat, aturan dan cara penggunaan serta rute pemberian tidak lengkap terisi.
- Dari segi telaah klinis : sudah terlaksana oleh apoteker karena jika ada interaksi obat langsung diberi jeda pemberian obat oleh apoteker.

2. Dispensing Sediaan Steril

- Staf yang melakukan dispensing sediaan obat steril non sitostatika terlatih dan kompeten. Apoteker yang memiliki sertifikat pelatihan prinsip penyiapan obat dan teknik aseptik tersertifikasi kemenkes yaitu 1 orang. Sedangkan Apoteker, TVF, bidan, dan perawat sudah memiliki sertifikat pelatihan dispensing sediaan obat steril non sitostatika di pelatihan internal.
- Tersedia bukti hasil pemantauan suhu, kelembaban, tekanan ruang, pemeliharaan LAF. Fasilitas dispensing sesuai standar praktik kefarmasian sesuai dengan perundang-undangan.
- Kebersihan ruangan dispensing sediaan obat non steril dan obat steril selalu terjaga. Petugas melakukan desinfeksi sebelum melakukan dispensing obat non steril dan obat steril. Renovasi Pencampuran Obat (LAF) sesuai standart selesai tanggal 20/03/2025, ruangan steril dilapisi vinyl. Tata letak ruang sudah di sekat dimana terdapat ruang persiapan dan ruang ganti APD, ruang antara, dan ruang steril (ada alat UV ruangan, pass box, LAF).
- Pencampuran obat IV dilakukan di LAF dengan dilengkapi APD sesuai ketentuan setiap pukul 13.00 WIB, untuk resep obat injeksi sore dan malam. Tidak ditemukan keterlambatan pengiriman obat ke ruangan.

3. Pemantauan Terapi Obat (PTO)

Tersedia bukti pelaksanaan Pemantauan Terapi Obat dan sudah terisi lengkap oleh apoteker sesuai kriteria PTO.

4. Kejadian Efek Samping Obat

- Hasil monitoring pelaporan MESO bulan April 2026 tidak ditemukan kejadian efek samping obat.
- Kurangnya pelaporan kejadian efek samping obat oleh tenaga kesehatan.

5. Edukasi Obat pada pasien dan keluarga

- Hasil supervisi dari rekam medis di rawat inap pada form edukasi bahwa apoteker sudah melakukan edukasi dibuktikan dengan ttd pasien/ keluarga di form edukasi.
- Hasil supervisi dirawat jalan petugas farmasi sudah melakukan edukasi ke pasien dibuktikan dengan ttd penerima obat beserta KIE.

6. Konseling

Pelaksanaan konseling sudah dilakukan pada pasien di rawat jalan dan/ataupun rawat inap yang mendapatkan terapi polifarmasi dan penyakit kronis. Apoteker memanggil pasien, identifikasi, menyerahkan obat dan edukasi. Konseling sudah dilakukan apoteker dibuktikan dengan bukti edukasi di form edukasi (pasien rawat inap) dan ttd penerima obat di resep (pasien rawat jalan).

7. Pemantauan Kadar Obat Dalam Darah : Tidak di lakukan di RS.

8. Visite Ronde Besar

Visite ke pasien rawat inap yang dilakukan Apoteker bersama tim tenaga kesehatan untuk mengamati kondisi klinis pasien secara langsung, dan mengkaji masalah terkait obat, memantau terapi obat, dan reaksi obat yang tidak dikehendaki, meningkatkan terapi obat yang rasional, dan menyajikan informasi obat kepada dokter, pasien serta professional kesehatan lainnya tidak pernah dilakukan, hal ini disebabkan waktu visite DPJP dan tenaga kesehatan lainnya tidak secara bersamaan.

9. Visite Pasien/ Farmasi Klinik

Visite dilakukan kepada setiap pasien rawat inap di RS dan di dokumentasikan di rekam medis pasien. Visite dilakukan untuk meminimalisir terjadinya medication error dan meningkatkan keberhasilan terapi pada pasien rawat inap

10. Pelayanan Informasi Obat (PIO)

PPA dapat mengakses Map informasi obat berisi : daftar dosis maksimal prorenata (jika perlu), daftar obat automatic stop order, daftar obat high alert update, daftar obat resiko jatuh, informasi cara pengenceran obat, informasi pembatasan resep, tabel rekonstitusi untuk pemberian intravena; MIMS; aplikasi Medscape di nurse station atau di poli, dan e-book yang tersedia di SIMRS.

11. Obat tertinggal yang tidak diambil pasien

Data obat tertinggal yang tidak diambil pasien April 2026 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan Maret 2026, dengan total resep yang di retur yaitu bulan Maret 2026 sebanyak 39 dan bulan April 2026 sebanyak 35. Hal ini disebabkan beberapa pasien tidak mengetahui mendapatkan resep sehingga obat ditinggal dalam waktu 3x24 jam, keterlambatan penyiapan obat sehingga waktu tunggu obat lama, dan pasien tidak rutin minum obat sehingga obat kunjungan sebelumnya masih ada.

Tindak Lanjut :

1. Pengkajian resep :

- Koordinasi dengan tim SIMRS untuk membuat sistem jika resep tidak terinput dengan lengkap maka resep tidak dapat masuk ke Depo Farmasi.
- Inputan resep harus dilakukan oleh dokter/ dokter spesialis yang kompeten dan berwenang mulai dari identitas pasien, nama obat, dosis, rute pemberian, waktu pemberian, nama dan tandatangan dokter (untuk resep manual).
- Pelatihan penulisan resep untuk semua dokter dan dokter spesialis.

2. Dispensing Sediaan Steril

- Pelatihan penyiapan obat IV dan teknik aseptik tahun 2025 target peserta Apoteker, TTK, Perawat, Bidan di laksanakan pada tanggal 08 Desember 2025.
- Monitoring dan evaluasi pengisian monitoring suhu dan kelembaban ruangan serta suhu lemari pendingin di depo farmasi, gudang farmasi, dan ruang pencampuran obat (LAF) oleh apoteker setiap hari.
- Supervisi Kains secara berkala dan mempertahankan kinerja yang sudah berjalan dengan baik

3. Pemantauan Terapi Obat (PTO) : supervisi secara berkala

4. Kejadian Efek Samping Obat

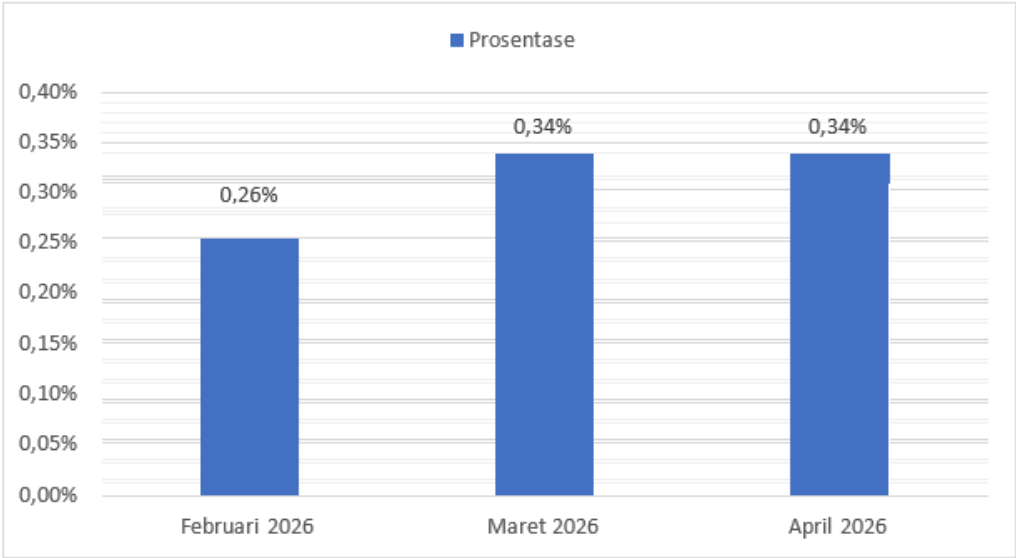
- Kolaborasi dengan komite medik, kepala bidang keperawatan, kepala bidang pelayanan medis untuk sosialisasi pentingnya pelaporan kejadian efek samping obat, alergi obat, interaksi obat, dan ROTD oleh tenaga kesehatan.
- Monitoring Efek Samping Obat (MESO) dan Pemantauan Reaksi Obat Tidak Dikehendaki (ROTD) dilaksanakan secara kolaboratif antara dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, ditulis di dalam dokumen rekam medik pasien dan dilaporkan selambat - lambatnya 1 x 24 jam dalam bentuk laporan MESO dan dicatat dalam status pasien.
- Mendeteksi adanya kejadian reaksi obat yang tidak dikehendaki (ESO).
- Mengidentifikasi obat-obatan dan pasien yang mempunyai risiko tinggi mengalami ESO.
- Menganalisa laporan ESO.
- Mengisi formulir ESO (lihat di lembar pelaporan ESO).

- Melaporkan ke Tim MESO dan ROTD.
 - Konsul ke DPJP terkait keluhan pasien dan advice DPJP obat di stop.
5. Edukasi Obat pada pasien dan keluarga : Supervisi berjenjang terkait pelaksanaan edukasi obat di rawat inap dan rawat jalan.
 6. Konseling : Supervisi berjenjang terkait pelaksanaan konseling di rawat inap dan rawat jalan.
 7. Pemantauan Kadar Obat Dalam Darah : Tidak dilakukan di RS.
 8. Visite Ronde Besar
Koordinasi dengan PPA (Professional Pemberi Asuhan) agar dilakukan visite ronde besar.
 9. Visite Pasien/ Farmasi Klinik : Supervisi berjenjang terkait pelaksanaan visite pasien di rawat inap.
 10. Pelayanan Informasi Obat (PIO)
Map informasi obat, MIMS, aplikasi medscape sudah tersedia di unit pelayanan, dan e-book yang tersedia di SIMRS.
 11. Obat tertinggal yang tidak diambil pasien
 - Farmasi tiap hari menghubungi pasien jika sudah melewati 1x24 jam obat ditinggal untuk mengurangi penumpukan obat tertinggal.
 - Kebijakan pengambilan obat maksimal 2x24 jam menghindari penumpukan obat tertinggal yang mengakibatkan retur penjualan.
 - Mengadakan promo pelayanan pengantaran obat untuk pengguna baru.

Tabel Kekosongan Obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Prima Husada

No	Tanggal	Nama Obat	Golongan Obat	Distributor	Tindak Lanjut
1	1/02/2026-28/02/2026	Borraginol-N Suppositoria	Hemoroid	PT. United Dico Citas	Substitusi Superhoid suppositoria
2	1/02/2026-28/02/2026	Borraginol-S Suppositoria	Hemoroid	PT. United Dico Citas	Substitusi Superhoid suppositoria
3	1/02/2026-28/02/2026	Pramivex 0.125 mg	Anti parkinson	PT. Antar Mitra Sembada	Substitusi Pramivex 0.25 mg
4	23/02/2026-25/02/2026	Hydrochlorotiazide tab 25 mg	Diuretik	PT. Kimia Farma	Tanpa saran substitusi
Total prosentase Februari 2026 = 0.27%					
1	01/03/2026-31/03/2026	Borraginol-N Suppositoria	Hemoroid	PT. United Dico Citas	Substitusi Superhoid suppositoria
2	01/03/2026-31/03/2026	Borraginol-S Suppositoria	Hemoroid	PT. United Dico Citas	Substitusi Superhoid suppositoria
3	01/03/2026-31/03/2026	Pramivex 0.125 mg	Anti parkinson	PT. Antar Mitra Sembada	Substitusi Pramifrol 0.375 mg
4	01/03/2026-31/03/2026	Pramivex 0.25 mg	Anti parkinson	PT. Antar Mitra Sembada	Substitusi Pramifrol 0.375 mg
Total prosentase Maret 2026 = 0.34%					
1	01/04/2026-30/04/2026	Borraginol-N Suppositoria	Hemoroid	PT. United Dico Citas	Substitusi Superhoid suppositoria
2	01/04/2026-30/04/2026	Borraginol-S Suppositoria	Hemoroid	PT. United Dico Citas	Substitusi Superhoid suppositoria
3	01/04/2026-30/04/2026	Pramivex 0.125 mg	Anti parkinson	PT. Antar Mitra Sembada	Substitusi Pramifrol 0.375 mg
4	01/04/2026-30/04/2026	Pramivex 0.25 mg	Anti parkinson	PT. Antar Mitra Sembada	Substitusi Pramifrol 0.375 mg
Total prosentase April 2026 = 0.34%					

1.2.1.11 Grafik Kekosongan Obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Prima Husada Februari - April 2026



Analisis :

- 1) Hasil monitoring ketersediaan obat selama 3 bulan ditemukan kekosongan di distributor karena kekurangan bahan baku, delisting produk (pabrik tidak produksi), stok Pramivex 0,125 mg dan Pramivex 0.25 mg di distributor habis, kekosongan produk originator, dan kosong nasional seperti Borraginol-N Suppositoria dan Borraginol-S Suppositoria (produk paten originator) sehingga tidak tersedia di pabrik lain dengan kandungan yang sama.RS belum bisa melakukan pembelian lewat e-purchasing sehingga belum bisa order obat fast moving khusus obat kronis.
- 2) RS belum bisa melakukan pembelian lewat e-purchasing sehingga belum bisa order obat fast moving khusus obat kronis.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Evaluasi mutu perjanjian kerjasama dengan distributor untuk memberikan konfirmasi apabila stok barang tidak tersedia di distributor setelah menerima pesanan dari RS.
- 2. Mencari substitusi obat lain yang isi/ kandungannya sama.
- 3. Evaluasi stok minimal depo farmasi dan Gudang farmasi serta alur pengadaan.
- 4. RS sudah mempunyai akun e-purchasing dan koordinasi dengan pengadaan terkait e-purchasing.
- 5. Memberitahukan info kekosongan obat di distributor ke DPJP melalui surat edaran beserta saran substitusi.

1.2.1.12 Tabel Pemusnahan Obat, BMHP/ Alat Kesehatan Rusak (Substandar), dan Recall Bulan April 2026

No	Kegiatan	Nama Obat/ BMHP/ Alat Kesehatan	Jumlah	Alasan	Keterangan
1	Pemusnahan Obat	Isoniazid tab	120+20	No. Batch : B40616N;	Pemusnahan obat TB dilakukan pada tanggal 05 Maret 2026 di spoel hook laboratorium sudah dibuatkan Berita Acara Pemusnahan Obat Dan Bahan Medis Habis Pakai Kedaluwarsa/ Rusak Nomor : 129.63/I-Bac/Ifrs/III/2026 dan dikirim ke dinkes kabupaten malang.
		300 mg -	216	ED : 02/2026	
		Hibah	160	No. Batch : B40360N;	
			120	ED : 02/2026	
			Total = 636	No. Batch : B40619N;	
				ED : 02/2026	
				No. Batch : B40617N;	
				ED : 02/2026	
		Ethambutol	66+224	No. Batch : T24D005;	
		tab 250 mg -	Total = 290	ED : 02/2026	
2	Obat/ BMHP Substandar/ Rusak	Plester anti air	Onemed	Plester bagian samping	Form keluhan dari IGD pada tanggal 30/04/2026. Saran ke pengadaan PT menggunakan plester anti air seperti di RS Prima
		Dermafix T 10	No. Batch:	mengelupas jadi air bisa	
		X 25 cm Type	01072588	rembes masuk. Banyak	
		A	(Jumlah)	kasus pasien datang ke	

			pasien lihat	IGD untuk mengganti	Husada Sukoreko yaitu Film
			Tabel 9.10)	plester kembali karna	Island Dressing 10x25 cm – SAG.
				mengelupas.	
3	Recall	-	-	-	Tidak ada recall

3.2.1.14 Tabel Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Farmasi Pada Bulan April 2026

No	Monitoring dan Evaluasi	Hasil	Tindak Lanjut
1	Perencanaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP	1. Perencanaan dilakukan dengan metode konsumsi dan rumus VEN-ABC. Perencanaan kebutuhan obat tahun 2026 dan 2027 sudah di approved oleh Dinas Kesehatan dan Kemenkes. 2. Ketidaksesuaian perhitungan perencanaan RKO tahun 2025 dengan realisasi pengadaan. 3. Evaluasi terhadap perencanaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP digudang farmasi menggunakan sistem ROP dan Non ROP farmasi di SIMRS, dikarenakan sistem ROP belum mendeteksi penjualan obat slow moving namun tetap harus disediakan jadi petugas mendata obat menipis secara manual kemudian diinput Non ROP farmasi.	Monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP menggunakan sistem ROP di gudang farmasi.
2	Pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP ke distributor	1. Pengadaan sediaan farmasi dan BMHP dengan pembelian langsung, repacking dan donasi/ hibah. 2. Tersedia PKS dengan distributor; 3. Semua pengadaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, termasuk obat vaksin harus menjamin garansi keaslian yakni : a. Sediaan farmasi - No.Ijin Edar dari BPOM b. Alkes - No.Ijin Edar dari Dirjen Binfar dan CoA c. BMHP - No ijin edar dari Binfar d. B3 - MSDS; 4. Kunjungan ke distributor; 5. Surat Pesanan obat, alkes, dan BMHP di tandatangan oleh APJ	Monitoring dan evaluasi terhadap pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP
3	Pemantauan suhu dan kelembaban ruangan serta suhu lemari pendingin	Form monitoring suhu dan kelembaban ruangan serta suhu lemari pendingin sudah tersedia namun petugas masih tidak rutin mengisi. Form monitoring suhu depo farmasi dan ruang pencampuran obat steril : https://drive.google.com/drive/folders/1XYh_AQhMkHwhOGCJ76IK4TQ4sewn7MHR Form monitoring suhu Gudang farmasi : https://drive.google.com/drive/folders/1Afz8-tngWZOA01zotU7Ju6TrzEje6OMF	Monitoring dan evaluasi pengisian monitoring suhu dan kelembaban ruangan serta suhu lemari pendingin di depo dan gudang farmasi oleh apoteker setiap hari

4	Supervisi box emergency, trolley emergency, kit emergency, box HPP dan Eklamsi	Bedah box triwulan 2 pada Bulan April Tahun 2026 sudah dilakukan. Lampiran pada tabel 9.11. Pelaksanaan supervisi dilakukan sebagai berikut : - Pengecekan segel, pengecekan kedaluwarsa di list daftar obat dan pengecekan suhu penyimpanan dilakukan setiap hari. - Pengecekan jumlah dan dipakai dilakukan saat segel terbuka. - Pengecekan obat yang mendekati ED (<i>expired date</i>) 6 bulan segera diganti dilakukan tiap 3 bulan sekali untuk mencegah kedaluwarsa saat dibutuhkan. - Tidak ada obat near ED < 6 bulan.	Dilakukan supervisi oleh apoteker terhadap penyimpanan obat dan bmhp <i>emergency</i> dan segera diganti apabila dipakai, kedaluwarsa, atau rusak.
5	Kartu stok obat	Kepatuhan penulisan kartu stok 70% di depo farmasi, petugas masih merapel pengeluaran kartu stok dan belum menulis sisa stok. Kepatuhan penulisan kartu stok 100% di gudang farmasi.	- Supervisi petugas farmasi dalam melakukan pelayanan (barang masuk dan keluar) dengan tetap menuliskan pada kartu stok - Petugas lebih teliti ketika menghitung pemasukan atau pengeluaran.
6	Penyimpanan bahan berbahaya dan beracun (B3)	Penyimpanan bahan berbahaya dan beracun di ruangan terpisah dan didalam lemari B3 tersedia APAR dan diberi label B3 sesuai sifat dan risiko bahan.	Monitoring dan evaluasi terhadap penyimpanan bahan berbahaya dan beracun (B3)
7	Penyimpanan produk steril di unit	- Ditemukan perawat menyimpan sisa infus NS 0.9% dan sisanya digunakan kembali besok hari (lebih dari 1x24 jam) sehingga melewati batas BUD.	Supervisi secara berkala dan edukasi ke perawat BUD produk steril tidak boleh lebih dari 3 jam
8	Pelaksanaan double check untuk pemberian obat high alert	● Rawat inap : Double check obat dan bmhp resep ODD (One Daily Dose) dilakukan oleh farmasi sebelum distribusi ke ruangan rawat inap. Pelaksanaan double check obat high alert secara independen menggunakan resep dan daftar pemberian obat (DPO) antara farmasi dan perawat/ bidan. Perawat/ bidan penerima obat melakukan double check secara independen dengan PJ Shift/ kepala ruang menggunakan daftar pemberian obat (DPO) sebelum obat diserahkan/ disuntikkan ke pasien secara UDD (Unit Dose Dispensing). ● Rawat Jalan : Pelaksanaan double check obat high alert secara independen menggunakan resep antara petugas verifikasi dan petugas penyerah sebelum obat diserahkan ke pasien.	Supervisi secara berkala terkait pelaksanaan double check obat high alert di rawat inap dan rawat jalan

1.2.2. Laboratorium

Tabel Jumlah Pemeriksaan Laboratorium

Jenis Pemeriksaan	Targ et	Feb 26	Prosentase terhadap Bulan Sebelumnya (%)	Mar 26	Prosentase terhadap Bulan Sebelumnya (%)	Apr 26	Prosentase terhadap Bulan Sebelumnya (%)	Prosentase terhadap Target (%)
HEMATOLOGI	1950	1506	↓8,7%	1427	↓5,2%	1727	↑17,3%	↓11,44%
FAAL HEMOSTASIS	716	733	↓9,9%	710	↓3,1%	823	↑13,7%	↑14,94%
HEMATOLOGI LAIN	1	4	↑50%	0	↓>100%	1	↑100%	0%
URINALISIS	418	261	4,04%	232	↓11,1%	278	↑16,5%	↓33,49%
ANALISA FEACES	30	14	↑50%	22	↑36,3%	17	↓ 22,7	↓43,33%
FUNGSI HATI	611	278	2,89%	281	↑1,0%	397	↑29,2%	↓35,02%
LEMAK DARAH	806	740	5,4%	744	↑0,5%	828	↑10,14%	↑2,73%
GINJAL HIPERTENSI	1394	1394	↑18,0%	1257	↑9,8%	1570	↑19,9%	↑12,63%
GULA DARAH	1187	2120	↑10,6%	2080	↓1,18%	2662	↑21,8%	↑>100%
JANTUNG	583	500	↓20,5	515	↑2,9%	669	↑23,0%	↑14,75%
ELEKTROLIT DAN BGA	334	196	↓14,7	176	↓10,2%	242	↑27,27%	↓27,54%
IMUNO SEROLOGI	481	171	↓20,8	137	↓19,8%	165	↑16,9%	↓65,70%
REMATIK	6	8	↓37,5	4	↓50%	3	↓25%	↓50,00%
ENDOKRINOLOGI	60	71	13%	44	↓38,0	81	↑46,6%	↑35,00%
REPRODUKSI	44	60	↓38,7%	47	↓21,6	32	↑31,9%	↓27,27%
MIKROBIOLOGI	32	34	↓31,8	43	↑20,9	56	↑23,2%	↑75,00%
Jumlah	8654	8090	↓12,55	7719	↓4,5%	9551	↑23,7%	↑10,37%

Analisis :

Jumlah pemeriksaan laboratorium pada bulan April 2026 secara keseluruhan mengalami peningkatan sebanyak 23,75% dibandingkan dengan bulan Maret 2026 dan dibandingkan dengan target terdapat peningkatan jumlah pemeriksaan 10,37% dari target. Hal tersebut sejalan dengan adanya peningkatan jumlah kunjungan pasien pada bulan ini. Peningkatan terbanyak terjadi pada pemeriksaan endokrinologi dengan peningkatan sebanyak 46%. Hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan pasien dengan kasus hormonal dan metabolic. Sedangkan jika dibandingkan dengan target yang dimiliki oleh unit laboratorium, peningkatan terbanyak terjadi pada pemeriksaan gula darah yang meningkat melebihi 100% karena pada saat ini sudah dijalankan penertiban inputan pemeriksaan gula darah terutama POCT. Sedangkan penurunan pemeriksaan terjadi pada jenis pemeriksaan rematik dimana mengalami penurunan 25% dapat dikarenakan menurunnya kasus pasien serupa dan adanya alternative pemeriksaan lain yang bias dilakukan dan dirasa lebih efektif.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Melakukan monitoring dan evaluasi tren pemeriksaan secara berkala.
- 2. Memastikan penyebab meningkat dan menurunnya jumlah pemeriksaan bukan dikarenakan factor internal unit seperti kehabisan reagen dan kerusakan alat.
- 3. Monitoring ketersediaan reagen, kesiapan alat, dan sdm sesuai kebutuhan.
- 4. Menjaga mutu pelayanan laboratorium terkait ketepatan hasil dan monitoring adanya keterlambatan pelayanan.
- 5. Meningkatkan jejaring pemeriksaan melalui kegiatan MCU koordinasi dengan humas marketing.

2.2.2.1 Pelaporan Kerusakan Sampel pada Bulan April 2026

No	Tanggal	No RM	Unit	Jenis Specimen	Pemeriksaan	Alasan Kerusakan	Tindakan
1	1/4/2026	247139	IGD	Darah	DL	CLOTING	Sampling ulang
2	2/4/2026	039156	5C	Darah	PTT, KPTT	CLOTING	Sampling ulang
3	15/4/2026	246947	8A	Darah	PTT, KPTT	CLOTING	Sampling ulang
4	15/4/2026	210044	IGD	Darah	DL	CLOTING	Sampling ulang
5	18/4/2026	248014	IGD	Darah	DL	CLOTING	Sampling ulang
6	20/4/2026	234642	2C	Darah	SE	LYSIS	Sampling ulang
7	20/4/2026	081065	2C	Darah	PTT, KPTT	SAMPEL KURANG	Sampling ulang
8	20/4/2026	234642	2C	Darah	SE	LYSIS	Sampling ulang
9	24/4/2026	242893	ICU	Darah	PTT, KPTT	SAMPEL KURANG	Sampling ulang
10	29/4/2026	241558	IGD	Darah	SE	LYSIS	Sampling ulang
11	30/4/2026	102422	IGD	Darah	DL	CLOTING	Sampling ulang

Analisis :

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah kerusakan sampel pada bulan April cukup banyak sebanyak 11 sampel dimana semuanya pada jenis specimen darah. Dimana terjadi 3-4 kali pada pasien yang berbeda pada pemeriksaan SE, DL, PTT-KPTT dengan kerusakan terbanyak karena clotting. Sedangkan unit yang paling sering terjadi kerusakan sampel adalah unit IGD, hal tersebut dapat dikarenakan karena teknik pengambilan sampel yang kurang, pencampuran antikoagulan yang tidak tepat dan mungkin juga pada proses pengiriman sampel yang tidak tepat. Selain itu, factor kondisi pembuluh darah yang sulit yang menyebabkan kekurangan jumlah sampel yang diambil. Adanya kerusakan ini dapat menyebabkan terjadinya keterlambatan hasil dan mengurangi kepuasan pasien karena harus disampling ulang.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Koordinasi dengan komite keperawatan terkait skill dan kemampuan perawat yang melakukan kegiatan pengambilan sampel darah.
- 2. Monitoring kondisi tabung dengan antikoagulan dalam keadaan baik.
- 3. Melakukan resosialisasi pada petugas unit terkait penanganan sampel darah saat setelah sampling sampai pengantaran.
- 4. Melakukan pencatatan dan pelaporan sampel rusak untuk dilakukan rencana tindak lanjut berikutnya.

1.2.2.2 Jumlah Pemeriksaan Patologi Klinik (Permeriksaan Rujukan)

No	Golongan PA	Februari 2026	Maret 2026	April 2026	Prosentase terhadap bulan sebelumnya
1	PA Golongan 1	2	7	9	↑28,57%
2	PA Golongan 2	0	1	5	↑100%
3	PA Golongan 3	79	53	103	↑94,33%
4	Total	81	61	126	↑>100%

Analisis:

Dari table diatas, tampak peningkatan yang sangat signifikan pada pemeriksaan PA golongan 3 dan PA golongan 2. Hal ini sejalan dengan adanya peningkatan pasien operasi pada bulan ini.

Rencana Tindak Lanjut:

- 1. Monitoring dan evaluasi tren pemeriksaan secara berkala.
- 2. Menjaga mutu pelayanan laboratorium terkait ketepatan hasil dan monitoring adanya keterlambatan pelayanan.
- 3. Meningkatkan jejaring pemeriksaan melalui kegiatan MCU koordinasi dengan humas marketing.

1.2.2.3 Permintaan Labu Darah pada Bank Darah Rumah Sakit

No	Bulan	Permintaan Labu darah				Total Permintaan Labu darah
	Golda	A	AB	O	B	
1	Januari	21	6	24	29	80
2	Februari	16	27	37	7	87
3	Maret	33	11	57	40	141
4	April	15	32	30	7	84

Catatan: Tidak ada hasil incompatible crossmatch pada Bulan April 2026

Tabel Jumlah Permintaan Return Labu Darah April 2026

No	Bulan	Permintaan Return Labu darah				Total Permintaan Labu darah
	Golda	A	AB	O	B	
1	Januari	4	1	4	2	11
2	Februari	2	6	0	0	8
3	Maret	14	11	20	20	65
4	April	-	2	4	-	6

Analisis:

Terjadi penurunan kebutuhan labu darah pada April 2026 terutama pada golongan darah B. Dari total keseluruhan juga mengalami penurunan diikuti dengan menurunnya kasus pasien dengan kebutuhan transfuse darah. Begitu juga dengan permintaan return labu darah juga mengalami penurunan pada bulan ini hanya sejumlah 6 labu pada golongan darah AB dan O.

Rencana Tindak Lanjut:

1. Buat aturan stok minimal pada bank darah dengan melihat rata-rata permintaan labu darah tiap bulannya pada tiap golongan darah.
2. Monitoring stoknya jangan sampai ada kekosongan yang menyebabkan keterlambatan pelayanan.
3. Pertahankan mutu kualitas pengambilan sampel darah dan proses crossmatch agar tidak terjadi hasil incompatible.
4. Memastikan proses crossmatch dan identifikasi identitas saat pemberian labu darah sesuai.

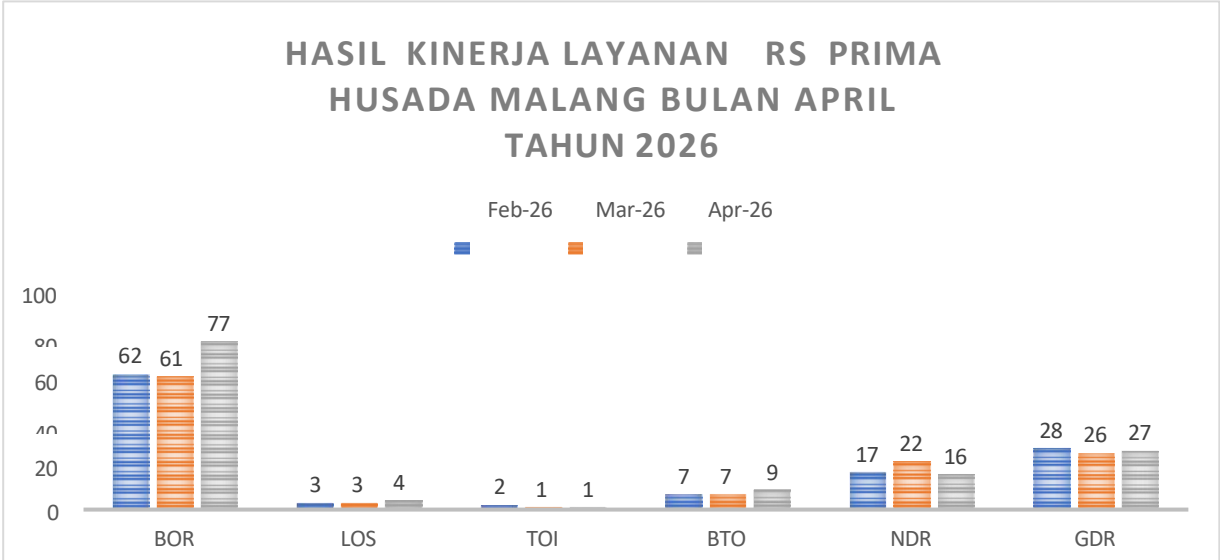
3.2.3 Rekam Medis – Pendaftaran

Tabel Kinerja Unit Rawat Inap Bulan April 2026

Indikator	Keterangan	Rumus	Data	Standar Depkes	Laporan	Ruang													
						LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	MTS	NICU	HCU	ICU	TOTAL
BOR (Bed Occupancy Rate)	Prosentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu	$(\sum HP/(\sum TT \times \text{jumlah hari dalam satu periode})) \times 100$	Jumlah hari perawatan, jumlah TT, jumlah hari dalam satu periode	60 - 80 %	Februari	60	46	13	65	72	54	74	77	80	65	52	57	26	62
					Maret 26	44	59	0	60	54	56	70	59	62	63	32	56	27	61
					April 26	62	61	32	70	78	68	87	76	87	71	20	53	39	77
ALOS (Average Length of Stay)	Rata-rata lama rawat seorang pasien	$LD / \sum px \text{ keluar (H+M)}$	jumlah lama dirawat, jumlah pasien keluar	6 - 9 hari	Februari 26	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	2	3
					Maret	3	4	0	2	3	3	3	3	3	2	3	4	5	3
					April 26	3	3	4	3	4	4	4	4	4	7	5	3	3	4
TOI (Turn Over Interval)	Rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati	$((\sum TT \times \sum \text{hari}) - HP) / \sum \text{pasien keluar (H+M)}$	Jumlah tempat tidur, hari perawatan, pasien keluar	1 - 3 hari	Februari 26	2	3	1	2	1	2	1	1	1	1	3	2	5	2
					Maret 26	3	1	0	1	1	1	0	1	1	0	10	0	6	1
					April 26	1	2	5	1	1	1	0	1	0	4	5	1	10	1
BTO (Bed Turn Over)	Frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode	$\sum Px \text{ keluar (H+M)} / \sum TT$	jumlah pasien. Jumlah TT	4 - 5 kali	Februari	6	5	1	6	8	6	8	8	8	9	5	5	4	7
				(dalam hitungan bulan)	Maret 26	5	5	0	8	6	6	8	7	7	11	2	4	3	7
					April 26	8	8	5	9	9	8	9	8	9	4	3	11	.3	9
	Angka kematian 48		Jumlah		Februari	21	0	0	0	16	21	10	0	0	0	276	300	0	17

NDR (Net Death Rate)	jam setelah dirawat untuk setiap 1000 penderita keluar rumah sakit	$(\sum Px \text{ Mati } >48\text{jm}) / \sum Px \text{ keluar (H+M))} \times 1000\%$	pasien meninggal >48jm, jumlah pasien keluar	<25‰															
					Maret	0	0	0	0	10	32	22	0	23	0	0	0	684	22
					April 26	0	11	0	0	14	17	28	0	10	0	625	0	0	16
GDR (Gross Death Rate)	Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar rumah sakit	$(\sum Px \text{ mati } / \sum Px \text{ keluar (H+M))} \times 1000\%$	Jumlah pasien keluar mati, jumlah pasien keluar	<45‰	Februari	21	0	0	0	16	31	21	0	11	0	379	600	111	28
					Maret 26	0	0	0	0	10	32	22	12	23	0	842	0	0	26
					April 26	16	22	0	0	14	17	36	0	20	125	750	0	0	27

3.1.1.1 Grafik Kinerja Unit Rawat Inap Bulan April 2026



INDIKATOR	ANALISA	MASALAH	RTL (RENCANA TINDAK LANJUT)
BOR Total 77%	Pemanfaatan TT baik, masih dalam standar ideal 60–85%	Beberapa ruangan overload, beberapa ruangan rendah okupansi	Redistribusi pasien antar unit, evaluasi kelas/peruntukan kamar
ALOS Total 4 hari	Lama rawat relatif singkat	Kemungkinan dominan kasus ringan / pulang cepat / one day care	Evaluasi case mix dan clinical pathway
TOI Total 1 hari	Pergantian TT sangat cepat, efisien	Turnover tinggi dapat membebani cleaning & admisi	Perkuat koordinasi discharge planning dan housekeeping
BTO Total 9/bln	Frekuensi pemakaian TT tinggi	Beban kerja perawat tinggi pada unit sibuk	Penyesuaian SDM dan monitoring mutu pelayanan
NDR 16‰	Mortalitas setelah >48 jam masih perlu perhatian	Kasus berat / keterlambatan penanganan / komplikasi	Audit kematian, review manajemen kasus
GDR 27‰	Mortalitas umum masih di atas target ideal	Banyak pasien datang kondisi berat	Tingkatkan early warning system & rujukan cepat
3A BOR 32%	Utilisasi tempat tidur rendah	Bed tidak optimal terpakai	Evaluasi fungsi ruangan, promosi layanan, regrouping bed
NICU BOR 20%	Pemanfaatan sangat rendah	Kasus bayi rawat intensif sedikit / rujukan rendah	Bangun jejaring rujukan maternal-neonatal
ICU BOR 39% + GDR tinggi	Occupancy rendah namun kematian sangat tinggi	Pasien masuk kondisi kritis berat	Audit ICU, triase, respon cepat, evaluasi ventilator/sepsis bundle
6A & 8A BOR 87%	Hunian sangat tinggi	Risiko penuh, waiting list, infeksi nosokomial	Tambah TT / buka buffer room / percepat discharge planning
4A BOR 78%	Baik dan stabil	Perlu monitoring bila tren naik	Pertahankan mutu layanan
MTS BTO 11	Turnover sangat tinggi	Pasien singkat/rawat cepat	Pastikan administrasi & cleaning cepat
TOI beberapa unit = 0	Bed langsung terisi kembali	Tidak ada waktu persiapan bed	Perkuat bed management system

3.1.1.2 Tabel Diagnosa Terbanyak Rawat Jalan Bulan April 2026

NO	CODE ICD 10	DIAGNOSIS	JUMLAH
1	E11.4	With neurological complications	475
2	I51.9	Decomp Cordis / Heart disease, unspecified	330
3	E11.9	DM Tanpa komplikasi / Without complications	298
4	I25.9	Chronic ischemic heart disease, unspecified	269
5	I11.9	HHD / Hypertensive heart disease without (congestive) heart failure	263
6	I63.9	CVA Infark / Cerebral infarction, unspecified	241
7	K04.1	Necrosis of pulp	220
8	F41.2	Mixed anxiety and depressive disorder	208
9	A09.9	Gastroenteritis and colitis of unspecified origin	191
10	R10.4	Colic Abdomen / Other and unspecified abdominal pain	187

3.1.1.1 Tabel Diagnosa Rawat Inap Bulan April 2026

NO	KODE	DIAGNOSA	TOTAL
1.	A09.9	Gastro Enteritis Acute	67
2.	I63.9	Cerebro Vaskuler Accident Infark	61
3.	J18.9	Pneumonia	47
4.	E14.9	DM Hyperglikemia	31
5.	J44.9	Chronic Obstructive Pulmonary Disease	25
6.	A90	Dengue Fever	21
7.	K80.8	Cholelithiasis	20
8.	N40	Benign Prostatic Hyperplasia	18
9.	N20.0	Nephrolithiasis	16
10.	M72.6	Necrotizing Fascitis	15

Analisis :

Berdasarkan data 10 besar diagnosa, kasus terbanyak adalah Gastro Enteritis Acute (67 kasus) diikuti Cerebro Vaskuler Accident (CVA) Infark (61 kasus) dan Pneumonia (47 kasus). Hal ini menunjukkan dominasi kasus penyakit infeksi saluran cerna, penyakit degeneratif/kardiovaskular, serta infeksi saluran napas.

Kasus DM Hyperglikemia (31 kasus) dan Chronic Obstructive Pulmonary Disease/COPD (25 kasus) menandakan tingginya penyakit kronis yang memerlukan pengelolaan jangka panjang. Selain itu terdapat kasus bedah dan urologi seperti Cholelithiasis, BPH, Nephrolithiasis, yang menunjukkan kebutuhan layanan spesialis bedah dan urologi cukup tinggi.

Kasus Dengue Fever (21 kasus) mengindikasikan masih adanya penyakit musiman/endemis yang perlu diwaspadai. Sedangkan Necrotizing Fascitis (15 kasus) termasuk kasus berat yang membutuhkan penanganan cepat dan multi disiplin

Rencana Tindak Lanjut :

1. Peningkatan Promotif Preventif
 - Edukasi PHBS, cuci tangan, keamanan makanan, dan sanitasi.
 - Penyuluhan pencegahan pneumonia dan vaksinasi bila diperlukan.
2. Program Penyakit Kronis
 - Skrining hipertensi, diabetes, kolesterol, dan faktor risiko stroke.
 - Edukasi berhenti merokok dan pengelolaan COPD.
 - Optimalisasi program kontrol rawat jalan kronis.
3. Peningkatan Pelayanan Klinis

-
- Menyiapkan SDM dan sarana untuk kasus bedah, urologi, dan emergensi.
 - Memastikan ketersediaan obat, oksigen, ventilator, dan alat diagnostik.
4. Pengendalian DBD
- Koordinasi dengan puskesmas terkait edukasi masyarakat di masyarakat.
 - Surveilans kasus secara berkala.
5. Monitoring Evaluasi
- Analisis tren 10 besar diagnosa tiap bulan.
 - Evaluasi LOS, BOR, angka rujukan, dan mortalitas untuk perbaikan layanan.

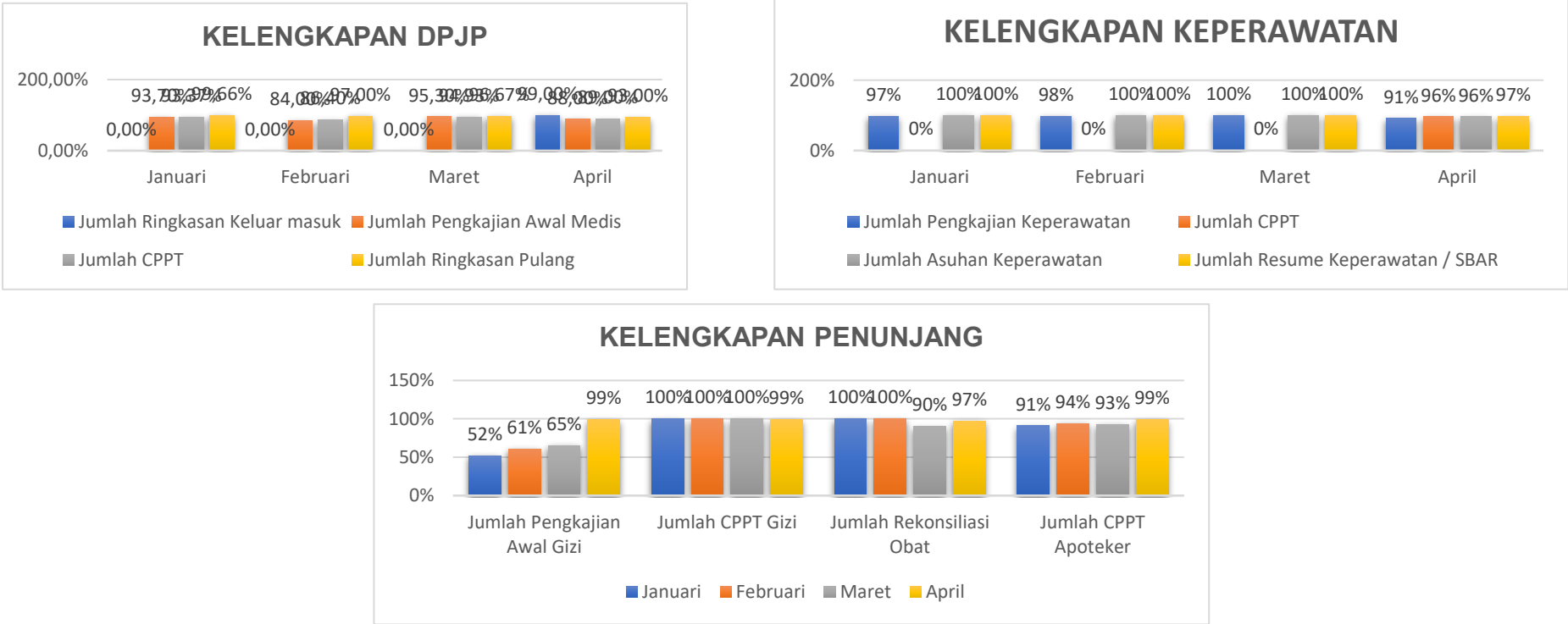
3.1.1.2 Audit Harian Dokumen Rekam Medis Rawat Inap Maret 2026

KELENGKAPAN																
DPJP																
BULAN	Ringkasan Keluar Masuk				Pengkajian Awal Medis				CPPT				Ringkasan Pulang			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Januari	-	-	-	-	1090	93,70	61	6,30	1080	93,37	69	5,16	1147	99,66	4	0,34
Februari	-	-	-	-	920	84	119	16%	929	86,4	110	13,6	1005	97	34	3
Maret	-	-	-	-	1001	95,30	54	16	1000	94,93	55	5,07	1031	96,67	24	,33
April	1244	99	12	1	1070	88	149	12	1113	89	142	11	1162	93	94	7
Mei																
Juni																
Juli																
Agustus																
September																
Oktober																

KELENGKAPAN																
PERAWAT																
BULAN	Pengkajian Keperawatan				CPPT				Asuhan Keperawatan				Resume Keperawatan / SBAR			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Januari	1013	97,18	38	2,82	-	-	-	-	1051	100	0	0	1051	100	0	0
Februari	1008	98	27	2	-	-	-	-	1034	100	2	0,3	1036	100	0	0
Maret	1047	100	7	0	-	-	-	-	1043	100	11	0	1054	100	0	0
April	1148	91	107	9	1203	96	52	4	1203	96	52	4	1220	97	35	3
Mei																
Juni																
Juli																
Agustus																
September																
Oktober																

KELENGKAPAN																
BULAN	AHLI GIZI								APOTEKER							
	Pengkajian Awal Gizi				CPPT				Rekonsialisasi Obat				CPPT			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Januari	556	52	484	48	1040	100	0	0	1133	100	0	0	1010	91	123	9
Februari	528	61	398	39	926	100	0	0	1027	100	0	0	965	94	62	6
Maret	587	65	341	35	927	100	1	0,07	1034	90	13	10	291	33	756	67
April	564	99	99	3	1130	99	11	1	1206	97	42	3	1171	99	13	1
Mei																
Juni																
Juli																
Agustus																
September																
Oktober																

3.1.1.6 Grafik Audit Harian Dokumen Rekam Medis Rawat Inap Bulan April 2026



Analisis :

- 1. Kelengkapan rekam medis mengalami fluktuasi pada beberapa unit. Bulan April menunjukkan:
- 2. Peningkatan signifikan pada Ahli Gizi dan Apoteker, namun terjadi penurunan pada DPJP dan sebagian dokumentasi perawat.
- 3. Area yang masih perlu perhatian:
- 4. Pengkajian Awal Medis DPJP, CPPT DPJP, CPPT Apoteker,
- 5. Pengkajian Keperawatan bulan April.

Faktor penyebab kemungkinan: beban kerja tinggi, kedisiplinan dokumentasi, keterlambatan pengisian, kurangnya monitoring harian, belum optimalnya evaluasi oleh kepala ruangan/komite medis.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Sosialisasi kelengkapan rekam medis dan ketepatan pengisian CPPT.
- 2. Monitoring dan evaluasi kelengkapan berkas setiap bulan.
- 3. Reminder kepada DPJP untuk melengkapi berkas sebelum pasien pulang koordinasi dengan karu dan kabisid pelayanan.
- 4. Supervisi rutin pengisian dokumentasi keperawatan.
- 5. Meningkatkan kepatuhan pengisian asesmen dan SBAR secara real time.
- 6. Audit internal kelengkapan rekam medis oleh kepala ruangan.
- 7. Mempertahankan kepatuhan pengkajian awal gizi.
- 8. Monitoring kelengkapan asesmen pasien baru.
- 9. Evaluasi rutin keterlambatan dokumentasi gizi.
- 10. Monitoring harian pengisian CPPT farmasi dan rekonsiliasi obat.
- 11. Evaluasi penyebab ketidaklengkapan dokumentasi.
- 12. Optimalisasi kepatuhan dokumentasi pelayanan farmasi klinis.

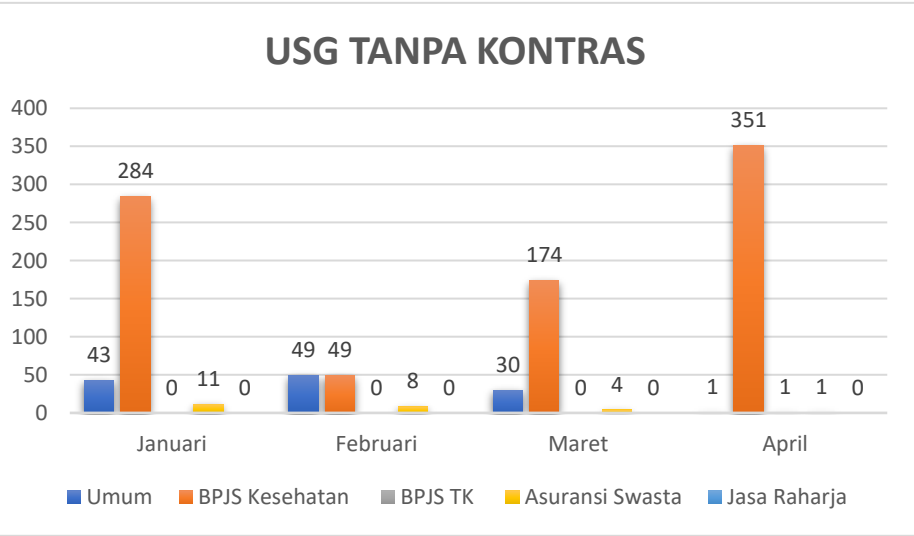
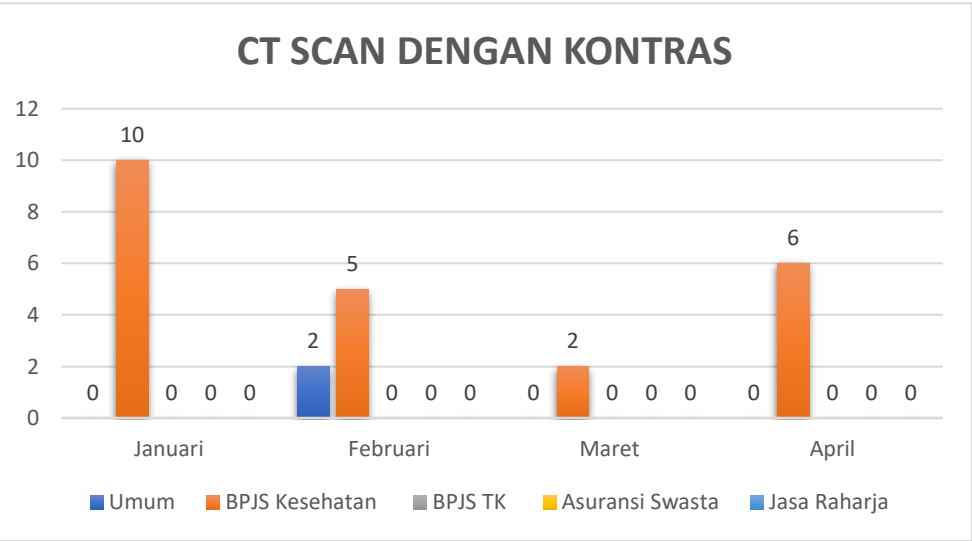
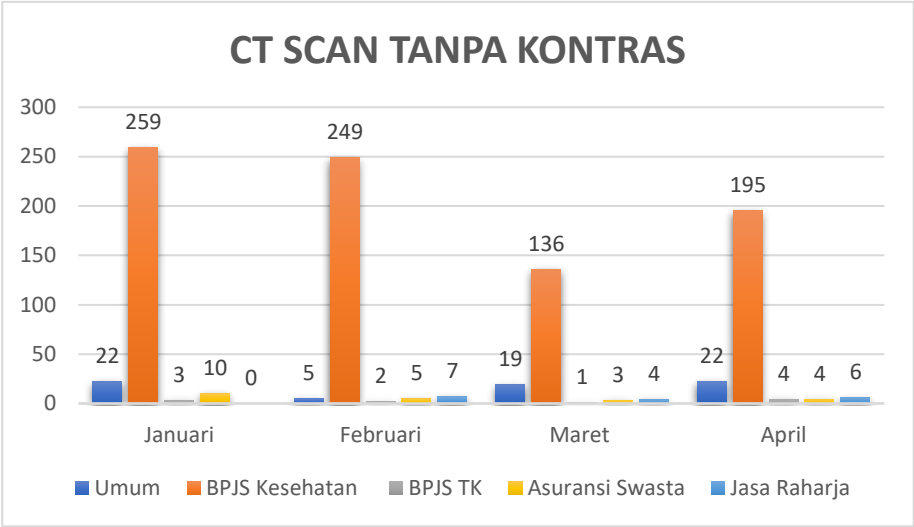
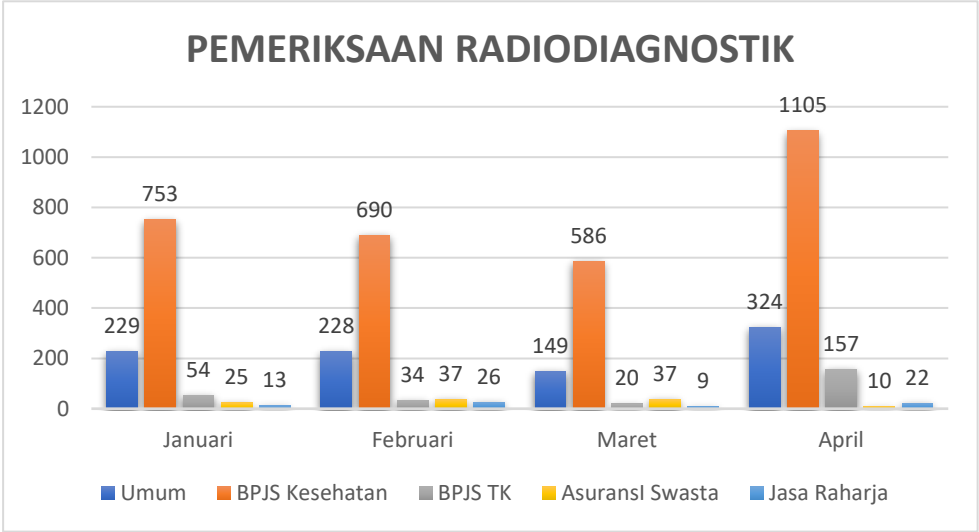
1.2.4 Radiologi

1.2.4.1 Tabel Jumlah Pemeriksaan Radiologi April 2026

NO	JENIS PEMERIKSAAN	PENJAMIN	BULAN		
			FEB	MAR	APR
1.	RADIODIAGNOSTIK	UMUM	228	149	324
		BPJS KESEHATAN	690	586	1105
		BPJS TK	34	20	157
		ASURANSI SWASTA	37	37	10
		JASA RAHARJA	26	9	22
		TOTAL	1.074	1.015	1589
2.	CT SCAN TANPA KONTRAS	UMUM	5	19	22
		BPJS KESEHATAN	249	136	195
		BPJS TK	2	1	4
		ASURANSI SWASTA	5	3	4
		JASARA HARJA	7	4	6
		TOTAL	294	268	231
3.	CT SCAN DENGAN	UMUM	2	0	0

	KONTRAS	BPJS KESEHATAN	5	2	6
		BPJS TK	0	0	0
		ASURANSI SWASTA	0	0	0
		JASARAHARJA	0	0	0
	TOTAL		10	7	6
4.	USG TANPA KONTRAS	UMUM	49	30	1
		BPJS KESEHATAN	249	174	351
		BPJS TK	0	0	1
		ASURANSI SWASTA	8	4	1
		JASARAHARJA	0	0	0
	TOTAL		338	304	354

1.2.4.2 Grafik Jumlah Pemeriksaan Radiologi April 2026



Analisis :

Bulan April 2026 produktivitas radiologi pada pemeriksaan radiodiagnostik sejumlah 1589 pasien. Terbagi menjadi pasien Umum, BPJS, Asuransi dan MCU. Hal ini mengalami kenaikan di bandingkan pada bulan Maret 2026 sebanyak 574 pasien.

Pada pemeriksaan CT-Scan sejumlah 237 pasien. Terbagi menjadi pasien Umum, BPJS, dan Asuransi. Hal ini mengalami kenaikan di bandingkan pada bulan Maret 2026 sebanyak 138 pasien.

Pada pemeriksaan USG sejumlah 354 pasien. Terbagi menjadi pasien Umum, BPJS, Asuransi dan MCU. Hal ini mengalami peningkatan di bandingkan pada bulan Maret 2026 sebanyak 50 pasien.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Melakukan monitoring rutin terhadap peningkatan jumlah pemeriksaan radiologi setiap bulan untuk memastikan pelayanan tetap optimal.
 2. Mengoptimalkan penjadwalan pemeriksaan radiodiagnostik, CT-Scan, dan USG guna mengurangi waktu tunggu pasien.
 3. Memastikan kesiapan alat radiologi melalui pemeliharaan dan kalibrasi berkala agar pelayanan tidak terganggu.
 4. Meningkatkan koordinasi antara petugas radiologi, dokter pengirim, dan unit terkait untuk memperlancar alur pelayanan pasien.
 5. Evaluasi kebutuhan SDM radiologi sesuai peningkatan jumlah kunjungan dan pemeriksaan.
-
6. Memastikan kelengkapan administrasi dan input hasil pemeriksaan dilakukan tepat waktu.
 7. Mempertahankan mutu pelayanan dan ketepatan hasil pemeriksaan melalui monitoring indikator mutu radiologi secara berkala.

1.2.4.3 Tabel Laporan Ulang Hasil Tahun 2026

N O	NAMA DOKTER	NAMA PASIEN	BACAAN AWAL	BACAAN ULANG	TOTAL
Bulan Januari 2026					
1	dr. AgungSp.Rad (K)	Abd Salam	Brain Atrofi Senilis	Brain Atrofi senilis, Infark	1
2	dr. Rumbiyo Yudho Sp.rad	-	-	-	-
Bulan Februari 2026					
1	dr. AgungSp.Rad (K)	Damiasih / 135744	Infark akut di periventrike	Tambahan bacaan Hydrocefalus obstrukti	1
2	dr. Rumbiyo Yudho Sp.rad	M Danendra Al Hussen / 201495	Normal	Normal	1
Bulan Maret 2026					
1	dr. AgungSp.Rad (K)	Asiyo Waga/24520	Fraktur distal ulna dan radius	Tambahan bacaan keterlibatan intra articular (epiphyasis)	1
2	dr. Rumbiyo Yudho Sp.rad	Sumarmi/011074	Fractura caput Os Humerus sinistra.Dislokasi sendi(+)	Tambahan bacaan fraktur epiphisis	1
Bulan April 2026					
1	dr. Agung, Sp.Rad (K)	1. Gusti fardi/192214 2. Ummu aimanah/231796 3. Tasir/091111	Normal Normal Susp cerebritis	Infark sub akut Infark sub akut Cerebritis	3
2	dr. Rumbiyo Yudho Sp.rad	1. Ngadinem/125411 2. Rasmini/247707 3. Kasanah/248579	Cardiomegali Normal Bronchitis	Cardiomegali,Pneumonia Atelectasis Paru kiri. Kp Duplex	3

Analisis :

Untuk bulan April 2026 terdapat pembacaan ulang pemeriksaan ke radiologi. Hal ini disebabkan karena klinis tidak sesuai dengan kondisi pasien pada surat permintaan radiologi sehingga dokter radiolog kurang menambahkan hasil bacaan tersebut.

Secara umum ditemukan discrepancy pembacaan pada sebagian besar kasus dengan diagnose diatas. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan standardisasi interpretasi, diskusi kasus, dan evaluasi berkala untuk meningkatkan kesesuaian hasil pembacaan radiologi.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Kolaborasi dengan MOD dan Kabid Pelayanan jika ada complain DPJP untuk melaporkan ke Radiologi dan Kabid Penunjang Medis.
- 2. Kolaborasi dengan Kabid Pelayanan dan Kabid Keperawatan untuk melengkapi pemeriksaan klinis pada surat pengantar supaya dapat menunjang hasil pemeriksaan.
- 3. Melakukan evaluasi terhadap kualitas hasil imaging untuk memastikan gambar diagnostik optimal.
- 4. Meningkatkan komunikasi antara dokter radiologi dan dokter pengirim terkait kondisi klinis pasien.
- 5. Menyusun standar interpretasi dan pelaporan radiologi untuk mengurangi variasi pembacaan.
- 6. Melakukan pembelajaran kasus (case review) pada hasil dengan discrepancy signifikan sebagai bahan peningkatan mutu pelayanan radiologi.

1.2.4.4 Tabel Rata-Rata Respon Time Pembacaan Pemeriksaan Radiologi

1. dr.Agung Setyawan, Sp.Rad (K)

PEMERIKSAAN	RATA-RATA SELESAI PERIKSA (Menit)	RATA-RATA SELESAI PEMBACAAN (Menit)
Ro Thorax	00:02:40	00:15:00 (waktu efektif) 05:00:00 (diatas jam 12 malam)
Ro Vertabrae	-	-
Ro Ekstremitas	-	-
Ro Skull	-	-
USG	00:05:00	00:05:00
CT Scan Non kontas	00:05:00	00:30:00 (waktu efektif) 18:49:00 (diatas jam 12 malam)
CT Scan Kontras	00:15:00	00:25:00 (waktu efektif) 18:49:00 (diatas jam 12 malam)
Radiologi Cito	00:10:00	00:04:00 (waktu elektif) 00:25:00 (diatas jam 12 malam)

2. dr. Rumbiyo Yudho, Sp.Rad (K)

PEMERIKSAAN	RATA-RATA SELESAI PERIKSA (Menit)	RATA-RATA SELESAI PEMBACAAN (Menit)
Ro Thorax	00:03:04	0:10:00 (pada saat jam praktek) 24:00:00 (diluar jam praktek)
Ro Vertabrae	00:04:00	0:10:00 (pada saat jam praktek) 24:00:00 (diluar jam praktek)
Ro Abdomen	00:10:00	0:10:00 (pada saat jam praktek) 24:00:00 (diluar jam praktek)
Ro Ekstremitas	00:02:00	0:10:00 (pada saat jam praktek) 24:00:00 (diluar jam praktek)
RO Skull	00:02:00	0:10:00 (pada saat jam praktek) 24:00:00 (diluar jam praktek)
USG	00:05:00	00:10.00
CT Scan Non kontras	-	-
CT Scan Kontras	-	-
Radiologi Cito	00:10:00	0:15:00

Analisa :

Berdasarkan data rata-rata response time pembacaan pemeriksaan radiologi bulan April 2026, secara umum waktu penyelesaian pemeriksaan sudah cukup baik dan sesuai standar pelayanan pada jam efektif/praktek dokter. Pemeriksaan radiologi konvensional, USG, CT Scan, maupun pemeriksaan cito dapat diselesaikan dalam waktu relatif cepat.

- a. Pada dr. Agung Setyawan, Sp.Rad(K):
 - Waktu selesai pemeriksaan relatif cepat, terutama pada Ro Thorax, USG, dan CT Scan.
 - Waktu pembacaan pada jam efektif masih baik, yaitu: Ro Thorax ± 15 menit, USG ± 5 menit, CT Scan $\pm 25-30$ menit.
 - Namun terdapat keterlambatan pembacaan pada pemeriksaan yang dilakukan di atas jam 12 malam dengan response time mencapai ± 5 jam pada Ro Thorax dan ± 18 jam 49 menit pada CT Scan.
- b. Pada dr. Rumbiyo Yudho, Sp.Rad(K):
 - Waktu selesai pemeriksaan radiologi konvensional dan USG sudah baik.
 - Waktu pembacaan saat jam praktek rata-rata ± 10 menit dan masih dalam kategori baik.
 - Namun untuk pemeriksaan di luar jam praktek terjadi keterlambatan pembacaan hingga ± 24 jam.

Secara umum, kendala utama response time terjadi pada pemeriksaan di luar jam praktek atau di atas jam 12 malam, yang dipengaruhi oleh keterbatasan jadwal dokter radiologi, sistem pembacaan onsite, serta alur pelaporan hasil pemeriksaan. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi kecepatan pelayanan dan tindak lanjut klinis pasien, terutama pada kasus non-cito yang membutuhkan hasil radiologi lebih cepat.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Melakukan evaluasi berkala terhadap response time pemeriksaan dan pembacaan radiologi.
- 2. Mengoptimalkan sistem pembacaan hasil radiologi di luar jam praktek melalui pengaturan jadwal on call dokter radiologi.
- 3. Meningkatkan koordinasi antara petugas radiologi dan dokter radiologi terkait prioritas pembacaan hasil.
- 4. Memprioritaskan pembacaan pemeriksaan cito agar tetap sesuai standar waktu pelayanan.
- 5. Mengembangkan sistem teleradiology/konsul atau pembacaan jarak jauh untuk mempercepat hasil pemeriksaan di luar jam kerja.
- 6. Melakukan monitoring dan pelaporan rutin terhadap keterlambatan pembacaan radiologi sebagai indikator mutu pelayanan.
- 7. Memastikan hasil pemeriksaan radiologi segera terinput dan terdistribusi ke unit pelayanan setelah pembacaan selesai.

1.2.4.5 Tabel PMI dan PME di Radiologi

No	Kegiatan Pokok	Kegiatan
1.	Mencatat waktu tunggu pelayanan foto	Mencatat waktu mulai pengerjaan hingga hasil diserahkan.
2.	Mencatat jumlah Reject Film	Mencatat kegagalan foto (review pembacaan dan review hasil radiograf).
3.	Memonitor pemakaian BMHP	Memonitor penyimpanan, pemeliharaan dan pemakaian bmhp.
4.	Melakukan uji paparan radiasi	Standarisasi peralatan radiologi setiap 1 tahun sekali oleh badan yang ditunjuk pemerintahan.
5.	Melakukan uji akurasi tegangan	Standarisasi peralatan radiologi setiap 1 tahun sekali oleh badan yang ditunjuk pemerintahan.
6.	Pengukuran TLD Badge	Kegiatan pengukuran dilakukan setiap 3 bulan sekali ke BPFK (Balai Pengaman Fasilitas Kesehatan).
7.	Kalibrasi alat radiologi	Standarisasi peralatan radiologi setiap 1 tahun sekali.
8.	Uji kesesuaian	Pengujian kondisi alat dilakukan setiap 4 tahun sekali oleh badan yang ditunjuk pemerintahan.
9.	Sertifikat kalibrasi	Memastikan sertifikat kalibrasi rs rujukan masih berlaku.

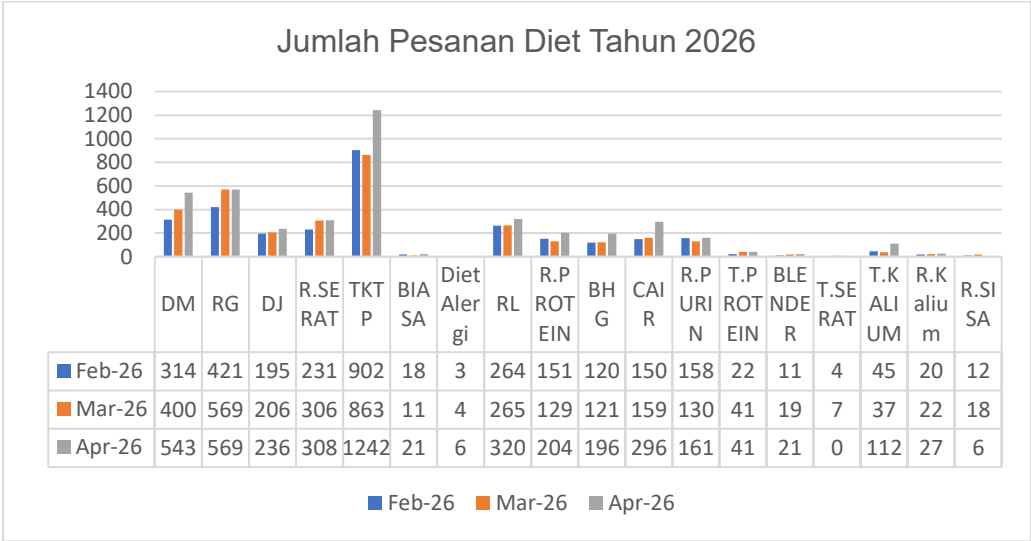
2.4.5 Gizi

2.4.5.1 Tabel Pemesanan Diit Maret 2026

No	Nama Diet	Jumlah pesanan diet			Persentase terhadap bulan sebelumnya (%)
		Bulan Februari 2026	Bulan Maret 2026	Bulan April 2026	
1.	Diabetes Mellitus	314	400	543	35
2.	Rendah Garam	421	569	569	0
3.	Jantung	195	206	236	14,5
4.	Rendah Serat	231	306	308	0,6
5.	TKTP	902	863	1242	43,9
6.	Makanan Biasa	18	11	21	90
7.	Diet Alergi	3	4	6	50
8.	Rendah Lemak	264	265	320	20,7
9.	Rendah Protein	151	129	204	58,1
10.	Bubur Halus	120	121	196	61,9
11.	Cair	150	159	296	86,1
12.	Rendah Purin	158	130	161	23,8
13.	Tinggi Protein	22	41	41	0
14.	Blender	11	19	21	10,5
15.	Tinggi Serat	4	7	0	-100
16.	Tinggi Kalium	45	37	112	202
17.	Rendah Kalium	20	22	27	22

No	Nama Diet	Jumlah pesanan diet			Persentase terhadap bulan sebelumnya (%)
		Bulan Februari 2026	Bulan Maret 2026	Bulan April 2026	
18.	Rendah Sisa	12	18	6	-66
	Jumlah	4208	3041	3307	4309

2.4.5.2 Grafik Jumlah Pesanan Diit 2026



Analisis :

Jumlah pesanan diet pasien rawat inap meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah pasien di rawat inap. Pemberian diet yang meningkat lebih dari 50% diantaranya adalah diet rendah protein dikarenakan banyaknya pasien dengan hasil ureum, kreatinin meningkat. Pemberian diet BHG dan cair juga meningkat dikarenakan meningkatnya pasien dengan keluhan sulit menelan dan membutuhkan diet bertahap bagi pasien post tindakan operasi.

Rencana Tindak Lanjut :

Koordinasi dengan humas dan marketing untuk meningkatkan jumlah kunjungan pasien rawat inap. Evaluasi kembali terkait kepuasan pasien terhadap variasi menu makanan dan mengajukan perubahan siklus menu. Melakukan konseling kepada karyawan perusahaan yang memiliki MOU dengan RSPHM.

2.4.5.3 Tabel Jumlah Konsultasi Gizi April 2026

No.	Indikasi	Jumlah Pasien Februari 2026	Jumlah Pasien Maret 2026	Jumlah Pasien April 2026
1.	Konsultasi Rawat Inap	902	894	1133
2.	Konsultasi Rawat Jalan	46	40	37

2.4.5.4 Jumlah Konsultasi Gizi pada April 2026



Analisis :
Jumlah konsultasi gizi rawat inap pada bulan April meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Jumlah konsultasi gizi rawat jalan bulan April mengalami penurunan namun tidak signifikan dikarenakan DPJP sudah mulai aktif melakukan rujukan konseling gizi rawat jalan. Poli Spesialis yang sering merujuk pasien untuk konseling gizi adalah poli jantung (dokter Mira Sp.JP) dan poli penyakit dalam (dr. Ardhyany Sp.PD, dokter Ardhi Bustami, Sp.PD dan dr.Heriyatmo, Sp.PD).

Rencana Tindak Lanjut :
Koordinasi dengan dokter DPJP dan asisten poli spesialis agar sering merujuk pasien nya untuk ke poli gizi, selain itu koordinasi dengan tim pendaftaran dalam mempromosikan poli gizi.

2.4.5.5 Tabel Rekap Data Komplain Pasien Terhadap Gizi Bulan April 2026

No	Keluhan	Jumlah Komplain Bulan Desember 2025	Jumlah Komplain Bulan Januari 2026	Jumlah Komplain Bulan Februari 2026
1.	Makanan yang disajikan dan penjelasan mengenai menu makanan.	1	1	2
	ISI KOMPLAINAN	- Tidak ada komplain terkait makanan pada bulan april		
	Analisis	-		
	RTL	-		

2.4.5.6 Tabel Rekap Food Waste (Sisa Makanan) Maret 2026

No	Menu	Rincian Menu	Total Sisa Makanan (kg)			Keterangan
			Feb 2026	Mar 2026	Apr 2026	
1.	Karbohidrat	Nasi	54,4	57,8	68,8	75,5% dari sisa makanan berasal dari karbohidrat. Sisa KH pada bulan April 2026 meningkat 0,5% dari bulan Maret 2026. Perlu adanya evaluasi pemorsian KH pada menu pasien
		Nasi Tim	83,6	82,2	98,8	
		Total	167,2	138	167,6	
2.	Snack	Roti Kukus	0	0	0	Untuk konsumsi snack di Prima Husada Malang pada bulan April tidak ada sisa yang kembali dari pasien diakarenakan pasien memindahkan snack yang masih ada kedalam wadah pribadi saat
		Setup Pisang	0	0	0	
		Kacang Hijau	0	0	0	
		Kue Hongkong	0	0	0	
		Terang Bulan	0	0	0	
		Bubur Sagu	0	0	0	

	Kue Lumpur		0	0	0	pengambilan alat makan snack pasien
	Puding		0	0	0	
	Donat		0	0	0	
	Tahu Fantasi		0	0	0	
	Brule Bomb		0	0	0	
	Total		0	0	0	
1.	Menu 1					Menu 4 adalah menu paling tidak diminati, sisa makanan sebanyak 11,7 Kg pada bulan Maret
	Bulan		Feb 2026	Mar 2026	Apr 2026	
	Pagi	Semur (Tahu, Buncis, Bakso)	3,6	2,7	3,8	
		Rolade Ayam				
	Tambahan VIP	Tempe Goreng				
	Siang	Sup Kemangi (Jagung, Wortel, Oyong, Kemangi)	4	2,6	4,5	
		Ayam Kecap				
		Tahu Bumbu Tomat				
	Tambahan VIP	Telur Ceplok				
	Sore	Sup (Suun, wortel, polong, bakso)	3,6	2,4	4,2	
		Perkedel kentang ayam				
	Tambahan VIP	Ayam fillet panggang teflon				
	Total		11,2	7,7	12,5	
	2.	Menu 2				
Bulan		Feb 2026	Mar 2026	Apr 2026		
Pagi		Sup (Manisah, Ayam Dadu, Wortel, Bihun)	4,2	4	4,7	
		Tahu Rempah (Remet)				
		Abon				
Tambahan VIP		Telur Rebus				
Siang		Sayur Bening (Bayam, Jagung, Wortel, Manisah)	3,8	3,9	4,6	
		Ayam Wijen				
		Bakwan Jagung				
Tambahan VIP		Telur Gulung				
Sore		Capjae (wortel, sawi hijau, bunga kol, bakso)	3,5	3,4	4,2	
		Telur dadar tebal				
Tambahan VIP		Tempe goreng				
Total		10,5	11,3	13,5		

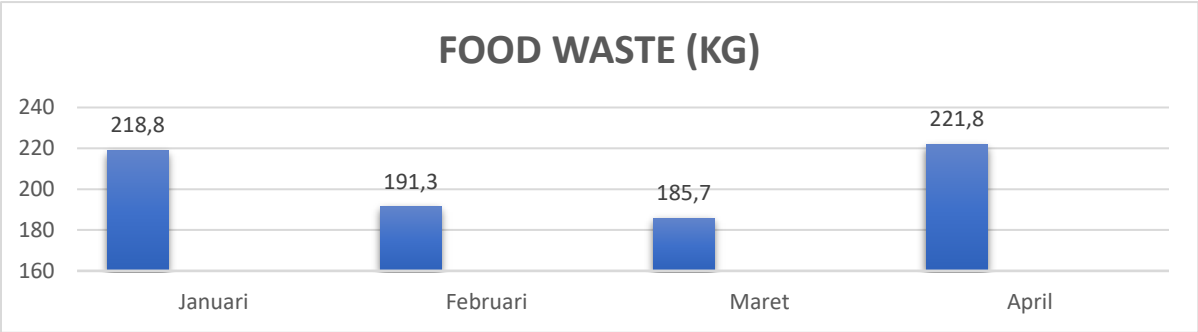
3.	Menu 3				
	Bulan		Feb 2026	Mar 2026	Apr 2026
	Pagi	Sup (wortel, Sawi Putih, Ayam Dadu)	3,9	3,9	4,2
		Tahu Krispy			
		Abon			
	Tambahan VIP	Telur Ceplok			
	Siang	Sayur Asem (Wortel, Kacang Panjang, Manisah)	3,4	3,9	4
		Rolade Ayam			
		Tahu Goreng			
	Tambahan VIP	Tempe Bacem			
	Sore	Sapo (tahu goreng, wortel, bakso,dedaunan, saos tiram)	3,2	3,9	0,5
		Telur rebus			
	Tambahan VIP	Tempe goreng			
	Total		10,5	11,7	8,7
4.	Menu 4				
	Bulan		Jan 2026	Feb 2026	Mar 2026
	Pagi	Sayur Bobor (Selada Air, Manisah, Kemangi)	3,6	3,7	3,8
		Tahu Nugget			
		Abon			
	Tambahan VIP	Oseng Bakso Mekar			
	Siang	Sup (Oyong, Wortel, Jagung)	1,5	2,7	4,2
		Ayam Kecap			
		Jamur Krispy			
	Tambahan VIP	Tahu Bacem			
	Sore	Fuyunghai (telur, wortel,daunan)sasu polong orang	3,4	2,8	0,9
		Jamur goreng			
	Tambahan VIP	abon			
	Total		8,5	9,2	8,9
5.	Menu 5				
	Bulan		Jan 2026	Feb 2026	Mar 2026
	Pagi	Sup (Bunga Kol, Sawi Daging, Bakso, Wortel)	2,8	3	2,7
		Opor Tahu			
		Oper Telur			
	Tambahan VIP	Tempe Goreng			

	Siang	Sayur Bening (Bayam, Jagung, Manisah)	3,9	2,9	3,9	
		Ayam Bombay				
		Bakwan Jagung				
	Tambahan VIP	Tahu Krispy				
	Sore	Soto ayam	4,2	4	4	
		Telur rebus				
		VIP= Perkedel ayam				
	Total		10,9	9,9	10,6	
	Total Sisa Menu tanpa KH		51,6	53,3	54,2	
Total Keseluruhan dengan KH		218,8	191,3	221,8		

1.4.5.7 Tabel Rekap Food Waste Tahun 2026

No	Bulan	Total Sisa Makanan (kg)
1.	Januari 2026	218,8
2.	Februari 2026	191,3
3.	Maret 2026	185,7
4.	April 2026	221,8
5.	Mei 2026	-
6.	Juni 2026	-
7.	Juli 2026	-
8.	Agustus 2026	-
9.	September 2026	-
10.	Oktober 2026	-
11.	November 2026	-

1.4.5.8 Grafik Food Waste pada Bulan Tahun 2026



Analisis :

Berdasarkan rekapitulasi food waste tahun 2026, jumlah sisa makanan pasien mengalami fluktuasi setiap bulan. Pada Januari total sisa makanan sebesar 218,8 kg, kemudian menurun pada Februari menjadi 191,3 kg dan kembali menurun pada Maret menjadi 185,7 kg. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan penerimaan makanan oleh pasien. Namun pada April terjadi peningkatan food waste menjadi 221,8 kg, lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya. Peningkatan sisa makanan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti:

1. ketidaksesuaian menu dengan selera pasien,
2. kondisi klinis pasien yang mempengaruhi nafsu makan,
3. variasi diet pasien,
4. waktu distribusi makanan,
5. maupun porsi makanan yang belum sesuai kebutuhan pasien.

Secara umum, food waste masih perlu menjadi perhatian karena dapat mempengaruhi efektivitas pelayanan gizi, kepuasan pasien, serta efisiensi penggunaan bahan makanan di rumah sakit.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Melakukan evaluasi rutin terhadap jumlah food waste setiap bulan.
- 2. Melakukan survei kepuasan dan daya terima makanan pasien secara berkala.
- 3. Mengevaluasi variasi menu, cita rasa, tekstur, dan suhu makanan agar lebih sesuai dengan kondisi pasien.
- 4. Menyesuaikan porsi makanan dengan kebutuhan dan kemampuan konsumsi pasien.
- 5. Meningkatkan koordinasi antara ahli gizi, perawat, dan instalasi gizi terkait kondisi pasien yang mempengaruhi intake makanan.
- 6. Melakukan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai pentingnya pemenuhan nutrisi selama perawatan.
- 7. Monitoring ketepatan waktu distribusi makanan agar kualitas makanan tetap baik saat diterima pasien.

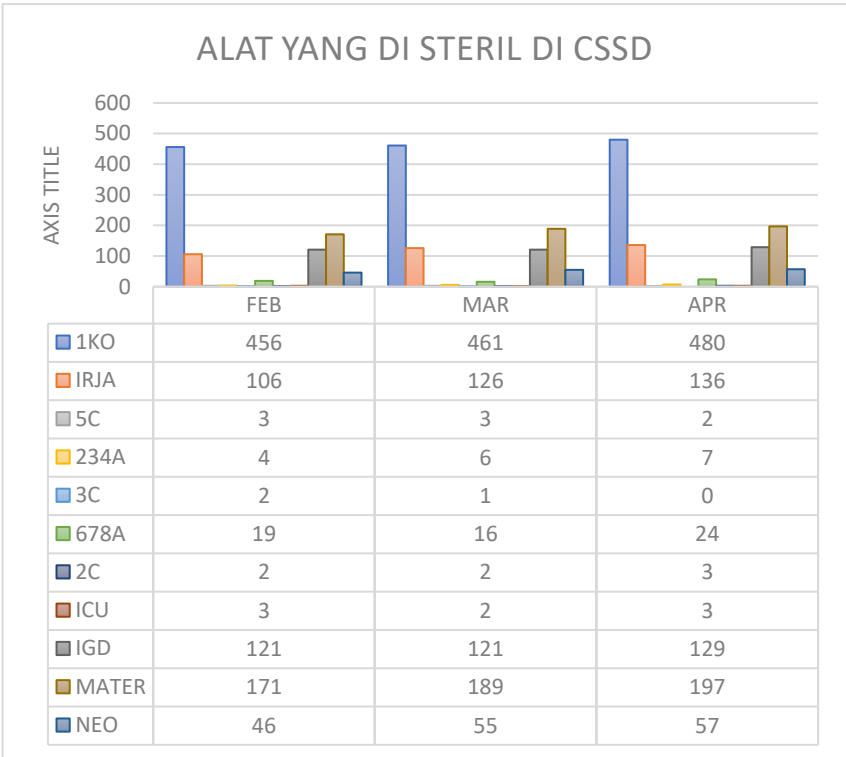
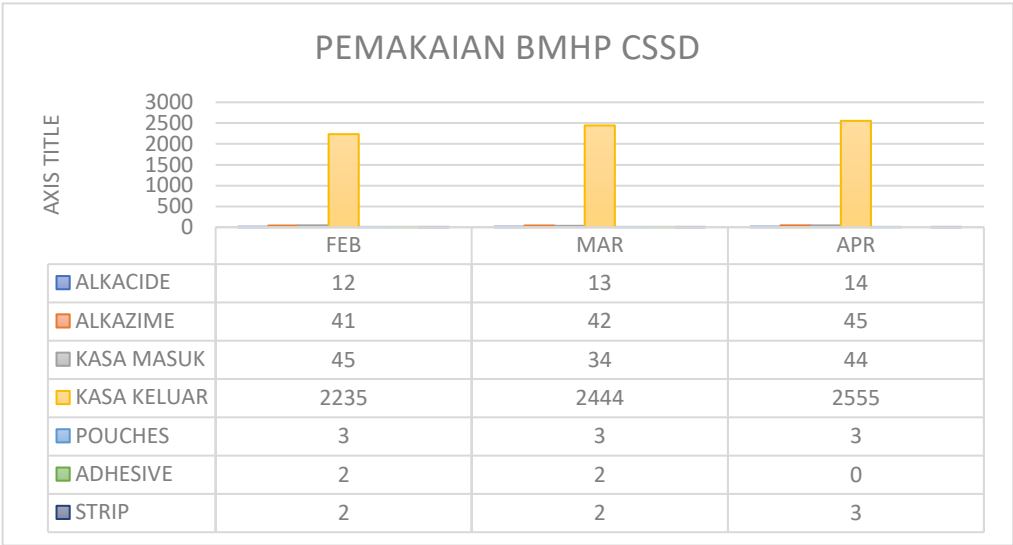
1.4.7 CSSD – Laundry

1.4.7.1 CSSD

1.4.7.2 Tabel Jumlah Pengeluaran Bahan Habis Pakai dan Alat yang Disetor ke CSSD April 2026

NO	HAL	BULAN		
		FEB 2026	MARET 2026	APR 2026
BHP				
1.	Chemical Alcacide (ml)/ oplos	12	13	14
2.	Chemical Alkazyme (pcs)/ oplos	41	42	45
3.	Kassa Masuk (roll)	45	34	44
4.	Kassa Keluar (pouches)	2235	2444	2555
5.	BHP Pouces (roll)	3	3	3
6.	Indikator Adhesive (roll)	2	2	0
7.	Indikator Strip Steam (roll)	2	2	3
Jumlah		2340	2540	2664
Alat yang disetor (set)				
8.	IKO	456	461	480
9.	IRJA	106	126	136
10.	IRNA 5C	3	3	2
11.	IRNA 2A, 3A dan 4A	4	6	7
12.	IRNA 3C ANAK	2	1	0
13.	IRNA 6A, 7A dan 8A	19	16	24
14.	IRNA 2C VIP	2	2	3
15.	IRNA ICU	3	2	3
16.	IGD	121	121	129
17.	MATERNITAS	171	189	197
18.	NEONATOLOGI	46	55	57
Jumlah		933	982	1038

1.4.7.3 Grafik Jumlah Alat Yang Disetor ke CSSD Bulan April 2026



Analisis :

Secara umum, peningkatan jumlah alat dan penggunaan BHP menunjukkan beban kerja CSSD meningkat seiring peningkatan pelayanan rumah sakit. Kondisi ini perlu diimbangi dengan pengelolaan stok, pemantauan mutu sterilisasi, dan kesiapan SDM agar pelayanan tetap optimal.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Melakukan monitoring rutin penggunaan BHP dan jumlah alat steril setiap bulan.
2. Memastikan ketersediaan stok BHP terutama bahan indikator sterilisasi agar tidak terjadi kekosongan.
3. Melakukan evaluasi penggunaan BHP untuk mencegah pemborosan dan memastikan penggunaan sesuai standar.
4. Meningkatkan koordinasi dengan unit pelayanan terkait jadwal pengiriman dan kebutuhan alat steril.
5. Melakukan pemeliharaan dan monitoring berkala alat sterilisasi untuk menjaga mutu hasil

steril.

- 6. Menyesuaikan kebutuhan SDM dan beban kerja CSSD sesuai peningkatan jumlah alat yang diproses.
- 7. Melakukan monitoring kepatuhan penggunaan indikator sterilisasi sebagai bagian dari pengendalian mutu CSSD.

1.4.7.2 Laundry

1.4.7.2.1 Tabel Produksi Linen Steril

JENIS LINEN	JAN	FEB	MAR	APR
Linen IKO	206 SET	201 SET	213 SET	221 SET
Linen mata	11 SET	8 SET	8 SET	11 SET

Analisa:

Berdasarkan data produksi linen steril tahun 2026, jumlah produksi linen steril mengalami peningkatan secara bertahap terutama pada linen IKO. Sedangkan linen mata relatif stabil dengan jumlah produksi 8–11 set per bulan. Peningkatan produksi linen steril menunjukkan meningkatnya kebutuhan pelayanan tindakan operatif dan penggunaan linen steril di kamar operasi.

1.4.7.2.2 Penggunaan Chemical Laundry

CHEMICAL	JANUARI	FEBRUARI	MARET
CLAX BUILT LITE	1	1	2
CLAX 100	1	1	2
CLAX SONRIL	1	1	1
CLAX NEUTRAL	1	1	1
CLAX SOFT	1	1	1
SNAPY	15 LITER	0	5 LITER
RAPIKA	14 L	28 L	20 L
BAYKLIN	15 L	17 L	16 L
SOFTENER	0	0	
LIQUID	30 L	30 L	33 L
LPG	22 TABUNG	24 TABUNG	36 TABUNG

Tabel Kinerja Produktifitas Linen-Laundry Tahun 2026

JENIS LINEN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL
Lineninfeksius	2496	2256	2278	2366
Linen non infeksi	2402	2309	2443	2480
234 A	483	445	426	440
678 A	529	487	540	574
2 C	280	248	193	201
3 C	342	389	400	410
4 C/Mater	425	356	382	390
5 C	232	183	195	196
IKO	2.030	1869	1812	2005
IGD	173	175	232	240
ICU	202	218	201	198
IRJA	107	100	123	120
M.S	58	56	28	31
Umum	9	7	24	9
CSSD	13	7	11	11
DAPUR/GIZ	9	7	6	6
RAD	9	11	8	8

LAB	8	7	6	7
Jumlah	4898	4565	4721	4846

Analisa:

Jumlah produktivitas linen laundry mengalami fluktuasi dari bulan ke bulan. Pada April terjadi peningkatan dibanding Februari dan Maret, menunjukkan meningkatnya aktivitas pelayanan rumah sakit dan kebutuhan pengelolaan linen. Linen infeksius dan non infeksius relatif tinggi dan stabil, menandakan tingginya aktivitas pelayanan pasien rawat inap. Peningkatan cukup terlihat dari unit IRNA 3c, 678A, IKO, IGD. Hal ini menunjukkan peningkatan penggunaan linen pada ruang perawatan, kamar operasi, dan pelayanan gawat darurat. Secara umum, produktivitas linen-laundry sudah berjalan baik dalam memenuhi kebutuhan pelayanan. Namun peningkatan volume linen perlu diimbangi dengan pengawasan mutu pencucian, pengendalian infeksi, serta pengelolaan linen yang efektif agar tidak terjadi keterlambatan distribusi maupun kerusakan linen.

Rencana Tindak Lanjut:

1. Melakukan monitoring rutin terhadap jumlah produksi linen steril dan produktivitas laundry setiap bulan.
2. Memastikan ketersediaan linen sesuai kebutuhan pelayanan di masing-masing unit.
3. Melakukan pengawasan mutu proses pencucian, sterilisasi, dan distribusi linen sesuai standar PPI.
4. Meningkatkan pemeliharaan mesin laundry dan alat sterilisasi untuk menjaga kelancaran operasional.
5. Melakukan evaluasi penggunaan linen infeksius dan non infeksius agar sesuai klasifikasi dan mencegah risiko infeksi.
6. Mengoptimalkan koordinasi antara laundry, CSSD, dan unit pelayanan terkait kebutuhan dan distribusi linen.
7. Melakukan monitoring kondisi linen untuk mengurangi linen rusak dan meningkatkan efisiensi penggunaan linen rumah sakit.

4.4 Kinerja Bidang Umum

5.4.1 SDM

Ketenagaan (Distribusi Tenaga, Kualifikasi, Jabatan dan Kebutuhan)

NO	UNIT	PENDIDIKAN	TOTAL	JUMLAH	TETAP	TIDAK TETAP	RESIGN
1	Direktur	Dokter Umum	1	1	1	0	0
2	Kabid Pelayanan Medis	D3 Kebidanan	1	1	1	0	0
3	Kabid Penunjang Medis	S1 Kesehatan Lingkungan	1	1	1	0	0
4	Kabid Keperawatan	Profesi Ners	0	0	0	0	0
5	Kabid Umum	Dokter Gigi Umum	1	1	0	1	0
6	Casemix Manager	SMK	1	1	1	0	0
7	Farmasi	Profesi Apoteker	38	12	6	6	0
		S1 Farmasi		3	2	1	0
		D3 Analisis Farmasi dan Makanan		1	1	0	0
		D3 Farmasi		21	14	7	0
		SMK		0	0	0	0
		S1 Manajemen		1	1	0	0
8	Asuransi Center	D3 Asuransi Kesehatan	10	1	1	0	0
		D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		8	7	1	0
		SMK		0	0	0	0
		SMA		1	1	0	0
9	CSSD	D3 Keperawatan	3	2	1	1	0

		SMA		1	1	0	0
		SMK		0	0	0	0
10	Fisioterapi	S1 Fisioterapi	5	1	0	1	0
		D3 Fisioterapi		3	2	1	0
		D3 Terapi Wicara		1	0	1	0
11	Gizi	S1 Ilmu Gizi	16	2	2	0	0
		D4 Gizi dan Dietetika		2	2	0	0
		D3 Ahli Gizi		2	2	0	0
		SMK		6	0	6	0
		SMA		1	0	1	0
		SMP		3	2	1	0
12	Humas & Marketng	D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	2	1	0	1	0
		S1 Teknik Informatika		1	0	1	0
13	ICU dan HCU	Profesi Ners	10	5	5	0	0
		D3 Keperawatan		4	2	2	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
14	IGD	Profesi Ners	23	10	8	2	0
		D3 Keperawatan		9	7	2	0
		D4 Kebidanan		2	2	0	0
		D3 Kebidanan		2	2	0	0
15	IKO	Profesi Ners	11	7	7	0	0
		D3 Keperawatan		4	4	0	0
		D3 Kebidanan		0	0	0	0
16	IPCN	Profesi Ners	2	2	2	0	0
17	IPSRS	S1 Tenik Elektro	6	1	1	0	0
		S1 Kesehatan Masyarakat		1	1	0	0
		D3 Teknik Elektromedis		1	0	1	0
		SMK		3	3	0	0
18	IRJA	Profesi Ners	28	7	7	0	0
		D3 Keperawatan		15	14	1	0
		D4 Keperawatan Gigi		2	1	1	0
		Profesi Kebidanan		1	0	1	0
		D3 Kebidanan		3	3	0	0
19	IRNA 2C	Profesi Ners	6	4	4	0	0
		D3 Keperawatan		2	2	0	0
20	IRNA 2A, 3A, & 4A	Profesi Ners	16	7	7	0	0
		D3 Keperawatan		9	6	3	0
21	IRNA 3C Anak	Profesi Ners	12	4	2	2	0
		D3 Keperawatan		8	7	1	0
		D3 Kebidanan		0	0	0	0
22	IRNA 5C	Profesi Ners	8	2	1	1	0
		D3 Keperawatan		6	4	2	0
23	IRNA 6A, 7A, & 8A	Profesi Ners	21	8	4	4	0
		D3 Keperawatan		13	10	3	0
24	Maternitas	Profesi Kebidanan	10	1	0	1	0
		D4 Kebidanan		2	2	0	0
		D3 Kebidanan		7	7	0	0
25	Neonatologi	Profesi Ners	8	3	2	1	0
		D3 Keperawatan		4	4	0	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0

26	Keuangan & Akuntansi	S1 Ekonomi	8	2	2	0	1
		S1 Akuntansi		1	0	1	0
		S1 Manajemen		1	1	0	0
		SMK		1	1	0	0
		SMA		3	3	0	0
27	Laboratorium	D4 Analis Kesehatan	8	1	0	1	0
		D3 Analis Kesehatan		7	6	1	0
28	Laundry	SMK	5	2	1	1	0
		SMA		2	1	1	0
		SMP		1	0	1	0
29	Rekam Medis	D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	8	8	8	0	0
30	Pendaftaran	S1 Sastra Inggris	13	0	0	0	0
		S1 Kesehatan Masyarakat		1	1	0	0
		D3 Asuransi Kesehatan		1	0	1	0
		D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		6	5	1	0
		D1 Administrasi Perkantoran		1	1	0	0
		SMK		1	1	0	0
		SMA		3	3	0	0
31	PIPP & MPP	Profesi Ners	4	0	0	0	0
		D4 Kebidanan		1	1	0	0
		D3 Keperawatan		1	1	0	0
		D3 Kebidanan		2	2	0	0
32	PMKP	Profesi Ners	1	1	1	0	0
33	Radiologi	D3 Radiodiagnostik & Radioterapi	6	6	4	2	0
34	SDM	S1 Sosial	1	1	1	0	0
35	Sekretaris	S1 Administrasi Publik	1	1	1	0	0
36	SIMRS & IT	S1 Teknik Informatika	3	3	3	0	0
37	Umum & Rumah Tangga	S1 Ekonomi	1	1	1	0	0
38	Cleaning Service	SMK	40	13	7	6	0
		SMA		22	18	4	0
		SMP		5	5	0	0
39	Security	SMK	10	4	2	2	0
		SMA		6	5	1	0
40	Driver	D1 Administrasi Perkantoran	6	1	1	0	0
		SMA		4	3	1	0
		SMP		1	1	0	0
41	Gudang Umum	SMP	1	1	1	0	0
42	Staf Orientasi	Profesi Ners	11	5	0	5	0
		D3 TVF		2	0	2	0
		D3 Analis Kesehatan		1	0	1	0
		SMK		3	0	3	0
Total Karyawan			367	367	274	93	2
43	Dokter IGD	Dokter Umum	8	8	0	8	0
44	Dokter Casemix	Dokter Umum	1	1	0	1	0
45	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Pendidikan Dokter Spesialis	5	5	1	4	0
46	Dokter Spesialis Anak	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
47	Dokter Spesialis Bedah Umum	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0

48	Dokter Spesialis Bedah Plastik	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
49	Dokter Spesialis Bedah Saraf	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
50	Dokter Spesialis Obsitetri dan Ginekologi	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
51	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
52	Dokter Spesialis Mata	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
53	Dokter Spesialis THT	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
54	Dokter Spesialis Paru	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
55	Dokter Spesialis Saraf	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
56	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
57	Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatology	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
58	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
59	Dokter Spesialis Urologi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
60	Dokter Spesialis Anestesi	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	1	2	0
61	Dokter Spesialis Radiologi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
62	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
63	Dokter Spesialis Patologi Klinik	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
64	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
65	Dokter Spesialis Gigi Periodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
66	Dokter Spesialis Gigi Pedodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
67	Dokter Spesialis Gigi Orthodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
68	Dokter Spesialis Konservasi Gigi	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
Total Dokter			64	64	2	62	0
Total Keseluruhan			431	431	276	155	1

Keterangan :
Pada bulan April tidak terdapat staf resign.

3.5.1.1 Update STR / SIP

NO	NAMA	PROFESI	TANGGAL KEJADIAN	KETERANGAN
1	Neneng Aprilia Pangestuti, A.Md.Kep	Perawat	09/04/2026	SIP Perpanjangan
2	Bagus Ardhiansyah Putra, S.Kep.Ns	Perawat	17/04/2026	SIP Perpanjangan
3	Septian Teguh Imanda, AMd.Kep	Perawat	22/04/2026	SIP Perpanjangan
4	Ineke Yulkarnain, S. Kep., Ns	Perawat	06/04/2026	SIP Baru
5	Nike Kristanti,S.Kep.,Ns (Alih Jenjang)	Perawat	22/04/2026	SIP Alih Jenjang Pendidikan

Keterangan :
Pada bulan April 2026 terdapat 5 SIP baru yang terbit.

3.5.1.2 Rekrutmen

NO	PROFESI	JUMLAH YANG DIBUTUHKAN	TERPENUHI	KEKURANGAN	PENYEBAB	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Terapi Okupasi	1	0	1	Sulit mencari kandidat terapis okupasi	Menghubungi sosial media komunitas terapis okupasi, menghubungi kampus dengan jurusan terapis okupasi
2	Dokter Spesialis Bedah	1	0	1	Sulit mencari kandidat Dokter Gigi Spesialis	Menghubungi kampus dengan jurusan tersebut

	Mulut				Bedah Mulut	
3	Dokter Spesialis Radiologi	1	0	1	Belum mendapatkan kandidat	Dibutuhkan yang Perempuan
4	Dokter Umum IGD	2	0	2	Proses seleksi sudah dilakukan oleh PT. Menunggu hasil.	Proses seleksi sudah dilakukan oleh PT. Menunggu hasil.
5	Dokter Casemix	1	0	1	Mengganti dokter yang akan resign	Proses seleksi sudah dilakukan oleh PT. Menunggu hasil.

3.5.1.3 Orientasi Staf Baru

3.5.1.3.1 Orientasi Staf

NO	TANGGAL	JENIS ORIENTASI	NAMA STAF	PENDIDIKAN	PROFESI	SPMJ (TANGGAL MASUK)	KETERANGAN

Keterangan : Pada bulan April 2026 tidak ada staf dengan orientasi khusus

3.5.1.4 Diklat

NO	JUDUL DIKLAT	JENIS DIKLAT	JUMLAH PESERTA		TANGGAL PELAKSANAAN	SERTIFIKAT		HASIL EVALUASI DALAM KINERJA SEHARI-HARI	
			HADIR	TIDAK HADIR		ADA	TIDAK	PATUH	TIDAK PATUH

Keterangan:

Pada bulan April 2026 belum ada diklat yang dilaksanakan di RS Prima Husada Malang.

3.5.1.5 Evaluasi Kinerja Staf

NO	UNIT	PENILAIAN KINERJA	CATATAN KHUSUS		HASIL EVALUASI				KESIMPULAN
			Baik	Jelek	SB	B	C	K	
1	Direktur	Umum	1	0	0	1	0	0	Unit Direktur secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
2	Kabid Pelayanan Medis	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit Kabid Pelayana Medis secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
3	Kabid Penunjang Medis	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit Kabid Penunjang Medis secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
5	Kabid Umum	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit Kabid Umum & Keuangan secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
6	Casemix Manager	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit Satuan Pengawas Internal secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
7	Farmasi	Umum	38	0	7	21	7	1	Unit Farmasi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
8	Asuransi Center	Umum	10	0	6	3	0	1	Unit Asuransi Center secara keseluruhan mendapat catatan

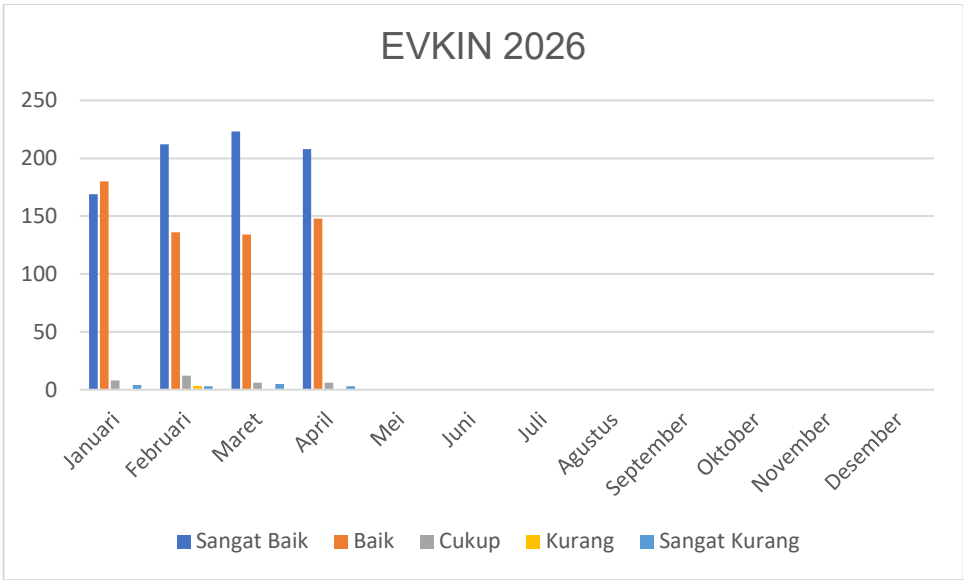
NO	UNIT	PENILAIAN KINERJA	CATATAN KHUSUS		HASIL EVALUASI				KESIMPULAN
			Baik	Jelek	SB	B	C	K	
									baik dalam penilaian kinerja umum.
9	CSSD	Umum	3	0	2	1	0	0	Unit CSSD secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
10	Fisioterapi	Umum	5	0	0	4	1	0	Unit Fisioterapi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
11	Gizi	Umum	16	0	9	7	0	0	Unit Gizi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
12	Humas & Marketing & PKRS	Umum	2	0	0	2	0	0	Unit Humas Markrting & PKRS secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
13	ICU dan HCU	Umum	10	0	7	3	0	0	Unit ICU & HCU secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
14	IGD	Umum	23	0	17	6	0	0	Unit IGD secara keseluruhan mendapatcatatan baik dalam penilaian kinerja umum.
15	IKO	Umum	11	0	10	1	0	0	Unit IKO secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
16	IPCN	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit IPCNsecara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
17	IPSRS	Umum	6	0	4	2	0	0	Unit IPSRS secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
18	IRJA	Umum	28	0	18	7	3	0	Unit IRJA secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
18	IRNA 2C	Umum	7	0	7	0	0	0	Unit IRNA 2C secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
19	IRNA 2A, 3A, & 4A	Umum	16	0	14	2	0	0	Unit IRNA 234A secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
20	IRNA 3C Anak	Umum	12	0	12	0	0	0	Unit IRNA 3C Anak secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
21	IRNA 5C	Umum	8	0	5	3	0	0	Unit IRNA 5C secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
22	IRNA 6A, 7A, & 8A	Umum	21	0	20	1	0	0	Unit IRNA 6A, 7A & 8A secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
23	Maternitas	Umum	10	0	7	3	0	0	Unit Maternitas secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
24	Neonatologi	Umum	8	0	7	1	0	0	Unit Neonatologi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
25	Kuangan & Akuntansi	Umum	9	0	2	7	0	0	Unit Keuangan secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.

NO	UNIT	PENILAIAN KINERJA	CATATAN KHUSUS		HASIL EVALUASI				KESIMPULAN
			Baik	Jelek	SB	B	C	K	
26	Laboratorium	Umum	8	0	2	6	0	0	Unit Laboratorium secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
27	Laundry	Umum	5	0	1	4	0	0	Unit Laundry secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
28	Rekam Medis	Umum	7	0	2	5	0	0	Unit Rekam Medis secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
29	Pendaftaran	Umum	14	0	3	10	0	1	Unit Pendaftaran secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
30	PIPP & MPP	Umum	4	0	4	0	0	0	Unit PIPP secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum. Terdapat 1 staf dengan evaluasi kinerja sangat kurang dikarenakan cuti melahirkan.
31	PMKP	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit Mutu & PMKP secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
32	Radiologi	Umum	6	0	4	2	0	0	Unit radiologi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
33	SDM	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit SDM secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
34	Sekretaris	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit Sekretaris secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
35	SIMRS & IT	Umum	3	0	1	2	0	0	Unit IT SIMRS secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
36	Umum & Rumah Tangga	Umum	1	0	0	1	0	0	Unit IRJA secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
37	Cleaning Service	Umum	40	0	23	17	0	1	Unit Cleaning Service secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
38	Security	Umum	12	0	10	2	0	0	Unit Security secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
39	Driver	Umum	6	0	3	2	1	0	Unit Driver secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
40	Gudang Umum	Umum	1	0	0	1	0	0	Unit Gudang Umum secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.

Analisis :
Hampir seluruh unit di RS Prima Husada Malang berada pada kategori Sangat Baik pada penilaian umum periode April 2026.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

3.7.1 Grafik Evaluasi Kinerja Karyawan



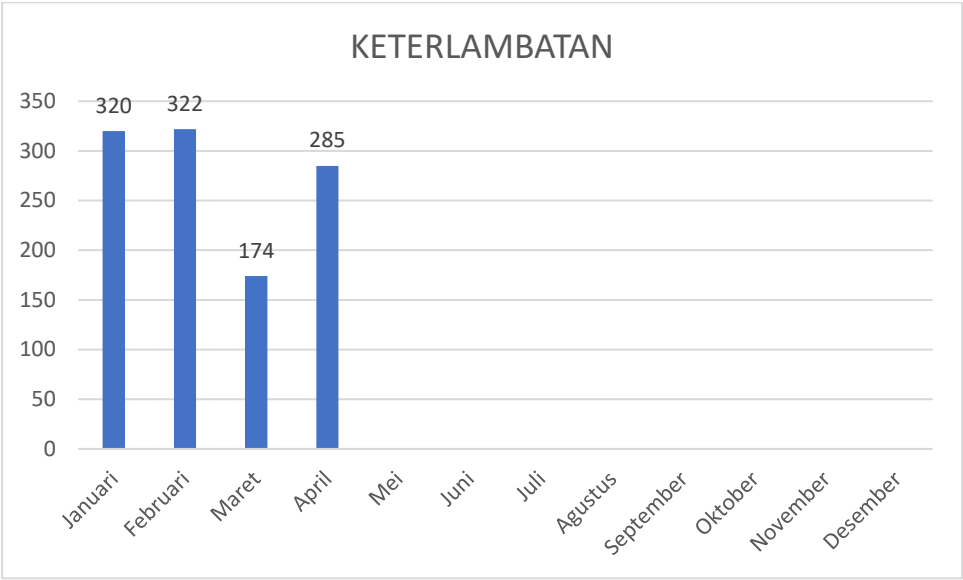
Kategori	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Sangat Baik	169	212	223	208								
Baik	180	136	134	148								
Cukup	8	12	6	6								
Kurang	0	3	0	0								
Sangat Kurang	4	3	5	3								
TOTAL	361	366	368	365								

Analisa :
Secara umum terdapat kenaikan kategori sangat baik.

- Rencana Tindaklanjut :**
- 1. Sosialisasi kepada Karu dan Kabid untuk mengingatkan kembali kepada stafnya.
 - 2. Melakukan tahapan teguran sesuai taat tertib yang berlaku.
 - 3. Mempertahankan kinerja staf terkait kedisiplinan.
 - 4. Membuat diklat dengan konsep baru sesuai arahan PT

Tabel Keterlambatan Karyawan

	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
KETERLAMBATAN	320	332	174	285								



Analisa :
Secara umum terdapat peningkatan jumlah keterlambatan pada bulan ini

- Rencana Tindak Lanjut :**
- 1. Sosialisasi kepada Karu dan Kabid untuk mengingatkan kembali kepada stafnya.
 - 2. Melakukan tahapan teguran sesuai taat tertib yang berlaku.
 - 3. Mempertahankan kinerja staf terkait kedisiplinan.

3.5.1.6 Konseling

3.5.1.6.1 Tabel Capaian Konseling

NO	UNIT	JUMLAH KONSELING GRUP	JUMLAH KONSELING INDIVIDU					
			KONTRAK N-ED	TERKAIT TATA TERTIB	TERKAIT KETIDAKPATUHAN MUTU	TERKAIT KETIDAKPATUHAN PPI	TERKAIT MANRISK	KARIR
1	Manajerial RS	0	0	0	0	0	0	0
2	SDM	0	0	0	0	0	0	0
3	Asuransi Center	0	0	0	0	0	0	0
4	IRNA 2C	0	0	0	0	0	0	1
5	IRNA 3C Anak	0	0	0	0	0	0	0
6	IRNA 3A & 4A	0	0	0	0	0	0	0
7	IRNA 5C	0	0	0	0	0	0	0
8	IRNA 6A & 7A	0	0	0	0	0	0	1
9	Maternitas	0	0	0	0	0	0	0
10	Neonatologi	0	0	0	0	0	0	0
11	IGD	0	0	0	0	0	0	0
12	ICU	0	0	0	0	0	0	0
13	HCU	0	0	0	0	0	0	0
14	IKO	0	0	0	0	0	0	0
15	Gizi	0	0	0	0	0	0	0
16	Farmasi	0	0	0	0	0	0	0
17	Laboratorium	0	0	0	0	0	0	0
18	Radiologi	0	0	0	0	0	0	0
19	Rekam Medis	0	0	0	0	0	0	0
20	Pendaftaran	0	0	0	0	0	0	1
21	CSSD	0	0	0	0	0	0	0
22	Laundry	0	0	0	0	0	0	0
23	Kuangan &	0	0	0	0	0	0	0

	Akuntansi							
24	PIPP	0	0	0	0	0	0	0
25	MPP	0	0	0	0	0	0	0
26	Umum Cleaning Service	0	0	0	0	0	0	1
27	SIMRS	0	0	0	0	0	0	1
28	DRIVER	0	0	0	0	0	0	0
29	Security	0	0	0	0	0	0	0
30	IRJA	0	0	0	0	0	0	0
31	Rehab Medik	0	0	0	0	0	0	0
32	Kasir Parkir	0	0	0	0	0	0	1
33	Parkir	0	0	0	0	0	0	1
Total		0	0	0	0	0	0	7

Analisis :
 Konseling staf dilaksanakan sesuai kebutuhan

Rencana Tindak Lanjut :
 Monitoring dan evaluasi

3.5.1.6.1 Supervisi

Jenis	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Supervisi (2x/bulan)	0	0	0	0								

Analisis:
 Belum dilakukan

Rencana Tindak Lanjut :
 Lebih ditingkatkan supervisi ke tiap unit khususnya unit dengan tingkat temuan banyak.

3.5.1.7 Mutasi

Tabel Daftar Staf Mutasi

NO	NAMA STAF	UNIT ASAL	UNIT BARU
1	Gadis Arivia, S. Farm., Apt	Pengadaan PT	Gudang Farmasi
2	Yeni Christiana, S. Farm., Apt	Gudang Farmasi	Pengadaan PT
3	Lydia Desiariani, S.E	Kasir RS	Keuangan PT

Analisis : pada bulan April 2026 terdapat 3 staf rotasi

3.5.2 IPSRS

3.5.2.1 Pemeliharaan Alat Medis

Perhitungan capaian berdasarkan jumlah kunjungan per unit oleh elektromedis ke unit-unit di rumah sakit (33 unit) dalam satu bulan

3.5.2.1.1 Tabel Capaian Maintanance Alat Medis

	Target	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
Capaian Maintenance Ruangan		58,97%	82,05%	64,10%	72%								

BULAN	TOTAL ALAT	CAPAIAN	PROSENTASE
Januari	276	119	43,12%
Februari	276	138	50%
Maret	276	124	44,93%
April	276	112	41%
Mei			
Juni			
Juli			
Agustus			
September			
Oktober			
November			

TOTAL ALAT (PERBAIKAN)	TOTAL ALAT
Januari	8
Februari	16
Maret	13
April	16
Mei	
Juni	
Juli	
Agustus	
September	
Oktober	
November	

Analisa :
 Pada bulan ini capaian adalah 72 % untuk ruangan naik dari bulan sebelumnya

Rencana Tindak Lanjut :
 Koordinasi dengan PT untuk rekrutmen ATEM sesuai ABK (tidak ada pemenuhan rekrutmen)

3.5.2.2 Pemeliharaan Alat Non Medis

3.5.2.2.1 Air Conditioner

3.5.2.2.1.1 Tabel Capaian Pemeliharaan AC Split

	CAPAIAN	TARGET	PROSENTASE
JAN-26	25	64	39.06%
FEB-26	40	64	62.50%
MAR-26	27	64	42.19%
APR-26	2	64	3.13%

Analisa :
 Pemeliharaan AC bulan ini turun karena alat AC mengalami kerusakan pada tanggal 6 April 2026, Tanggal 7 April sudah dicarikan offline sparepart namun tidak ada. Unit IPSRS order alat tanggal 8 April 2026 dan baru datag tang 26 April 2026 sehingga menghambat maintenance. Perbaikan AC April sebanyak 19 unit AC.

Rencana Tindak Lanjut :
 Monitoring dan evaluasi

1.5.2.2.3 Genset

1.5.2.2.3.1 Tabel Capaian Pemeliharaan Genset

NO	BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
1	Januari	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
2	Februari	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
3	Maret	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
4	April	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
5	Mei	4x/bulan			
6	Juni	4x/bulan			
7	Juli	4x/bulan			
8	Agustus	4x/bulan			
9	September	4x/bulan			
10	Oktober	4x/bulan			
11	November	4x/bulan			

Analisis :

Pada bulan ini, pemeliharaan genset dilakukan 4x dan sudah terlapor dengan baik.

Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan evaluasi berkala

Melalui link :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/110WG4QS8bLSVMEPsinZvqSZrNmPuELqYBKbs_oUd89Eo/edit?gid=2003963143#gid=2003963143

1.5.2.2.4 Panel Listrik

3.7.2 Tabel Capaian Pemeliharaan Panel

Bulan	Jumlah Target (satu bulan)	Capaian	Prosentase	Keterangan
Januari	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Maret	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
April	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Mei	4x/bulan			
Juni	4x/bulan			
Juli	4x/bulan			
Agustus	4x/bulan			
September	4x/bulan			
Oktober	4x/bulan			
November	4x/bulan			
Desember	4x/bulan			

Analisis :

Pemeliharaan panel listrik di Gedung A,B,C,D dilakukan 4x dalam satu bulan dan dilakukan rekapan dokumentasi. Kegiatan ini sudah berjalan sesuai target

Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan Evaluasi

1. Link Pemeliharaan Panel Gedung A
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1K3AmeFpNj9z9LRM1HECH586kvHODUBC>

[2dxtMaMTx1WQ/edit?gid=1843933243#gid=1843933243](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wHFESDvzTLN0KBqURQnOMLsTCiqXqpLWCMAG6OMZK7k/edit?gid=1843933243#gid=1843933243)

- 2. Link Pemeliharaan Panel Gedung B
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wHFESDvzTLN0KBqURQnOMLsTCiqXqpLWCMAG6OMZK7k/edit?gid=1243237048#gid=1243237048>
- 3. Link Pemeliharaan Panel Gedung C
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vg3l7 SLF6JsafyAZHxZKoPBLPgAbgEV92qYIFZj4M/edit?gid=183386497#gid=183386497>
- 4. Link Pemeliharaan Panel Gedung D
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Fj662P7GKprEiZdfb8deF4N2QJmVQGokfuJtxTLk8DQ/edit?gid=462403140#gid=462403140>
- 5. Link Pemeliharaan Panel Gedung E
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pBsP-cAEM1iC5zDKXn4KuGJAYz1vEbGXE73obF9jQ80/edit?gid=0#gid=0>
- 6. Link Pemeliharaan Panel LVMDP
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HH5lmQzu3mwuMa1Qj72tGD5eDJHUXIzD63VM4gWdNQ/edit?gid=0#gid=0>

1.5.2.2.5 Liquid Oksigen

1.5.2.2.5.1 Tabel Pencatatan Liquid Harian

April 2026							
Tanggal	Stok Liquid	Sebelum pengisian	Penggunaan	Satuan	Keterangan	Pengiriman	Satuan
01/04/2026	2007	1703	304	MMHG			MMHG
02/04/2026	1703	1354	349	MMHG			MMHG
03/04/2026	1354	918	436	MMHG			MMHG
03/04/2026	918	3394	0	MMHG	sesudah pengisian	2476	MMHG
04/04/2026	3394	3127	267	MMHG			MMHG
05/04/2026	3127	2804	323	MMHG			MMHG
06/04/2026	2804	2512	292	MMHG			MMHG
07/04/2026	2512	2209	303	MMHG			MMHG
08/04/2026	2209	1930	279	MMHG			MMHG
09/04/2026	1930	1635	295	MMHG			MMHG
10/04/2026	1350	3265	0	MMHG	sesudah pengisian	1915	MMHG
10/04/2026	3265	3225	40	MMHG			MMHG
11/04/2026	3225	2930	295	MMHG			MMHG
12/04/2026	2930	2644	286	MMHG			MMHG
13/04/2026	2644	2332	312	MMHG			MMHG
14/04/2026	2332	1996	336	MMHG			MMHG
15/04/2026	1996	1645	351	MMHG			MMHG
16/04/2026	1645	1038	607	MMHG			MMHG
17/04/2026	1038	3349	0	MMHG	sesudah pengisian	2311	MMHG
17/04/2026	3329	3219	110	MMHG			MMHG
18/04/2026	3219	2966	253	MMHG			MMHG
19/04/2026	2966	2668	298	MMHG			MMHG
20/04/2026	2668	2368	300	MMHG			MMHG
21/04/2026	2368	2034	334	MMHG			MMHG

22/04/2026	2034	1675	359	MMHG			MMHG
23/04/2026	1675	1132	543	MMHG			MMHG
24/04/2026	1132	3346	0	MMHG	sesudah pengisian	2214	MMHG
24/04/2026	3346	3222	124	MMHG			MMHG
25/04/2026	3222	2901	321	MMHG			MMHG
26/04/2026	2901	2608	293	MMHG			MMHG
27/04/2026	2608	2360	248	MMHG			MMHG
28/04/2026	2360	2113	247	MMHG			MMHG
29/04/2026	2113	1861	252	MMHG			MMHG
30/04/2026	1861	1363	498	MMHG			MMHG
Jumlah total pemakaian oksigen bulan ini			8166	MMHG			MMHG
Jumlah total pengisian liquid oksigen bulan ini						6440	MMHG
Rata-rata penggunaan okisgen per hari			571.8461538	MMHG			
Rata- rata pengisian liquid per bulan ini						3220	MMHG

Analisis :
 Kegiatan sudah dilakukan dengan baik sesuai target, setiap hari dilakukan pengecekan. Stok oksigen selalu terjaga.

Rencana Tindak Lanjut :
 Monitoring dan Evaluasi

1.5.2.2.6 IPAL

1.5.2.2.6.1 Tabel Capaian Pemeliharaan IPAL

BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
Januari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Maret	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
April	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Mei	1x/bulan			
Juni	1x/bulan			
Juli	1x/bulan			
Agustus	1x/bulan			
September	1x/bulan			
Oktober	1x/bulan			
November	1x/bulan			

Analisis :
 Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan. Pencatatan debit IPAL juga dilakukan dan di dokumentasikan.

Rencana Tindak Lanjut :
 Monitoring dan evaluasi melalui link:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yuzd_v1pO6Q2IDQr5clmEvCF-S-0EF2VI8LY_e93IQE/edit?gid=342425059#gid=342425059

1.5.2.2.7 Filter Air

3.7.3 Tabel Capaian Pemeliharaan Filter Air

BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
Januari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Maret	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
April	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Mei	1x/bulan			
Juni	1x/bulan			
Juli	1x/bulan			
Agustus	1x/bulan			
September	1x/bulan			
Oktober	1x/bulan			
November	1x/bulan			

Analisis :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi melalui
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1utB1tcauU1Xi-rY4On3PymLDuNIIV0egQRdVkhgSayw/edit?gid=392489547#gid=392489547>

1.5.2.2.8 Lift

1.5.2.2.8.1 List Lokasi Lift

NO	LOKASI	KONDISI
1	Lift Gedung A Pasien	Baik
2	Lift Gedung A Pengunjung	Baik
3	Lift Gedung B	Baik
4	Lift Gedung C Umum	Baik
5	Lift Gedung C Karyawan	Baik
6	Lift Gedung D (Garansi)	Baik

1.5.2.2.8.2 Tabel Capaian Pemeliharaan Lift

BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
Januari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Maret	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
April	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Mei				
Juni				

Juli				
Agustus				
September				
Oktober				
November				
Desember				

Analisis :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi melalui link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-qMBqK_KT7GLwypkDMOm-X2vb5cPJtVV/edit?gid=730491017#gid=730491017

1.5.2.2.9 UPS
1.5.2.2.9.1 Tabel Capaian Pemeliharaan UPS

BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
Januari	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Maret	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
April	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Mei				
Juni				
Juli				
Agustus				
September				
Oktober				
November				
Desember				

Analisis :

Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan evaluasi melalui link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1W11Uen83_wiMyVk-BL2oB4Nc24b7pgBOK6Lufn7skng/edit?usp=sharing

1.5.2.2.10 Air Minum

NAMA	LOKASI	KONDISI
Instalasi Air Minum 1	Lantai 1 Gedung C	Baik

BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
Januari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Maret	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
April	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Mei				
Juni				
Juli				
Agustus				
September				
Oktober				
November				
Desember				

Analisa :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

RTL :
monitoring dan evaluasi melalui link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aMBnSKVuoMC4Z1Wj1dya_t19f-XM272Mf0hcWAsBak4/edit?gid=0#gid=0

1.5.2.2.11 Filter Air Bersih Poli Gigi 1 dan Poli Gigi 2

NAMA	LOKASI	KONDISI
Filter Air Bersih Poli Gigi 1	Lantai 2D	Baik
Filter Air Bersih Poli Gigi 2	Lantai 2D	Baik

BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
Januari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target

Maret	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
April	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Mei				
Juni				
Juli				
Agustus				
September				
Oktober				
November				
Desember				

Analisa :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan
RTL :
monitoring dan evaluasi melalui link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aMBnSKVuoMC4Z1Wj1dya_t19f-XM272Mf0hcWAsBak4/edit?gid=0#gid=0

1.5.2.2.12 Rekapen Kegiatan External

Bulan	Jumlah Kegiatan	Waktu yang Dibutuhkan
Januari	19	47 jam 27 menit
Februari	12	37 jam 7 menit
Maret	15	33 jam 47 menit
April	12	24 jam 9 menit
Mei		
Juni		
Juli		
Agustus		
September		
Oktober		
November		
Desember		

April 2026										
DATE	TIME	URAIAN PEKERJAAN	UNIT AREA	PETUGAS	SELESAI	HASIL	JAM	MENIT		
01/04/2026	07:30	pendampingan teknisi instalasi dan pemasangan ups ct scan	rsdh	M Arifin	16:30	selesai	9			
02/04/2026	14:30	switch kompresor / switch scaller dental	klินิก karlos, klินิก ptp	M Arifin, Tulus j	16:45	selesai	2			
10/04/2026	10:30	pengecekan sound	klินิก ptp	M Arifin	11:30	selesai	1			
10/04/2026	11:30	suport perbaikan nuc/mini pc	klินิก ptp	M Arifin, Yonatan d	14:30	selesai	3			
11/04/2026	10:30	suport it tarik kabel lan ruang obat 3b	Rsphm	Dian T, Yonatan d	11:30	selesai	1			
13/04/2026	16:26	perbaikan ac bocor	klินิก ptp	Dian T	17:15	selesai				44
20/04/2026	14:41	pengambilan coldchain dari bedali ke ptp	klินิก bedali, klินิก ptp	Dian T, Yonatan d	16:18	selesai	2			55
22/04/2026	16:30	perbaikan ac server	klินิก ptp	Dian T,	20:30	selesai	4			

		bocor		Yonatan d				
		perbaikan psu mic wireles						
		perbaikan sound hall						
25/04/2026	09:47	perbaikan mobil mainan	Dpm	Dian T, Yonatan d	09:54	selesai		17
25/04/2026	11:44	perbaikan proyektor	klinik ptp	Dian T, Yonatan d	12:45	selesai	1	
TOTAL JAM DINAS LUAR							23	116
PEMBULATAN		DUA PULUH EMPAT JAM 9 MENIT					24	9

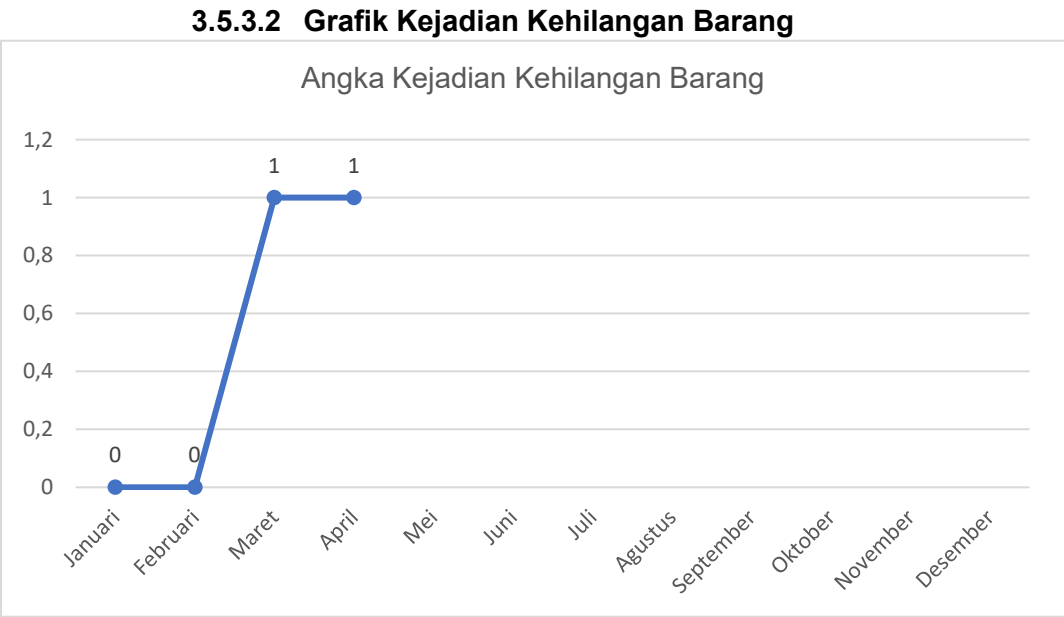
Keterangan :
 Total 24 jam 9 menit untuk perbantuan eksternal.

Rekapan link : <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y9Y3r4WUcch1rpMPxi3-kN2P5nlyuxZi/edit?gid=1966879934#gid=1966879934>

1.5.3 Security

3.5.3.1 Tabel Angka Kejadian Kehilangan Barang

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1	Angka kejadian kehilangan barang	0	0	1	1								



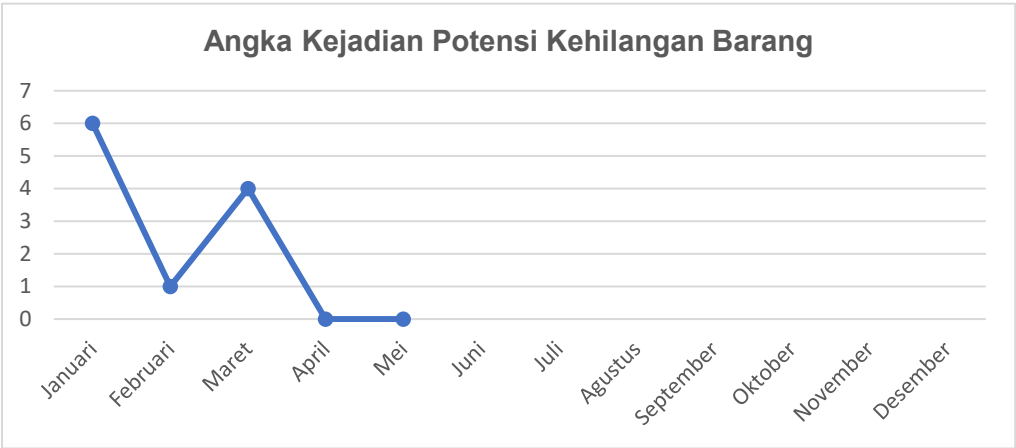
Analisa :
 Tidak ada kehilangan barang bulan ini

Rencana Tindak Lanjut :
 Monitoring dan evaluasi

3.7.4 Tabel Angka Potensi Kejadian Kehilangan Barang

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV
1	Angka kejadian kehilangan barang	6	1	4	0							

3.7.5 Grafik Angka Kejadian Kehilangan Barang



3.7.6 Tabel Angka Kejadian Berpotensi Kehilangan Barang

TANGGAL	KETERANGAN	RTL
Nihil	Nihil	Nihil

Analisis :

Alur berjalan baik. Pencatatan telah dilakukan dengan baik.

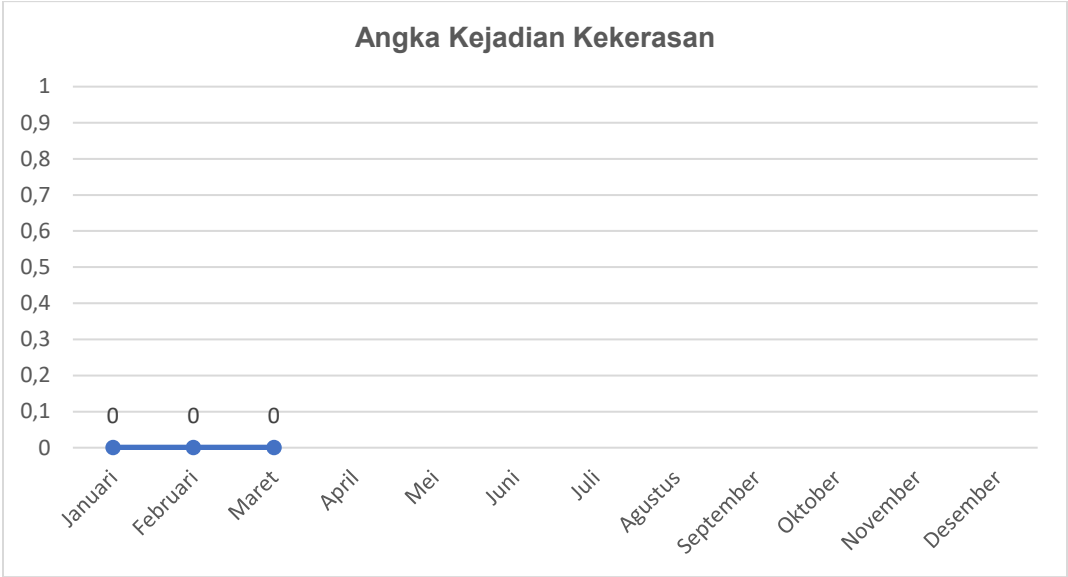
Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan evaluasi

3.5.3.3 Tabel Angka Kekerasan di Lingkungan Rumah Sakit

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV
1.	Angka kejadian kekerasan	0	0	0	0							

3.5.3.4 Grafik Angka Kejadian Kekerasan

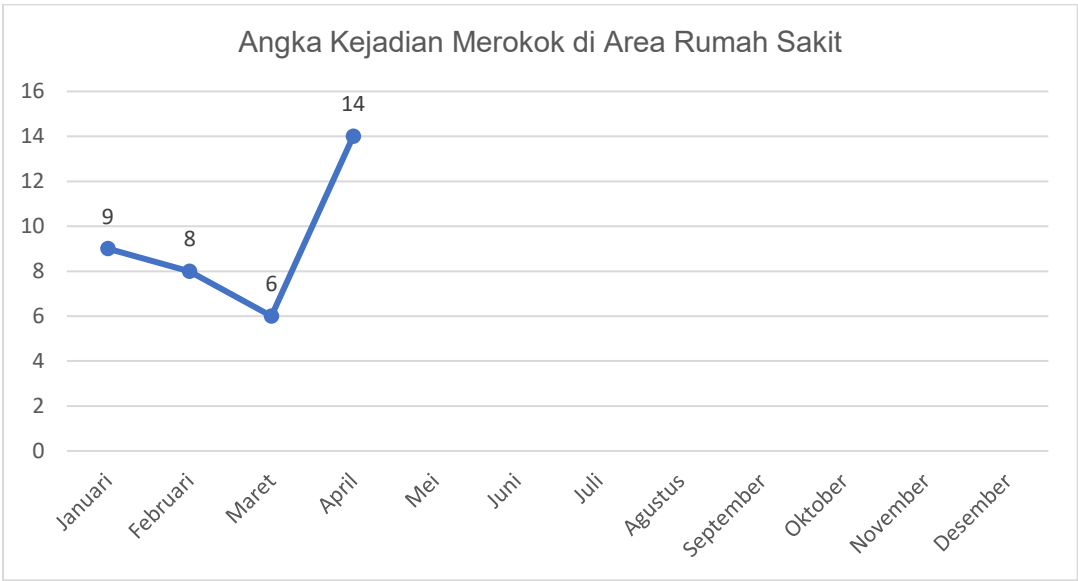


Analisis :
Tidak terdapat kejadian kekerasan karena pelayanan dilakukan dengan baik oleh seluruh karyawan dan tidak ada oknum yang menciptakan kerusuhan.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

3.5.3.5 Tabel Angka Kejadian Merokok di Area Rumah Sakit

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1	Angka kejadian merokok di area Rumah Sakit	9	8	6	14								

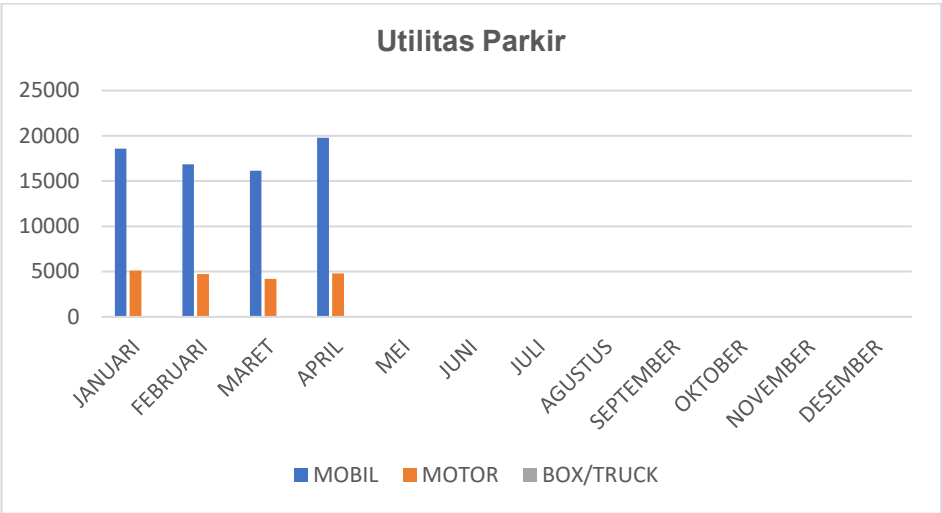


Analisis :
Angka 6 ini terindikasi masih belum terekap semua, hal ini ditunjukkan dari rata-rata per hari yang telah diedukasi karena merokok bisa lebih dari 1x.

Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring evaluasi. Pencatatan melalui WA grup dan operan shift dengan instrument dashboard spreadsheet.

3.5.4 Parkir



Analisis :

Progres parkir fluktuatif sesuai dengan kunjungan pasien dan jumlah hari libur

Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan evaluasi

3.5.5 Humas Marketing

3.5.5.1 Perjanjian Kerjasama (PKS)

3.5.5.1.1 Pencapaian Kinerja PKS – IKS Februari 2026

No	Bulan	Target	Jumlah					
			Berlaku	ED	Baru	Kurang Baru	Progres	Total Kurang
1	Januari	1 IKS baru	128	1	1	0	1 (Proses review)	1
2	Februari	1 IKS baru	131	2	1	2	1 (Proses Perpanjangan 2)	2
3	Maret	1 IKS baru	132	1	1	2	2 (Proses perpanjangan)	2
4	April	1 IKS baru	133	2	1	0	2 (Proses Perpanjangan)	1

Analisis ;

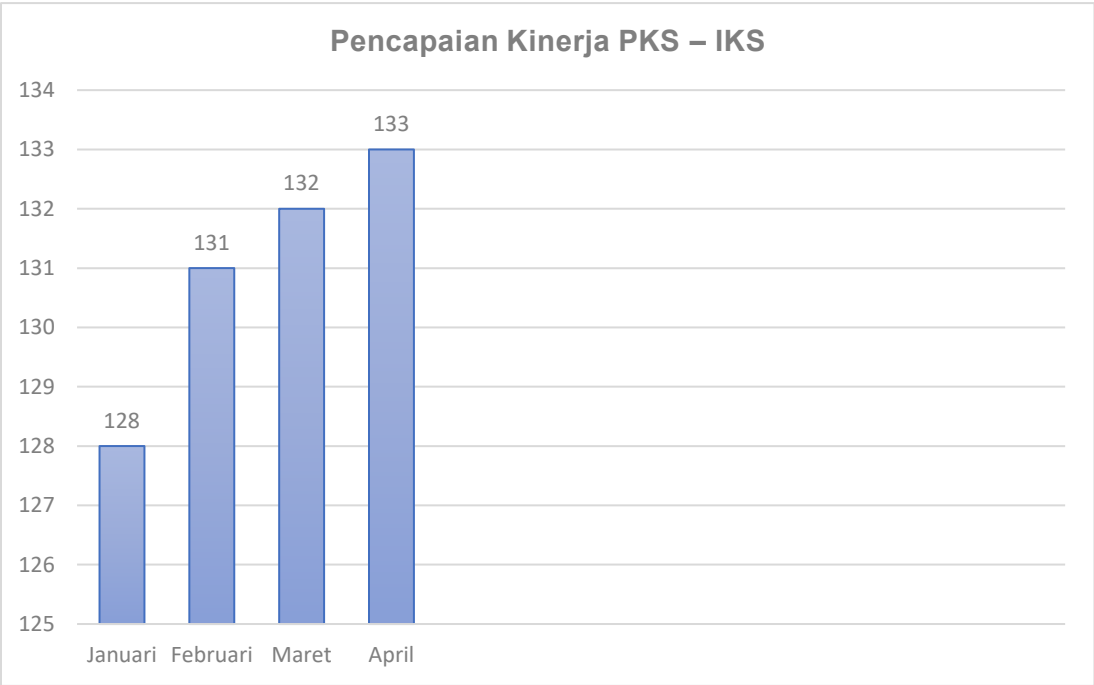
- Pada bulan April 2026, Perpanjangan MOU dengan Klinik Muslimat Singosari selesai, Perpanjangan MOU dengan Klinik Wijaya Husada Tahap Review Pihak ke-2, dan MOU Baru dengan PT CV Kurnia Edi Peni (KEP)
- Draft yang dikirim ke Pihak kedua dalam tahap Review

Rencana Tindak Lanjut :

- Memfollow up PKS yang sudah dikirim ke pihak kedua

3.5.5.1.2 Tabel Progres IKS Baru 2025

No	Nama PKS	Progres Pengurusan	Kendala
1	PT Global Excel	Review	Perbedaan template draft PKS
2	PT Malang Intermedia Pers	Review	Proses Review
3	Dispenduk Kab. Malang Ketan Ireng	TTD Pihak ke-2	Selesai
4	PT Mane Indonesia	Review	Proses Pihak Kedua
5	TPA Halodoc	Review	Proses Tanda Tangan
6	Klinik Waras Wiris	Review	Selesai
7	SLB tingkat Nasional Bagian C	Review	Selesai
8	PMI Kota Malang	Review	Selesai
9	PMI Kabupaten Malang	TTD Pihak ke-2	Menunggu TTD
10	SK dan PKS Tim Penerjemah untuk Akreditasi	Review	Selesai
11	MOU Kementrian Agama Kabupaten Malang	Review	Selesai
12	MOU Klinik Muslimat Singosari	Review	Proses Pihak Kedua
13	MOU klinik BLK Singosari	Review	Proses Pihak Kedua
14	RSUD Lawang	TTD Pihak ke-2	Menunggu TTD
15	Asuransi Astra Life	Review	Proses Review
16	Panti Nirmala	TTD Pihak ke-2	Menunggu TTD
17	Panglima Sudirman	Review	Proses Review
18	Klinik Muslimat Singosari	TTD Pihak ke-2	Selesai
19	Klinik Wijaya Husada	Review	Proses Review
20	PT CV Kurnia Edi Peni (KEP)	Proses TTD Dir PT	Proses TTD Dir PT



3.5.5.2 Medical Check Up (MCU)

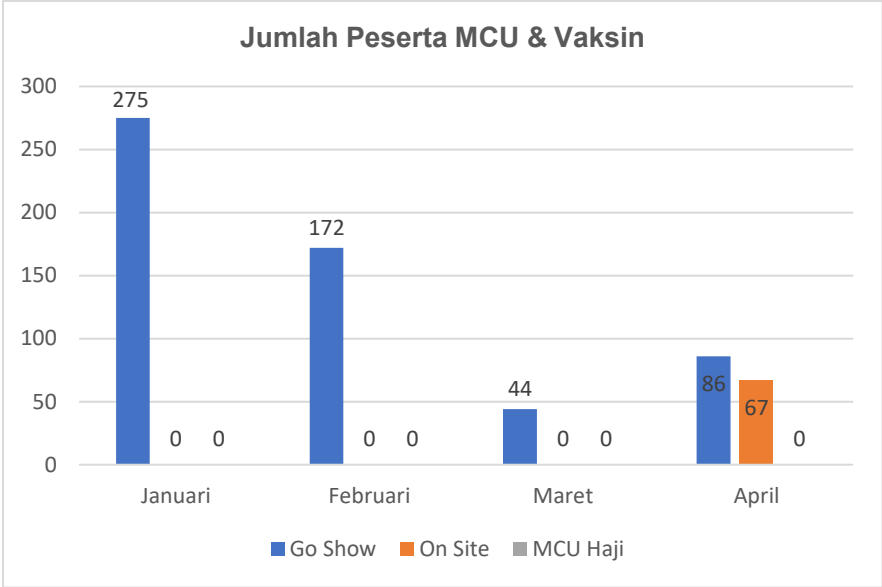
1.5.5.2.1 Pencapaian Hasil Kinerja MCU dan Vaksin Tahun 2026

No	Bulan	Target	Jumlah Pasien GOSHOW	ON SITE
1	Januari	150	275	-

2	Februari	150	172	-
3	Maret	150	44	-
4	April	150	86	67

Analisis ;
Jumlah peserta MCU dan Vaksin bulan April mengalami peningkatan kunjungan goshow sebesar 42 pasien atau sekitar 95.45% dari periode sebelumnya dan ada 67 peserta onsite perusahaan.

Rencana Tindak Lanjut :
1. Melakukan Promosi kesehatan kembali melalui Social Media
2. Kunjungan Perusahaan dan sekolah untuk menawarkan program MCU



1.5.5.2.2 Tabel Evaluasi Hasil Penawaran MCU Tahun 2026

NO	BULAN	INSTANSI	HASIL
1	Januari	PT Sinergi Pangan	Sudah terlaksana MCU dengan 12 Orang di Rumah Sakit
		Travel Kbih Al Muchsinin	Sudah dilaksanakan Vaksin dengan 24 Jamaah di RSPHM
		Travel King Salman	Sudah dilaksanakan Vaksin dengan 5 Jamaah di RSPHM
2	Februari	PT Pangan Lestari Malang	Sudah terlaksana MCU dengan 12 Orang di Rumah Sakit
		PT Riset Perkebunan Nusantara	Sudah terlaksana MCU dengan 1 Orang di Rumah Sakit
3	Maret	PT Multi Daya Mitra	Tidak berhasil karena Harga Tinggi
		PT Bangun Sarana Wreksa	Belum terlaksana karena perubahan Pimpinan dan Penawaran masih diajukan kembali
4	April	PT Bangun Sarana Wreksa	Pimpinan belum ingin melaksanakan MCU
		PT indonesian Tobacco Tbk	Sudah Terlaksana dengan 2 Peserta di Rumah Sakit
		PT Arthawena	Pelaksanaan MCU ikut dengan kegiatan Skrining Klinik Mutiara Sehat
		PT Green Mountains Natural Foods	Sudah terlaksana MCU Onsite dengan 67 Peserta di Perusahaan
		Penelitian FK UMM	Sudah Terlaksana dengan 11 Peserta di Rumah Sakit

3.5.5.2.3 Kegiatan Kunjungan Eksternal

3.5.5.2.3.1 Tabel Jumlah Kunjungan Eksternal

Target	No	Tanggal	Instansi	Kegiatan Yang Dilakukan	Hasil Yang Diperoleh	Tindak Lanjut
5 Kunjungan per bulan	1	12/01/2026	PT TENTREM	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	1. Mendapatkan Respon positif, 2. PIC tertarik dalam program MCU, dan akan disampaikan kepada pimpinan Perusahaan	Follow up kembali untuk Kegiatan MCU
	2	12/01/2026	PT KEMAS SUPER INDONESIA (KSI)	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	Belum ada respon	Follow up ulang akhir bulan
	3	12/01/2026	PT ARTHAWENA SAKTI GEMILANG	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	1. Mendapatkan Respon positif, 2. PIC tertarik dalam program MCU, dan akan disampaikan kepada pimpinan Perusahaan	Follow up kembali untuk Kegiatan MCU

	4	12/01/2026	PT BANGUN SARANA WREKSA	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	1. Mendapatkan Respon positif, 2. PIC tertarik dalam program MCU, dan akan mempelajari penawaran terlebih dahulu	Follow up kembali untuk Kegiatan MCU
	5	12/01/2026	CV AUMIRETA ANGGUN	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	Belum ada respon	Follow up ulang akhir bulan
	6	12/01/2026	PT CIPTA SANDHI DARMA	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	Belum ada respon	Follow up ulang akhir bulan

	7	12/01/2026	PT INTAN PRAMADITA	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	1. Mendapatkan Respon positif, 2. PIC tertarik dalam program MCU, dan akan mempelajari penawaran terlebih dahulu 3. PIC menanyakan untuk paket Pemeriksaan Narkoba dan sudah dijelaskan	Follow up kembali untuk Kegiatan MCU
	8	12/01/2026	PT INDOMARINE	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	1. Mendapatkan Respon positif, 2. PIC tertarik dalam program MCU, dan akan mempelajari penawaran terlebih dahulu 3. PIC menyampaikan penawaran akan menjadi bahan referensi	Follow up kembali untuk Kegiatan MCU
	9	12/01/2026	PT LAWANGMAS PRIMAPACK INDONESIA	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	Belum ada respon	Follow up ulang akhir bulan

	10	12/01/2026	PT MALINDO INTITAMA RAYA	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	1. Mendapatkan Respon positif, 2. PIC tertarik dalam program MCU, dan akan mempelajari penawaran terlebih dahulu	Follow up kembali untuk Kegiatan MCU
	11	12/01/2026	PT UNGGUL ANUGRAH SEJAHTERA	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	1. Mendapatkan Respon positif, 2. PIC tertarik dalam program MCU, 3. PIC akan menanyakan kepada pimpinan dan bila pimpinan mengadakan program MCU akan di arahkan ke RS	Follow up kembali untuk Kegiatan MCU
	12	15/01/2026	PT OTSUKA	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	Belum ada respon	Follow up ulang akhir bulan

	13	15/01/2026	PT RAGAM RAYA RASA	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	Mendapatkan Respon positif terkait penawaran	Follow up ulang akhir bulan
	14	15/01/2026	PT KHARISMA SELARAS	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	Mendapatkan Respon positif terkait penawaran	Follow up ulang akhir bulan
	15	15/01/2026	PT ADI PUTRO	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	Mendapatkan Respon positif terkait penawaran	Follow up ulang akhir bulan

	16	15/01/2026	PT USTEGRA	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	Mendapatkan Respon positif terkait penawaran	Follow up ulang akhir bulan
	17	15/01/2026	PT INDOSTAR BUILDING MATERIAL	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	Belum ada respon	Follow up ulang akhir bulan
	18	15/01/2026	PT SUMBER ALFARIA	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	1. Mendapatkan Respon positif, 2. PIC tertarik dalam program MCU, dan akan disampaikan kepada pimpinan Perusahaan	Follow up kembali untuk Kegiatan MCU

	19	15/01/2026	PT WIM (KTG)	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	1. Mendapatkan Respon positif, 2. PIC tertarik dalam program MCU, dan akan disampaikan kepada pimpinan Perusahaan	Follow up kembali untuk Kegiatan MCU
	20	20/01/2026	PT SINAR TAMAN PLASTINDO	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	Belum ada respon	Follow up ulang akhir bulan
	21	20/01/2026	PT PADMA INDAH PRIMA PERKASA	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	Belum ada respon	Follow up ulang akhir bulan
	22	31/01/2026	Kegiatan Senam Yoga Lansia	1. Program dengan komunitas Lansia geriatri berupa Yoga 2. Jumlah peserta 56 orang 3. Peserta aktif mengikuti seluruh kegiatan	Kegiatan berjalan dengan baik, peserta sangat antusias mengikuti kegiatan	Koordinasi dengan PKRS untuk agenda selanjutnya

	23	03/02/2026	PT Pangan Lestari	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	1. Hasil FU Mendapatkan Respon positif, 2. PIC tertarik dalam program MCU, 3. Pembahasan Kebutuhan MCU dan Harga Penawaran Terbaru 4. PIC menyampaikan untuk penawaran tersebut akan disampaikan kepada pimpinan Perusahaan	Follow up untuk Agreement Letter
	24	06/02/2026	PT Multi Daya Mitra	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	1. Hasil FU Mendapatkan Respon positif, 2. PIC tertarik dalam program MCU, 3. Pembahasan Kebutuhan MCU dan Harga Penawaran Terbaru 4. PIC menyampaikan untuk penawaran tersebut akan disampaikan kepada pimpinan Perusahaan	Follow up ulang
	25	09/02/2026	PT Bangun Sarana Wreksa	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	1. Hasil FU Mendapatkan Respon positif, 2. PIC tertarik dalam program MCU, 3. Pembahasan Kebutuhan MCU dan Harga Penawaran Terbaru 4. PIC menyampaikan untuk penawaran tersebut akan disampaikan kepada pimpinan Perusahaan	Follow up ulang akhir bulan
	26	11/02/2026	Puskesmas Lawang	1. Monitoring jumlah rujukan bulan sebelumnya. 2. Diskusi kendala pelayanan pasien. 3. Informasi program Vaksinasi dan MCU	1. Puskesmas menyampaikan koordinasi dengan tim pelayanan sudah baik dan bagus karena selalu direspon dengan cepat 2. Puskesmas menyampaikan bahwa adanya beberapa pasien yang sudah tidak aktif BPJSnya, walaupun pemberitahuan Program BPJS baru dinformasikan tetapi dari bulan januari sudah ada peserta BPJS yang dinonaktifkan dan harus melakukan konfirmasi ke pihak	1. Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik 2. Melakukan koordinasi dengan Kabid untuk tindak lanjut terkait kendala

					desa menerima informasi layanan terbaru. Kritik dan Saran : 1. Puskesmas menyampaikan untuk ltr pasien yang mendapatkan obat yang bisa didapatkan di Faskes apakah bisa jika di PRBkan saja 2. Puskesmas menyampaikan mohon dibantu untuk menginformasikan kepada pasien terkait SRB diberikan ke Puskesmas dan pasien tidak perlu membawa SRB ketika menuju ke RS	
	27	11/02/2026	Klinik Garuda	1. Monitoring jumlah rujukan bulan sebelumnya. 2. Diskusi kendala pelayanan pasien. 3. Informasi program Vaksinasi dan MCU	1. Klinik menyampaikan koordinasi dengan tim RS sudah baik dan selalu direspon dengan cepat 2. Klinik menyampaikan bahwa adanya perubahan jadwal di klinik dari yang biasanya buka sampai dengan jam 20.00, berubah hanya sampai jam 15.00, sehingga beberapa peserta klinik ada yang berganti ke faskes lain. Kritik dan Saran : 1. Klinik menyampaikan bahwa ada satu pasien yang diminta untuk kembali ke klinik dengan memberikan surat pemeriksaan dari IGD dan meminta untuk dibuatkan rujukan, apakah bisa dibantu untuk pemeriksaan dari IGD diberikan surat keterangan bila memang hasil pemeriksaan di IGD menyatakan Perlu untuk dibuatkan rujukan maka pasien diberikan surat keterangan hasil pemeriksaan agar klinik bisa	1. Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik 2. Melakukan koordinasi dengan Kabid untuk tindak lanjut terkait kendala

					mengkonfirmasi dengan data tersebut	
	28	11/02/2026	Puskesmas Singosari	1. Monitoring jumlah rujukan bulan sebelumnya. 2. Diskusi kendala pelayanan pasien. 3. Informasi program Vaksinasi dan MCU	1. Klinik menyampaikan koordinasi dengan tim RS cukup baik dan selalu direspon dengan cepat Kritik dan Saran : 1. Puskesmas menyampaikan untuk PRB pasien dari RS PHM masih sedikit sedangkan rapot puskesmas di BPJS merah di RS PHM 2. Puskesmas menyampaikan ada satu pasien dengan 2 rujukan yang aktif dan 1 rujukan tersebut obatnya di PRB kan, tetapi dari RS memberikan Obat untuk 2 rujukan sehingga ketika Puskesmas memberikan klaim ke Kimia Farma, mereka meminta untuk obat tersebut dikembalikan karena pihak kimia farma tidak bisa mengklaim obat PRB yang diberikan oleh RS 3. Pihak Puskesmas meminta tolong untuk ketika ada pasien yang membutuhkan dua rujukan apakah bisa jika diselangi untuk jadwal kontrolnya sehingga habisnya berbeda 4. Puskesmas menyampaikan untuk diagnosa dokter dicky masih dibuat berbeda dengan kondisi asli pasien, seperti cholelithiasis dibuat ulcerative 5. Pihak Puskesmas meminta saran untuk Print Out resume pulang	

					pasien karena data tersebut digunakan jika ada audit dari BPJS 6. Adapun penolakan dari IGD untuk rujukan jantung dari Puskesmas Singosari di bulan Desember rujukan jantung dengan hasil EKG SVT, dari RS Prima husada menginformasikan bahwa tindakan PCI belum ada dan pasien hanya bisa ditindak rawat inap saja sedangkan ketika puskesmas konfirmasi ke marsudi rujukan langsung diterima dengan tindakan kejut jantung sesuai dengan SOAP yg diberikan oleh tim puskemas	
	29	16/02/2026	PMI Kabupaten Malang	Menyampaikan dokumen Pembaruan PKS dengan PMI Kabupaten Malang	Sudah diterima oleh PIC PMI Kabupaten Malang	Follow up MOU
	30	16/02/2026	PMI Kota Malang	Menyampaikan dokumen Pembaruan PKS dengan PMI Kota Malang	Sudah diterima oleh PIC PMI Kota Malang	Follow up MOU
	31	24/02/2026	SLB Tingkat Nasional Bagian C	Menyampaikan dokumen MOU dengan SLB Tingkat Nasional Bagian C untuk kebutuhan Penerjemah Bahasa Isyarat	Sudah diterima oleh PIC SLB Tingkat Nasional Bagian C	Follow up MOU
	32	24/02/2026	PMI Kota Malang	Pengambilan MOU yang sudah selesai	Sudah diterima oleh Humas	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	33	24/02/2026	Kementrian Agama Kabupaten Malang	Menyampaikan dokumen MOU dengan Kementrian Agama Kabupaten Malang untuk kebutuhan Bimbingan kerohanian	Sudah diterima oleh PIC Kementrian Agama Kabupaten Malang	Follow up MOU

	34	27/02/2026	Kementrian Agama Kabupaten Malang	Pengambilan MOU yang sudah selesai	Sudah diterima oleh Humas	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	35	27/02/2026	SLB Tingkat Nasional Bagian C	Pengambilan MOU yang sudah selesai	Sudah diterima oleh Humas	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	36	10/03/2026	Klinik Waras Wiris	Mengantarkan MOU yang sudah selesai	Sudah diterima oleh Ibu Kholifa	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	37	10/03/2026	Fitness Plus Singosari	1. Mengantarkan MOU yang sudah selesai 2. Koordinasi terkait Cross selling yang akan terjadi antara Fitness Plus Singosari dengan RS PHM	1. Sudah diterima oleh Mba Nanda 2. Koordinasi dilakukan terkait kerjasam Flyer Membership Fitness Plus 3. Voucher MCU RSPHM 4. Penempatan desain Banner untuk diletakkan di Fitness Plus	Menginformasikan hal tersebut kepada Kepala Bidang dan Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	38	14/03/2026	Klinik Losari Medika	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh PIC Pendaftaran atas nama wahyu	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	39	14/03/2026	Bidan Indi (KRI Putra Husada)	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh PIC Pendaftaran atas nama diandra	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	40	14/03/2026	Klinik BLK	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh PIC Ibu Ria	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	41	14/03/2026	Klinik Mitra Prima Care	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh PIC Dokter tari	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	42	14/03/2026	Puskesmas Lawang	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh PIC Ibu Reni	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	43	16/03/2026	CV Aumireta Anggun	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh Team Security	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	44	16/03/2026	PT Kemas Super Indonesia	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh Security Pak Suryono	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama

						yang baik
	45	16/03/2026	PT Malindo Intitama Raya	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh Security Pak Gunawan	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	46	16/03/2026	PT Molindo Raya Industri	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh Security Pak Yudi	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	47	16/03/2026	PT Bangun Sarana Wreksa	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh Bapak Nanda	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	48	16/03/2026	PT Pesta Pora Abadi	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh PIC Ibu Reni	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	49	16/03/2026	PT Kencana Tiara Gemilang	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh Security Andik	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	50	16/03/2026	PT Lawangmas Primapack Indonesia	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh PIC Bapak Dian	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	51	16/03/2026	Puskesmas Ardimulyo	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh PIC Mailing Ibu Vale	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	52	16/03/2026	Klinik Garuda	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh PIC Ibu Dinda	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	53	16/03/2026	Klinik Brawijaya Lawang	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh PIC TU Pak Rizza	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	54	16/03/2026	DPM Lidya Putri	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh ibu resi	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	55	16/03/2026	DPM Suhariningsih	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh PIC Pendaftaran Rosia	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	56	16/03/2026	DPM Farida Rusniah	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh PIC Bapak Setiani	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	57	16/03/2026	KRI Muslimat Singosari	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh PIC Ibu devi putri	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik

	58	16/03/2026	Klinik Wijaya Husada	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh PIC Ibu Yeni	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	59	16/03/2026	DPM Wulandarti Wien	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh Anak atas nama Ibu Nastiti	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	60	17/03/2026	PT Jasa Raharja	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh PIC bapak Hari	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	61	17/03/2026	Klinik Kartini Medika	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh Security Rendy	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	62	17/03/2026	Klinik Nayaka 02	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh Dokter Virda	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	63	17/03/2026	DPM Arry Budiarti	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh Suami	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	64	18/03/2026	DPM Ida Bagus D.	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh dr Ida Bagus	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	65	18/03/2026	PKM Singosari	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh Dokter syamsu	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	66	18/03/2026	DPM Yosephine Pratiwi	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh PIC Pendaftaran Novi	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	67	18/03/2026	PT Kharisma Selaras	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh Ibu Lina	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	68	18/03/2026	PT Indostar Building Material	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh Ibu Riri	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	69	18/03/2026	Relawan Siaga Utara (RESITA)	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh Istri	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	70	07/04/2026	Nestle Bear Brand	Mengantarkan kiriman Susu Kloter pertama untuk RS Prima Husada Malang Tahun 2026	Sudah diterima dan sudah diinformasikan untuk bukti penerimaan kepada pihak Bear Brand	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik

	71	15/04/2026	Fitness Plus Singosari	1. Mengantarkan Banner dan Voucher diskon untuk membership dan Karyawan dari Fitness Plus 2. Koordinasi terkait dengan promo membership Fitness Plus kepada Staff RS Prima Husada Malang	1. Sudah disampaikan terkait dengan mekanisme penggunaan voucher dan diterima dengan baik oleh pihak Fitness Plus Singosari 2. Permintaan Promo untuk karyawan RS Prima Husada Malang sudah di proses, jika ada peserta yang akan daftar membership maka akan dibantu daftar dari Humas	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	72	22/04/2026	Klinik Muslimat Singosari	Mengirimkan Perpanjangan MOU dengan Klinik	Sudah diterima oleh ibu Devi	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	73	27/04/2026	Relawan Ambulance (Resita)	Menyerahkan MOU dan Susu Bear Brand serta monitoring apakah ada kesulitan ketika mengantarkan pasien ke RS Prima Husada	1. Susu Bear Brand sudah diterima, MOU sudah diterima langsung dengan Pak Jali 2. Evaluasi sudah baik, tidak ada kesulitan dan pasien yang diantarkan juga diterima dengan baik	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	74	27/04/2026	Indonesian Tobacco Tbk.	Menyerahkan Hasil MCU dan Tagihan MCU kepada Perusahaan	Sudah diterima oleh bapak Bryllian	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	75	27/04/2026	Shanaya Resort	Menyerahkan Hasil MCU dan Tagihan MCU kepada Shanaya Resort	Sudah diterima oleh mba Stefani	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	76	27/04/2026	PT Green Mountains Natural Foods	1. Menyerahkan Tabung Sampling untuk pemeriksaan FL dan penyampaian terkait alur dan tata cara sampling 2. Cek Lokasi untuk bis MCU	1. Sudah diterima oleh Ibu Harnanik. 2. Sudah dilakukan pengecekan terakit dengan Lokasi Bis MCU dan semua aman	Bina komunikasi untuk Koordinasi pelaksanaan MCU

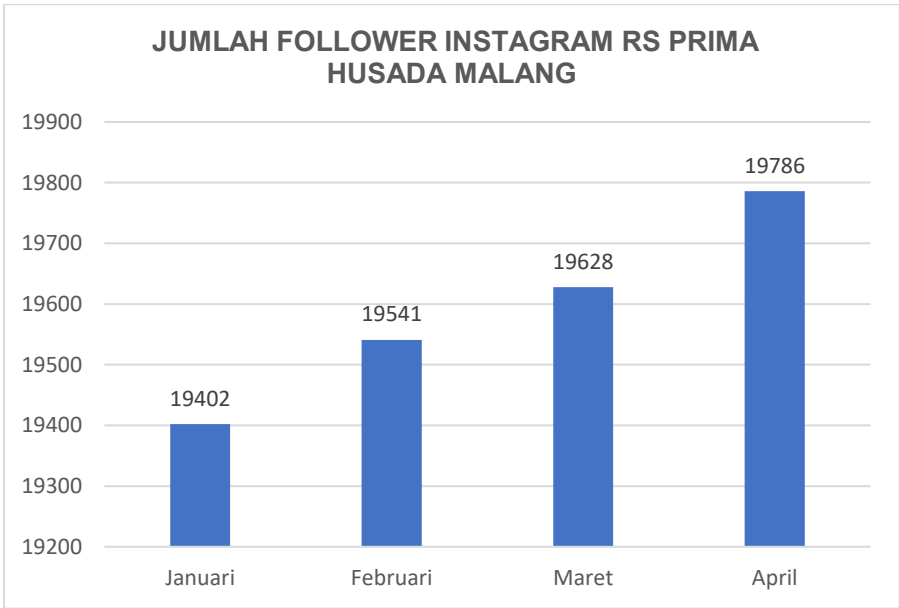
Tabel Hasil Kinerja Event Eksternal Humas Marketing RSPHM Pada Tahun 2026

Target	No	Tanggal	Instansi	Kegiatan Yang Dilakukan	Hasil Yang Diperoleh	Tindak Lanjut
MCU dan Vaksin	1	09/01/2026	PT Sinergi Pangan Gemilang	Program MCU Karyawan di RS dengan PT Sinergi Pangan Gemilang	Sudah dilaksanakan untuk Program MCU sesuai ketentuan penawaran dengan 12 Orang	Hasil Pemeriksaan telah diberikan
MCU dan Vaksin	2	14/01/2026	KBIH AI Muchsinin	Program Vaksin 24 jamaah Travel	Sudah dilaksanakan vaksin untuk 24 orang di tanggal 14 Januari 2026	Sudah selesai
MCU dan Vaksin	3	26/01/2026	KBIH Alfattah Singosari	Program Vaksin 9 jamaah Travel	Sudah dilaksanakan Vaksin untuk 6 Orang di tanggal 14 Januari 2026	Sudah selesai
MCU dan Vaksin	4	26/01/2026	Travel King Salman	Program Vaksin 5 jamaah Travel	Sudah dilaksanakan untuk vaksin sesuai ketentuan penawaran dengan 6 Orang	Sudah selesai
MCU dan Vaksin	5	04/02/2026	PT Riset Perkebunan Nusantara	Program MCU Karyawan Baru di RS dengan PT Riset Perkebunan Nusantara	Sudah dilaksanakan untuk Program MCU sesuai ketentuan penawaran dengan 1 Orang	Sudah selesai
MCU dan Vaksin	6	19/02/2026	PT Pangan Lestari Malang	Program MCU Karyawan di RS dengan PT Pangan Lestari Malang	Sudah dilaksanakan untuk Program MCU sesuai ketentuan penawaran dengan 12 Orang	Sudah selesai
MCU dan Vaksin	7	29/04/2026	PT Green Mountains Natural Foods	Program MCU Karyawan di RS dengan PT Green Mountains Natural Foods	Sudah dilaksanakan untuk Program MCU sesuai ketentuan penawaran dengan 67 Orang	Sudah Selesai

1.5.5.2.4 Digital Marketing

1.5.5.2.4.1 Daftar Kegiatan Digital Marketing

JUMLAH KONTEN BARU	JANUAR I	FEBRUAR I	MARE T	APRI L	ME I	JUN I	JUL I	AGUSTU S	SEPTEMBE R	OKTOBE R	NOVEMBE R	DESEMBE R
FEED FOTO	12	5	16	13								
REELS	4	6	6	8								
STORY	13	31	28	22								
TOTAL	29	41	50	43								0
JUMLAH TOTAL POSTINGAN (BARU + LAMA)	JANUAR I	FEBRUAR I	MARE T	APRI L	ME I	JUN I	JUL I	AGUSTU S	SEPTEMBE R	OKTOBE R	NOVEMBE R	DESEMBE R
FEED FOTO	13	5	16	14								
FEED VIDEO	4	6	6	8								
REELS	4	6	6	8								
STORY	89	85	53	82								
TOTAL	110	102	81	112								
JENIS	JANUAR I	FEBRUAR I	MARE T	APRI L	ME I	JUN I	JUL I	AGUSTU S	SEPTEMBE R	OKTOBE R	NOVEMBE R	DESEMBE R
JUMLAH FOLLOWER (CUT OFF TANGGAL 1)	19402	19541	19628	19786								
JENIS	JANUAR I	FEBRUAR I	MARE T	APRI L	ME I	JUN I	JUL I	AGUSTU S	SEPTEMBE R	OKTOBE R	NOVEMBE R	DESEMBE R
JUMLAH PENINGKATAN FOLLOWER	311	242300	177	285								
TARGET	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300



Analisa :

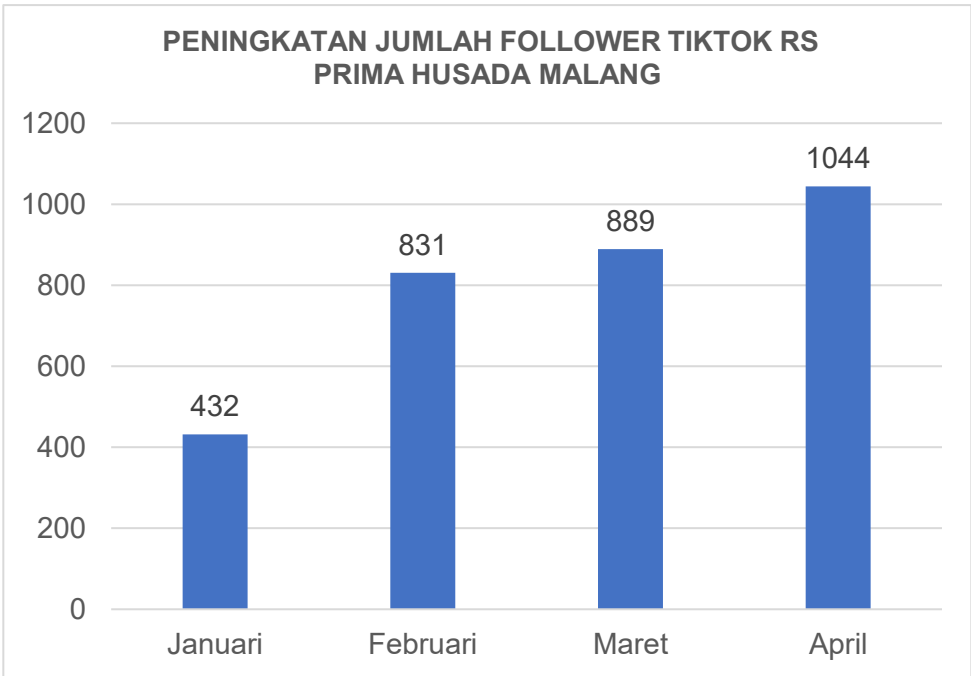
Jumlah Follower Instagram RS Prima Husada Malang mengalami peningkatan sebanyak 87 Followers atau sebesar 0.80% dari bulan sebelumnya

Rencana Tindal Lanjut :

- 1. Terus melakukan Konsistensi upload dan posting kegiatan RS setiap harinya
- 2. Mencari waktu yang tepat untuk memposting agar meningkatkan viewers
- 3. melakukan kolaborasi konten dengan Unit lain untuk memperbarui isi Konten

Platform Tik Tok

JENIS	JANUA RI	FEBRU ARI	MARE T	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST US	SEPTEMB ER	OKTOB ER	NOVEMBE R	DESEMB ER
JUMLAH KONTEN BARU	2	9	5	5								
TARGET	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
JENIS	JANUA RI	FEBRU ARI	MARE T	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST US	SEPTEMB ER	OKTOB ER	NOVEMBE R	DESEMB ER
JUMLAH FOLLOWER (CUT OFF TANGGAL 1)	432	831	889	1044								
JENIS	JANUA RI	FEBRU ARI	MARE T	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST US	SEPTEMB ER	OKTOB ER	NOVEMBE R	DESEMB ER
JUMLAH PENINGKATA N FOLLOWER	23	399	58	155								
TARGET	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
JENIS	JANUA RI	FEBRU ARI	MARE T	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST US	SEPTEMB ER	OKTOB ER	NOVEMBE R	DESEMB ER
JUMLAH LIKE	1876	3374	3753	4477								



Analisa :

Jumlah Follower Tiktok RS Prima Husada Malang mengalami peningkatan sebanyak 155 Followers atau sebesar 17,44% dari bulan sebelumnya

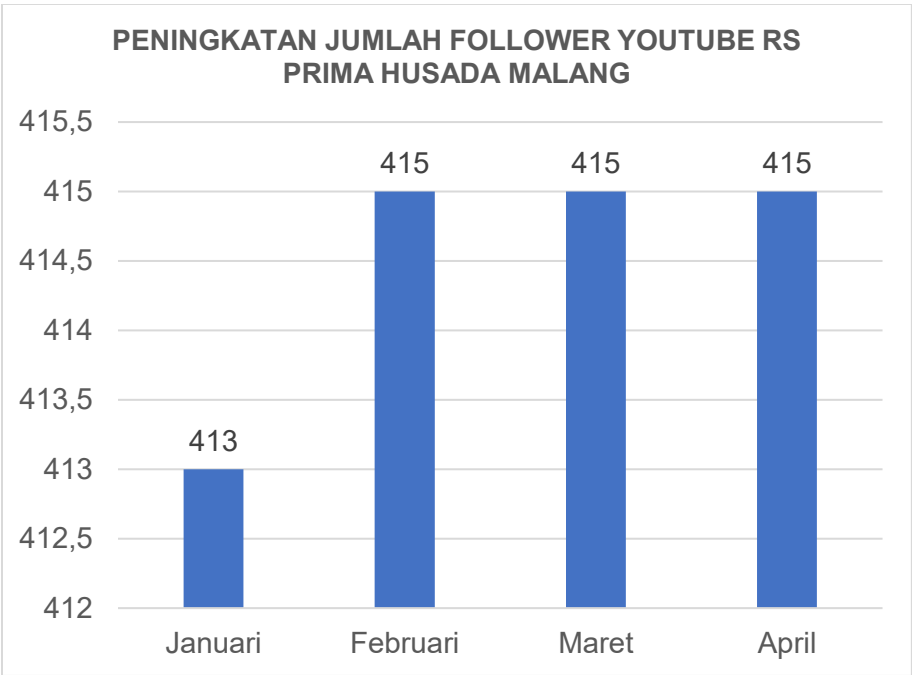
Rencana Tindal Lanjut :

- 1. Terus melakukan Konsistensi upload dan posting kegiatan RS kolaborasi dengan PKRS
- 2. Mencari waktu yang tepat untuk memposting agar meningkatkan viewers
- 3. melakukan kolaborasi konten dengan Unit lain untuk memperbarui isi Konten

Platform Youtube

JENIS	JANUA RI	FEBRUA RI	MARE T	APRI L	ME I	JUN I	JU LI	AGUST US	SEPTEMB ER	OKTOB ER	NOVEMBE R	DESEMB ER
JUMLAH KONTEN BARU	0	0	0	0								
TARGET	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

JENIS	JANUA RI	FEBRUA RI	MARE T	APRI L	ME I	JUN I	JU LI	AGUST US	SEPTEMB ER	OKTOB ER	NOVEMBE R	DESEMB ER
JUMLAH SUBS	413	415	415	415								
JENIS	JANUA RI	FEBRUA RI	MARE T	APRI L	ME I	JUN I	JU LI	AGUST US	SEPTEMB ER	OKTOB ER	NOVEMBE R	DESEMB ER
JUMLAH PENINGKATAN SUBS	5	2	0	0								0
TARGET	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

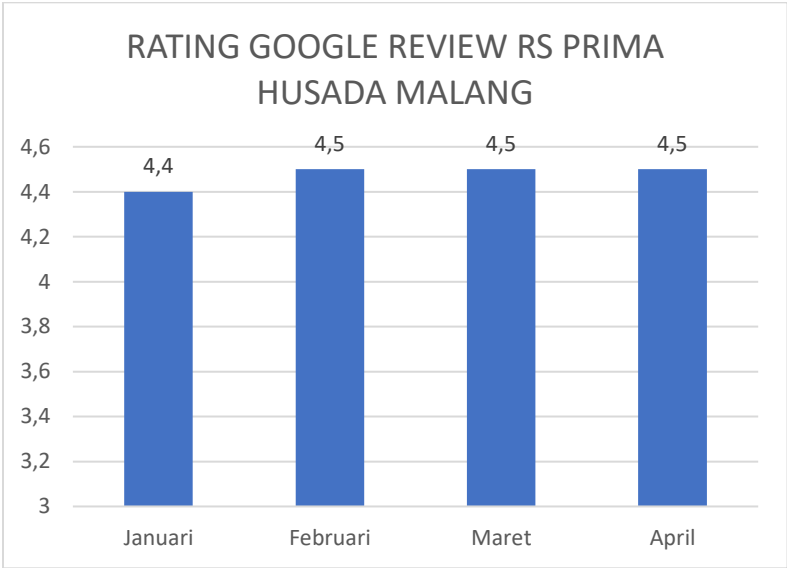


Analisa :
Jumlah Follower Youtube RS Prima Husada Malang mengalami peningkatan Sebesar 1,23 % dari bulan Sebelumnya

- Rencana Tindal Lanjut :**
- 1. Terus melakukan Konsistensi upload dan posting kegiatan RS kolaborasi dengan PKRS
 - 2. Mencari waktu yang tepat untuk memposting agar meningkatkan viewers
 - 3. melakukan kolaborasi konten dengan Unit lain untuk memperbarui isi Konten

Google Review

PROGRESS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH RATING	4.4	4.5	4.5	4.5								



BULAN	RATE CAPAIAN GOOGLE REVIEW	
	POSITIF	NEGATIF
Januari	122	4
Februari	133	3
Maret	114	5
April	149	9

- Analisa :
1. Progres untuk Rating Google Review RS Prima Husada Malang tidak mengalami peningkatan maupun penurunan dari bulan sebelumnya
 2. Pengisian Google Review mengalami penurunan 17 review atau sekitar 12,50% dibanding bulan sebelumnya.
 3. Pengisian Google Review dengan Rate Positif mengalami penurunan 19 review atau sekitar 14,29% dibanding bulan sebelumnya.
 4. Pengisian Google Review dengan Rate Negatif mengalami kenaikan 2 Review atau sekitar 66.67% dibanding bulan sebelumnya.

- Rencana Tindal Lanjut :
1. Meningkatkan Survei kepuasan pasien dengan melakukan pengisian Google Review

3.5.5 Penjaminan

3.5.5.1 Piutang

3.5.5.1.2 Analisa Progres Penyelesaian Piutang

PERIODE APRIL 2026 :																
1	Asuransi	409.160.190	157.320.305	2.198.680	249.041.204	153.031.015	37.119.969	764.939	115.146.107	364.187.311	222.996.552	23.736.454	21.614.713	15.386.884	80.453.509	364.187.311
2	Perusahaan	436.236.940	211.733.175	8.122.000	216.381.766	357.408.950	19.895.822	0	337.513.128	553.894.894	465.974.080	3.427.884	5.273.534	-	79.219.396	553.894.894
3	Mandiri Inheath	36.044.387	21.867.452	1.853.132	12.323.803	19.397.484	-	-	19.397.484	32.321.288	32.321.288	-	-	-	-	32.321.288
4	Jasa Raharja	223.225.905	163.454.401	-	54.771.505	143.085.650	55.540.082	1	97.946.567	142.318.072	142.318.072	-	-	-	-	142.318.072
5	BPJS Ketenagakerjaan	1.096.621.636	1049.992.760	46.628.936	-	704.608.508	-	-	704.608.508	704.608.508	704.608.508	-	-	-	-	704.608.508
Total Saldo										1.797.330.673	1.868.218.506	27.164.338	26.688.247	15.386.884	153.672.584	1.797.330.673

Keterangan : Cut off 30 April 2026 sebesar Rp 1.797.330.073

3.5.5.2 Klaim Pending

NO	MASALAH	DAMPAK	TINDAK LANJUT
RAWAT INAP			
1.	Reseleksi J189 sebagai DU, indikasi MRS sesak, DM sebagai komorbid DS	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending

2	Readmisi	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
3	Luka terbuka pada kepala dengan tindakan muscle suturing (83.65) gunakan kode prosedur 86.5 (Suture or other closure of skin and subcutaneous tissue)	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
4	Kode G936 (edema cerebri) manifes DU (ich), tidak dikoding terpisah	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
5	Indikasi rawat inap	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
6	Pasien dengan dehidrasi, sesuai dengan penunjang reseleksi du lebih spesifik menjadi A09.9 (gea)	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
7	Tatalaksana pneumonia tidak sesuai ketentuan, minimal inj AB 72 jam, pasien dengan LOS 3 hari	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
8	Pasien usia 76tahun, lempeng pertumbuhan sdh menutup, reseleksi kode tindakan epipisis 79.41 menjadi 79.01	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
RAWAT JALAN			
1	Indikasi pasien kunjungan hanya dilakukan rujuk kers yang lebih tinggi, jadi satu tagihan	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
2	Potensi PRB	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
3	Tidak layak, Pre Operasi (PMK 26/2021)	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
4	Pending, px post 4x kontrol masih kontrol kembali dengan indikasi apa? bukankah kompetensi FKTP? jika pasien katarak imatur harusnya dikembalikan FKTP dl	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
5	Konsul internal jadi satu tagihan	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
6	Pending tidak sesuai kaidah pengkodean : kode prosedur tidak sesuai	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending

3.5.6 PIPP – MOD – MPP

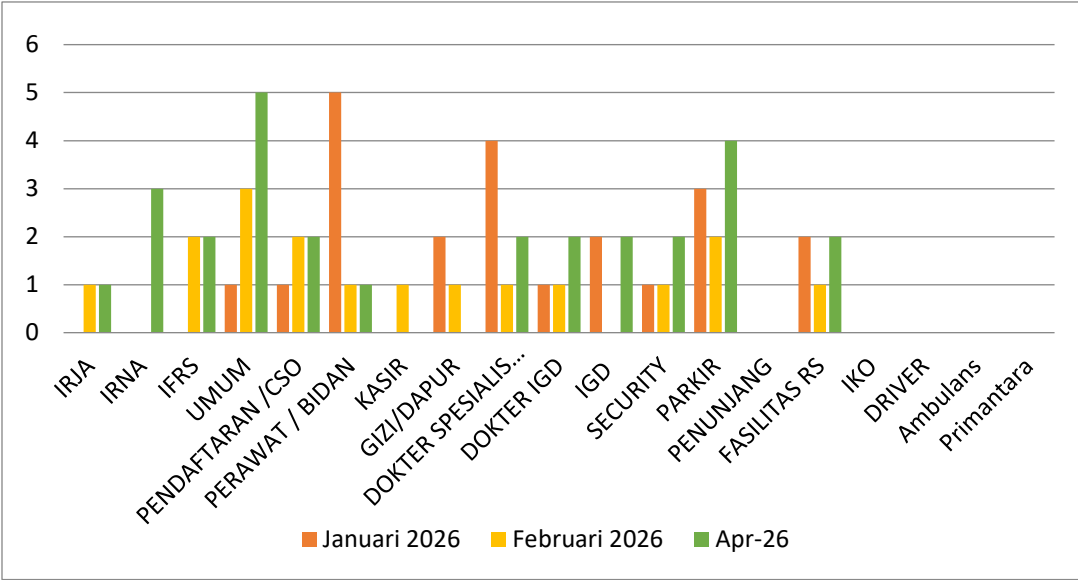
3.5.6.1 Laporan Komplain Pasien

1.5.6.1.1 Tabel Distribusi Laporan Komplain Pasien Per Unit Bulan Februari 2026

NO	Jumlah Komplain Pasien Terhadap Unit	Februari 2026	Maret 2026	April 2026
1.	IRJA	0	1	1
2.	IRNA	0	0	3
3.	IFRS	0	2	2
4.	UMUM	1	3	5

5.	PENDAFTARAN /CSO	1	2	2
6.	PERAWAT / BIDAN	5	1	1
7.	KASIR	0	1	0
8.	GIZI/DAPUR	2	1	0
9.	DOKTER SPESIALIS (KOMITE MEDIS)	4	1	2
10.	DOKTER IGD	1	1	2
11.	IGD	2	0	2
12.	SECURITY	1	1	2
13.	PARKIR	3	2	4
14.	PENUNJANG	0	0	0
15.	FASILITAS RS	2	1	2
16.	IKO	0	0	0
17.	DRIVER	0	0	0
18.	Ambulans	0	0	0
19.	Primantara	0	0	0
Total		22	17	28

3.5.7.1.1 Grafik Laporan Komplain Pasien Per Unit April 2026



Analisis :

Jumlah pasien komplain selama Bulan April 2026 mengacu pada komplain pasien. Asal complain pasien ditemukan dari beberapa unit yang ada di RS.

- Jumlah complain Pada bulan April 2026 mengalami kenaikan dibanding pada bulan sebelumnya. Pada bulan Februari 2026 sebanyak 22 pasien. pada bulan maret 2026 sebanyak 17 pasien Sedangkan pada bulan April sebanyak 28 pasien
- Komplain terbanyak pada bulan April 2026 yaitu dari bagian UMUM sebayak 5 kasus, Parkir sebanyak 4 kasus, CSO dan IFRS sebanyak masing-masing 2 kasus yang disampaikan secara kuesioner, WA maupun tatap muka langsung.
- Pada bulan April 2026 terdapat 6 complain yang tidak bisa langsung diselesaikan, diantaranya :
 - Parkir
Terdapat 4 kasus diantaranya terkait tarif parkir rawat inap yang terlalu mahal dan permintaan dilakukan pembayaran 1x untuk rawat inap

- Fasilitas
Terdapat 2 kasus terkait fasilitas yaitu saran untuk perluasan kamar dan upgrade fasilitas VIP

Rencana Tindak Lanjut :

Melakukan evaluasi pada bidang atau bagian yang dikeluhkan pasien agar pelayanan bisa berjalan dengan baik dengan kolaborasi dengan unit terkait

3.5.7.2 Tabel Media yang Digunakan Pasien Komplain Bulan April 2026

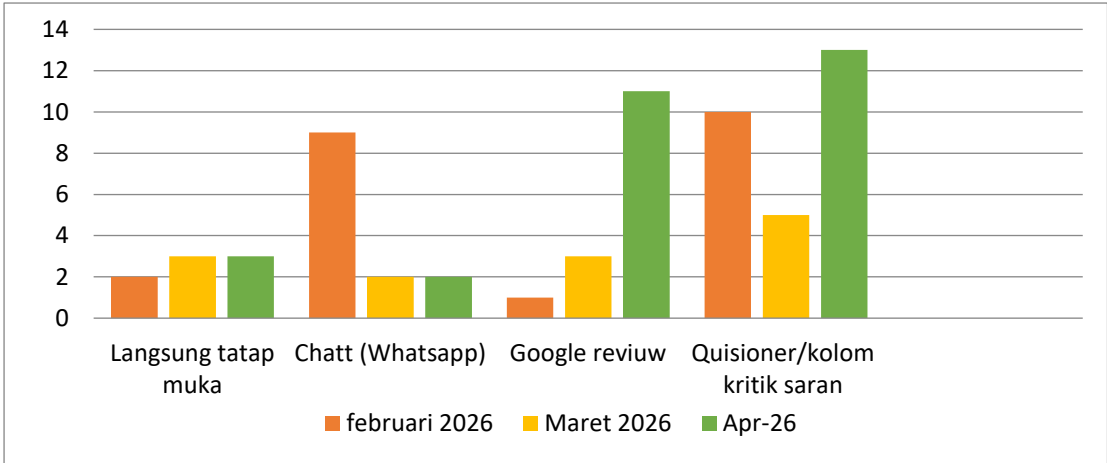
NO	JENIS PASIEN COMPLAIN	FEBRUARI 2026	MARET 2026	APRIL 2026
1.	Langsung tatap muka	2	3	3
2.	Tidak Langsung :			
	a. Chatt (Whatsapp)	9	2	2
	b. Google reviuw	1	3	11
3.	Quisioner/kolom kritik saran	10	5	13

Rincian KESSAN

KESSAN (Kesan dan Pesan Setelah Layanan) merupakan aplikasi dari BPJS Kesehatan untuk mendorong FKTP dalam meningkatkan layanan bagi peserta JKN-KIS serta memenuhi kewajiban terhadap kontrak kerjasama dengan BPJS Kesehatan

	KESSAN BPJS	Bintang 1	Bintang 2	Bintang 3	Bintang 4	Bintang 5
		2	0	4	245	703

3.5.7.3 Grafik Media yang Digunakan Pasien Komplain Bulan April 2026



Analisis :

Pada bulan April 2026 jumlah jenis pasien complain terbanyak didapatkan dari penilaian Quisioner yang dinilai dari pengisian link Quisioner rawat inap sebanyak 13 kasus komplain.

Rencana Tindak Lanjut :

Melakukan evaluasi pada bidang atau bagian yang dikeluhkan pasien agar pelayanan bisa berjalan dengan baik dengan kolaborasi dengan unit terkait

3.5.7.4 Tabel Waktu Tanggap dan Penyelesaian Komplain Bulan Februari 2026

No	Jenis pasien complain	Waktu tanggap		Waktu penyelesaian		< 3 hr Manajerial RS	7 hr ke PT
		Standard < 5 '	Pencapaian (dari waktu total dibagi jml komplain atau rata2 waktu tanggap)	Standard < 60 '	pencapaian		
1.	Langsung tatap muka	100%	100%	100%	100%	0	0
2.	Chatt (WA/Tele/SMS/IG)	100%	100%	100%	100%	0	0
3.	Google reviuw	100%	100%	100%	100%	0	0
4.	Quisioner/kolom kritik saran	100%	100%	100%	60%	40%	0
					7	6	
5.	KESSAN	100%	100%	100%	100%	0	0

Analisis :

Waktu tanggap dan penyelesaian komplain pasien pada bulan April 2026 masih ada yang belum sesuai target 100% yaitu complain melalui Quisioner dengan capaian 60%. hal ini dikarenakan ada beberapa kasus complain yang tidak bisa langsung diselesaikan seperti fasilitas RS yang memerlukan diskusi dengan manajemen.

Pada bulan April 2026 terdapat 6 complain yang tidak bisa langsung diselesaikan, diantaranya:

- Parkir
Terdapat 4 kasus diantaranya terkait tarif parkir rawat inap yang terlalu mahal dan permintaan dilakukan pembayaran 1x untuk rawat inap
- Fasilitas
Terdapat 2 kasus terkait fasilitas yaitu saran untuk perluasan kamar dan upgrade fasilitas VIP.

Rencana Tindak Lanjut :

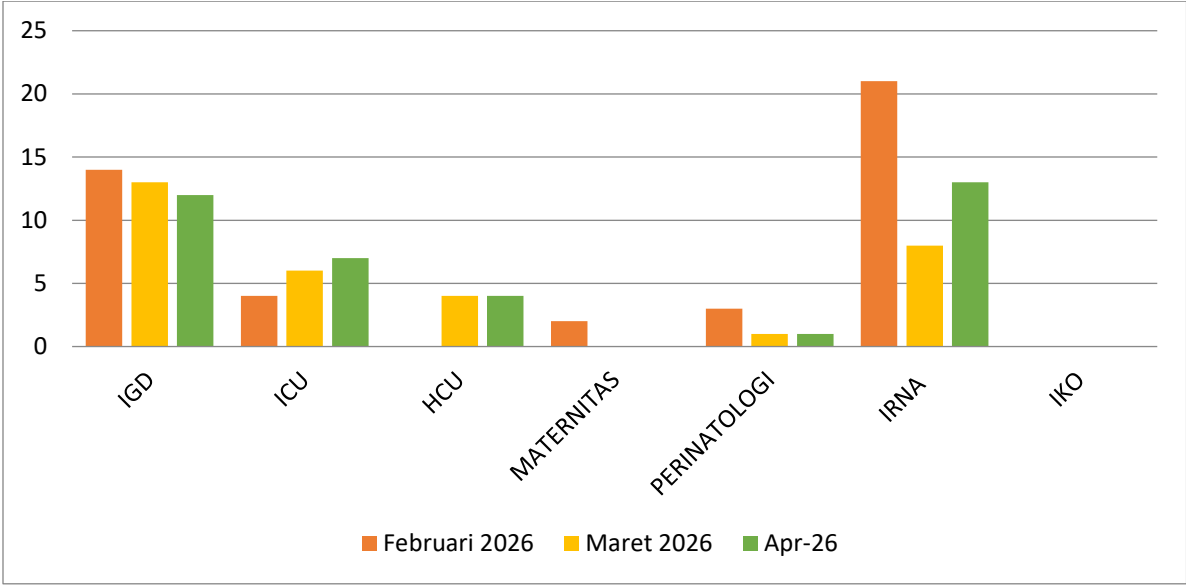
Penyelesaian komplain dilakukan dengan melakukan telusur lapangan sederhana dengan kolaborasi dengan unit terkait

3.5.7.5 Laporan Pasien Rujuk

3.5.7.5.1 Tabel Distribusi Pasien Rujuk Per Unit Bulan Maret 2026

No	Unit Perujuk	Februari 2026	Maret 2026	April 2026
1.	IGD	14	13	12
2.	ICU	4	6	7
3.	HCU	0	4	4
4.	MATERNITAS	2	0	0
5.	NEONATOLOGI	3	1	1
6	IRNA	21	8	13
7	IKO	0	0	0
Total		44	32	37

3.5.7.5.2 Grafik Jumlah Pasien Rujuk Eksternal Bulan April 2026



3.7.7 Tabel Rincian Pasien Rujuk April 2026

NO	NO RM	Nama Pasien	UNIT	DIAGNOSIS	DPJP	RS TUJUAN	ALASAN RUJUK	PLAVON HABIS
1	247139	NY. SULISTYO KARTINA SARI	ICU	NSTEMI+ADHF EF 16%+ DM HIPERGLIKEMIA	DR IRA SETYA WATY SP JP	RS UMM	RUJUK PRO PCI	Tidak
2	247123	MUHAMMAD KUSAERI	6A	NSTEMI, DISLIPIDEMIA	DR IRA SETYA WATY SP JP	RST SOEPRAOEN	PRO PCI	TIDAK
3	203623	WISNU WALUYO CAHYO WIDODO	7A	CVA INFARK	DR AHMAD FARID WAJDI SP. N	RS PANTI NIRMALA	APS	TIDAK
4	247092	FAIDATUL FIRSYA AGISTA RAMADHANI	ICU	Meningoensefalitis TB	DR FIONA PARAMITHA SP.A	RSSA	Pro tatalaksana pneumothorax	TIDAK
5	88310	HADI MULYONO	IGD	1. Susp metabolic encephalopathy 2. ADHF, 3. Acute on CKD	DR ARDHI BUSTAMI,SP.PD	RS LAVALET	PRO HD CITO	TIDAK
6	247380	SITI ASKARIFAH	IGD	SOL	DR AHMAD FARID WAJDI SP. N	RST SOEPRAOEN	PRO EXCISI TUMOR	TIDAK
7	113933	BUDIANTO	IGD	CKD, CHF	DR YOGA WARANUGRAHA SP JP	RSUB	PRO HD	TIDAK
8	52853	DESI TRI MUNIARTI	IGD	CKD, ALO	DR ARDHI BUSTAMI,SP.PD	RSUD	PRO HD	TIDAK
9	247072	MUSTAKIM	2C	HIV ST 4, LIMFADENOPATHY COLI SUSP TB	DR ARDHI BUSTAMI,SP.PD	RS LAVALETTE	PRO PERAWATAN HIV	TIDAK
10	247598	REIHANA NUR ARDHANI	3C	LIMFADENITIS COLLI	DR DICKY FATURRACHMAN,S PA,M,BIOMED	RS HERMINA MALANG	PRO BEDA ANAK	TIDAK
11	244579	SALIKAN	2A	1. cholelitiiasis dd hydeops GB + obs joundice	DR ANTON, SP.B	RS SOETOMO SURABAYA	Pro bedah digestif.	TIDAK
12	247314	SLAMET BUDIMAN	8A	CVA Emboli, Afasia Global, HHD, HF	DR DEWI MAHARANI SP. S	RS SAIFUL ANWAR	rujuk pro subspesialis storke/neurovasculer	TIDAK
13	247662	BY NY. SUFIATI ULFA	NEO	RDS ok HMD DD neonatal pneumonia , BBLASR	DR FIONA PARAMITHA SP.A	RS SAIFUL ANWAR	rujuk pro subspesialis neonatologi , pro surfaktan	TIDAK
14	225147	Tn. HERNOWO	4A	1. oc dt geriatric problem 2. dm type 2 hiperglikemia coma 3. AKI 4. HHD 5. post hipoglikemia	DR ADHYA AJI PRATAMA, SP.PD	RS SAIFUL ANWAR	pro KGER	TIDAK
15	244579	Tn. SALIKAN	2A	cholilitiasis dd hydrops GB + obs jaundice	DR ANTON, SP.B	RS DR.SOETOMO	Pro bedah digestif.	TIDAK
16	247650	TN. WULAN LINTANG KUSUMA CANDRA	HCU	Shock Hemorrhagic Transient Response dt susp. Abdominal Internal Bleeding + Fraktur Pelvis Vertical Shear	DR ROSSY ZAKI, SP.B	RS SAIFUL ANWAR	Perawatan lanjutan	TIDAK
17	247810	MOHAMAD SANAMI	IGD	STEMI INFERIOR DAN RV INFARCT	DR MIRYANTI CAHYANINGTIAS	RS SAIFUL ANWAR	PRO PCI	TIDAK

					SP JP			
18	187627	IMAM SUKARDI	IGD	STEMI ANTERIOR DAN INFERIOR	DR YOGA WARANUGRAHA SP JP	RS UMM	PRO PCI	TIDAK
19	244514	SITI NAPSIYAH	IGD	doc e.c. suspect CVA	DR AHMAD FARID WAJDI SP. N	RS LAVALETTE	PRO STROKE UNIT	TIDAK
20	247145	CHELSEA VITA ALISSA	HCU	SLE flare berat efusi pericardila shock septic transaminitis	DR ARDHI BUSTAMI,SP.PD	RS SAIFUL ANWAR	Perawatan lanjutan pemberian terapi cyclophosphamid	TIDAK
21	143110	CHATARINA IVONNEDA S	4A	cf FEMUR	DR ARIANTO, SP.OT	RS SAIFUL ANWAR	PRO OP Interlocking Nail dan C-Arm	TIDAK
22	243702	VIKY EFFENDI	ICU	CKD STAGE 5	DR ADHYA AJI PRATAMA, SP.PD	RS SAIFUL ANWAR	PRO HD	TIDAK
23	247974	ADY IRFANSYAH	IGD	STEMI, ANEMIA, HEMATURIA	DR YOGA WARANUGRAHA SP JP	RS SAIFUL ANWAR	PRO PCI	TIDAK
24	195155	ABDUL ROSID	HCU	CVA TROMBOSIS LUAS DD EMBOLI, CAD POST PCI	DR FAHIMMA, SP. N	RS SAIFUL ANWAR	PRO STROKE UNIT	YA
25	095673	SUBARDAN	4A	CVA SAH, hydrocephalus post op VP shunt	DR FACHRY, SP.BS	RS SAIFUL ANWAR	PRO CTA	TIDAK
26	098399	MOCHAMMAD JAJULI	ICU	STEMI anterior luas	DR MIRYANTI CAHYANINGTIAS SP JP	RSI AISYIAH	PRO PCI	TIDAK
27	098640	H. NU'MAN KHUMAIDI	ICU	1. Stemi anteroseptal recent onset 2. Syok cardiogenik 3. Adhf dt dm cardiomyopaty 4. Dm tipe 2 5. TB paru tuntas oat 2021	DR MIRYANTI CAHYANINGTIAS SP JP	RS UMM	PRO PCI	TIDAK
28	197075	MUSTOFA	HCU	1. CVA ICH 2nd Attack 2. HT 3. Leokositosis 4. AKI	DR FAHIMMA, SP. N	RSSA	PRO STROKE UNIT	TIDAK
29	202350	RIKI CHRISTIAN RATU OPENG	IGD	SOL	DR AHMAD FARID WAJDI SP. N	RST SOEPRAOEN	PRO EXCISI TUMOR	TIDAK
30	195464	SITI AMINAH	IGD	STEMI ATEROSEPTAL, HHD	DR MIRYANTI CAHYANINGTIAS SP JP	RSI AISYIAH	PRO PCI	TIDAK
31	248276	SYARIFAH NUR ROHMANIYAH	6A	CF HUMERUS D/S	DR ARIANTO, SP.OT	RSSA	PRO C-ARM	TIDAK
32	248436	NUR AHMAD	7A	ICH EDEMA CEREBRI	DR AHMAD FARID WAJDI SP. N	RST SOEPRAOEN	PRO EVAKUASI HEMATOME	TIDAK
33	162944	solikin	ICU	STEMI ANTERSEPTAL	DR MIRYANTI CAHYANINGTIAS SP JP	RS MUHAMMADIYAH MALANG	PRO PCI	tidak
34	242460	JUMA'IYAH	7A	CKD STAGE 5	DR ARDHI BUSTAMI,SP.PD	RSUD LAWANG	PRO HD	TIDAK
35	212705	sri rohmiyati	IGD	COS + Susp. Fraktur Basis Cranii + Contusio Temporal Sinistra + Open Wound Mentalis et Labialis Inferior	DR. ANDI ABDILLAH,SP.B	RST SOEPRAOEN	Penanganan multitrauma	tidak
36	248486	GUNAWAN	ICU	CVA ICH IVH 30 cc	DR FAHIMMA, SP. N	RSSA	PRO STROKE UNIT	tidak
37	227016	KOESIYAH	IGD	Stemi ateroseptal	DR YOGA WARANUGRAHA SP JP	RST SOEPRAOEN	PRO PCI	Tidak

Analisis :

- Terjadi peningkatan jumlah pasien yang dirujuk ke RS lain dalam bulan April 2026.
 Pada bulan februari 2026 sebanyak 44 pasien pada bulan Maret 2026 turun menjadi 32 pasien. Sedangkan pada bulan April sebanyak 37 pasien
- Alasan rujuk karena sarana dan prasarana tidak dimiliki oleh RSPH Malang, seperti :
 - Pro PCI
 - Pro CVCU
 - Pro stroke unit
 - Pro HD
 - MRI
 - Pro bedah saraf lanjutan
 - Membutuhkan alat khusus
 - Membutuhkan pengobatan ARV
- Alasan rujuk karena plavon habis menurun dari bulan sebelumnya.
 Pada bulan bulan maret 2026 Minus Sebesar Rp.5.829.733 sedangkan pada bulan April 2026 Tidak ada plavon habis yang dilakukan rujuk

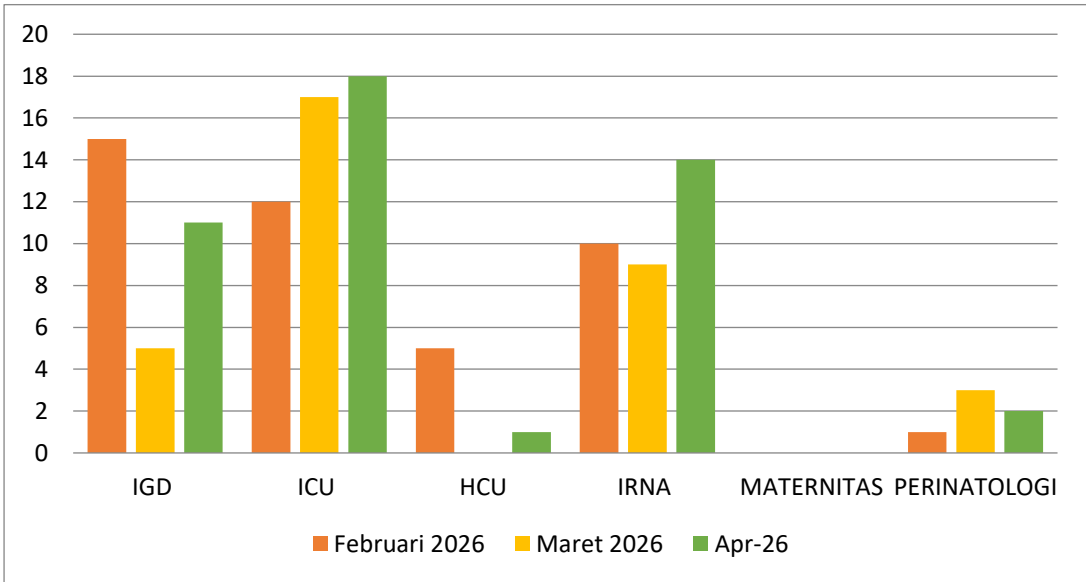
Rencana Tindak Lanjut:

- 1. Dilakukan evaluasi alasan terhadap rujukan pasien keluar yang semakin meningkat
- 2. Dilakukan komunikasi dengan DPJP melalui rapat komdik terkait plavon minus.

3.5.7.5.3 Jumlah Pasien Meninggal Bulan Maret 2026

No	Unit Asal Pasien Meninggal	Februari 2026	Maret 2026	April 2026
1.	IGD	15	5	11
2.	ICU	12	17	18
3	HCU	5	0	1
4.	IRNA	10	9	14
5.	MATERNITAS	0	0	0
6	NEONATOLOGI	1	3	2
Total		43	34	46

Grafik Jumlah Pasien Meninggal April 2026



Tabel Rincian Pasien Meninggal April 2026

NO	NO RM	Nama Pasien	LAMA RAWAT	STATUS	UNIT	PENYEBAB KEMATIAN	DIAGNOSIS	DPJP	EWS
1	245942	DEWI SARTINIGSIH	5	BPJS Kesehatan	IGD	Cardiac arest	MR+HF+HHD+CVA INFARK+SEVERE HIPERNATREMI	DR YOGA WARANUGRAHA SP JP	√
2	247090	INSIAH	3	BPJS Kesehatan	ICU	Cardiac arest	TB+HIV+EFUSI PLEURA	DR. ANDY SP. P	√
3	247022	ASTIK	4	BPJS Kesehatan	6A	Cardiac arest	NSTEMI, CHF, DM Type II, Cystitis	DR IRA SETYA WATY SP JP	√
4	247123	MUHAMMAD KUSAERI	2	BPJS Kesehatan	6A	-	NSTEMI, DISLIPIDEMIA	DR IRA SETYA WATY SP JP	√
5	246966	SURIYAH	5	BPJS Kesehatan	ICU	Cardiac arest	respiratory failure, observasi konvulsi	DR FIONA PARAMITHA SP.A	√
6	137124	WINARSO	3	BPJS Kesehatan	ICU	Cariac arest	Uremic encelopathy + AKI	DR YOGA WARANUGRAHA SP JP	√

7	246437	SOFYAN INDARIANTO	0	UMUM	IGD	Cardiac arest	DOA		√
8	237045	FINA FARA MIDA	3	BPJS Kesehatan	6A	Cardiac arest	DM TYPE I KAD	DR ADHYA AJI PRATAMA, SP.PD	√
9	150662	NOVIE ROSARIE B	2	BPJS Kesehatan	8A	Cardiac arest	DM TIPE 2, SYPCK CONDITION,ANEMIA, CKDST IV	DR ARDITYO RAHMAT ARDHANY, SP.PD, K-GH	√
10	138829	NY. ENI KHULIANAH	0	UMUM	IGD	Cardiac arest	DOA	DR ISROTUL	√
11	247397	FATIMAH	3	BPJS Kesehatan	5C	Cardiac arest	TB Paru + DM Hiperglikemia + Hiperbilirubin	DR CATUR ELVI PURNAMAWATI SP P	√
12	146282	SA'IN	7	BPJS Kesehatan	ICU	Cardiac arest	CVA ICH, CKD 3	DR AHMAD FARID WAJDI SP. N	√
13	247482	ROHAYAH	3	BPJS Kesehatan	ICU	Cardiac arest	ARDS, cva infark, pneumonia	DR FAHIMMA, SP. N	√
14	237991	RUSINAH	4	BPJS Kesehatan	8A	Cardiac arest	ADHF dt DM Cardiomyopaty, Efusi pleura, Hipoalbumi, MR, AR, TR, PR	DR ZORAIDA DWI WAHYUNI, SP. PD	√
15	247607	HONNAH	2	UMUM	6A	Cardiac arest	COPD AE, HT, CARDIOMEGALI	DR. ANDY SP. P	√
16	247211	KASIAMI	11	BPJS Kesehatan	ICU	Cardiac arest	Coma hipoglikemia + CKD + bacterial infection + ards	DR HERI YATMO SAID SP PD,M.KES	√
17	122451	JAHMAN	10	BPJS Kesehatan	4A	Cardiac arest	Cardiac arrest + Unstable angina pectoris + HF	DR YOGA WARANUGRAHA SP JP	√
18	-	BY NY ANTI PUJI	0	BPJS Kesehatan	NEO	IUFD	IUFD	DR HUMAIRAH, SP.OG	√
19	242558	SITI MUKAROMAH	2	BPJS Kesehatan	HCU	Cardiac arest	Edema paru, SVT ,AKI ,Lekositosis,Shock condition	DR ARDHI BUSTAMI,SP.PD	√
20	170478	NATHANIEL DEREK LAY	1	BPJS Kesehatan	IGD	Cardiac arest	Suspek ARDS dt Pneumonia CURB-65 4	DR CATUR ELVI PURNAMAWATI SP P	√
21	246941	SAMSUL HARIYADI	4	BPJS Kesehatan	2A	Cardiac arest	adhesi ileoleal gr 3-4, perforasi ileum+perforasi bladder post op explorasi laparatomy+adeolisis secara tajam ileostomy+repair bladder.	DR ROSSY ZAKI, SP.B	√
22	247523	PARINI LASIANAH	1	BPJS Kesehatan	IGD	Cardiac arest	respiratory failure	DR YENI	√
23	247621	SUWAHYUDI	1	UMUM	IGD	Cardiac arest	respiratory failure		√
24	231377	RIAMI	3	BPJS Kesehatan	6A	Cardiac arest	CKD, HHD, COPD AE	DR ARDITYO RAHMAT ARDHANY, SP.PD, K-GH	√
25	247893	MATASIM	1	BPJS Kesehatan	2A	Cardiac arest	Nefrolitasis + hn + jaundice with transaminitis.	DR ADHYA AJI PRATAMA, SP.PD	√
26	247906	HANDIK SUYANTO	2	BPJS Kesehatan	ICU	Cardiac arest	Pneumonia, AKI dd ACKD	DR CATUR ELVI PURNAMAWATI SP P	√
27	245370	SITI CHOLIFAH	5	BPJS Kesehatan	ICU	Cardiac arest	CVA INFARK, ARDS,PVC	DR AHMAD FARID WAJDI SP. N	√
28	215971	MUSYAROF A H	3	BPJS Kesehatan	ICU	Cardiac arest	Respiratory failure, DOC 111 dt susp CVA infarc	DR HERI YATMO SAID SP PD,M.KES	√
29	247794	TRI ASTUTIK RAHAYU	0	BPJS Kesehatan	IGD	Cardiac arest	Cardiac arest	DR YOLANDA	√
30	246904	RUSMANA J	3	BPJS Kesehatan	ICU	Cardiac arest	POST DEBRIDEMENT, ULKUS PEDIS, DM	DR ANTON, SP.B	√
31	247745	SUBEKTI	9	BPJS Kesehatan	ICU	Cardiac arest	CVA ICH, SAH, POST CRANIOTOMI, CARDIAC AREST	DR FACHRY, SP.BS	√
32	131012	AGUS HANDOYO	3	BPJS Kesehatan	5C	Cardiac arest	CKD ST 4	DR ARDITYO RAHMAT ARDHANY, SP.PD, K-GH	√
33	247977	TUMA'INI	3	BPJS Kesehatan	ICU	Cardiac arest	respiratory failure, cva infark, DM 2, hipertiroid,	DR AHMAD FARID WAJDI SP. N	√

							omsk, susp copd		
34	248146	SUDIARTONO	2	BPJS Kesehatan	2C	Cardiac arest	SUSP TETANUS	DR. ANDI ABDILLAH,SP.B	√
35	244439	DIVA ADELIA	1	BPJS Kesehatan	ICU	Cardiac arest	CARDIAC ARREST + TB ON OAT	DR DICKY FATURRACHMAN,SPA,M ,BIOMED	√
36	149588	SUMADIYONO	8	BPJS Kesehatan	ICU	Cardiac arest	shock cardiogenic + CVA + TB on OAT	DR YOGA WARANUGRAHA SP JP	√
37	248045	AGUS SETIAWAN	5	BPJS Kesehatan	ICU	Cardiac arest	TB paru, DM hipoglikemia, hepatitis drug induced oat	DR CATUR ELVI PURNAMAWATI SP P	√
38	242893	ANDY FADILLAH	5	BPJS Kesehatan	ICU	Cardiac arest	TB Paru, Takiaritmia	DR CATUR ELVI PURNAMAWATI SP P	√
39	247981	sapikyah	3	BPJS Kesehatan	ICU	Cardiac arest	Mitral Insufficiency	DR YOGA WARANUGRAHA SP JP	√
40	246967	WASDI	2	BPJS Kesehatan	IGD	Cardiac arest	DOC e.c Uremic encefalopaty	DR HERI YATMO SAID SP PD,M.KES	√
41	248388	SUPRAYITNO	4	BPJS Kesehatan	4A	Cardiac arest	1. Gradual DOC dt Susp Hepatic Encephalopathy 2. SOP Cerebri dt Susp Cystic Pituitary Adenoma 3. Silent infarction 4. Severe hiponatremia 5. Hipokalemia	DR ARDITYO RAHMAT ARDHANY, SP.PD, K-GH	√
42	174743	IKSAN	2	BPJS Kesehatan	ICU	Cardiac arest	DM Hipoglikemi, asidosis metabolik berat, AKI, Gagal nafas, shock sepsis	DR HERI YATMO SAID SP PD,M.KES	√
43	248530	By Ny Tunik Rahayu	0	UMUM	IGD	Cardiac arest	Respiratory distress	DR DICKY FATURRACHMAN,SPA,M ,BIOMED	√
44	248442	MUJI ASTUTIK	0	BPJS Kesehatan	IGD	Cardiac arest	HT Emergency. konvulsi	dr Arrara	√
45	179317	SUKARYOSO	0	BPJS Kesehatan	IGD	Cardiac arest	Doc dt catdiogenic dd non cardiogenik	DR YUNIAR ARDY	√
46		By Ny Rifa Datul	0	UMUM	NEO	Cardiac arest	IMATUR	DR HUMAIRAH, SP.OG	√

Analisa :

- Jumlah pasien meninggal dunia pada bulan April 2026 sebanyak 46 pasien
- Jumlah terbanyak yaitu dari ICU : 18 pasien IRNA : 14 pasien IGD : 11 pasien dan Neo : 1 pasien
- Pada bulan Maret 2026 Jumlah kasus DOA di IGD sebanyak 2 kasus.
- Pengisian EWS sudah dilakukan di IGD dan IRNA.

Rencana Tindak Lanjut

Dilakukan evaluasi terhadap pasien datang ke IGD dengan kasus DOA

3.5.7.6 Laporan MPP

Tabel Rekap Berdasarkan Skrining Pasien

NO	IDENTIFIKASI / SKRINING PASIEN	BULAN / JUMLAH		
		FEBRUARI 2026	MARET 2026	APRIL 2026
1	Usia lanjut	6	2	52
2	Kasus penyakit kronis / terminal katastropik	0	0	73
3	Riwayat penggunaan alat bantu (kursi roda, walker, tongkat, dll)	0	0	0
4	Perkiraan biaya tinggi	6	3	33
5	Kemungkinan sistem pembiayaan yang kompleks (2 asuransi)	0	0	0
6	Pasien dengan fungsi kognitif rendah	0	0	1
7	Potensial komplain tinggi	4	1	25
8	Kasus yang melebihi rata-rata lama rawat	0	0	1

9	Kasus yang diidentifikasi rencana pemulangannya	0	0	16
10	Berisiko membutuhkan kontinuitas pelayanan	0	0	50
11	Berpotensi masalah hukum	0	0	0
12	Naik kelas pelayanan	4	7	13
13	Lain - lain	7	10	27

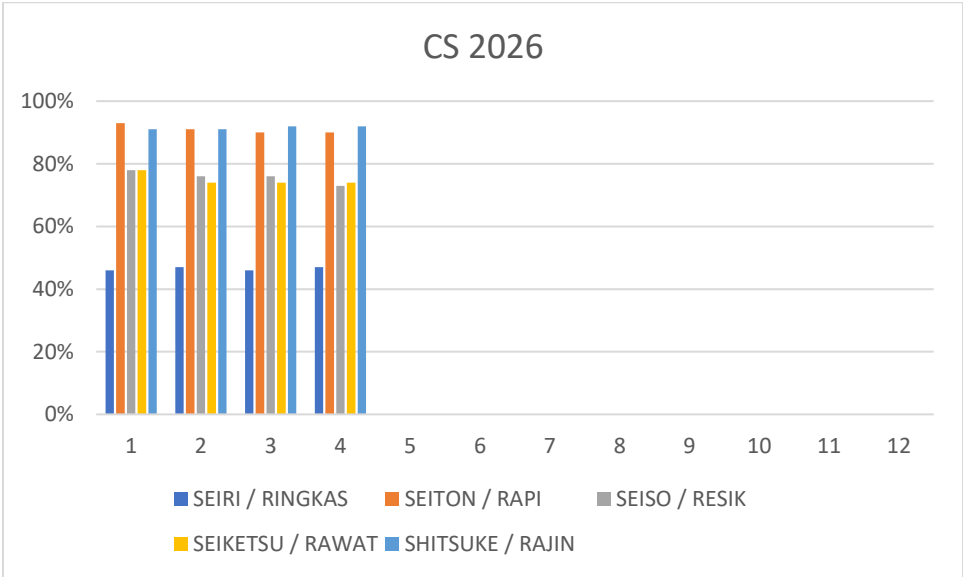
3.5.8 Cleaning Service

3.5.8.1 Indikator Kerja Cleaning Service

KATEGORI	DESKRIPSI
Seiri	Penempatan Alat Kebersihan Di Janitor/ Trolly
	Penempatan Alat Kebersihan Di Janitor/ Trolly
Seiton	Kerapian Baju Dan Kebersihan, Penampilan Petugas Cs
	Kerapian Baju Dan Kebersihan, Penampilan Petugas CS
Seiso	Membersihkan Area Kerja Secara Rutin Sesuai Jadwal
	Membersihkan Area Kerja Secara Rutin Sesuai Jadwal
Seiketsu	Mematuhi Sop Kebersihan
	Mematuhi SOP Kebersihan
Shiketsu	Konsistensi Dalam Menjalankan 5S Secara Mandiri Tanpa Pengawasan
	Konsistensi Dalam Menjalankan 5S Secara Mandiri Tanpa Pengawasan
	Konsistensi Dalam Menjalankan 5S Secara Mandiri Tanpa Pengawasan

3.5.8.2 Tabel Produktifitas Cleaning Service

NO	JENIS SPV	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	SEIRI / RINGKAS	46%	47%	46%	47%								
2	SEITON / RAPI	93%	91%	90%	90%								
3	SEISO / RESIK	78%	76%	76%	73%								
4	SEIKETSU / RAWAT	78%	74%	74%	74%								
5	SHITSUKE / RAJIN	91%	91%	92%	92%								



Analisa :

Terdapat progress pada semua factor penilaian bulan ini. Peningkatan perlu

dipertahankan.

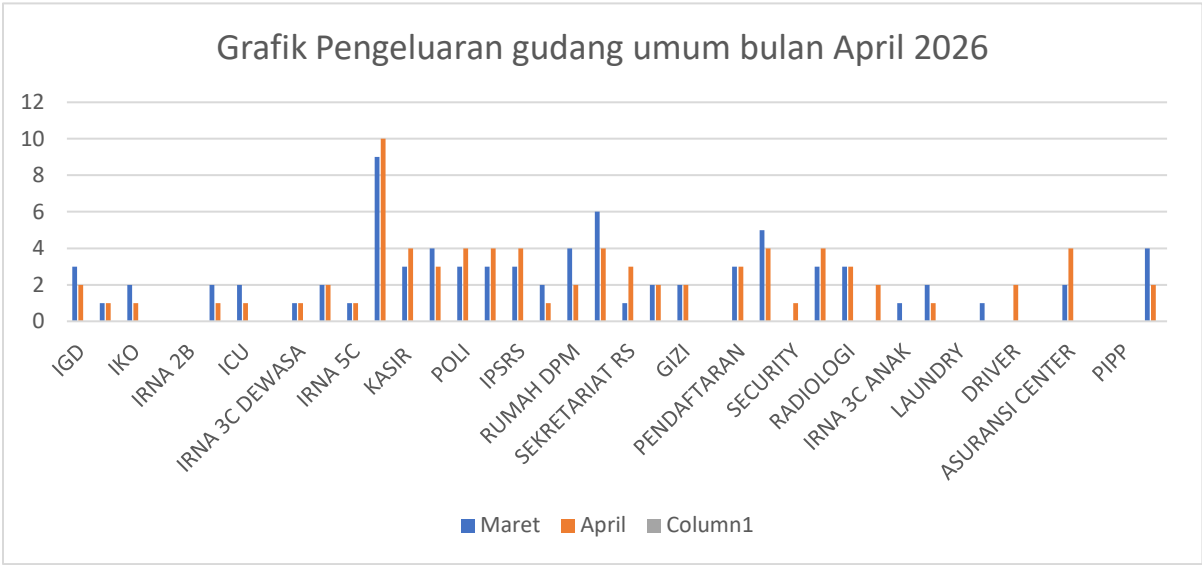
Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan Evaluasi

3.5.9 Pengadaan dan Gudang Umum

3.5.9.1 Tabel Laporan Pencatatan Pengeluaran Barang

NO	UNIT ASAL	JUMLAH BARANG		PERSENTASE
		MARET	APRIL	
1	IGD	3	2	↓-66,66%
2	MATERNITAS	1	1	↓0%
3	IKO	2	1	↓-100%
4	IRNA 2A	0	0	↓0%
5	IRNA 2B	0	0	↓0%
6	IRNA 2C	2	1	↓-100%
7	ICU	2	1	↓-100%
8	IRNA 3A+4A	0	0	↓0%
9	IRNA 3C DEWASA	1	1	↓0%
10	IRNA 4A	2	2	↑ 0%
11	IRNA 5C	1	1	↓0%
12	MS PTP , MS LAWANG,MS KARLOS	9	10	↑10%
13	KASIR	3	4	↑25%
14	DAPUR	4	3	↓ -33,33%
15	POLI	3	4	↑25%
16	CLEANING SERVICE	3	4	↑25%
17	IPSRS	3	4	↑25%
18	GUDANG FARMASI	2	1	↓-100%
19	RUMAH DPM	4	2	↓-100%
20	SEKRETARIAT PT	6	4	↓-50%
21	SEKRETARIAT RS	1	3	↑66,66%
22	CSSD	2	2	↓0%
23	GIZI	2	2	↓0%
24	REKAM MEDIS	0	0	↓0%
25	PENDAFTARAN	3	3	↑0%
26	DEPO FARMASI	5	4	↓25%
27	SECURITY	0	1	↑100%
28	LABORATORIUM	3	4	↑25%
29	RADIOLOGI	3	3	↓0%
30	FISIOTERAPI	0	2	↑100%
31	IRNA 3C ANAK	1	0	↓0%
32	NS NICU	2	1	↓-100%%
33	LAUNDRY	0	0	↑0%
34	LANTAI 6A,7A,8A	1	0	↑0%
35	DRIVER	0	2	↑100%
36	SIMRS	0	0	↓0%
37	ASURANSI CENTER	2	4	↑50%
38	DPW	0	0	↓0%
39	PIPP	0	0	↑0%
40	RS DH	4	2	↓-100%

3.5.9.2 Grafik Jumlah Pengeluaran Barang Berdasarkan Asal Unit



Analisis :

Pada grafik diatas dapat kita lihat bahwa data barang paling banyak ada pada unit Mutiara sehat , dan Poli

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Mendisiplinkan kepatuhan jadwal pengambilan barang
- 2. Memberi edukasi ke unit agar tidak salah input barang atau salah unit
- 3. Menyarankan ke seluruh unit agar punya data inventaris ATK secara terperinci

3.5.10 IT SIMRS

1.3.5.10.1 Pemeliharaan PC Server

Tabel 6. Pemeliharaan PC Server

NO	BULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KETERANGAN	DOKUMENTASI
	JANUARI	4x/tahun	1x	25%	30/01/2025	server SIMRS 2, CCTV, INACBG, SIMIPSRs, SYNOLOGY, FINGER, NYESHARE, SIDOKAR, FREENAS	
	FEBRUARI						
	MARET						
	APRIL	4x/tahun	1x	100%	30/01/2026	Selesai	Terlampir
	MEI						
	JUNI						
	JULI	4x/tahun					
	AGUSTUS						
	SEPTEMBER						
	OKTOBER	4x/tahun					
	NOVEMBER						

	DESEMBER						
--	----------	--	--	--	--	--	--

Analisa : Sudah dilakukan maintenance sesuai target

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

3.3.5.10.2 Pemeliharaan Mikrotik

Tabel Pemeliharaan Mikrotik

NO	BULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KETERANGAN	DOKUMENTASI
	JANUARI	62x/bulan	62x	100%	Setiap hari	mikrotik IT (Ruang Server)	
	FEBRUARI	56x/bulan	56x	100%	Setiap hari	mikrotik IT (Ruang Server)	
	MARET	62x/bulan	62x	100%	Setiap hari	selesai	
	APRIL	60x/bulan	60x	100%	Setiap hari	selesai	Terlampir
	MEI						
	JUNI						
	JULI						
	AGUSTUS						
	SEPTEMBER						
	OKTOBER						
	NOVEMBER						
	DESEMBER						

Analisa : Sudah dilakukan maintenance sesuai target

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

3.3.5.10.3 Pemeliharaan DVR dan Kamera CCTV

Tabel 8. Pemeliharaan DVR dan Kamera CCTV

NO	BULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KETERANGAN	DOKUMENTASI
	JANUARI	1x/bulan	1x	100%	16/01/2025	Gedung A1, A2, DPM, Gedung B, Gedung C, Maternitas, Gudang Farmasi, Poli sentral It1, It2, Ruang Server IT, Parkiran Karyawan, Blok 3,	

						Parkiran Belakang, Server IPCAM	
	FEBRUARI	1x/bulan	1x	100%	14/02/2025	Selesai	
	MARET	1x/bulan	1x	100%	09/03/2026	Selesai	
	APRIL	1x/bulan	1x	100%	24/04/2026	Selesai	Terlampir
	MEI						
	JUNI						
	JULI						
	AGUSTUS						
	SEPTEMBER						
	OKTOBER						
	NOVEMBER						
	DESEMBER						

Analisa : Sudah dilakukan maintenance sesuai target

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

3.3.5.10.4 Pemeliharaan Modem Internet

Tabel 9. Pemeliharaan modem internet

NO	BULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KETERANGAN	DOKUMENTASI
	JANUARI	4x/tahun	1x	25%	30/01/2015	Modem Indibiz, D-NET, Biznet, Indihome	
	FEBRUARI						
	MARET						
	APRIL	4x/tahun	1x	100%	22/04/2026	Selesai	Terlampir
	MEI						
	JUNI						
	JULI	4x/tahun					
	AGUSTUS						
	SEPTEMBER						
	OKTOBER	4x/tahun					
	NOVEMBER						
	DESEMBER						

Analisa : Sudah dilakukan maintenance sesuai target

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

1.3.5.10.5 Pemeliharaan Komputer Unit

Tabel Pemeliharaan Komputer unit

NO	BULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KETERANGAN	DOKUMENTASI
	JANUARI	15PC/Bulan	4x	26%	26/01/2025	Gate Parkir, Server Gate Parkir, Server IPCAM, Irna lantai 2A	
	FEBRUARI	15PC/Bulan	7x	47%	17/02/2026	Belum selesai	
	MARET	15PC/Bulan	8x	54%	23 s/d 25 maret 2026	PC all Farmasi	
	APRIL	15PC/Bulan	21x	100%	19 s/d 26 april	Verif,rm, manajemen selesai	Terlampir
	MEI	15PC/Bulan					
	JUNI	15PC/Bulan					
	JULI	15PC/Bulan					
	AGUSTUS	15PC/Bulan					
	SEPTEMBER	15PC/Bulan					
	OKTOBER	15PC/Bulan					
	NOVEMBER	15PC/Bulan					
	DESEMBER	15PC/Bulan					

Analisa : Sudah dilakukan maintenance sesuai target

Tindak lanjut : melanjutkan maintenance dibulan berikutnya dengan menambah jumlah

3.3.5.10.6 Pemeliharaan Printer Unit

Tabel 11. Pemeliharaan Printer unit

NO	BULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KETERANGAN	DOKUMENTASI
	JANUARI	3 Printer /bulan	3x	100%	1/01/2025	PT, Rekam Medis (management), PDF IGD.	
	FEBRUARI	3 Printer /bulan	3x	100%	16/02/2026	Selesai	
	MARET	3 Printer /bulan	3x	100%	19/03/2026	Selesai	
	APRIL	3 Printer /bulan	3x	100%	22/04/2026	Selesai	

	MEI						
	JUNI						
	JULI						
	AGUSTUS						
	SEPTEMBER						
	OKTOBER						
	NOVEMBER						

Analisa :
 Perawatan tidak dilakukan. Karena persiapan survey simulasi akreditasi dan terdapat 1 staf yang cuti Panjang akibat sakit dan urusan administrasi.

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

3.3.5.10.7 Perapian Kabel Internet

Tabel Perapian kabel internet

NO	BULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KETERANGAN	DOKUMENTASI
1	JANUARI	4x/Tahun	1x	25%	2/01/2025	Poli THT, Poli Syaraf 2, Poli Obgyn 2, SPI	
2	FEBRUARI						
3	MARET		1x	50%	19/03/2026		
4	APRIL						
5	MEI						
6	JUNI						
7	JULI						
8	AGUSTUS						
9	SEPTEMBER						
10	OKTOBER						
11	NOVEMBER						
12	DESEMBER						

Analisa : Sudah dilakukan maintenance sesuai target

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

3.3.5.10.8 Perapian Kabel Telepon

Tabel Perapian kabel telepon

NO	BULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KETERANGAN	DOKUMENTASI
1	JANUARI	4x/tahun	1x	25%	31/01/2025	Ruang Server PABX	
2	FEBRUARI						



3	MARET		1x	50%	19/03/2026	Selesai	
4	APRIL						
5	MEI						
6	JUNI						
7	JULI						
8	AGUSTUS						
9	SEPTEMBER						
10	OKTOBER						
11	NOVEMBER						
12	DESEMBER						

Analisa : Sudah dilakukan maintenance sesuai target

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

3.3.5.10.9 Pemeliharaan Access Point

Tabel Pemeliharaan access point

NO	BULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KETERANGAN	DOKUMENTASI
1	JANUARI	4x/tahun	1x	25%	04/01/2025	Gedung A 1-8 PT, Management, Gedung C 1-5, Gedung D 1-4. blok 3, Pdf Paru, Lounge laundry, Gudang farmasi, CSSD, Farmasi depo, Driver, DPM	
2	FEBRUARI						
3	MARET						
4	APRIL	4x/tahun	1x	50%	22/04/2026	Selesai	Terlampir
5	MEI						
6	JUNI						
7	JULI						
8	AGUSTUS						
9	SEPTEMBER						
10	OKTOBER						
11	NOVEMBER						
12	DESEMBER						

Analisa : Sudah dilakukan maintenance sesuai target

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

3.3.5.10.10 Pemeliharaan Switch Internet di Setiap Panel dan Unit

Tabel Pemeliharaan switch internet di setiap panel dan unit

NO	BULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KETERANGAN	DOKUMENTASI
1	JANUARI					Gedung A 1-8 PT, Management, Gedung C 1-5, Gedung D 1-4. blok 3, Pdf Paru, Lounge laundry, Gudang farmasi, CSSD, Farmasi depo, Driver, DPM	
		4x/tahun	1x	25%	09/01/2025		
2	FEBRUARI						
3	MARET						
4	APRIL	4x/tahun	1x	50%	09/04/2025	Selesai	Terlampir
5	MEI						
6	JUNI						
7	JULI						
8	AGUSTUS						
9	SEPT						
10	OKTOBER						
11	NOVEMBER						
12	DESEMBER						

Analisa : Sudah dilakukan maintenance sesuai target

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

3.3.5.10.11 Pemeliharaan Modem GSM

Tabel Pemeliharaan modem gsm

NO	BULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KETERANGAN	DOKUMENTASI
1	JANUARI	4x/tahun	1x	25%	30/01/2025	Ruang Server PABX	
2	FEBRUARI						
3	MARET						
4	APRIL	4x/tahun	1x	50%	7/04/2026	1. modem mati (perlu	Terlampir

						Ganti baru)	
5	MEI						
6	JUNI						
7	JULI						
8	AGUSTUS						
9	SEPTEMBER						
10	OKTOBER						
11	NOVEMBER						
12	DESEMBER						

Analisa : Sudah dilakukan maintenance sesuai target

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

3.3.5 10.12 Capaian Kegiatan Lainnya

No	Bulan	Kegiatan	Hasil	Petugas	Keterangan
1	April	Pemasangan computer untuk farmasi rajal khusus pengambilan obat rajal	Tuntas	Internal	
2	April	Pemasangan unit computer baru untuk dr ashlicah	Tuntas	Internal	
3	April	Pindahan computer unit PT	Tuntas	Internal	
4	April	Sursim & Melengkapi dokumen dokumen akreditasi bab MRMIK	Tuntas	Internal	
5.	April	Instalasi computer dan jaringan baru di LAF 3C	Tuntas	Internal	
6	April	Penambahan camera cctv area atm	tuntas	Internal	
7	April	Distribusi laptop ex sekre ke unit GIZI dan Sekre pakai laptop baru	tuntas	Internal	
8.	April	Pindahan chanel dvr parkir an ke dvr Gudang farmasi	tuntas	Internal	Dvr ex parkir an untuk area LAF lantai 4

3.3.5 10.13 Rencana Kegiatan Lainnya

NO	Kegiatan	Target (Bulan)	Hasil	Keterangan
1.	Maintenace pc Verif dan kantor manajemen	Mei	Tuntas / Tidak Tuntas	Verif, Rm dan manajemen
2	Setting IP public untuk kebutuhan virtual server APISIX	Mei	Tuntas / Tidak Tuntas	Bulan maret belum acc
3	Persiapan sursim akreditasi	Mei	Tuntas / Tidak Tuntas	Melengkapi dokumen dan setting jaringan
4.	Penambahan kamera cctv	Mei	Tuntas / Tidak Tuntas	Area LAF farmasi di lantai 4

3.3.6 Penanganan Keluhan

3.3.6.1 Keluhan Terkait Software

Tabel Keluhan Terkait Software

BULAN	JUMLAH LAPORAN	JUMLAH TERSELESAIKAN	PROSENTASE (%)
Januari	51	51	100%
Februari	32	32	100%
Maret	72	72	100%
April	77	77	100%
Mei			
Juni			
Juli			
Agustus			
September			
Oktober			
November			
Desember			

Analisa : Sudah dilakukan penanganan

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

3.3.6.2 Keluhan Terkait Hardware

Tabel 17. Keluhan Terkait Hardware

BULAN	JUMLAH LAPORAN	JUMLAH TERSELESAIKAN	PROSENTASE (%)
Januari	69	69	100%
Februari	107	107	100%
Maret	54	54	100%
April	43	43	100%
Mei			
Juni			
Juli			
Agustus			
September			
Oktober			

November			
Desember			

Analisa : Sudah dilakukan penanganan

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

3.3.6.3 Jenis Keluhan

Tabel Keluhan Spesifik

SPESIFIK	JUMLAH											
	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
PC	13	30	16	24								
PRINTER	17	28	19	15								
SIMRS	4	6	10	3								
JARINGAN INTERNET	60	57	61	58								
TELPON PABX	5	5	1	4								
CCTV	3	3	3	3								
UPS	1	0	0	0								
HP / TAB	3	0	0	0								
CAMERA	2	0	0	0								
KEYBOARD DAN MOUSE	3	0	0	0								
LAINNYA	2	3	9	2								
TOTAL	113	132	119	109	0	0	0	0	0	0	0	0

Analisa : Sudah dilakukan penanganan

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

3.3.6.4 Keluhan lain

No	Kegiatan	Jumlah	Hasil	Petugas	Keterangan
1	Setting ip public kebutuhan server satu sehat dan server MS Klinik	1	tuntas	Internal	Koordinasi dengan mas dhihin
4	Pemasangan komp input obat di farmasi	1	Tuntas	internal	Pengambilan obat dari perawat

Analisa : Sudah dilakukan penanganan

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

3.3.6.5 Progress Peremajaan

Tabel Data PC

NO	BULAN	JUMLAH TOTAL PC RS	JUMLAH PC YANG PERLU PEREMAJAAN	JUMLAH PC YANG SUDAH DILAKUKAN PEREMAJAAN	PROSENTASE	KETERANGAN
1	Januari	188	- RM - Verif	IRNA 2A (pakai pc ex pdf loket 6)		
2	Februari	188	- Verif - PC poli ipd perawat	IGD p2 IRNA 2A		Sudah Dilakukan peremajaan
3	Maret	188	- Verif - PC poli ipd perawat			
4	April	188	- Verif - PC poli ipd perawat - irna 2a			

Tabel Data CCTV

NO	BULAN	JUMLAH TOTAL CCTV RS	JUMLAH CCTV YANG PERLU PEREMAJAAN	JUMLAH CCTV YANG SUDAH DILAKUKAN PEREMAJAAN	PROSENTASE	KETERANGAN
1	Januari	100	1 (DPM Depan gerbang rumah 7b)			Pergantian power dvr yang konslet
2	Februari	100				
3	Maret	100	Power supply dvr cctv dpm			Pergantian power dvr yang konslet
4	April	101	Penambahan kamera cctv di area atm	Pindahan chanel dvr parkir ke dvr Gudang farmasi		Pemasangan baru

Tabel Data Printer

NO	BULAN	JUMLAH TOTAL PRINTER RS	JUMLAH PRINTER YANG PERLU PEREMAJAAN	JUMLAH PRINTER YANG SUDAH DILAKUKAN PEREMAJAAN	PROSENTASE	KETERANGAN
1	Januari	44		1. Printer etiket parkir get in Jaminan		Untuk printer belum dilakukan permajaan dikarenakan akan proses ERM
2	Februari	44		1. Admin Jaminan (Ganti sensor head dengan kanibal unit printer yg sudah rusak)		
3.	Maret	44	2 (printer hasil & pengantar laborat)			Head printer lx 310 sudah mulai bergaris
4.	April	44	2 (printer cso dan radiologi)	Pdf igd		Pergantian karet penarik kertas

3.3.6.6 Downtime

Tabel Laporan Downtime

NO	TANGGAL KEJADIAN DOWNTIME	JENIS DOWNTIME (TERENCANA/TIDAK TERENCANA)	LAMA DOWNTIME	PENYEBAB DOWNTIME	RTL
1	25/04/2026	Tidak Terencana	12.30 s/d 13.00	Kabel internet NAS terputus	Setting dan pemasangan kembali
2	30/04/2026	Terencana	17.00 s/d 05.00	Maintenance bulanan server BPJS	Info ke pendaftaran proses manual

3.5.11 Driver

Tabel Rekapitulasi Pengantaran Berdasarkan Keperluan

KEPERLUAN	JUMLAH											
	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
RUJUK PASIEN KE RS LAIN	47	44	31	36								
RUJUK PASIEN KE RSPHS	0	1	0	0								
JEMPUT RUMAH PASIEN	21	27	19	20								
ANTAR RUMAH PASIEN	22	21	15	25								

SAMPEL LAB	31	33	29	29								
SAMPEL SHK	3	4	3	2								
KEPERLUAN NONKLINIS STAF RSPHM	8	4	3	6								
KEPERLUAN NON KLINIS STAF PT	1	0	3	1								
PENGANTARAN JENAZAH	42	33	34	37								
RUJUK CT SCAN	0	5	0	12								
ANTAR MCU RSPHM	0	1	0	0								
LAIN-LAIN	16	17	18	11								
TOTAL	191	190	155	179								

Analisa :
Utilitas pada bulan April mengalami kenaikan dibanding bulan sebelumnya dan masih dalam tahap normal sehingga bisa tidak ada kendala.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan Evaluasi

3.5.12 PRIMANTARA

Tabel Jumlah Pengantaran Obat

BULAN	JUMLAH	RATA-RATA / BULAN
JANUARI	1024	40
FEBRUARI	1025	44
MARET	907	39
APRIL	1152	48
MEI		
JUNI		
JULI		
AGUSTUS		
SEPTEMBER		
OKTOBER		
NOVEMBER		
DESEMBER		
TOTAL		

Analisa :
Penurunan akibat kunjungan juga berkurang dikarenakan adanya libur lebaran.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan Evaluasi

3.6 Komite dan Tim

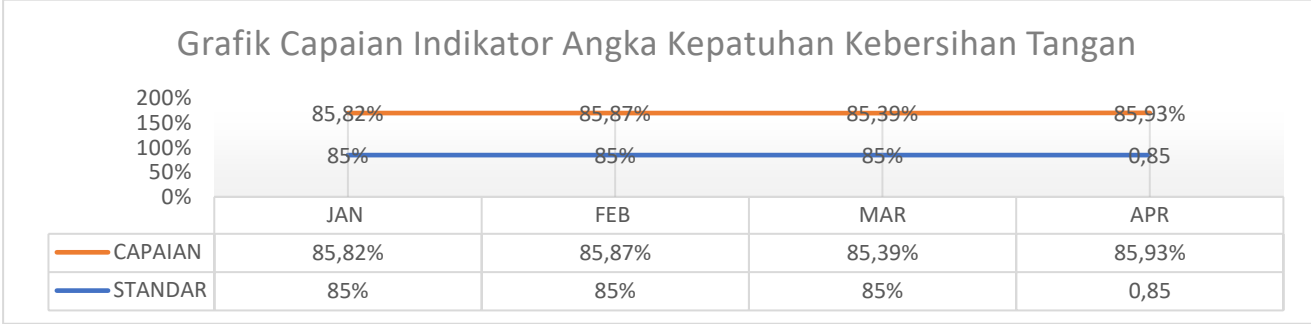
3.6.1 Komite Mutu

3.6.1.1 Indikator Mutu Nasional

NO	JUDUL	STAND	Jan '26	Feb '26	Mar '26	Apr '26	Mei '26	Jun '26	Juli '26	Agust '26	Sept '26	Okt '26	Nov '26	Des '26	Rata-Rata
1.	Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	85.82%	85.87%	85.39%	85.93%									
2.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	96.82%	96.88%	96.40%	96.48%									
3.	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	99.96%	99.06%	99.89%	99.97%									
4.	Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi	≥ 80%	100%	100%	100.00 %	100.00 %									
5.	Waktu Tunggu Rawat Jalan	≥ 80%	89.9%	86.3%	89.20%	95.04%									
6.	Penundaan Operasi Elektif	≤ 5%	0%	0%	0.00%	0.00%									
7.	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥ 80%	66.67%	73.63%	68.35%	87.98%									
8.	Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium	100%	100%	100%	100.00 %	100.00 %									
9.	Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional	≥ 80%	86.13%	86.07%	86.45%	86.33%									
10.	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	30.51%	%	18.75%	55.37= %									
11.	Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh	100%	91.54%	93.31%	95.60%	96.55%									
12.	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	≥ 80%	100%	100%	100.00 %	100.00 %									
13.	Kepuasan Pasien	≥ 76,61	99.7%	99.89%	99.79%	99.88%									

3.1.1 Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan

Gambar 1. Grafik Capaian Indikator Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan

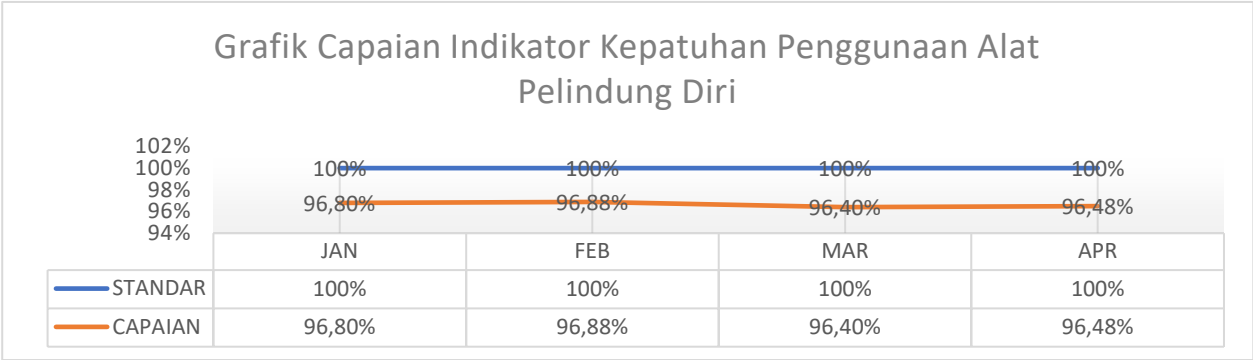


Analisis:

Pada Bulan April, angka kepatuhan kebersihan tangan di RS Prima Husada Malang mencapai 85.93%. Berdasarkan grafik pada gambar 3.1, diketahui bahwa capaian ini mengalami peningkatan dari Bulan Maret sebesar 0.54%. Capaian ini telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Kemenkes yakni $\geq 85\%$. Meskipun capaian di bulan ini telah memenuhi standar yang ditetapkan, namun masih dekat dengan batas tersebut sehigga masih diperlukan upaya untuk meningkatkan capaiannya. Unit yang memiliki capaian kepatuhan kebersihan tangan tertinggi adalah IKO dengan capaian sebesar 94.80%. Sementara unit dengan capaian kebersihan tangan terendah adalah Instalasi Gizi dengan capaian sebesar 81.94%. Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah memperkuat program edukasi, monitoring kepatuhan secara berkala, dan pemberian umpan balik kepada petugas. Sebuah studi Quality Improvement yang dilakukan oleh Sitohang dkk., (2025) membuktikan bahwa edukasi tenaga kesehatan, monitoring dan supervisi IPCN, serta simulasi langsung *5 Moments Hand Hygiene* efektif dalam meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan di rumah sakit.

3.1.2 Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

Gambar 2. Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri



Analisis:

Pada Bulan April, kepatuhan penggunaan alat pelindung diri di RS Prima Husada Malang mencapai 96.48% yang mengalami penurunan dari Bulan Maret sebesar 0.08%. Capaian ini masih memiliki gap sebesar 3.52% dari standar minimal yang ditetapkan yakni 100%. Unit yang mencapai angka 100% dalam kepatuhan penggunaan APD terdiri dari IGD, HCU, ICU, PICU, IKO, IFRS, Pengadaan Farmasi, Instalasi Laboratorium, Instalasi Radiologi, IRNA 2A, IRNA 2C, IRNA 3A, IRNA 3C, IRNA 4A, IRNA 6A, IRNA 7A, Maternitas, Neonatologi, dan Perinatologi. Sementara unit yang memiliki angka kepatuhan penggunaan APD terendah berada di CSSD yaitu sebesar 75.56%, mengalami penurunan sebesar 11,66% dari Bulan Maret. Unit yang mengalami penurunan dari bulan sebelumnya selain CSSD, yaitu Instalasi Gizi (penurunan sebesar 0.99%), dan IRNA 5C (penurunan sebesar 0.86%). Unit yang mengalami kenaikan angka kepatuhan penggunaan APD dari bulan sebelumnya yakni CS (kenaikan sebesar 1.80%), IRJA (kenaikan sebesar 1.37%), IRNA 7A (kenaikan sebesar 2.22%), dan IRNA 8A (kenaikan sebesar 0.50%).

Tabel PDSA Capaian Kepatuhan Penggunaan APD pada bulan April tahun 2026

Problem	Capaian kepatuhan penggunaan APD di RS Prima Husada Malang pada Bulan April 2026 sebesar 96.48% yang artinya masih belum memenuhi standar minimal yang ditetapkan yakni 100%. Terdapat gap sebesar 3.52% yang dapat berisiko pada keselamatan staf dan pasien. Masalah yang ditemukan adalah masih ditemukan ketidaktepatan penggunaan APD baik yang tidak lengkap maupun berlebihan, pemahaman staf mengenai indikasi penggunaan APD masih belum merata, kebiasaan kerja lama masih memengaruhi perilaku penggunaan APD sehingga praktik belum konsisten, dan monitoring dan audit kepatuhan belum dilakukan secara merata.
Plan	Mengupayakan peningkatan kepatuhan penggunaan APD sehingga mencapai standar minimal (100%) dengan mengingatkan petugas yang memakai APD berlebihan, mengevaluasi penggunaan stok APD, memberikan edukasi, dan melakukan supervisi terkait ketersediaan dan penggunaan APD.
Do	1. Pengawasan penggunaan APD 2. Edukasi penggunaan APD
Study	Capaian target bulan ini masih belum memenuhi standar minimal (100%) sebesar 96.48%. Terjadinya penurunan dari bulan sebelumnya menunjukkan adanya penurunan perilaku penggunaan APD, menurunnya kesadaran staf, atau kurangnya pengaruh dari pengawasan dan edukasi langsung yang dilakukan bulan sebelumnya. Beberapa upaya yang dilakukan dari bulan sebelumnya yakni reminder kepada staf untuk memakai APD sesuai standar, peningkatan monitoring oleh kepala unit. Dari upaya tersebut didapatkan kenaikan kepatuhan penggunaan APD sebesar 0.08% dari bulan sebelumnya. Upaya ini bisa terus dilakukan untuk dapat

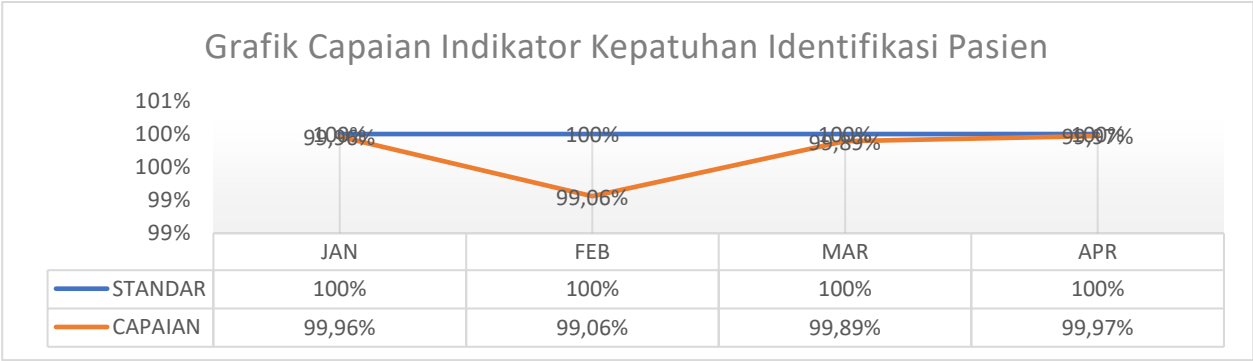
	semakin meningkatkan capaian kepatuhan penggunaan APD sehingga dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Action	1. Melakukan evaluasi penggunaan stok APD pada petugas koordinasi dengan pengadaan farmasi. 2. Memberikan proses pembelajaran kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. (mendata ketidakpatuhan pemakaian APD, konfirmasi Karu dan SDM). 3. Meningkatkan monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai. 4. Melakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD. 5. Memberikan edukasi pemakaian APD yang tepat antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya.

Tabel Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Peningkatan Kepatuhan Monitoring Penggunaan APD	Mengurangi penggunaan APD yang tidak sesuai (kurang/berlebihan)	Unit pelayanan	Supervisi langsung di ruangan dan penguatan budaya keselamatan kerja	• Komite PPI, IPCN • Kepala Ruangan	Berkelanjutan
2	Peningkatan konsistensi penggunaan APD yang benar	Meningkatkan konsistensi penggunaan APD	Seluruh staf unit pelayanan	Audit kepatuhan penggunaan APD secara berkala dan pemberian feedback	• Komite PPI	Setiap bulan
3	Kontroling ketersediaan APD	Mengoptimalkan ketersediaan dan penggunaan APD	Unit pelayanan	Monitoring penggunaan dan stok APD serta koordinasi dengan instalasi farmasi	• Komite PPI • Farmasi	Setiap bulan

3.1.3 Kepatuhan Identifikasi Pasien

Gambar 3. Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Identifikasi Pasien



Analisis:

Pada Bulan April tahun 2026, kepatuhan identifikasi pasien di RS Prima Husada Malang mencapai 99.97% yang mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya sebesar 0.08%. Capaian ini semakin mendekati standar minimal yang ditetapkan yakni sebesar 100%. Namun, masih terdapat gap sebesar 0.03% dari standar yang ditetapkan yang berarti masih ada ketidakpatuhan dalam identifikasi pasien. Unit yang belum mencapai standar angka kepatuhan identifikasi pasien yakni IRJA (99.92%) dan IRNA 3C (99.14%).

Tabel PDSA Capaian Kepatuhan Identifikasi Pasien pada bulan April tahun 2026

Problem	Capaian kepatuhan identifikasi pasien pada Bulan April sebesar 99.97%. Terdapat gap sebesar 0.03% dari standar yang ditetapkan dikarenakan namun masih ditemukan ketidakpatuhan dalam mengidentifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas pasien (nama lengkap dan tanggal lahir/nomor rekam medis). Beberapa petugas hanya mengidentifikasi pasien menggunakan nama saja, yang dapat berisiko terhadap keselamatan pasien.
Plan	Berdasarkan hasil monitoring indikator mutu kepatuhan identifikasi pasien di unit pelayanan, ditemukan bahwa kepatuhan petugas dalam melakukan identifikasi pasien belum sepenuhnya sesuai dengan standar yang ditetapkan rumah. Beberapa temuan antara lain petugas tidak melakukan identifikasi menggunakan minimal dua identitas pasien (nama lengkap dan tanggal lahir / nomor rekam medis) sebelum tindakan. Selain itu masih terdapat petugas yang tidak melakukan konfirmasi ulang kepada pasien. Oleh karena itu direncanakan upaya perbaikan berupa sosialisasi ulang SPO identifikasi pasien, peningkatan pengawasan oleh kepala unit, serta penguatan budaya keselamatan pasien.
Do	Komite Mutu bersama kepala unit dan ruangan melakukan sosialisasi kembali terkait standar identifikasi pasien kepada seluruh petugas pelayanan. Mengingatkan kembali mengenai pentingnya identifikasi pasien sebelum tindakan. Selain itu dilakukan monitoring dan audit kepatuhan identifikasi pasien secara berkala serta pengawasan langsung oleh kepala unit.
Study	Setelah dilakukan intervensi berupa reminder langsung kepada staf untuk mengidentifikasi pasien sesuai SOP dan pengawasan langsung oleh didapatkan kenaikan sebesar 0.08%. Dari hasil evaluasi tersebut dapat diartikan bahwa pengingatan kembali kepada staf untuk melakukan identifikasi pasien sesuai SOP dan pengawasan langsung oleh kepala unit mampu meningkatkan angka kepatuhan identifikasi pasien. Masih ada petugas yang belum konsisten melakukan identifikasi sesuai SOP terutama pada kondisi pelayanan yang sibuk atau pada pasien yang sudah dikenal oleh petugas.
Action	Meningkatkan pengawasan oleh kepala unit/ruangan

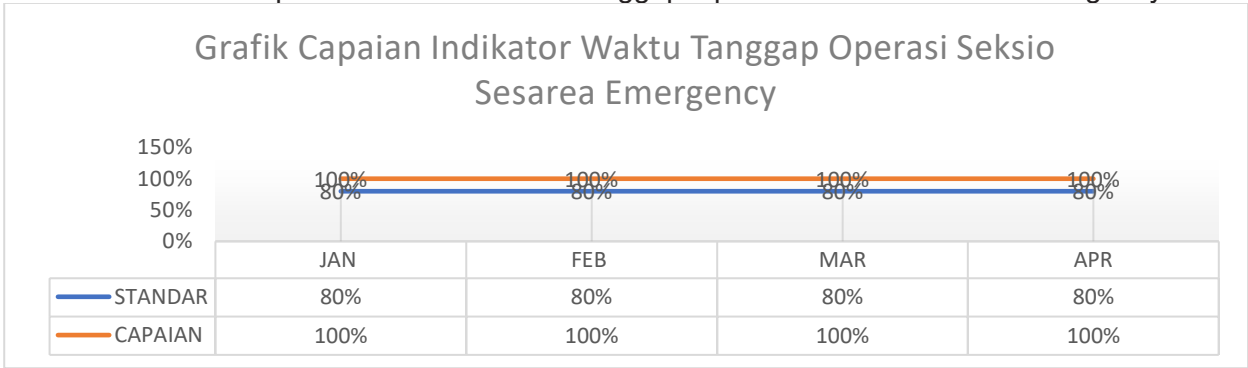
Tabel Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Meningkatkan pengawasan oleh kepala unit/ruangan	Meningkatkan kewaspadaan petugas untuk melakukan identifikasi pasien sesuai SOP	Seluruh tenaga kesehatan	Rumah sakit akan terus melakukan monitoring dan evaluasi kepatuhan identifikasi pasien secara berkala. Kepala ruangan diminta memberikan pengawasan secara langsung serta memberikan umpan balik kepada petugas yang belum patuh mengidentifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas pasien (nama lengkap dan tanggal lahir/nomor rekam medis). Edukasi terkait keselamatan pasien akan	Kepala ruangan	1 bulan

				terus dilakukan secara berkelanjutan agar kepatuhan identifikasi pasien dapat mencapai dan mempertahankan standar yang telah ditetapkan oleh rumah sakit.		
--	--	--	--	---	--	--

3.1.4 Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergency

Gambar 4. Grafik Capaian Indikator Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergency

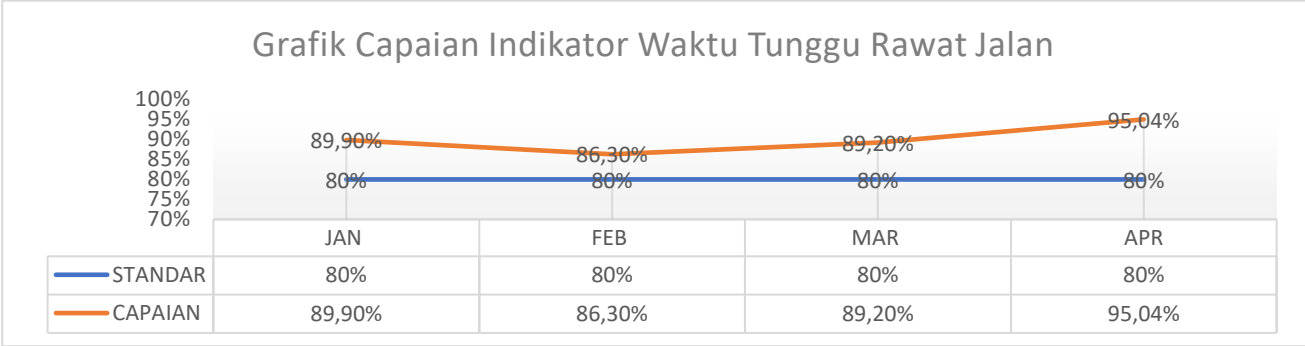


Analisis:

Pada bulan April 2026, capaian indikator waktu tanggap operasi seksio sesarea emergensi ≤30 menit mencapai 100%, sehingga telah melampaui standar minimal yang ditetapkan yaitu sebesar 80%. Dari total 10 kasus operasi seksio sesarea emergensi, seluruh pasien mendapatkan pelayanan dengan waktu respons ≤30 menit. Keberhasilan capaian ini didukung oleh koordinasi dan kerja sama yang optimal antara Instalasi Gawat Darurat, Unit Maternitas, Instalasi Kamar Operasi, serta dukungan manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang dalam menjaga mutu pelayanan kegawatdaruratan obstetri. Selain itu, ketersediaan sumber daya manusia yang memadai serta sarana dan prasarana penunjang yang optimal turut berperan dalam tercapainya indikator tersebut. Hasil yang telah dicapai perlu dipertahankan secara konsisten guna mengurangi risiko komplikasi pada ibu maupun bayi serta menjamin keselamatan pasien.

3.1.5 Waktu Tunggu Rawat Jalan

Gambar 5. Grafik Capaian Indikator Waktu Tunggu Rawat Jalan

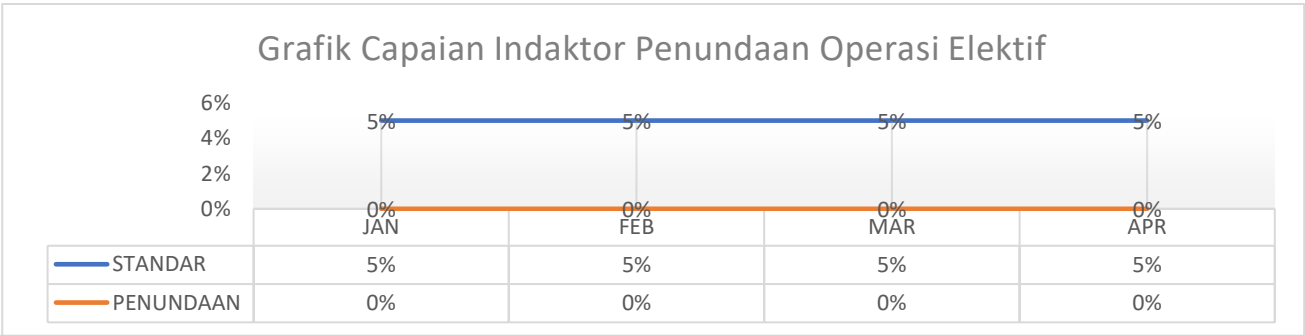


Analisis:

Pada bulan April 2026, capaian indikator waktu tunggu pelayanan rawat jalan ≤ 60 menit di Rumah Sakit Prima Husada Malang mencapai 95,04%. Hasil tersebut telah melampaui standar minimal yang ditetapkan yaitu $\geq 80\%$ serta mengalami peningkatan sebesar 5,84% dibandingkan bulan sebelumnya. Peningkatan capaian ini menunjukkan adanya perbaikan dalam efektivitas alur pelayanan rawat jalan, mulai dari proses pendaftaran, pemeriksaan awal, hingga pelayanan oleh dokter di poliklinik. Keberhasilan tersebut didukung oleh koordinasi yang baik antar unit pelayanan, optimalisasi jadwal pelayanan, serta monitoring waktu tunggu secara berkala oleh manajemen dan unit terkait. Dengan capaian yang tinggi ini, diharapkan mutu pelayanan rawat jalan, kepuasan pasien, dan efisiensi pelayanan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan secara berkesinambungan.

3.1.6 Penundaan Operasi Elektif

Gambar 6. Grafik capaian Indikator Penundaan Operasi Elektif

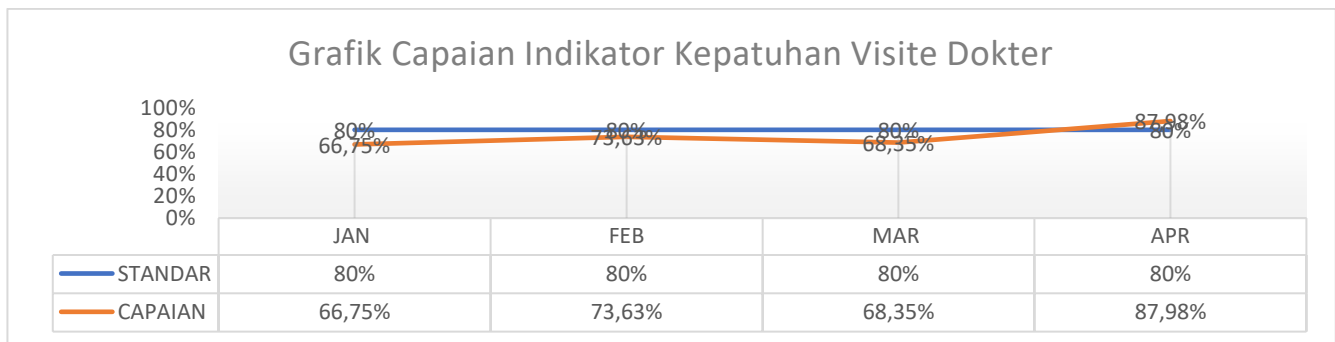


Analisis:

Pada bulan April 2026, capaian indikator penundaan operasi elektif di Rumah Sakit Prima Husada Malang sebesar 0%, sehingga telah memenuhi standar yang ditetapkan yaitu $\leq 5\%$. Tidak adanya kejadian penundaan operasi elektif menunjukkan bahwa proses pelayanan operatif berjalan dengan baik dan terkoordinasi secara optimal. Keberhasilan ini didukung oleh sinergi yang baik antara Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Kamar Operasi, serta dukungan manajemen rumah sakit dalam menjaga mutu pelayanan. Selain itu, perencanaan yang efektif terkait kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan alat, dan pengaturan ruang operasi turut berkontribusi dalam mencegah terjadinya penundaan operasi elektif. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan guna menjamin kelancaran pelayanan dan meningkatkan kepuasan serta keselamatan pasien.

3.1.7 Kepatuhan Waktu Visite Dokter

Gambar 7. Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Visite Dokter



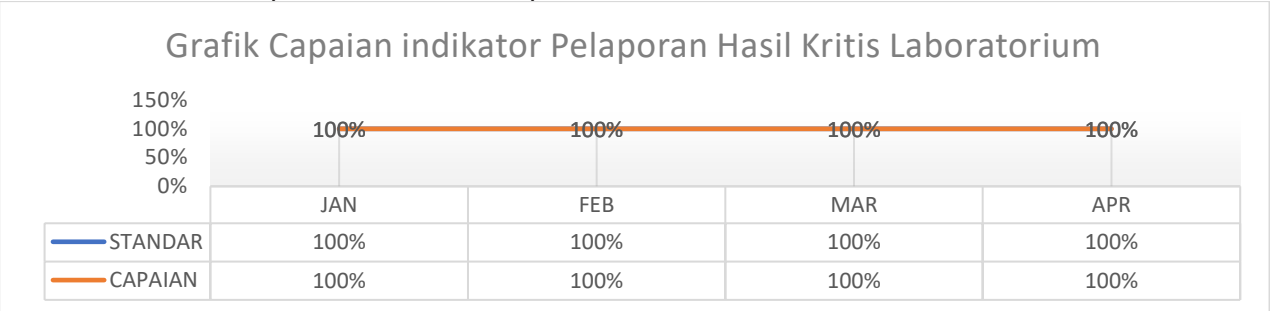
Analisis:

Pada Bulan April 2026, capaian indikator kepatuhan waktu visite dokter di Rumah Sakit Prima Husada Malang sebesar 87,98%, mengalami peningkatan sebesar 19,63% dibandingkan bulan sebelumnya. Hasil tersebut telah melampaui standar minimal yang ditetapkan yaitu $\geq 80\%$, sehingga menunjukkan adanya perbaikan kepatuhan dokter dalam melaksanakan visite tepat waktu. Peningkatan capaian ini dipengaruhi oleh berbagai upaya perbaikan yang telah dilakukan secara berkesinambungan, antara lain penguatan komunikasi dan komitmen dengan DPJP terkait pelaksanaan visite sesuai jadwal yang telah disepakati, koordinasi aktif antara perawat dengan DPJP mengenai jadwal visite pasien, serta monitoring rutin oleh manajemen dan unit terkait terhadap pelaksanaan visite dokter. Unit yang telah mencapai kepatuhan waktu visite dokter sebesar 100% yakni IRNA 2A, IRNA 3A, dan IRNA 3C. Sementara itu, unit dengan capaian kepatuhan waktu visite dokter terendah adalah dari unit maternitas (52.98%). Dengan tercapainya indikator ini, diharapkan mutu pelayanan pasien rawat inap, kontinuitas asuhan, serta kepuasan pasien dapat terus meningkat

dan dipertahankan secara konsisten.

3.1.8 Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium

Gambar 8. Grafik Capaian Indikator Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium

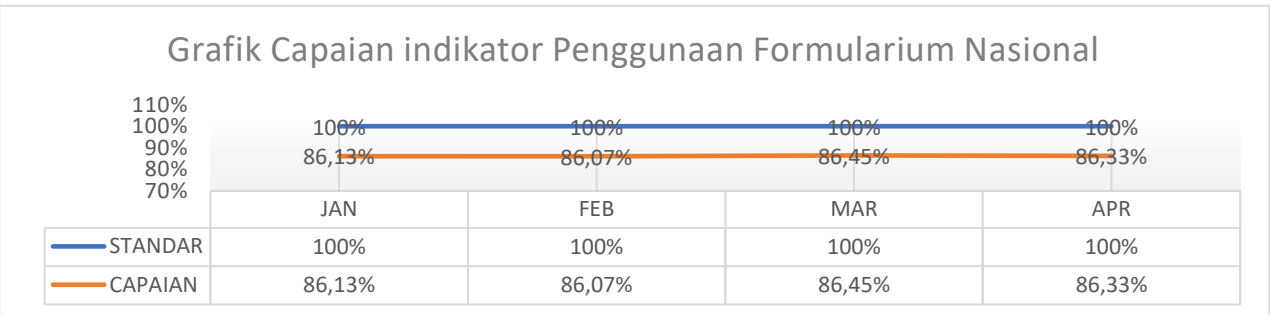


Analisis:

Pada bulan April 2026, capaian indikator pelaporan hasil kritis laboratorium di Rumah Sakit Prima Husada Malang mencapai 100% dan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Capaian tersebut juga berhasil dipertahankan selama empat bulan berturut-turut, yang menunjukkan konsistensi petugas dalam melaksanakan pelaporan hasil kritis secara tepat dan sesuai prosedur. Keberhasilan ini mencerminkan adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antar petugas laboratorium dengan unit pelayanan terkait dalam mendukung keselamatan pasien. Upaya yang terus dilakukan untuk mempertahankan capaian tersebut meliputi sosialisasi kebijakan dan SPO pelaporan hasil kritis, penguatan alur komunikasi hasil kritis antar unit, serta peningkatan kesadaran seluruh petugas untuk menjadikan pelaporan hasil kritis sebagai bagian dari budaya keselamatan pasien di rumah sakit.

3.1.9 Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

Gambar 9. Grafik Capaian Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

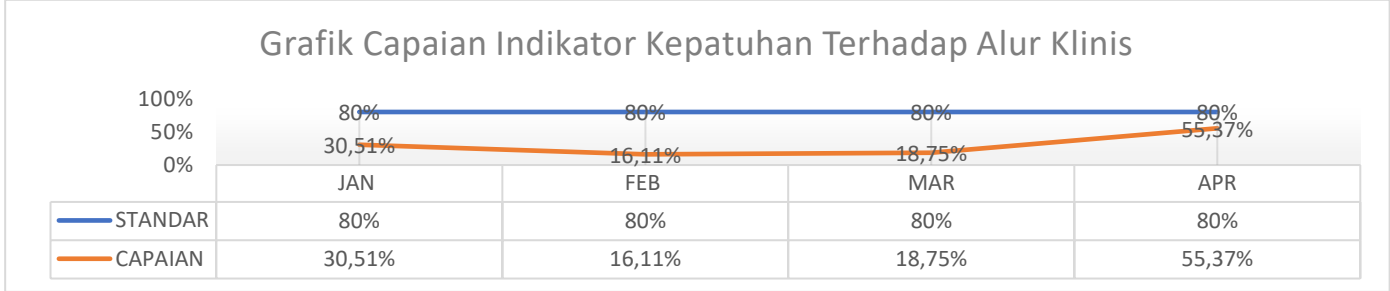


Analisis:

Pada bulan April 2026, capaian indikator pelaporan hasil kritis laboratorium di Rumah Sakit Prima Husada Malang sebesar 86,33%. Capaian tersebut mengalami sedikit penurunan sebesar 0,12% dibandingkan bulan sebelumnya. Meskipun demikian, hasil yang diperoleh masih berada di atas standar minimal yang ditetapkan yaitu ≥80%, sehingga menunjukkan bahwa pelaksanaan pelaporan hasil kritis laboratorium secara umum telah berjalan dengan baik. Penurunan capaian ini perlu menjadi perhatian sebagai bahan evaluasi untuk mengidentifikasi kendala dalam proses pelaporan hasil kritis, baik dari aspek komunikasi, ketepatan waktu, maupun kepatuhan petugas terhadap prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan dan monitoring secara berkelanjutan agar capaian indikator dapat terus ditingkatkan dan dipertahankan secara optimal sesuai standar yang telah ditetapkan.

3.1.10 Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)

Gambar 10. Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Terhadap Alur Klinis



Analisis:

Pada Bulan April Tahun 2026, capaian indikator kepatuhan terhadap alur klinis (*clinical pathway*) RS Prima Husada Malang sebesar 55.37%. Hasil ini mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya sebesar 44.63%. Namun, meski mengalami peningkatan, capaian ini masih jauh dari standar yang ditetapkan dengan gap sebesar 24.63%. Hal ini tentunya masih menjadi permasalahan untuk terus diupayakan perbaikannya agar semakin mengecilkan gap dengan standar setiap bulannya.

Tabel PDSA Kepatuhan terhadap Alur Klinis

Problem	Capaian kepatuhan alur klinis pada Bulan April sebesar 53.13%, mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya sebesar 2.64%. Namun, capaian ini masih jauh dari standar yang ditetapkan (80%). Beberapa faktor penyebab yang teridentifikasi antara lain kurangnya pemahaman petugas mengenai penggunaan alur klinis, keterbatasan waktu dalam pengisian dokumen, kurangnya monitoring dari unit terkait, dan masih belum dilakukan fiksasi untuk alur klinis yang disepakati oleh DPJP. Hal tersebut membuat tenaga medis belum sepenuhnya patuh mengisi dokumen alur klinis (clinical pathway) pada pasien dengan diagnosis yang telah ditetapkan.
Plan	Meningkatkan capaian kepatuhan terhadap alur klinis agar memenuhi standar yang ditetapkan (80%) dengan sosialisasi kembali mengenai penggunaan alur klinis, peningkatan monitoring kepatuhan pengisian oleh kepala ruangan atau PJ Mutu Unit, serta koordinasi dengan Komite Medik dan DPJP.

Do	Komite Mutu bersama Komite Medik melakukan sosialisasi dan edukasi kepada dokter dan tenaga kesehatan terkait pentingnya penggunaan alur klinis dalam pelayanan pasien. Selain itu dilakukan pengingat kepada DPJP dan petugas terkait untuk mengisi alur klinis sesuai diagnosis yang telah ditentukan. Kepala unit rawat inap juga diminta melakukan monitoring kelengkapan pengisian alur klinis pada rekam medis pasien.
Study	Capaian kepatuhan terhadap alur klinis pada bulan April sebesar 53.13%. Sementara pada bulan Maret mencapai 18.75% yang berarti mengalami peningkatan sebesar 46.87%. Upaya yang dilakukan untuk menaikkan capaian tersebut adalah meningkatkan monitoring oleh kepala ruangan dan kabid pelayanan medis. Selanjutnya, upaya tersebut dapat terus ditingkatkan agar semakin mendorong tercapainya kepatuhan terhadap alur klinis untuk dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Action	1. Sosialisasi terkait pengisian dokumen alur klinis (clinical pathway) 2. Diskusi dengan PPA dalam fiksasi alur klinis yang dilakukan

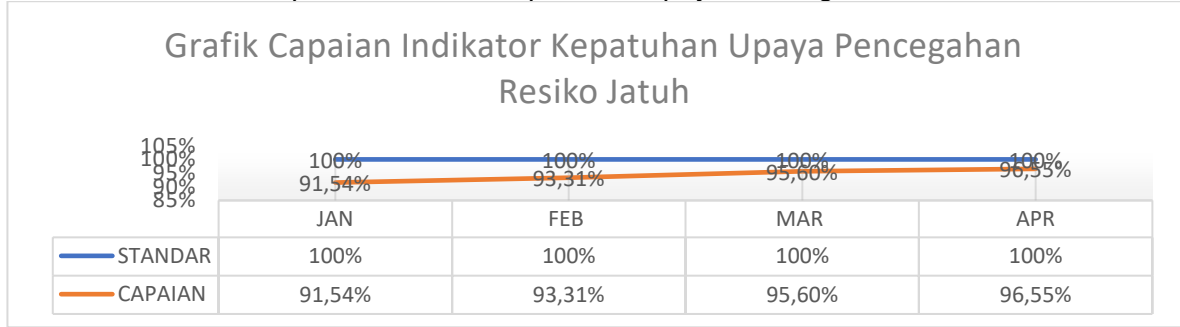
Tabel Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Sosialisasi terkait pengisian dokumen alur klinis (<i>clinical pathway</i>)	Meningkatkan kepatuhan pengisian dokumen alur klinis	Seluruh tenaga medis pelayanan	Rumah sakit akan terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kepatuhan penggunaan alur klinis. Komite Medik bersama Komite Mutu akan melakukan penguatan implementasi clinical pathway kepada DPJP serta melakukan supervisi terhadap pengisian dokumen alur klinis dalam rekam medis pasien. Selain itu, akan dilakukan evaluasi berkala serta pemberian umpan balik kepada unit pelayanan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap alur klinis sehingga capaian indikator dapat mencapai standar yang ditetapkan.	• Komite Medik • Komite Mutu • Kabid Pelayanan Medis	1 bulan
2	Diskusi dengan PPA dalam fiksasi alur klinis yang dilakukan	Mendapatkan alur klinis yang telah disepakai oleh semua PPA sehingga PPA akan memberikan perawatan yang seragam.	Seluruh PPA	Rumah sakit akan melakukan penyamaan persepsi antar PPA mengenai alur pelayanan dan tahapan tindakan klinis sesuai SPO atau clinical pathway yang berlaku dan penguatan koordinasi dan komunikasi efektif antar PPA untuk memastikan kesinambungan pelayanan pasien	• Komite Medik • Komite Mutu • Kabid Pelayanan Medis • Komite Keperawatan • Kepala Instalasi Gizi	1-2 bulan

					Kepala Instalasi Farmasi	
--	--	--	--	--	--	--

3.1.11 Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh

Gambar 11. Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh



Analisis:

Pada bulan April tahun 2026, capaian kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh sebesar 96.55%. Capaian ini mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya sebesar 0.95%. Meskipun capaian ini mengalami peningkatan namun masih belum memenuhi standar yang ditetapkan dengan gap sebesar 3.45%. Unit yang belum mencapai kepatuhan upaya pencegahan risiko jatuh sebesar 100% yaitu ICU, IKO, IRNA 4A, IRNA 5C, dan IRNA 8A. Capaian kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh paling rendah yaitu di IRNA 4A dengan capaian sebesar 63,42%. Perlu upaya perbaikan untuk meningkatkan kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh.

Tabel PDSA Capaian Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh

Problem	Capaian kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh pada Bulan April sebesar 96.55%. Meskipun angka ini cukup tinggi, namun masih di bawah standar 100%. Terdapat gap sebesar 3.45% yang berisiko pada keselamatan pasien. Capaian belum mencapai standart 100% karena kepatuhan petugas dalam melaksanakan upaya pencegahan risiko jatuh belum optimal, edukasi pasien dan keluarga belum optimal, monitoring dan dokukemntasi belum lengkap.
Plan	Meningkatkan capaian kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh agar memenuhi standar 100% dengan sosialisasi ulang SOP pencegahan risiko jatuh dan audit kepatuhan pencegahan risiko jatuh secara rutin.
Do	- Melaksanakan pengkajian risiko jatuh pada pasien saat masuk dan berkala - Pemberian tanda risiko jatuh (gelang/label/stiker) - Penerapan intervensi pencegahan sesuai tingkat risiko - Edukasi pasien dan keluarga tentang pencegahan jatuh

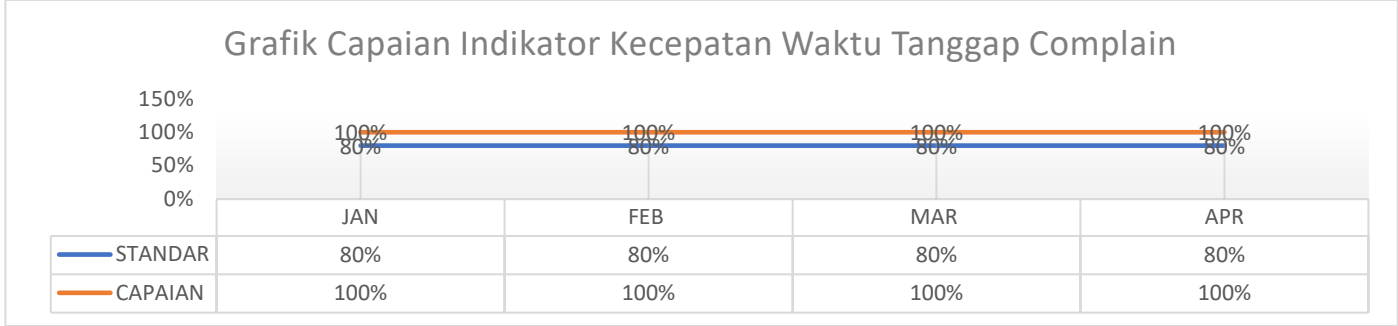
Study	Setelah dilakukan intervensi berupa edukasi pasien dan keluarga tentang pencegahan jatuh dan monitoring pemasangan pemberian tanda risiko jatuh didapatkan kenaikan capaian sebesar 0.95% dari bulan sebelumnya. Adanya peningkatan capaian menunjukkan bahwa upaya intervensi yang dilakukan mampu meningkatkan kepatuhan upaya pencegahan risiko jatuh. Upaya tersebut dapat terus dilakukan untuk semakin meningkatkan capaian sehingga mampu memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Action	1. Meningkatkan edukasi kepada pasien dan keluarga/penunggu pasien untuk pencegahan jatuh 2. Monitoring pemasangan tanda risiko jatuh (gelang/label/stiker)

Tabel Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Meningkatkan edukasi kepada pasien dan keluarga/penunggu pasien untuk pencegahan jatuh	Meningkatkan pemahaman pasien dan keluarga mengenai upaya pencegahan risiko jatuh selama perawatan	Pasien risiko jatuh dan keluarga/penunggu pasien	• Memberikan edukasi secara langsung saat pasien masuk rawat inap • Menggunakan media edukasi seperti leaflet/poster • Mengingatkan keluarga untuk mendampingi pasien risiko jatuh • Melakukan dokumentasi edukasi pada rekam medis	• Perawat ruangan • Kepala ruangan • Komite Mutu	Berkelanjutan
2	Monitoring pemasangan tanda risiko jatuh (gelang/label/stiker)	Meningkatkan kedisiplinan staf dalam pencegahan risiko pasien jatuh	Perawat dan tenaga kesehatan	• Melakukan monitoring harian pemasangan gelang/label/stiker risiko jatuh • Melakukan audit kepatuhan secara berkala • Memberikan umpan balik kepada petugas apabila ditemukan ketidaksesuaian • Mengingatkan petugas melalui briefing/safety morning	• Perawat ruangan • Kepala ruangan • Komite Mutu	Berkelanjutan

3.1.12 Kecepatan waktu tanggap complain

Gambar 12. Grafik Capaian Indikator Kecepatan Waktu Tanggap Complain

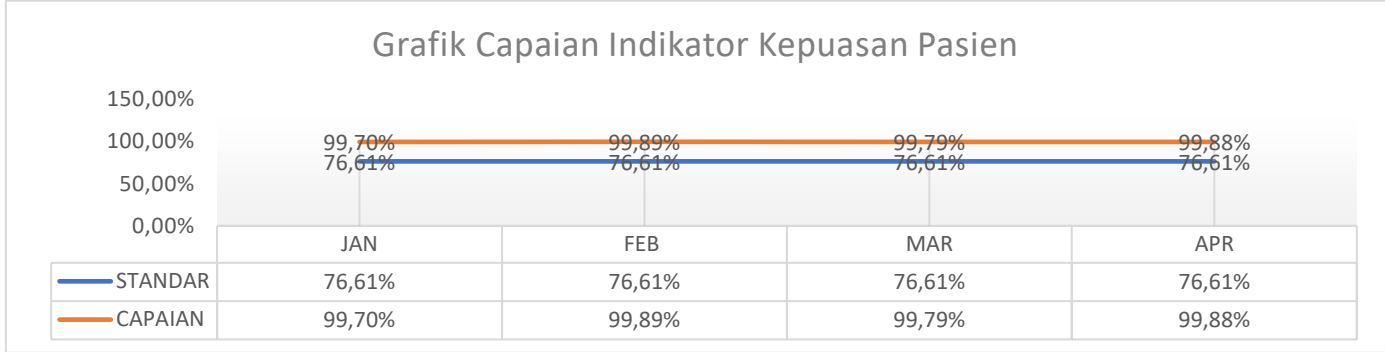


Analisis:

Pada bulan April 2026, capaian indikator kecepatan waktu tanggap komplain di Rumah Sakit Prima Husada Malang mencapai 100% dan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Capaian ini juga berhasil dipertahankan selama empat bulan berturut-turut, yang menunjukkan konsistensi rumah sakit dalam memberikan respons cepat terhadap setiap komplain yang diterima. Keberhasilan tersebut didukung oleh koordinasi dan kerja sama yang baik antara PIPP dengan manajemen rumah sakit dalam melakukan tindak lanjut komplain secara cepat dan tepat. Selain itu, tersedianya mekanisme pelaporan komplain yang mudah diakses melalui PIPP, telepon, WhatsApp, maupun formulir online turut meningkatkan efektivitas penerimaan dan penanganan komplain pasien. Dukungan sumber daya manusia yang telah terlatih dalam manajemen komplain serta memiliki kemampuan komunikasi yang baik juga menjadi faktor penting dalam tercapainya indikator ini. Capaian tersebut diharapkan dapat terus dipertahankan sebagai bentuk komitmen rumah sakit dalam meningkatkan mutu pelayanan dan kepuasan pasien.

3.1.13 Kepuasan Pasien

Gambar 3.1.13 Grafik Capaian Indikator Kepuasan Pasien



Analisis:
Pada bulan April 2026, capaian indikator kepuasan pasien di Rumah Sakit Prima Husada Malang sebesar 99,88%, mengalami peningkatan sebesar 0,09% dibandingkan bulan sebelumnya. Hasil tersebut telah melampaui standar yang ditetapkan yaitu $\geq 76,61\%$, sehingga menunjukkan bahwa mutu pelayanan yang diberikan rumah sakit telah mampu memenuhi harapan dan kebutuhan pasien dengan sangat baik. Peningkatan capaian ini mencerminkan adanya upaya perbaikan pelayanan yang dilakukan secara berkesinambungan oleh seluruh unit pelayanan, baik dari aspek komunikasi petugas, kecepatan pelayanan, kenyamanan fasilitas, maupun ketepatan pemberian asuhan kepada pasien. Capaian yang tinggi ini diharapkan dapat terus dipertahankan melalui evaluasi rutin, tindak lanjut terhadap masukan pasien, serta peningkatan budaya pelayanan prima guna menjaga kepercayaan dan kepuasan pasien terhadap pelayanan rumah sakit.

3.2 Indikator Sasaran Keselamatan Pasien

No.	Judul	Stand	Jan '26	Feb '26	Mar '26	Apr '26	Mei '26	Jun '26	Jul '26	Agust '26	Sept '26	Okt '26	Nov '26	Des '26	Rata-Rata
1.	Kepatuhan verifikasi identitas pasien sebelum pemberian obat pasien rawat jalan (farmasi)	100%	100%	100%	100%	100%									
2.	Kepatuhan pelaporan hasil kritis radiologi (radiologi)	100%	100%	100%	100%	100%									

3.	Kepatuhan penempelan label obat LASA dan obat obatan High Alert dirawat inap	100%	-	92.14%	92.90%	92.83%									
4.	Kepatuhan penandaan lokasi operasi (IKO)	100%	100%	100%	100%	100%									
5.	Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6 langkah cuci tangan (PPI)	100%	85.05%	85.70%	85.91%	86.59%									
6.	Kepatuhan pemasangan handrell dan penguncian roda brankar (IGD, IRNA, IKO)	100%	-	87.11%	92.08%	98.42%									

3.3 Indikator Mutu Pelayanan Klinis Prioritas

No.	Judul	Stand	Jan '26	Feb '26	Mar '26	Apr '26	Mei '26	Jun '26	Jul '26	Agust '26	Sept '26	Okt '26	Nov '26	Des '26	Rata-Rata
1.	Kepatuhan Pengisian Form Discharge Planing pasien DM dengan ulkus (Rawat Inap)	100%	-	7.08%	12.50%	11.9%									
2.	Kepatuhan Pengisian Form Edukasi pada pasien DM dengan ulkus (Rawat Inap)	100%	-	12.1%	21.48%	12.34%									
3.	Kepatuhan PPK dan CP Pasien DM (Rawat Inap)	100%	-	8.341%	12.05%	17.94%									

3.4 Tujuan Strategis

NO	JUDUL	STAND	Jan '26	Feb '26	Mar '26	Apr '26	Mei '26	Jun '26	Juli '26	Agust '26	Sept '26	Okt '26	Nov '26	Des '26	Rata-Rata
1.	Kejadian komplain pasien / keluarga di <i>google review</i>	0	5	1	3	11									

3.5 Perbaikan Sistem

No	Judul	Stand	Jan '26	Feb '26	Mar '26	Apr '26	Mei '26	Jun '26	Jul '26	Agust '26	Sept '26	Okt '26	Nov '26	Des '26	Rata-Rata
1.	Kepatuhan petugas dalam pemeliharaan alat	100%	100%	100%	100%										
2.	Waktu tunggu obat racikan kurang dari 60 menit	100%	10.38%	17.34%	16.84%	86.44%									

3.6 Hasil Kegiatan Mutu Prioritas Unit

NO	JUDUL INDIKATOR MUTU	UNIT	Bulan												STAND ART
			Jan '26	Feb '26	Mar '26	Apr '26	Mei '26	Jun '26	Jul '26	Agt '26	Sep '26	Okt '26	Nov '26	Des '26	
1	Ketidaklengkapan E-RM pengkajian awal IGD dan SPRI	IGD	-	54.72%	1.53%	0.86%									0%
2	Kejadian ketidakpatuhan staf medis dalam penempatan pasien dengan EWS	IGD	-	0	0	0									0
3	Kejadian kesalahan asuhan medis dokter IGD	IGD	-	0	0	0									0
4	Kejadian kesalahan asuhan medis DPJP	Rawat Inap	-	0	0	0									0
5	Angka Kejadian pasien tidak dilaksanakan visite	Rawat Inap	-	55.64%	29.92%	11.76%									0%
6	Ketidaklengkapan e-rm asuhan pasien selama di rawat inap	Rawat Inap	-	60.71%	56.75%	30.15%									0%
7	Ketidaklengkapan e-rm asuhan pasien selama di ICU dan HCU	ICU / HCU	-	70.45%	0%	0%									0%
8	Kejadian Kesalahan saat hand over (serah terima)	ICU / HCU	0	0	0	0									0
9	Kejadian Keterlambatan pemasangan intubasi pasien	ICU / HCU	0	0	1	0									0
10	Angka pasien kembali ke perawatan intensive dengan kasus yang sama <72 jam	ICU/HC U	0	4	0	1									<3%
11	Kepatuhan DPJP terhadap Jadwal Praktek	Rawat Jalan	-	87.6%	84.62%	85.31%									100%
12	Ketidaklengkapan e-rm asuhan pasien selama di rawat jalan	Rawat Jalan	-	2.55%	2.58%	2.14%									0%

13	Target Pasien PRB dan iterasi	Rawat Jalan	-	-	1.14%	100%									100%
14	Kegagalan pelaksanaan layanan di rawat jalan (pasien gagal pelayanan atas kesalahan) setiap hari	Rawat Jalan	-	0	0	0									0
15	Kegagalan pelaksanaan layanan di rawat jalan (pasien gagal pelayanan atas kesalahan) setiap hari	Fisioterapi	5	2	0	3									0
16	Pelayanan tidak sesuai program terapi	Fisioterapi	0%	0%	0%	0%									0%
17	Ketidaklengkapan e-rm asuhan pasien selama di maternitas	Maternitas	11%	13%	15%	11.92%									0%
18	Angka kematian ibu	Maternitas	0%	0%	0%	0%									0%
19	Kejadian perdarahan post partum	Maternitas	3	3	2	3									0
20	Angka Kejadian partus macet	Maternitas	18.5%	31.3%	33.3%	13.21%									<10%
21	Kejadian eklamsi	Maternitas	3	0	0	0									0
22	Kejadian pre eklamsi	Maternitas	0	1	1	4									0
23	Kejadian infeksi nifas	Maternitas	0	0	0	0									0
24	Angka Kematian Bayi	Neonatalogi	0%	0%	1.59%	0%									0%
25	Kejadian Keterlambatan pemasangan Intubasi pada pasien dengan indikasi	Neonatalogi	0	0	0	0									0
26	Kejadian SHK yang di tolak Dinkes	Neonatalogi	0	0	0	0									0

27	Kejadian re operasi	IKO	0	0	0	0									0
28	Ketidaklengkapan pengisian e-rm laporan operasi dan anestesi sedasi pasien selama di IKO	IKO	-	9.32%	1.49%	3.83%									0
29	Kejadian kegagalan pembiusan SAB, sehingga prosedur dialihkan menjadi pembiusan GA	IKO				0									0
30	Keterlambatan hasil patologi anatomi sesuai dengan regulasi	Laboratorium	0	24	27	12									0
31	Surveilans harian hemovigilance "Kejadian Reaksi Transfusi"	Laboratorium	100%	100%	100%	100%									<3%
32	Ketersediaan kantong darah sesuai golongan darah	Laboratorium	98.5%	100%	100%	100%									100%
33	Kejadian ketidakcocokan hasil bacaan radiologi dengan klinis pasien	Radiologi	0	16	5	5									0
34	Kejadian keterlambatan hasil radiologi sesuai dengan regulasi	Radiologi	0	40	30	30									0
35	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD) oleh petugas pengolahan	Instalasi Gizi	-	91.09%	87.76%										100%
36	Kepatuhan identifikasi pasien oleh penyaji	Instalasi Gizi	-	100%	100%										100%
37	Angka Kelengkapan Pengkajian Gizi	Instalasi Gizi	100%	100%	100%										100%
38	Kejadian kesalahan pemberian diet	Instalasi Gizi	2	1	1	2									0
39	Kejadian adanya benda asing dalam makanan	Instalasi Gizi	0	0	0	0									0
40	Kejadian makanan basi	Instalasi Gizi	1	1	0	0									0
41	Angka keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit.	Farmasi	-	43.56%	43.06%										0%

42	Kejadian ketidakpatuhan retur obat rawat inap	Farmasi	0	0	0	0									0
43	Kejadian Kesalahan Penyiapan Obat	Farmasi	2	4	6	2									0
44	Kejadian Kesalahan Pemberian Obat	Farmasi	1	2	0	1									0
45	Kejadian Kesalahan Penulisan Etiket Obat	Farmasi	1	0	0	1									0
46	Kejadian Kesalahan Input E-Resep	Farmasi	1	4	0	0									0
47	Keterlambatan sediaan farmasi datang	Pengada an Farmasi	-	20.6%	28%										0%
48	Kesalahan pembelian sediaan farmasi	Pengada an Farmasi	-	0%	0%										0%
49	Angka selisih stok opname	Pengada an Farmasi	-	0.88%	0.73%										0%
50	Respon time memasukkan master barang baru 1X24 Jam	Pengada an Farmasi	-	93.75%	97.37%										≥95%
51	IDO (Infeksi Daerah Operasi)	PPI	0%	0%	0%	0%									≤ 2 %
52	IADP (Infeksi Aliran Darah Primer)	PPI	0%	0%	0%	0%									≤3,5‰
53	VAP (Ventilation Associated Pneumonia)	PPI	0 ‰	0 ‰	1.82%	0%									≤ 5,8 ‰
54	ISK (Infeksi Saluran Kencing)	PPI	0 ‰	0 ‰	0.81%	0%									≤ 4,7 ‰
55	Infeksi Aliran Darah Perifer /ILI (Phlebitis)	PPI	0.35%	0.3%	0.17%	0.33%									≤ 5 %
56	Angka Decubitus	PPI	0%	0%	9.09%	0%									0%

57	Kejadian petugas tertusuk jarum bekas pasien (pajanan)	PPI	0	0	0	0								0
58	Kejadian keterlambatan pengurusan SIP/SIK	SDM	0%	4.72%	0	1								0
59	Angka turn over staf	SDM	1.4%	0%	0.28%	0.55%								0%
60	Kesalahan pendaftaran pasien	Pendaftar	-	25	25	38								0
61	Kejadian pasien BPJS TK tidak memasukkan dalam system E-PLKK	Pendaftar	-	4	1	1								0
62	Kejadian ketidaksesuaian tanggal pengunjungan pasien RI dengan SPRI	Pendaftar	-	0	1	5								0
63	Ketidakpatuhan pembuatan PCRA	K3RS	-	0	0									0
64	Waktu pengajuan klaim	Asuransi Center	Tgl 5	Tgl 5	Tgl 5	Tgl 5								Tgl 5 awal bulan
65	Klaim pending RJTL	Asuransi Center	0	-	-	1.9%								<0.1%
66	Klaim pending RITL	Asuransi Center	0	-	-	8.3%								<1%
67	Klaim tidak layak	Asuransi Center	0	-	-	0.03%								0%
68	Nilai Pengembalian Audit Klaim RJTL	Asuransi Center	0	-	-	-								<1 juta
69	Nilai Pengembalian Audit Klaim RITL	Asuransi Center	0	-	-	-								<5 juta
70	Nilai selisih negatif klaim RJTL	Asuransi Center	251.175.040	232.420.655	151.929.783	251.293.106								<50 juta
71	Nilai selisih negatif klaim RITL	Asuransi Center	- 1.216.03	-	-	- 1.462.31 3.938								<100 juta

			722.654												
72	Persentase readmisi pasien rawat inap	Asuransi Center	373.5%	1.8%	2.3%	3.5%									0%
73	Angka kelengkapan berkas klaim di SIMRS	Asuransi Center	66.744%	58%	61.3%	70%									100%
74	Waktu tanggap respon dan penanganan pelaporan kerusakan unit	IPSRS	96.83%	98.08%	88.28%	81.25%									100%
75	Kejadian kerusakan sarana prasarana	IPSRS	124	156	145										0
76	Ketidapatuhan pengambilan barang oleh unit	Gudang Umum	4	8	1	4									0
77	Respon time menanggapi keluhan unit <10 menit	Cleaning Service	90.91%	79.1%	84.62%	88.07%									≥ 90%
78	Angka ketidaklengkapan pengumpulan dokumen meeting RS (saat akhir rapat)	Sekretariat	25%	0%	0%	0%									0%
79	Kejadian linen ruang perawatan hilang	Laundry	0	16	38										0
80	Kejadian tercampur benda asing	Laundry	1	0	4										0
81	Kejadian keterlambatan penyediaan kasa steril	CSSD	2	0	0										0
82	Kejadian ditemukannya instrument hilang atau kurang	CSSD	0	0	2										0
83	Kejadian CCTV tidak terecord	IT	0	0	■										0
84	Kejadian Komputer dan internet lemot	IT	60	53	■										0
85	Ketidapatuhan pencatatan buku transit jenazah	Kamar Jenazah	0%	0%	0%	0%									0%

86	Kejadian permintaan driver yang bersamaan	Driver	0	4	1	2									0%
87	Kejadian Oncall driver	Driver	3	5	2	2									0
88	Penggunaan ambulance Luar RS	Driver	12	11	10	5									0
89	Kelolosan tamu tidak menggunakan kartu visitor	Security	1	0	1	1									0
90	Kejadian ketidaktertiban pengunjung rawat inap	Security	15	14	13	26									0
91	Kesalahan pelunasan yang dilakukan	Kasir	2	5	5	7									0
92	Keterlambatan pelunasan pembayaran	Kasir	1	1	0	0									0
93	kejadian pemulangan pasien rawat inap lebih dari 15 menit	Kasir	0	4	13	13									0
94	Keterlambatan perpanjangan perjanjian kerja sama	Humas													0
95	Kejadian komplain pasien karena keterlambatan pengantaran obat	Primanta ra	1	1	0	2									0
96	Kepatuhan PPA dalam pengisian form edukasi kolaborasi	PKRS	-	-	87%										100%
97	Angka Kelengkapan Dokumentasi Metode SBAR dan Konfirmasi "Read Back" pada Instruksi Verbal	PKRS	-	-	93%										100%
98	Angka Kepatuhan Petugas dalam Survei kelengkapan Form Edukasi Kolaborasi Oleh PPA	PKRS	-	-	90%										100%
99	Angka kepatuhan petugas dalam memberikan edukasi Kelompok	PKRS	-	-	-										100%
100	Angka kepuasan pasien peserta BPJS	PIPP	99.89%	100%	100%	100%									100%

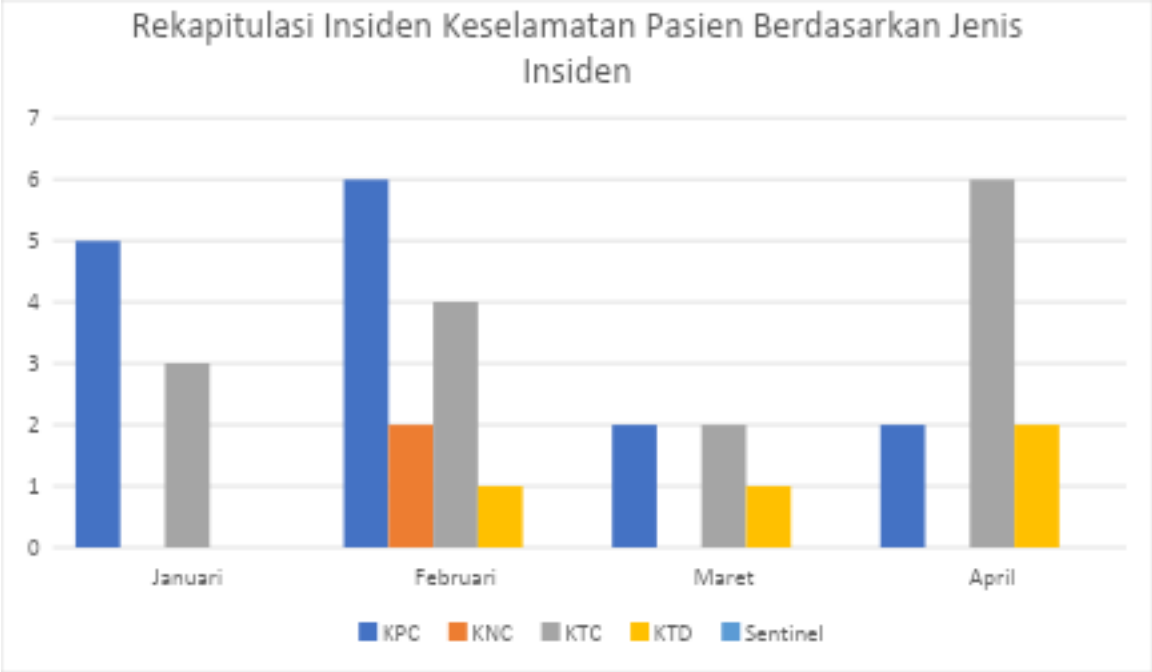
101	Angka terhubungnya display TT dengan mobile JKN	PIPP	100%	100%	100%	100%									≥ 90%
102	Angka terhubungnya operasi dengan mobile JKN	PIPP	100%	100%	100%	100%									≥ 90%
103	Angka Pasien Terkonfirmasi Bakteriologis	PROGN AS TB	100%	100%	100%	100%									100%
104	Angka capaian pelayanan KB per metode kontrasepsi, baik Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Non MKJP	PROGN AS KB	25.6%	7.44%	10.6%										100%
105	Angka capaian pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	PROGN AS KB	23.9%	9.9%	22.6%										70%
106	Kejadian tidak dilakukannya KB Pasca Persalinan pada ibu baru bersalin dan KB Pasca Keguguran pada Ibu pasca keguguran	PROGN AS KB	92	94	89										0
107	Angka Pelaksanaan kunjungan rumah dan PKM pasien Stunting & Wasting	PROGN AS STUNTING	-	-	-										100%
108	Angka Kepatuhan Petugas dalam Memberikan edukasi kelompok sebagai upaya Pencegahan Stunting & Wasting (4x/bln)	PROGN AS STUNTING	-	-	-										100%
109	Angka pasien terkonfirmasi bakteriologis	PROGN AS TB	100%	100%											
110	Angka kepatuhan petugas dalam melakukan skrining dan testing pasien dengan resiko HIV/AIDS	PROGN AS HIV													100%

3.7 LAPORAN KEJADIAN IKP

Tabel Rekapitulasi IKP Berdasarkan Jenis Insiden

	KPC	KNC	KTC	KTD	SENTINEL	JUMLAH
JANUARI	5		3			8
FEBRUARI	6	2	4	1		13
MARET	2		2	1		5
APRIL	2		6	2		10
MEI						
JUNI						
JULI						
AGUSTUS						
SEPTEMBER						
OKTOBER						
NOVEMBER						
DESEMBER						
JUMLAH	15	2	15	5		37

Grafik Rekapitulasi IKP Berdasarkan Jenis Insiden



NO.	TGL KEJADIAN	STAF YG TERLIBAT		JENIS IKP	KRONOLOGI	TINDAK LANJUT
		NAMA	UNIT			
1	06 April	Deya	Maternitas	KTC	Bidan salah menginput data di kematian maternal yang seharusnya di kematian abortus di web MPDN, sehingga data yang diisi sesuai dengan KTP Ibu.	1. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang melaporkan ke Kemenkes RI sehingga data kematian maternal sudah dihapus. 2. Dilakukan input kematian abortus. 3. Penyampaian kesalahan input di aplikasi kepada pasien dan suami pasien oleh MOD.
2	11 April	Hefti, Lilis, Defi	Farmasi	KTC	Kesalahan penulisan etiket obat antara antibiotik dan obat anti nyeri sehingga pasien tidak menghabiskan antibiotik yang seharusnya dihabiskan	1. Melakukan pengecekan ulang etiket setelah di print. 2. Melakukan pengecekan ulang pada saat packing resep dan sebelum di serahkan kepada pasien (Double check). 3. Peningkatan kedisiplinan penulisan paraf pada label ISEP, sehingga dapat diketahui petugas yang melakukan input, penyiapan, etiket, maupun KIE
3	12 April	Nisa	IRNA 2C	KTC	Kesalahan pemberian obat injeksi. Perawat memberikan obat kepada pasien anak dengan cara dibolus, seharusnya obat pekat diberikan secara didrip, sehingga anak menangis. Lalu keluarga komplain karena infus tiba-tiba menetes	1. (a) Pendokumentasian perintah DPJP dalam pemberian obat terutama untuk jenis injeksi kepada pasien anak-anak. (b) Jika cara pemberian obat belum jelas dan perawat ragu-ragu atau

					4cepat.	bingung, boleh bertanya ke DPJP. (c) Refreshing 5B pemberian obat. (d) Memberikan informasi yang detail dan jelas termasuk pemberian obat saat operan shift. 2. Perawat senior harus mendampingi perawat baru setiap melakukan tindakan ke pasien. 3. (a) KIE kepada keluarga pasien terutama pasien anak, jika infus menetes cepat, bisa memberitahu perawat. (b) Menggunakan prosedur yang benar saat membenahi tetesan infus. 4. Masukan dari dr. Heru, jika terjadi komplain, boleh meminta DPJP untuk menjelaskan ke keluarga pasien, agar lebih membuat tenang. 5. Koordinasi dengan komite keperawatan
4	14 April	Karisa	IGD	KPC	Kesalahan penulisan form SBAR karena perawat copy paste advice DPJP di WA tanpa melakukan pengecekan ulang identitas pasien sehingga form SBAR yang tertulis di e-RM adalah milik pasien lain.	1. Melakukan <i>crosscheck</i> sebanyak 3x saat menuliskan SBAR di E-RM 2. Harus melihat identitas sebelum menulis SBAR di E-RM
5	16 April	Lilis, Wisnu	Farmasi	KTC	Kejadian kesalahan pemberian antibiotik karena staf farmasi kurang teliti menyiapkan obat. Perawat IRNA hanya double check di etiket	1. Melakukan pengecekan ulang/verifikasi obat sesuai SPO Verifikasi Pemberian Obat Rawat Inap dan pelaksanaan 5 benar

					tapi tidak di obatnya sehingga tidak menyadari obat yang diberikan farmasi berbeda dengan obat yang diadvicekan DPJP	telaah obat (Benar Pasien, Benar Obat, Benar Dosis, Benar Rute, Benar Waktu Pemberian)
6	21 April			KTD	Kejadian penurunan kesadaran dan gangguan napas pasca operasi remove implant diduga dipicu krisis hipertiroid yang sebelumnya tidak teridentifikasi saat pengkajian praoperasi karena pasien memiliki riwayat hipertiroid namun tidak rutin berobat, sehingga pasien memerlukan perawatan intensif di ICU.	1. Melakukan penguatan pengkajian praoperasi sesuai SPO asesmen pra anestesi dan pra operasi melalui verifikasi ulang riwayat penyakit pasien, riwayat pengobatan, serta pemeriksaan penunjang yang diperlukan, disertai peningkatan komunikasi dan koordinasi antar DPJP, dokter anestesi, perawat, dan pasien/keluarga guna meminimalkan risiko komplikasi perioperatif.
7	22 April	Mita, Ara, Wahyu	Maternitas	KTD	Bidan memberikan premed ondansentron padahal DPJP tidak memberi advice tersebut. Kemudian muncul bentol-bentol di tangan pasien akibat reaksi alergi ondansentron sehingga pelaksanaan kuret ditunda	1. Pengkajian alergi harus terkaji mulai awal, jika di awal belum terkaji, harus dikaji pada tahap selanjutnya. 2. Memberikan pertanyaan terbuka jika bertanya ke bidan lain mengenai premed yang diberikan. Bidan juga harus meningkatkan fokus dan tidak memberikan tanggapan dengan mengangguk saja. 3. Melihat kembali advice DPJP di WA sebelum memberikan asuhan pada pasien.
8	23 April	Amalya	Farmasi	KTC	Kesalahan penyiapan obat karena petugas tidak teliti konversi dosis sesuai obat yang tersedia sehingga jumlah obat kurang	1.Melakukan pengkajian resep dan konversi dosis sesuai resep. 2.Melakukan pengecekan ulang pada saat packing resep dan sebelum di serahkan kepada pasien (Double check).

						3.Peningkatan kedisiplinan penulisan paraf pada label ISEP, sehingga dapat diketahui petugas yang melakukan input, penyiapan, etiket, maupun KIE
9	24 April	dr. Yoga, Ana, Sina, Sherli, Aris, Susanti, Resta	Farmasi	KTC	Kesalahan penyiapan obat diawali dari DPJP tidak teliti dalam menginput resep, kemudian sudah direvisi namun petugas tidak teliti menyiapkan obat yang seharusnya diberikan sebanyak 60 tablet, hanya diberikan sebanyak 30 tablet. Lalu apoteker melakukan identifikasi pasien dan melakukan double check etiket dan obat dengan resep namun tidak teliti melihat kesesuaian resep dan jumlah obat.	1. Koordinasi dengan komite medik 2. Melakukan pengecekan ulang pada saat packing resep dan sebelum di serahkan kepada pasien (Double check). 3. Peningkatan kedisiplinan penulisan paraf pada label ISEP, sehingga dapat diketahui petugas yang melakukan input, penyiapan, etiket, maupun KIE
10	29 April	Roida	IGD	KPC	Kesalahan penulisan SBAR karena perawat langsung mengcopy paste advice DPJP tanpa melihat identitas pasien.	1.Melakukan <i>crosscheck</i> sebanyak 3x saat menuliskan SBAR di E-RM 2. Harus melihat identitas sebelum menulis SBAR di E-RM

3.8 Indikator Mutu Pengelolaan Klaim Asuransi Kesehatan

NO	INDIKATOR MUTU	STANDAR	FEBRUARI	MARET	APRIL
1	Waktu pengajuan klaim	< 5 Setiap Bulan	03/03/2026	05/03/2026	5/5/2026
2	% Klaim pending RJTL	< 0,5%	5.98%	1,87%	
3	% Klaim pending RITL	< 0,1%	12.04%	8,32%	
4	Klaim tidak layak RJTL	0 (No)	2	3	
5	Klaim tidak layak RITL	0 (No)	0	0	
6	Audit pasca klaim RJTL	< 1.000.000	0	0	
7	Audit pasca klaim RITL	< 5.000.000	0	0	
8	Selisih klaim RS vs INACBGs IRJA	< 50.000.000	232.420.665	153.296.445	250.986.654
9	Selisih klaim RS vs INACBGs IRNA	<100.000.000	- 934.791.853	777.985.662,00	-964.163.400

3.8 Indikator Mutu Pelayanan Pasien BPJS Kesehatan

NO.	INDIKATOR MUTU	STANDAR	FEBRUARI	MARET	APRIL
	Kesesuaian Jadwal Praktik Dokter atau Tenaga Kesehatan				
1		Jadwal praktik 100% sesuai = 100	75	75	75
		Jadwal praktik 60% - 99% sesuai = 75			
		Jadwal praktik 40% - 59% sesuai = 50			
		Jadwal praktik 20% - 39% sesuai = 25			
		Jadwal praktik <20% sesuai = 0			
		Tidak ada kunjungan = 100			
2	Tindak Lanjut dan Penyelesaian Pengaduan	Tidak ada pengaduan pada bulan penilaian = 100	50	50	50
		Pengaduan ditindaklanjuti sesuai SLA & bukan merupakan Top 10 Pengaduan Nasional tahun sebelumnya = 75			
		Pengaduan ditindaklanjuti sesuai SLA & merupakan Top 10 Pengaduan Nasional tahun sebelumnya = 50			
		Pengaduan tidak ditindaklanjuti atau tindak lanjut melebihi SLA = 0			
3	Umpan Balik Peserta (Customer Feedback)	Σ responden 100% target = 100	100	100	100
		Σ responden 75 - 99% target = 75			
		Σ responden 50 - 74% target = 50			
		Σ responden 25 - 49% target = 25			
		Σ responden <25% target = 0			
4	Update Data Ketersediaan Tempat Tidur	Σ update ≥ 25 hari dan tidak ada pengaduan terkait ketersediaan kamar rawat inap = 100	100	100	100
		Σ update ≥ 25 hari = 75			
		Σ update 15 - 24 hari = 50			
		Σ update 10 - 14 hari = 25			
		Σ update < 10 hari = 0			
5	Update Jadwal Tindakan Medis Operatif	Jadwal TMO terinput setiap bulan dan terhubung dengan sistem informasi BPJS Kesehatan = 100	100	100	100
		Tidak menginput jadwal TMO = 0			
6	Pemanfaatan Antrean Online terintegrasi MJKN	Pemanfaatan MJKN 100% target dan WTL tercapai = 100	100	100	75

	dan Waktu Tunggu Rawat Jalan				
		Pemanfaatan MJKN 91% - 99% target = 75			
		Pemanfaatan MJKN 81% - 90% target = 50			
		Pemanfaatan MJKN 71% - 80% target = 25			
		Pemanfaatan MJKN ≤ 70% target = 0			
7	Penerbitan Surat Kontrol	Surat Kontrol terbit >90% sesuai = 100	100	100	100
		Surat Kontrol terbit 81% - 90% sesuai = 75			
		Surat Kontrol terbit 61% - 80% sesuai = 50			
		Surat Kontrol terbit 51% - 60% sesuai = 25			
		Surat Kontrol terbit ≤50% sesuai = 0			
8	Interoperabilitas Rekam Medis Elektronik	RME terintegrasi dengan system informasi BPJS Kesehatan, digunakan untuk dokumen pengajuan klaim dan waktu pengiriman data < 7 hari = 100	50	50	50
		RME terintegrasi dengan system informasi BPJS Kesehatan = 75			
		RME diimplementasikan untuk tingkat layanan rawat jalan dan rawat inap = 50			
9	% Approval SEP	<1%	0,20%	0	
10	Angka Capaian Iterasi	1854	10%	44%	47,90%
11	Angka Capaian PRB	1370	33,20%	85,30%	86,86%

3.9 Aspek Analisis Mutu Pengelolaan Klaim Asuransi

3.9.1 Klaim Pending Rawat Jalan

NO	ASPEK	DEFINISI	MASALAH YANG DITEMUKAN	TINDAK LANJUT (TL)	WAKTU TL
1	Sistem	Klaim bermasalah karena tidak sesuai persyaratan mutlak dan teknis	-	-	-
2	Administrasi	Dokumen klaim yang tidak melampirkan administrasi peserta, administrasi pelayanan & penunjang, dan administrasi keuangan	-	-	-
3	Klinis	Ketidaklengkapan, ketidakjelasan dan ketidaktepatan anamnesis, pemeriksaan fisik dan tatalaksana yang mendukung diagnosis sesuai peraturan yang berlaku	1. Kunjungan mata berulang tanpa indikasi, rujukan internal/fragmentasi 2. indikasi numpang rujukan dan self referral (top 5 poli perujuk) 3. kunjungan multipoli hingga 5 poli	Dilakukan sosialisasi kepada 5 SMF terbanyak (untuk penekanan rujuk antar Rumah Sakit) dan pemahaman terkait dengan aturan Rujuk Internal dan Konsul Internal	Dilakukan Sosialisasi pada Rapat Komite medik dan dilakukan diskusi lebih intens Per SMF secara berkala
4	Koding	Kesalahan dalam melakukan koding penyakit, tindakan dan diagnostik sesuai aturan ICD	-	-	-

		10, ICD 9 CM, ICD IM dan peraturan yang berlaku			
--	--	---	--	--	--

3.9.2 Klaim Pending Rawat Inap

NO	ASPEK	DEFINISI	MASALAH YANG DITEMUKAN	TINDAK LANJUT (TL)	WAKTU TL
1	Sistem	Klaim bermasalah karena tidak sesuai persyaratan mutlak dan teknis	Belum Mendapatkan Status Respon Final Dari PT.Jasa Raharja	Klaim bermasalah karena tidak sesuai persyaratan mutlak dan teknis	Belum Mendapatkan Status Respon Final Dari PT.Jasa Raharja
2	Administrasi	Dokumen klaim yang tidak melampirkan administrasi peserta, administrasi pelayanan & penunjang, dan administrasi keuangan	Readmisi	Dokumen klaim yang tidak melampirkan administrasi peserta, administrasi pelayanan & penunjang, dan administrasi keuangan	readmisi
3	Klinis	Ketidaklengkapan, ketidakjelasan dan ketidaktepatan anamnesis, pemeriksaan fisik dan tatalaksana yang mendukung diagnosis sesuai peraturan yang berlaku	1. Indikasi Pasien Rawat inap 2. Pasien Dirujuk ditagihkan rawat inap => meminta tagihan menjadi Rawat Jalan 3. Tatalaksana pneumonia tidak sesuai ketentuan, minimal inj AB	Ketidaklengkapan , ketidakjelasan dan ketidaktepatan anamnesis, pemeriksaan fisik dan tatalaksana yang mendukung diagnosis sesuai peraturan yang berlaku	1. Indikasi Pasien Rawat inap 2. Pasien Dirujuk ditagihkan rawat inap => meminta tagihan menjadi Rawat Jalan 3. Tatalaksana pneumonia tidak sesuai ketentuan, minimal inj AB
4	Koding	Kesalahan dalam melakukan koding penyakit, tindakan dan diagnostik sesuai aturan ICD 10, ICD 9 CM, ICD IM dan peraturan yang berlaku	1. luka terbuka pada kepala dengan tindakan tindakan muscle suturing (83.65) gunakan kode prosedur 86.5 (suture or other closure of skin and subcutaneous tissue) 2. kode G936 (edema cerebri) manifes DU (ich), tidak	Kesalahan dalam melakukan koding penyakit, tindakan dan diagnostik sesuai aturan ICD 10, ICD 9 CM, ICD IM dan peraturan yang berlaku	1. luka terbuka pada kepala dengan tindakan tindakan muscle suturing (83.65) gunakan kode prosedur 86.5 (suture or other closure of skin and subcutaneous tissue) 2. kode G936 (edema cerebri) manifes DU (ich), tidak

			dikoding terpisah 3. kode tindakan repair tendon 8388 (Other plastic operations on tendon) kurang tepat, reseleksi 83.64 (Other suture of tendon)		dikoding terpisah 3. kode tindakan repair tendon 8388 (Other plastic operations on tendon) kurang tepat, reseleksi 83.64 (Other suture of tendon)
--	--	--	--	--	--

3.9.3 Klaim Tidak Layak Rawat Jalan

NO	ASPEK	DEFINISI	MASALAH YANG DITEMUKAN	TINDAK LANJUT (TL)	WAKTU TL
1	Sistem	Klaim bermasalah karena tidak sesuai persyaratan mutlak dan teknis	Cara Pulang Meninggal Tidak Sesuai, SEP: - TXT:Meninggal	Penertiban terkait pemulangan pasien dengan cara pulang meninggal pada Vclaim	Setiap bulan
2	Administrasi	Dokumen klaim yang tidak melampirkan administrasi peserta, administrasi pelayanan & penunjang, dan administrasi keuangan	-	-	-
3	Klinis	Ketidaklengkapan, ketidakjelasan dan ketidaktepatan anamnesis, pemeriksaan fisik dan tatalaksana yang mendukung diagnosis sesuai peraturan yang berlaku	1. indikasi numpang rujukan dan self referral (top 5 poli perujuk) 2. kunjungan multipoli hingga 5 poli 3. kunjungan pre op	Dilakukan sosialisasi kepada 5 SMF terbanyak (untuk penekanan rujuk antar Rumah Sakit) dan koordinasi dengan dpjp terkait kunjungan pasien pre op	Dilakukan Sosialisasi pada Rapat Komite medik dan dilakukan diskusi lebih intens Per SMF secara berkala
4	Koding	Kesalahan dalam melakukan koding penyakit, tindakan dan diagnostik sesuai aturan ICD 10, ICD 9 CM, ICD IM dan peraturan yang berlaku	-	-	-

3.9.4 Selisih klaim RS vs INACBGs IRJA

NO	ASPEK	DEFINISI	MASALAH YANG DITEMUKAN	TINDAK LANJUT (TL)	WAKTU TL
1	Sistem	Klaim bermasalah karena tidak sesuai persyaratan mutlak dan teknis	1. Tarif tindakan yang lebih besar dari pada Inacbg's 2. Pasien DM dengan penunjang	1. Melakukan koordinasi dengan PT terkait dengan pengelompokan	Setiap bulan

			dan persepan Insulin	tarif tindakan 2. Melakukan koordinasi dengan DPJP terkait kriteria pemberian insulin	
2	Administrasi	Dokumen klaim yang tidak melampirkan administrasi peserta, administrasi pelayanan & penunjang, dan administrasi keuangan		-	-
3	Klinis	Ketidaklengkapan, ketidakjelasan dan ketidaktepatan anamnesis, pemeriksaan fisik dan tatalaksana yang mendukung diagnosis sesuai peraturan yang berlaku	-	-	-
4	Koding	Kesalahan dalam melakukan koding penyakit, tindakan dan diagnostik sesuai aturan ICD 10, ICD 9 CM, ICD IM dan peraturan yang berlaku	-	-	-

3.9.5 Selisih klaim RS vs INACBGs IRNA

NO	ASPEK	DEFINISI	MASALAH YANG DITEMUKAN	TINDAK LANJUT (TL)	WAKTU TL
1	Sistem	Klaim bermasalah karena tidak sesuai persyaratan mutlak dan teknis	-	-	-
2	Administrasi	Dokumen klaim yang tidak melampirkan administrasi peserta, administrasi pelayanan & penunjang, dan administrasi keuangan	kunjungan rawat jalan dan rawat inap di hari yang sama	koordinasi dengan staf pelayanan terkait kunjungan dihari yang sama	Dilakukan Sosialisasi pada Rapat Komite medik dan dilakukan diskusi lebih intens Per SMF secara berkala
3	Klinis	Ketidaklengkapan, ketidakjelasan dan ketidaktepatan anamnesis, pemeriksaan fisik dan tatalaksana yang mendukung diagnosis sesuai peraturan yang berlaku	-	-	-
4	Koding	Kesalahan dalam melakukan koding penyakit, tindakan dan diagnostik sesuai aturan ICD 10, ICD 9 CM, ICD IM dan peraturan yang berlaku	-	-	-

3.10 Evaluasi Mutu APM

Tanggal	Jml. Kunjungan	Jml. Mobile JKN	Jml. APM	Pemanfaatan APM berdasarkan Kunjungan	Pemanfaatan APM berdasarkan Kunjungan MJKN
Januari	10.955	7.477	4.418	40%	59%
Februari	9.712	6.453	4.456	46%	69%
Maret	8.665	5.660	3.709	43%	66%
April	10.819	6.884	5.165	48%	75%

No.	Keterangan	Januari	Februari	Maret	April
1	APM	40%	46%	43%	48%
2	Petugas	60%	54%	57%	52%
Jumlah		100%	100%	100%	100%

1.6.1 Komite PPI

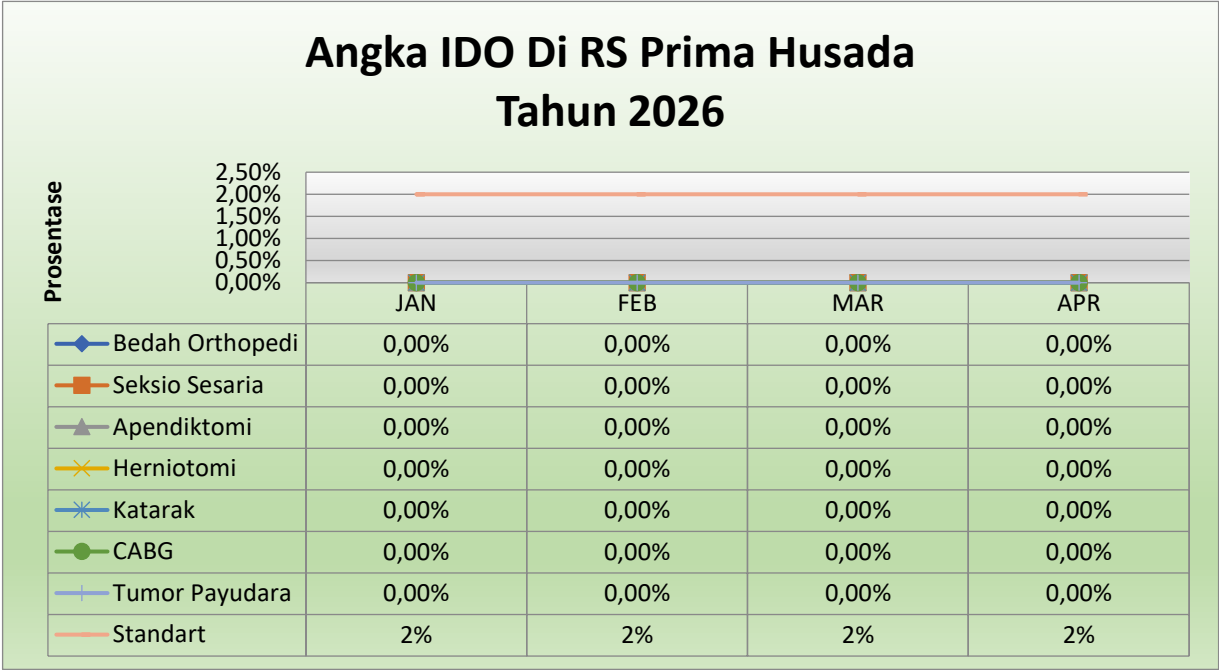
1.6.1.2 Hasil Surveilans dan Mutu PPI

1.6.1.2.5 IDO (Infeksi Daerah Operasi)

1.6.3.5.1 Tabel Data IDO berdasarkan Jenis Tindakan Operasi Sesuai Pelaporan SIMAR (Pelaporan INM dan HAls Kemenkes)

SSI 2026	Bedah Orthopedi	Seksio Sesaria	Apendiktomi	Herniotomi	Katarak	CABG	Tumor Payudara
Januari							
Jumlah Kasus	0	0	0	0	0	-	0
Jumlah Tindakan operasi	88	73	6	15	46	-	13
Insiden (%)	0%	0%	0%	0%	0%	-	0%
Februari							
Jumlah Kasus	0	0	0	0	0	-	0
Jumlah Tindakan operasi	66	67	16	8	51	-	15
Insiden (%)	0%	0%	0%	0%	0%	-	0%
Maret							
Jumlah Kasus	0	0	0	0	0	-	0
Jumlah Tindakan operasi	80	76	14	7	23	-	8
Insiden (%)	0%	0%	0%	0%	0%	-	0%
April							
Jumlah Kasus	0	0	0	0	0	-	0
Jumlah Tindakan operasi	87	69	10	11	52		21
Insiden (%)	0%	0%	0%	0%	0%	-	0%

1.6.3.5.2 Grafik Angka Infeksi Daerah Operasi (IDO)



Analisa	Secara keseluruhan angka IDO pada masing-masing jenis tindakan operasi adalah 0%, yang menunjukkan capaian indikator berada dalam kategori baik dan telah memenuhi standar mutu pelayanan rumah sakit. Namun masih perlu kewaspadaan terhadap kemungkinan under reporting.				
Masalah saat ini	Tidak ditemukan kasus IDO.				
Permasalahan sebelumnya	Tidak ditemukan kasus IDO sebelumnya.				
Tindakan yang dilakukan	• Monitoring rutin bundle/pencegahan SSI. • Monitoring kepatuhan Hand hygiene. • Monitoring pasien operasi dan dokumentasi rekam medis pasien.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
• Penguatan surveilans pasca operasi ≤30 hari (≤90 hari pada implan).	• Mempertahankan angka IDO ≤2% serta menjamin kekakuratan sistem surveilans.	• Tim Bedah, perawat kamar operasi, perawat IRNA/IGD/IRJA.	• Penguatan surveilans pasca operasi ≤30 hari (≤90 hari pada implan). • Menjalankan audit bundle SSI dengan baik. • Menjalankan kepatuhan pemberian antibiotik profilaksis. • Meningkatkan edukasi PPI kepada tenaga kesehatan dan kepada pasien/keluarga.	• Komite PPI, Kepala ruang, dokter operator, dan manajemen mutu.	• Monitoring bulanan
• Pertahankan bundle IDO berjalan dengan baik.	• Resiko IDO pada pasien berkurang/hilang.	• Pasien operasi	• Berkolaborasi dengan PPA terkait kondisi penyakit penyerta serta memberikan edukasi untuk mencegah agar risiko infeksi tidak menjadi aktual. • Memastikan bundle IDO (pre, durante, dan post op dilakukan dengan baik) • Melakukan monitoring persiapan pasien operasi khususnya pasien dianjurkan untuk mandi antiseptic/sabun untuk mengurangi resiko infeksi. • Penggunaan alat tetap diperhatikan proses sterilisasi central di CSSD terutama jika dilakukan operasi estafet dengan kasus yang sama (SC).	• Perawat /Bidan • Dokter • Karu • IPCLN/IPCEN	• Monitoring bulanan
• Pertahankan evaluasi pemahaman pemberian edukasi perawatan	• Meminimalisir kesalahpahaman penangkapan terkait edukasi perawatan pasien post operasi.	• Pasien post operasi.	• Koordinasi dengan perawat ruangan untuk memastikan pasien dan sudah mendapatkan edukasi terkait perawatan saat di rumah. • Pastikan pasien paham saat diedukasi dengan menanyakan kembali inti edukasi yang telah diberikan. (Memastikan	• Perawat /Bidan • Karu • IPCLN/IPCEN	• Monitoring bulanan

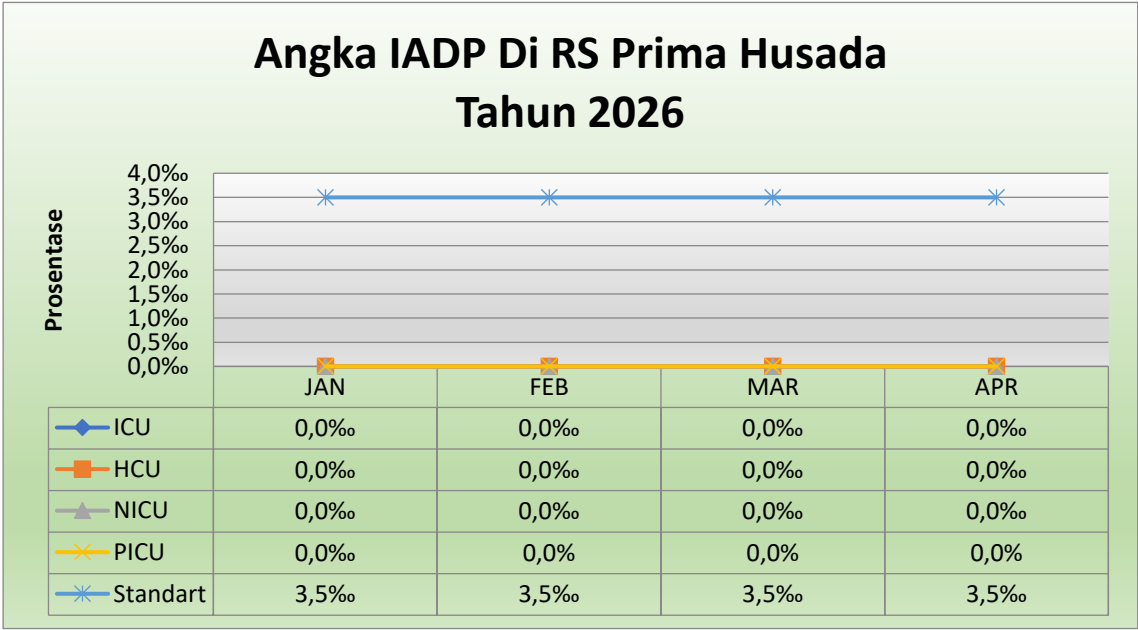
pasien pasca operasi			komponen edukasi tersampaikan dengan baik/Komunikasikan-pesan-media-feed back) • Berikan edukasi terutama terkait pemberian diit tinggi protein untuk membantu penyembuhan luka. • Lakukan edukasi pada saat pasien terdapat pendamping keluarga terutama yang satu rumah dengan pasien. • Berikan tambahan edukasi terkait kontrol pikiran pasien terutama terkait pantangan yang tidak perlu dipercaya di masyarakat.		
----------------------	--	--	--	--	--

3.6.1.1.2 IADP

3.6.1.1.2.1 Tabel Data IDP Berdasarkan Ruang sesuai Pelaporan SIMAR (Pelaporan INM dan HAIs Kemenkes

IADP 2026	ICU	HCU	NICU	PICU
Januari				
Jumlah Kasus	0	0	0	0
Jumlah Lama Hari pemakaian CVC	0	0	0	0
Insiden (%)	0‰	0‰	0‰	0‰
Februari				
Jumlah Kasus	0	0	0	0
Jumlah Lama Hari pemakaian CVC	0	0	0	0
Insiden (%)	0‰	0‰	0‰	0‰
Maret				
Jumlah Kasus	0	0	0	0
Jumlah Lama Hari pemakaian CVC	0	0	0	0
Insiden (%)	0‰	0‰	0‰	0‰
April				
Jumlah Kasus	0	0	0	0
Jumlah Lama Hari pemakaian CVC	15	0	0	0
Insiden (%)	0‰	0‰	0‰	0‰

3.7.8 Grafik Angka Infeksi Aliran Darah Primer (IADP)



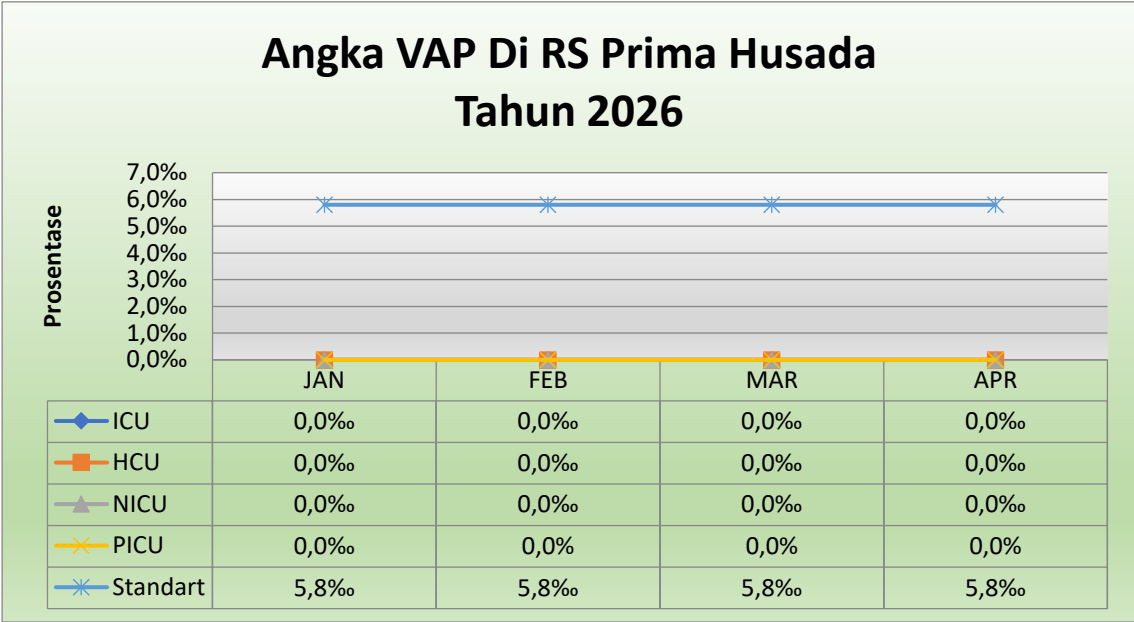
Tindakan yang dilakukan	- Melakukan evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas saat melakukan tindakan pemasangan CVC. - Melakukan evaluasi kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan CVC. - Melakukan monitoring kepatuhan desinfeksi area penusukan dan lokasi yang tepat. - Melakukan monitoring perawatan pemasangan CVC rutin, penggunaan spuit disposable, dan desinfeksi area penyuntikan.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Pertahankan kepatuhan bundle IADP.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle IADP.	Pasien dengan pemakaian CVC.	- Monitoring evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas. - Monitoring evaluasi kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan CVC. - Monitoring evaluasi kepatuhan desinfeksi area penusukan dan lokasi yang tepat. - Monitoring evaluasi perawatan pemasangan CVC rutin, penggunaan spuit disposable, dan desinfeksi area penyuntikan.	- Perawat /Bidan - Dokter - Karu - IPCLN/IPCN	Satu bulan

1.6.1.1.3 VAP

1.6.1.1.3.1 Tabel Data VAP berdasarkan Ruang sesuai Pelaporan SIMAR (Pelaporan INM dan HAls Kemenkes)

VAP 2026	ICU	HCU	PICU	NICU
Januari				
Jumlah Kasus	0	0	0	0
Jumlah Lama Hari pemakaian Ventilator Intubasi	86	0	0	0
Insiden (%)	0‰	0‰	0‰	0‰
Februari				
Jumlah Kasus	0	0	0	0
Jumlah Lama Hari pemakaian Ventilator Intubasi	78	0	12	0
Insiden (%)	0‰	0‰	0‰	0‰
Maret				
Jumlah Kasus	0	0	0	0
Jumlah Lama Hari pemakaian Ventilator Intubasi	98	0	60	0
Insiden (%)	0‰	0‰	0‰	0‰
Jumlah Kasus	0	0	0	0
Jumlah Lama Hari pemakaian Ventilator Intubasi	160	0	0	0
Insiden (%)	0‰	0‰	0‰	0‰

1.6.1.1.3.2 Grafik Angka Pneumonia Akibat Penggunaan Ventilator (VAP)



Analisa	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus VAP pada 160 hari total lama pemasangan ventilator pada 14 pasien di ICU.				
Masalah saat ini	• Tidak terjadi VAP				
Permasalahan sebelumnya	• Tidak terjadi VAP				
Tindakan yang dilakukan	• Melakukan evaluasi perawatan pasien dengan terpasang ventilasi mekanik. • Melakukan audit monitoring saat pemasangan ventilator. • Melakukan observasi tanda-tanda dehidrasi (bibir kering) pada pasien yang terpasang ventilator. • Melakukan evaluasi saat pasien dilakukan penghisapan lendir / suction. • Melakukan koordinasi dengan Kabid keperawatan terkait edaran kewajiban melakukan oral hygiene pada pasien yang terpasang ventilator dan mendokumentasikan di CPPT/Askep.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
• Tingkatkan kepatuhan bundle VAP, khususnya pelaksanaan oral hygiene.	• Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle VAP (oral hygiene).	• Pasien yang terpasang ventilator mekanik	• Monitoring evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas. • Monitoring evaluasi kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan ventilator. • Monitoring evaluasi posisi tepat pasien <i>head of bed</i> >30°-45°. • Monitoring evaluasi tindakan pemasangan ventilator. • Monitoring kegiatan oral hygiene dan	• Perawat /Bidan • Dokter • Karu • IPCLN/IPCN	• Satu bulan

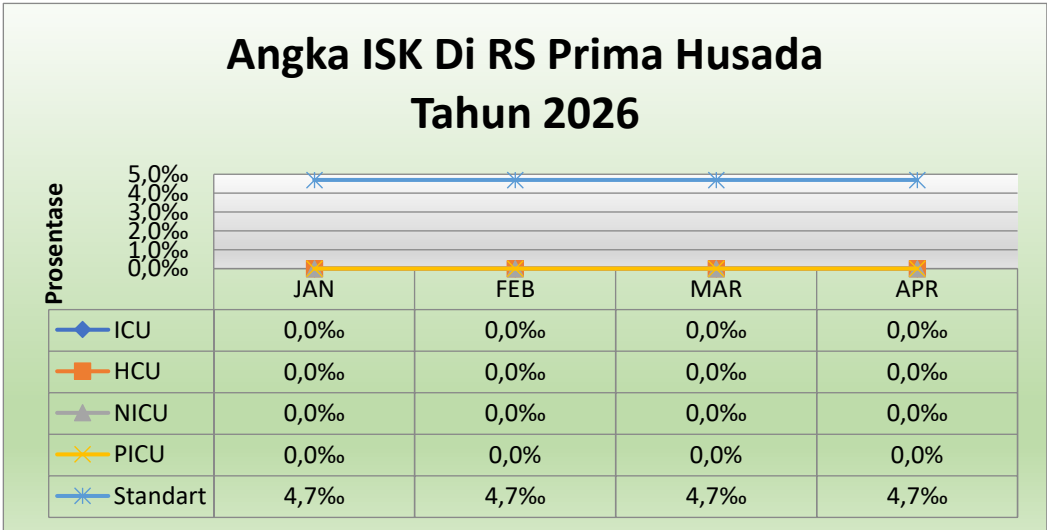
			pendokumentasian di RM. Pemberian tindakan oral hygiene mewajibkan juga diedukasikan pada keluarga pasien, agar keluarga ikut aktif mengingatkan petugas untuk melakukan tindakan tersebut.		
--	--	--	---	--	--

1.6.1.1.4 ISK

1.6.1.1.4.1 Tabel Data berdasarkan Ruang sesuai Pelaporan SIMAR (Pelaporan INM dan HAIs Kemenkes)

ISK 2026	ICU	HCU	PICU	NICU
Januari				
Jumlah Kasus	0	0	0	0
Jumlah Lama Hari pemakaian Catheter	188	40	0	0
Insiden (%)	0‰	0‰	0‰	0‰
Februari				
Jumlah Kasus	0	0	0	0
Jumlah Lama Hari pemakaian Catheter	168	78	6	0
Insiden (%)	0‰	0‰	0‰	0‰
Maret				
Jumlah Kasus	0	0	0	0
Jumlah Lama Hari pemakaian Catheter	180	45	3	0
Insiden (%)	0‰	0‰	0‰	0‰
April				
Jumlah Kasus	0	0	0	0
Jumlah Lama Hari pemakaian Catheter	246	89	10	0
Insiden (%)	0‰	0‰	0‰	0‰

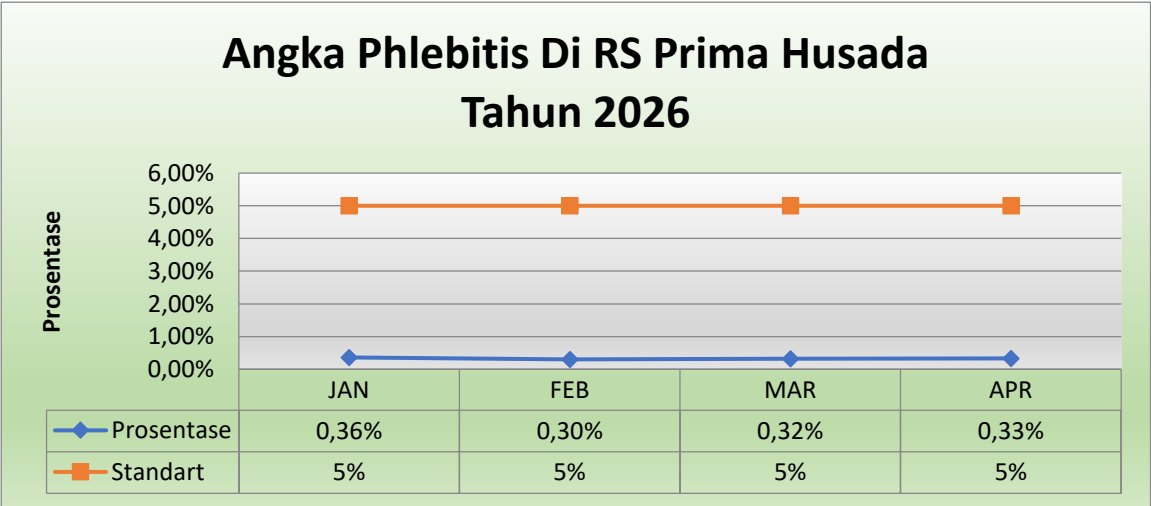
3.7.9 Grafik Angka Infeksi Saluran Kencing (ISK)



Analisa	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus decubitus pada 30 pasien tirah baring lama.				
Masalah saat ini	• Tidak terjadi decubitus				
Permasalahan sebelumnya	• Tidak terjadi decubitus				
Tindakan yang dilakukan	• Melakukan monitoring kepatuhan kebersihan tangan petugas saat melakukan proses perawatan pasien. • Melakukan monitoring evaluasi rutinitas petugas untuk melakukan imobilisasi pasien tiap 4 jam (mika-miki). • Melakukan monitoring timbulnya lecet pada area tubuh yang menempel pada alas tidur dan penggunaan serta penggantian pampers secara rutin. • Memastikan personal hygiene dilakukan dengan rutin oleh petugas.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
• Pertahankan kepatuhan pencegahan dekubitus.	• Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan pencegahan dekubitus.	• Pasien yang tirah baring lama (> 3x24 jam)	• Monitoring evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas. • Monitoring evaluasi rutinitas petugas untuk melakukan imobilisasi pasien tiap 4 jam (mika-miki). • Anjurkan penggunaan kasur anti decubitus atau alternatif lain • Monitoring timbulnya lecet pada area tubuh yang menempel pada alas tidur dan penggunaan serta penggantian pampers secara rutin. • Lakukan perawatan luka rutin jika sudah terdapat luka supaya tidak melebar.	• Perawat /Bidan • Dokter • Karu • IPCLN/PCN	• Satu bulan

1.6.1.1.6 Phlebitis

3.7.10 Grafik Angka Infeksi Jarum Infus (Phlebitis)

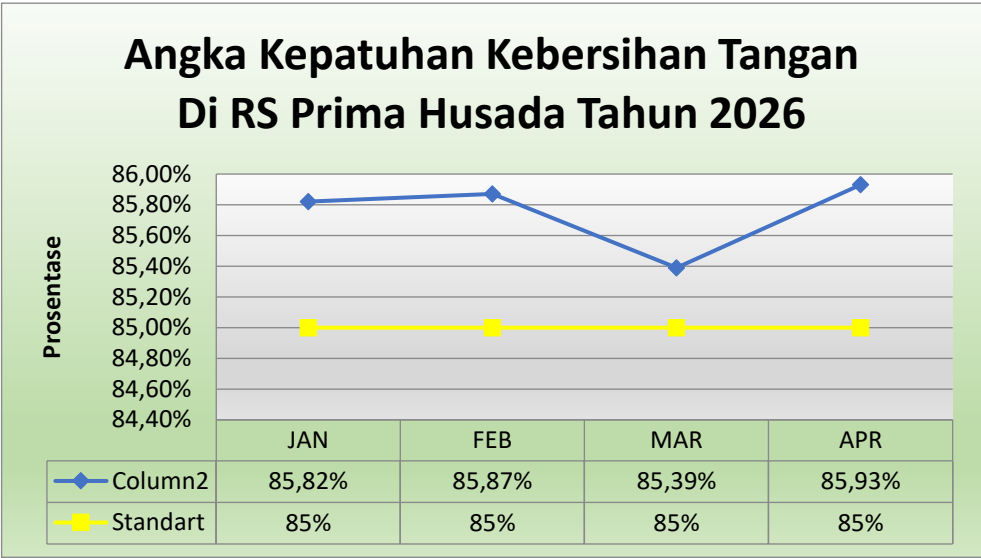


Analisa	Masih ditemukan kasus Phlebitis pada bulan ini dari total 3331 pasien yang terpasang infus setiap harinya dengan prosentase 0,33%, masih memenuhi standar nasional. Pencapaian ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan infeksi dan perawatan akses intravena pada bulan April berjalan optimal. Rendahnya angka phlebitis peningkatan pada perawatan infus, serta pelaksanaan monitoring rutin lokasi insersi. Selain itu, efektivitas kolaborasi antara Komite PPI dan Komite Keperawatan, dengan adanya pembinaan serta monitoring berkala turut berkontribusi terhadap penurunan angka phlebitis. Kondisi pada bulan ini menunjukkan bahwa tindakan korektif dan penguatan kepatuhan yang telah dilakukan memberikan hasil positif. Dari data yang diperoleh terdapat 11 pasien yang mengalami phlebitis. Faktor penyebab kemungkinan besar: Obat pekat/iritatif/antibiotik, pemberian transfusi darah. Dari 11 pasien yang ditanyai, tidak ditemukan pasien yang rawat inap mengalami infus slong (cairan infus pada indikator selang infus habis).				
Masalah saat ini	Penggunaan cairan pekat masih menjadi penyebab terjadinya phlebitis, termasuk juga pemberian transfusi darah.				
Permasalahan sebelumnya	- Penggunaan cairan pekat masih menjadi penyebab terjadinya phlebitis, termasuk juga pemberian transfusi darah. - Faktor internal pasien seperti usia pasien yang beresiko phlebitis juga berpengaruh, perlunya edukasi lanjut terkait ini.				
Tindakan yang dilakukan	- Mengkoordinasikan dengan komite keperawatan terkait sosialisasi pemasangan infus yang benar dan penanganan phlebitis. - Memberikan edukasi pada pasien setelah pemasangan infus terutama pada pasien yang beresiko tinggi phlebitis karena faktor internal. - Menganjurkan perawat untuk melakukan monitoring luka tusukan infus terutama pada pasien yang terpasang cairan pekat setiap hari setelah melakukan injeksi. - Menyarankan petugas untuk memberikan kompres hangat pada pasien yang mendapatkan cairan pekat pada area tangan yang terpasang infus untuk merilekskan pembuluh darah dan cairan pekat/darah tidak gampang menggumpal. - Menganjurkan perawat untuk terus mengingatkan edukasi tambahan terkait perawatan saat terpasang infus.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Perbaikan kepatuhan bundle phlebitis.	Memperbaiki kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle phlebitis.	Pasien yang terpasang infus	- Monitoring penyuntikan yang aman benar dilakukan. - Monitoring penggunaan cairan pekat maupun double antibiotic diberikan secara aman. - Monitoring kondisi luka tusukan infus setiap selesai melakukan injeksi. - Memberikan injeksi obat secara perlahan untuk mengurangi nyeri dan memperkecil resiko phlebitis. - Mengedukasi perawat unit untuk mengeset tetesan infus secara benar supaya hitungan jam habis infus dapat diperkirakan dan tidak sampai kehabisan. - Monitoring kepatuhan pemakaian APD terutama sarung tangan saat pemasangan infus dan kebersihan tangan sebelum memakai sarung tangan. - Monitoring teknik aseptik dan penggunaan alat steril pada saat pemasangan infus. - Tertibkan pencatatan petugas yang melakukan pemasangan infus pada plester infus pasien beserta tanggal	- Perawat /Bidan - Dokter - Karu - IPCLN/IPCN	Satu bulan

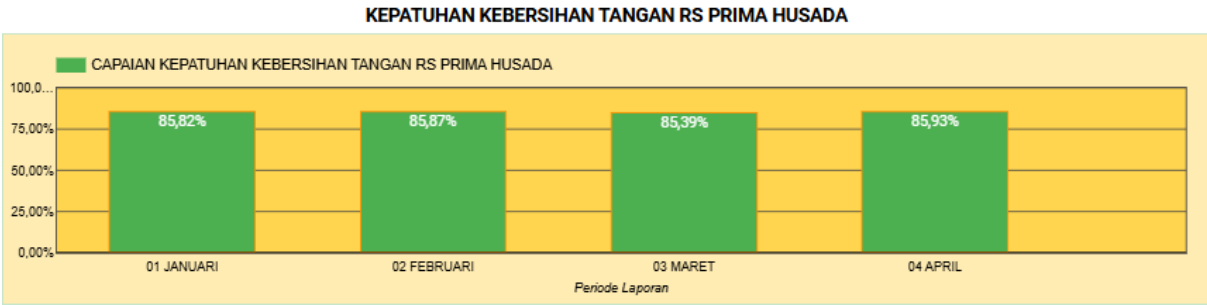
			pemasangan untuk mengontrol mutu skill dari perawat.		
• Pengendalian Penggunaan Obat Iritatif.	• Mengurangi resiko phlebitis karena pemberian obat pekat/iritan.	• Perawat/bidan • Apoteker	• Mewajibkan pengenceran adekuat sesuai standar farmasi. • Laju infus dikontrol untuk antibiotik dan obat pekat. • Koordinasi dengan Instalasi Farmasi untuk memberikan label “Obat Iritatif – Perlu Pengenceran”.	• Perawat /Bidan • Apoteker • Karu • IPCLN/IPCN	• Satu bulan
• Perbaikan Proses Pemasangan & Perawatan Infus	• Memperbaiki kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle phlebitis.	• Perawat/bidan	• Re-education SOP pemasangan infus (vena besar, hindari area fleksi). • Pelatihan ulang teknik aseptik untuk perawat yang belum mandiri memamsang infus. • Audit kepatuhan perawatan VAP & manajemen infus setiap bulan. • Checklist harian pemeriksaan lokasi infus oleh perawat jaga.	• Perawat /Bidan • Dokter • Karu • IPCLN/IPCN	• Tiga bulan

1.6.1.1.7 Kebersihan Tangan

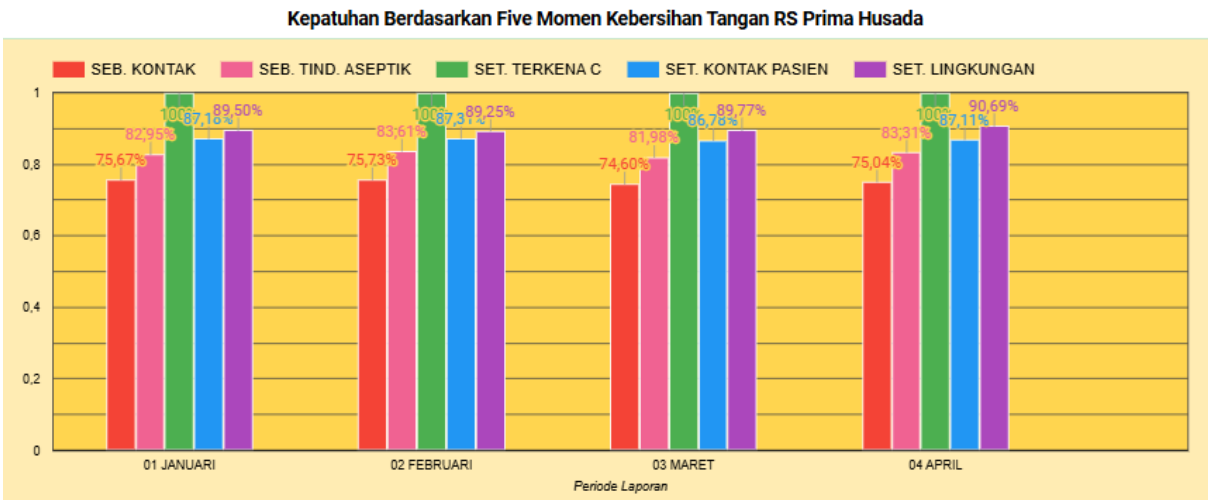
3.7.11 Grafik Angka Kepatuhan kebersihan Tangan (*Hand Hygiene*)



1.6.1.1.7.2 Grafik Kepatuhan 6 Langkah Kebersihan (Hand Hygiene)



1.6.1.1.7.3 Grafik Capaian Kepatuhan Kebersihan Tangan berdasarkan 5 Momen Cuci Tangan

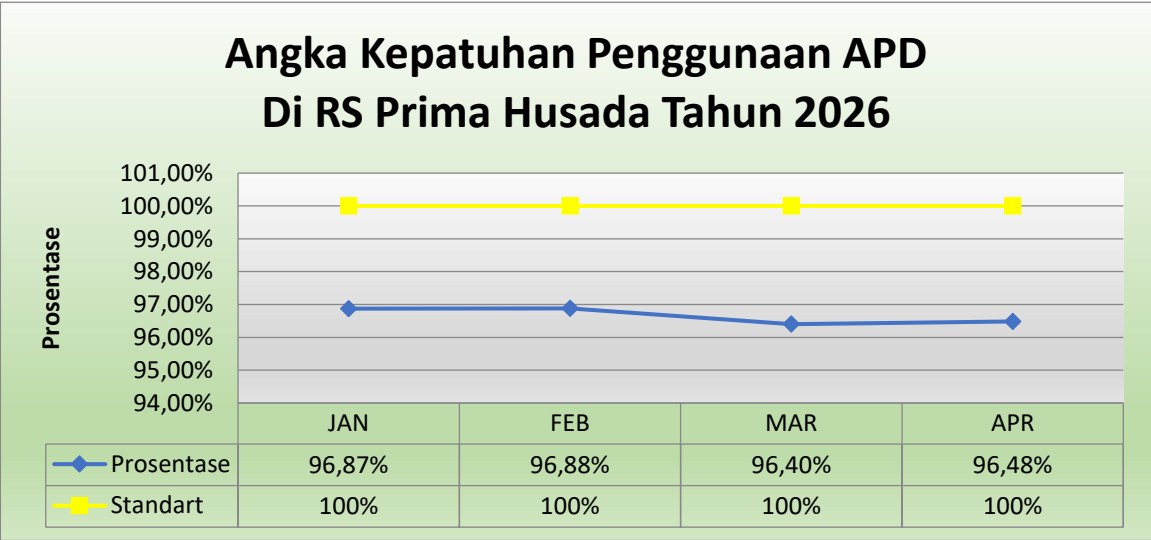


Analisa	Nilai kepatuhan hand hygiene bulan April 2026 berada sedikit di atas standar (selisih 0,54%). Meskipun masih memenuhi standar, terjadi sedikit penurunan kepatuhan, yang berarti ada sedikit penurunan kedisiplinan atau konsistensi dalam penerapan cuci tangan. Tren ini mengindikasikan perlunya penguatan pengawasan dan motivasi ulang kepada tenaga kesehatan agar tingkat kepatuhan terus meningkat. Nilai kepatuhan terhadap 6 langkah cuci tangan pada bulan ini: 86,59%. Nilai ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya (Maret 2026: 85,91%). Artinya, meskipun tenaga kesehatan mencuci tangan, kemungkinan masih belum melakukan seluruh 6 langkah dengan benar. Peningkatan ini bisa mencerminkan peningkatan perhatian terhadap teknik yang benar dan peningkatan proses audit cuci tangan karena kebanyakan dari staf akan melakukan sesuai standar saat diamati, bukan hanya peningkatan frekuensi mencuci tangan saja. Pelaksanaan 5 momen cuci tangan di bulan ini sudah cukup baik, namun perlu fokus peningkatan pada momen sebelum kontak pasien melalui edukasi dan reminder visual di area perawatan. Selain itu dengan adanya program "PPI Quick Tips" diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan staf di unit.				
Masalah saat ini	• Teknik 6 langkah cuci tangan belum dilakukan secara sempurna. • Kepatuhan muncul karena pengawasan (observer effect). • Kedisiplinan dan kesinambungan praktik belum merata.				
Permasalahan sebelumnya	• Ketidakonsistenan dalam melakukan 5 momen cuci tangan. • Kedisiplinan dan kesinambungan praktik belum merata. • Teknik 6 langkah cuci tangan belum dilakukan secara sempurna. • Kepatuhan muncul karena pengawasan (observer effect). • Edukasi dan reminder visual belum optimal.				
Tindakan yang dilakukan	• Melakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. • Melakukan kontrol monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. • Mengajarkan cuci tangan yang benar saat melakukan audit di ruangan. • Mengingatkan perawat atau nakes lain untuk lebih mengutamakan upaya kebersihan tangan agar aman bagi petugas dan pasien. • Meningkatkan penerapan program "PPI Quick Tips" untuk meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan staf.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
• Peningkatan kepatuhan 5 momen cuci tangan	• Meningkatkan kepatuhan 5 momen cuci tangan	• Seluruh perawat dan tenaga kesehatan di unit pelayanan	• Sosialisasi ulang 5 momen cuci tangan • Edukasi teknik 6 langkah melalui refresh training • Pemasangan poster & reminder visual di area strategis	• Komite PPI • Karu	• 1 bulan
• Peningkatan konsistensi	• Meningkatkan konsistensi praktik kebersihan tangan	• Seluruh staf unit pelayanan	• Audit kepatuhan mingguan • Feedback langsung hasil observasi • Monitoring ketersediaan sarana (handrub, wastafel, sabun)	• Komite PPI • IPCN • Karu	• Mingguan

praktik cuci tangan					
Peningkatan kepatuhan 6 langkah cuci tangan	Meningkatkan ketepatan teknik 6 langkah cuci tangan	- Perawat - Tenaga Kesehatan lainnya	- Simulasi praktik langsung saat supervisi - Supervisi saat jam pelayanan - Evaluasi melalui checklist observasi	- IPCN - IPCLN - Karu	Mingguan
Peningkatan kepatuhan kebersihan tangan saat tidak diamati.	Mengurangi kepatuhan semu karena observer effect	Seluruh staf	- Observasi acak tanpa pemberitahuan - Penguatan budaya keselamatan pasien koordinasi dengan komite PMKP - Kampanye internal "Hand Hygiene is Safety" jika diperlukan	- Komite PPI - Komite PMKP	Berkala
Peningkatan program kebersihan tangan	Meningkatkan keberlanjutan program kebersihan tangan	Unit pelayanan	- Implementasi rutin program "PPI Quick Tips" - Reward bagi unit dengan kepatuhan terbaik - Rapat evaluasi bulanan	- Komite PPI - Manajemen RS	Setiap bulan

2.6.1.1.8 Kepatuhan APD

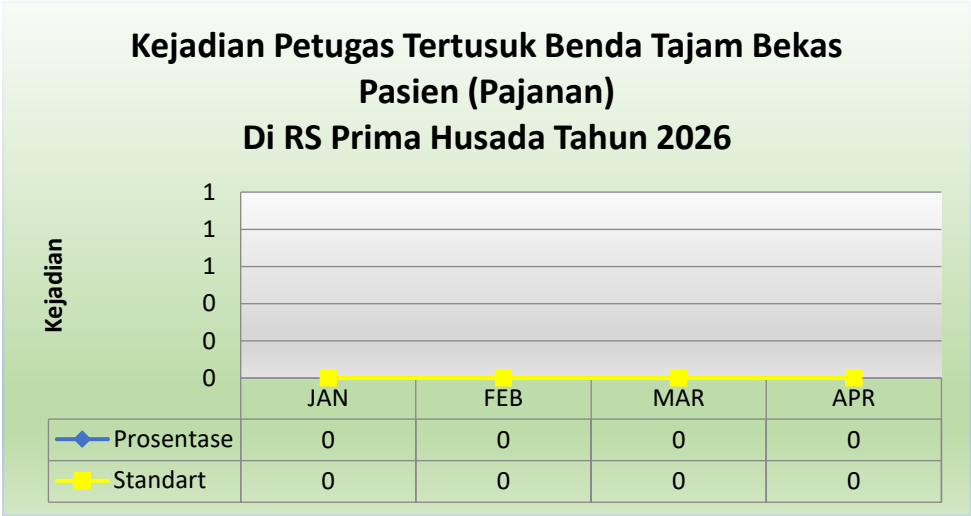
3.6.1.1.8 .1 Grafik Angka Kepatuhan Penggunaan APD oleh Petugas



Analisa	Kepatuhan penggunaan APD masih berada di bawah standar 100%, dengan hasil pada bulan ini 96,48%. Artinya, meskipun staf menggunakan APD, masih terdapat petugas yang tidak lengkap atau tidak sesuai indikasi pemakaian APD. Terjadi peningkatan sedikit pada bulan ini, menunjukkan adanya: penurunan perilaku penggunaan APD, menurunnya kesadaran staf, atau kurangnya pengaruh dari pengawasan dan edukasi langsung yang dilakukan bulan sebelumnya. Nilai tetap belum mencapai standar 100%, sehingga masih ada: ketidakpatuhan dalam penggunaan APD lengkap dan juga berlebihan menggunakan APD sehingga dianggap tidak patuh. Perubahan perilaku belum konsisten penggunaan APD masih dipengaruhi faktor situasional, bukan kebiasaan yang terbentuk secara kuat.
Masalah saat ini	• Masih ditemukan ketidaktepatan penggunaan APD, baik penggunaan APD yang tidak lengkap maupun penggunaan APD berlebihan yang tidak sesuai indikasi. • Pemahaman staf mengenai indikasi penggunaan APD masih belum merata. • Kebiasaan kerja lama masih mempengaruhi perilaku penggunaan APD sehingga praktik belum konsisten. • Monitoring dan audit kepatuhan belum dilakukan secara merata dan berkelanjutan di seluruh unit.
Permasalahan sebelumnya	• Masih ada salah persepsi “tindakan ringan tidak perlu APD lengkap atau lupa tidak melepas APD”. • Audit belum merata.
Tindakan yang	• Mengingatkan kembali petugas yang memakai APD berlebihan terkait transmisi penyebaran penyakitnya.

dilakukan	• Melakukan evaluasi penggunaan stok APD pada petugas koordinasi dengan pengadaan farmasi. • Memberikan proses pembelajaran kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. (mendata ketidakpatuhan pemakaian APD, konfirmasi Karu dan SDM). • Menanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing petugas bahwa pemakaian APD yang benar ini penting. • Melakukan monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai. • Melakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD. • Memberikan edukasi pemakaian APD yang tepat antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
• Peningkatan Kepatuhan penggunaan APD sesuai standar	• Meningkatkan kepatuhan penggunaan APD sesuai standar	• Seluruh tenaga kesehatan	• Sosialisasi ulang standar penggunaan APD sesuai indikasi	• Komite PPI, IPCN	• 1 bulan
• Peningkatan pemahaman staf terkait APD	• Meningkatkan pemahaman staf tentang penggunaan APD yang tepat	• Perawat dan tenaga kesehatan	• Edukasi dan refresh training terkait indikasi dan jenis APD	• IPCN • Kepala Ruangan	• 1–2 bulan
• Peningkatan Konsistensi penggunaan APD yang benar	• Meningkatkan konsistensi penggunaan APD	• Seluruh staf unit pelayanan	• Audit kepatuhan penggunaan APD secara berkala dan pemberian feedback	• Komite PPI	• Setiap bulan
• Menurunkan kebiasaan penggunaan APD yang tidak sesuai	• Mengurangi penggunaan APD yang tidak sesuai (kurang/berlebihan)	• Tenaga kesehatan di unit pelayanan	• Supervisi langsung di ruangan dan penguatan budaya keselamatan kerja	• Kepala Ruangan • IPCN • Komite PMKP	• Berkelanjutan
• Kontroling ketersediaan APD	• Mengoptimalkan ketersediaan dan penggunaan APD	• Unit pelayanan	• Monitoring penggunaan dan stok APD serta koordinasi dengan instalasi farmasi	• Komite PPI • Farmasi	• Setiap bulan

3.6.1.1.9 Kejadian Petugas Tertusuk Benda Tajam
3.6.1.1.9.1 Grafik Kejadian Petugas Tertusuk Benda Tajam Bekas Pasien (Pajanan)



Analisa	Tidak ditemukan kejadian tertusuk jarum bekas pasien pada petugas.				
Masalah saat ini	• Tidak ditemukan kejadian pajanan tertusuk benda tajam pada bulan ini.				
Permasalahan sebelumnya	• Tidak ditemukan kejadian pajanan tertusuk benda tajam pada bulan ini.				
Tindakan yang dilakukan	• Mengingatkan untuk melakukan penyuntikan yang aman dan pengolahan benda tajam yang baik dan benar. • Menganjurkan untuk tidak memegang area badan safety box, untuk menghindari jika ada jarum yang tembus, disarankan memegang tali safety box saja. • Menyarankan membawa safety box atau wadah khusus untuk langsung membuang jarum/benda tajam setelah tindakan. • Melakukan pemilahan sampah yang benar, terutama benda tajam. • Menggunakan APD yang sesuai untuk meminimalisir resiko pajanan.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
• Pertahankan proses	• Menurunkan kejadian pajanan	• Seluruh petugas pelayanan pasien	• Monitoring proses pemilahan sampah khususnya benda tajam saat melakukan tindakan.	• Seluruh petugas	• Satu bulan

penyuntikan yang aman dan pengelolaan benda tajam yang baik.	sesuai dengan standar 0 kejadian.		• Monitoring penggunaan safety box pada troli tindakan. • Biasakan petugas untuk membersihkan peralatan yang digunakan langsung tanpa mengoperkan pada shift berikutnya. • Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai di lapangan untuk mencegah paparan. • Monitoring teknik recapping tutup jarum.	pelayanan di RS.	
--	-----------------------------------	--	--	------------------	--

3.6.3 Tim PKRS

3.6.3.1 Edukasi Kelompok Unit

Unit	Target	Feb	Mar	Apr	%	MANDOK	Keterangan
IRNA 2C	4x/Bulan	100%	100%	100%	Tercapai	Lampiran B	IRNA 2C Mencapai Target
ICU\HCU	4x/Bulan	100%	0%	0%	Tidak Tercapai	Lampiran B	ICU/HCU Tidak mencapai target
IRNA 3C	4x/Bulan	0%	100%	100%	Tercapai	Lampiran B	IRNA 3C Mencapai target
MATERNITAS	4x/Bulan	100%	100%	100%	Tercapai	Lampiran B	MATERNITAS Mencapai Target
PERINATOLOGI	4x/Bulan	75%	100%	100%	Tercapai	Lampiran B	PERINATOLOGI Mencapai Target
IRNA 5C	4x/Bulan	100%	0%	0%	Tidak Tercapai	Lampiran B	IRNA 5C Tidak Mencapai Target
IRNA 2A,3A,4A	4x/Bulan	100%	100%	50%	Tidak Tercapai	Lampiran B	IRNA 2A,3A,4A Mencapai Target
IRNA 6A,7A,8A	4x/Bulan	50%	100%	100%	Tercapai	Lampiran B	IRNA 6A,7A,8A Mencapai target
IGD	4x/Bulan	25%	100%	100%	Tercapai	Lampiran B	IGD Mencapai Target
FARMASI	4x/Bulan	100%	25%	100%	Tercapai	Lampiran B	FARMASI Mencapai target
GIZI	4x/Bulan	100%	0%	50%	Tidak Tercapai	Lampiran B	Gizi Tidak Tidak Mencapai Target
IRJA	4x/Bulan	0%	100%	100%	Tercapai	Lampiran B	IRJA Mencapai Target

- ANALISIS** : Berdasarkan data edukasi kelompok unit pada bulan April Tahun 2026, Tim PKRS telah melaksanakan edukasi dan mencapai target, beberapa Unit belum mencapai target dan perlu ditingkatkan, berikut: ICU, IRNA 5C, 2,3,4A dan GIZI.
- RTL** : Menyampaikan kepada KARU unit yang belum tercapai untuk mengejar ketertinggalan edukasi, edukasi dilakukan di bulan April.

3.6.3.2 Pembinaan Komunitas Berbasis RS Prima Husada

UNIT	TARGET	KEGIATAN	FEB	MAR	APR	%	MANDOK	KET
Forum Kesehatan Usia Lanjut (F-KUL) Komunitas Geriatri	2X/Bulan	Senam	0%	0%	100%	Tidak Tercapai	Ada	
		Hypnoterapi						
		KIE						
Komunitas Ibu Hamil	2X/Bulan	Senam	0%	0%	100%	Tidak Tercapai	Ada	
		Hypnoterapi						
		KIE						
Yoga Lansia	2xBulan	Yoga	100%	25%	100%	Tidak Tercapai	Ada	
		Hynoterapi						
		KIE						
Komunitas Shirothul Jannah Perempuan	2X/Bulan	Pengajian	50%	50%	100%	Tercapai	Ada	
		Karya wisata						
Komunitas Shirothul Jannah Laki Laki	2X/Bulan	Pengajian	50%	50%	100%	Tercapai	Ada	
Bimbingan Doa	8X/Bulan	Mendoakan Pasien	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
General Meeting Karyawan	1x/2Bulan		0%	0%	0%	Tidak Tercapai	-	

Pembinaan Fatayat	1X/Tahun		
-------------------	----------	--	--

3.6.3.3 KIE Upaya Preventif Promotif PROGNAS

Unit	Target	Feb	Mar	Apr	%	Bukti di Form Edukasi Terintegrasi atau kolaborasi	Ket
PONEK	4X/Bulan	100%	25%	100%	Tercapai	√	
HIV	4X/Bulan	0%	0%	0%	Tidak Tercapai	-	
STUNTING dan WASTING	4X/Bulan	0%	0%	50 %	Tidak Tercapai	√	
KELURAGA BERENCANA RUMAH SAKIT (KABERUSA)	4X/Bulan	0%	0%	0%	Tidak Tercapai	-	
TB DOTS	4X/Bulan	0%	0%	0%	Tidak Tercapai	-	

ANALISIS : Bulan April PROGNAS belum tercapai.
RTL : Koordinasi dengan Kepala Bidang Umum dan Pelayanan untuk dapat Meningkatkan produktivitas Tim Prognas.

3.6.4 Tim Prognas

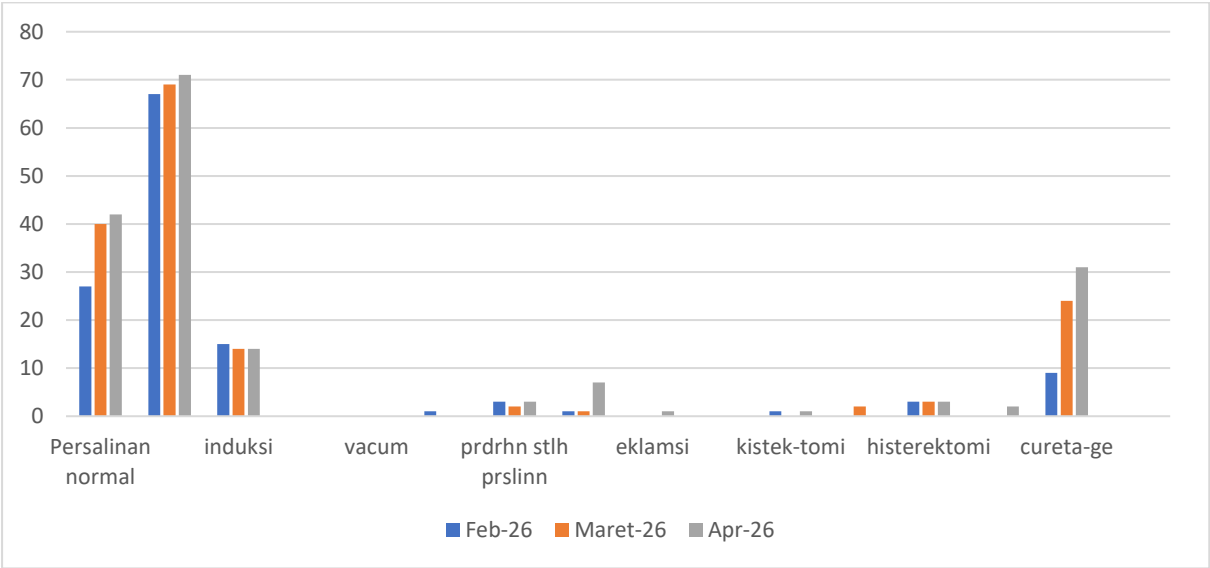
3.6.4.1 PONEK

3.6.4.1.1 Jumlah Kegiatan Pelayanan Maternal Ponek April 2026

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN FEBRUARI 2026	BULAN MARET 2026	BULAN APRIL 2026
1	Persalinan			
	a. Persalinan Normal	27	40	42
	b. <i>SectioCaesaria</i>	67	69	71
2				
	a. Induksi / Drip	15	14	14
	b. Sungsang	0	0	0
	c. Vacum	0	0	0
3				
	a. Perdarahan sebelum Persalinan	1	0	0
	b. Perdarahan setelah Persalinan	3	2	3
	c. Pre Eklamsi	1	1	7
	d. Eklamsi	0	092	1
	e. Infeksi	0	0	0
4				
	a. Curretage	9	24	31
	b. Kistektomi	1	0	1
	c. Miomektomi	0	2	0

d. Histerectomy	3	3	3
e. KET	0	0	2

3.6.4.1.2 Grafik Jumlah Kegiatan Pelayanan Maternal Di RS Prima Husada Bulan April 2026



Analisis :

1. Pada jenis persalinan normal pada bulan April 2026 yaitu 42 pasien meningkat jika dibandingkan dengan bulan Maret 2026 yaitu 40 pasien , sedangkan bulan Februari yaitu 27 pasien
2. Pada jenis pelayanan Persalinan secara Sectio Caesaria pada bulan April 2026 yaitu 71 pasien meningkat jika dibandingkan dengan bulan Maret 2026 yaitu 69 pasien, sedangkan bulan Februari yaitu 67 pasien.
3. Kebanyakan pasien yg dilakukan tindakan SC adalah pasien dari poli kandungan yang memang telah dijadwalkan untuk operasi dikarenakan ada diagnosa khusus sehingga harus dilakukan operasi SC, misalnya bekas SC, floating head, placenta previa, letak sungsang, dan lainnya,CPD atau pasien yang ada di ruang bersalin yang gagal untuk persalinan normal dikarenakan ada penyulit seperti prolong kala 1, kala 2 lama, fetal distress. Dan juga pasien dilakukan operasi sc adalah pasien rujukan dari bidan ataupun puskesmas yang harus dilakukan operasi dikarenakan adanya kegawatan pada ibu atau bayi dan akhirnya harus dilakukan operasi SC cito.
4. Tidak ada persalinan sungsang pada bulan April 2026 dan 2 bulan sebelumnya. Dan tidak ada persalinan dengan vacum pada bulan April 2026 dan 2 bulan sebelumnya.
5. Induksi/Drip pada bulan April dan Maret 2026 sama yaitu 14 pasien, sedangkan bulan Februari yaitu 15 pasien. Ini disebabkan kontraksi pasien inpartu sudah adekuat sehingga tidak perlu diberikan tambahan induksi/drip.
6. Jenis pelayanan persalinan dengan komplikasi ialah pre eklamsi. Pada bulan April 2026 yaitu 7, meningkat dibandingkan dengan bulan Maret dan Februari 2026 yaitu 1 kasus.
7. Jenis pelayanan persalinan dengan komplikasi ialah eklamsi. Pada bulan April 2026 yaitu 1, meningkat dibandingkan dengan bulan Maret dan Februari 2026 yaitu 0 kasus.
8. Jenis pelayanan curretage di bulan April 2026 yaitu 31 pasien meningkat jika dibandingkan dengan bulan Maret 2026 yaitu 24 pasien, sedangkan bulan Februari 2026 yaitu 9 pasien. Curetage dilakukan untuk Indikasi abortus, mola,

blighted ovum, sisa plasenta dan pada kasus-kasus gynekology biasanya dengan indikasi menometroragi, hyperplasia endometrium, dan lainnya.

Rencana dan Tindak Lanjut :

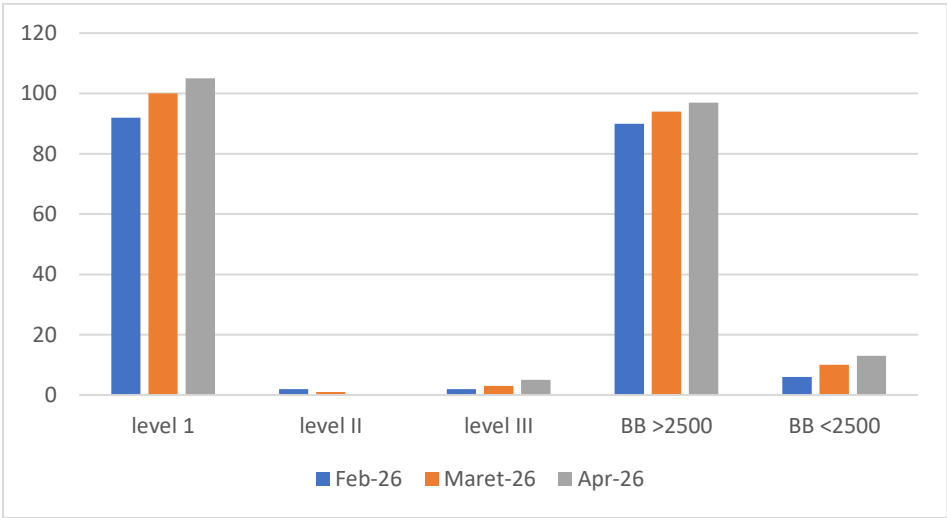
- 1) Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien obgyn salah satunya dengan mengadakan pelatihan bidan-bidan perujuk.
- 2) Melakukan edukasi kepada pasien hamil saat ANC tentang konsumsi makan makan yang mengandung garam terlalu tinggi, terutama pasien dengan riwayat darah tinggi.
- 3) Melakukan edukasi kepada pasien hamil saat ANC tentang tanda dan bahaya pada kehamilan.
- 4) Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 tentang tanda-tanda persalinan.
- 5) Melakukan edukasi kepada pasien ANC untuk melakukan senam hamil

3.6.4.1.3 Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal

3.6.4.1.3.1 Tabel Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal Ponek April 2026

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN FEBRUARI 2026	BULAN MARET 2026	BULAN APRIL 2026
1				
	a. Level 1/ rawat gabung	92	100	105
	b. Level II/ rujukan dari luar	2	1	0
	c. Level III/NICU	2	3	5
2				
	a. BB ≥ 2500 gram	90	94	97
	b. BB ≤ 2500 gram	6	10	13

3.6.4.1.3.2 Grafik Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal Di RS Prima Husada April 2026



Analisis :

- 1. Pada jenis pelayanan pasien neonatal level 1/ rawat gabung di bulan April 2026 yaitu 105 pasien meningkat jika dibandingkan dengan bulan Maret 2026 yaitu 100 pasien, sedangkan Februari 2026 yaitu 92 pasien
- 2. Pada pelayanan level 2/ rujukan dari luar pada bulan April 2026 yaitu 0 pasien , menurun dibandingkan bulan Maret 2026 yaitu 1 pasien, sedangkan pada bulan Februari yaitu 2 pasien.

- 3. Pada pelayanan level 3 pada bulan April yaitu 5 pasien, meningkat jika dibandingkan dengan Maret yaitu 3 pasien, sedangkan bulan Februari yaitu 2 pasien.
- 4. Pada jenis pelayanan bayi lahir hidup ialah BB >2500 gram di bulan April 2026 yaitu 97 pasien meningkat jika dibandingkan dengan bulan Maret 2026 yaitu 94 pasien, sedangkan bulan Februari 2026 yaitu 90 pasien.
- 5. Jumlah bayi lahir hidup <2500 gram (BBLR) di bulan April 2026 yaitu 13 pasien, meningkat jika dibandingkan dengan bulan Maret 2026 yaitu 10 pasien, dan Februari 2026 yaitu 6 pasien. Ini disebabkan karena masih adanya kelahiran < 2500 gram dikarenakan kelahiran belum cukup bulan atau IUGR.

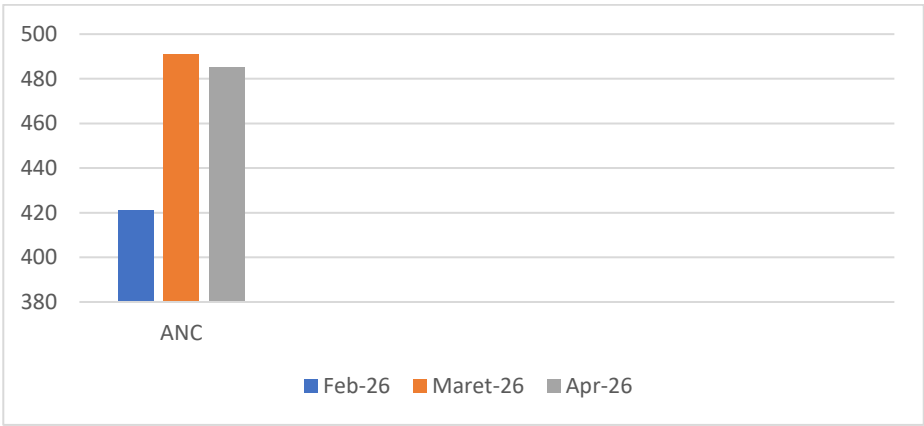
Rencana dan Tindak Lanjut

- 1. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil saat dilakukan ANC untuk mengurangi kegiatan berat dan istirahat cukup agar tidak terjadi partus prematurus imminens (PPI) yang mengakibatkan kelahiran prematur.
- 2. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil saat dilakukan ANC terkait asupan gizi saat ibu hamil, guna mencegah bayi lahir dengan IUGR.
- 3. Melakukan edukasi pada ibu hamil agar melakukan pemeriksaan rutin untuk memantau kehamilan

3.7.12 Pelayanan Ante Natal Care (ANC)
Tabel Pelayanan Ante Natal Care (ANC) Ponpek April 2026

No	Jenis Pelayanan	Jumlah		
		Bulan Februari 2026	Bulan Maret 2026	Bulan April 2026
1	ANC	421	491	485

Grafik Jumlah Pelayanan Ante Natal Care Di RS Prima Husada April 2026



Analisis :

- 1. Pelayanan ANC pada bulan April 2026 yaitu 485 pasien mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan 2 bulan sebelumnya, Sedangkan pada bulan Maret 2026 yaitu 491 pasien, dan bulan Februari yaitu 421 pasien,
- 2. Faktor Sistem dan Kebijakan terkait perubahan regulasi JKN

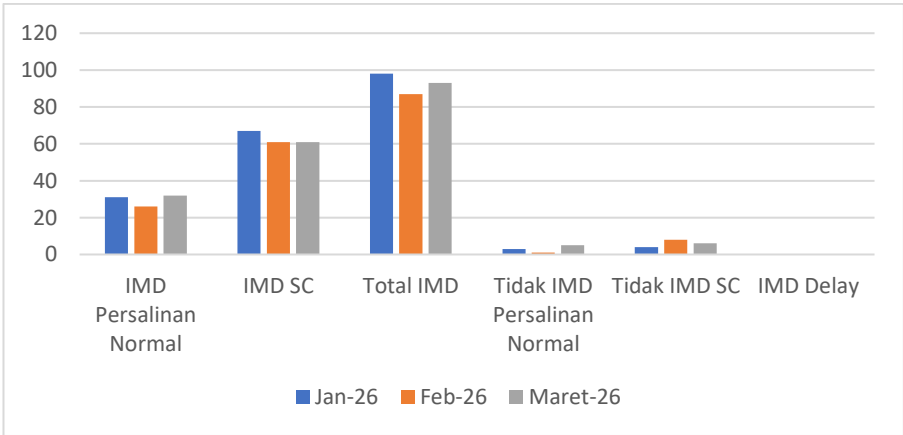
Rencana dan Tindak Lanjut :

1. Melakukan promosi kesehatan terkait pemeriksaan ANC di dokter spesialis Obgyn
2. Melakukan Promosi layanan ANC risiko tinggi
3. Melakukan Program kelas ibu hamil

3.7.13 Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
Tabel Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) April 2026

No	Uraian	Jumlah Pasien		
		Bulan Februari 2026	Bulan Maret 2026	Bulan April 2026
1	IMD Persalinan Normal	26	32	34
2	IMD SC	61	61	62
3	Total IMD	87	93	96
4	Tidak IMD Persalinan Normal	1	5	7
5	Tidak IMD SC	8	6	7
6	IMD Delay	0	0	0
	Total Persalinan Normal	27	37	41
	Total Kelahiran SC	67	67	69
	Total kelahiran	94	104	110

Grafik Jumlah Pelayanan IMD di RS Prima Husada Bulan April 2026



Analisis :

1. Pada bulan April 2026 jumlah IMD persalinan normal yaitu 34 pasien,meningkat di bandingkan bulan Maret yaitu 32 pasien sedangkan bulan Februari yaitu 26 pasien Bayi.
2. Sedangkan IMD pada kelahiran SC pada bulan April yaitu 62 pasien, meningkat sedikit dibandngkan dengan bulan Maret dan Februari yaitu 61 pasien.
3. Kejadian tidak dilakukan IMD pada persalinan normal bulan April yaitu 7 pasien, meningkat dibandingkan bulan Maret yaitu 5 pasien sedangkan bulan Februari yaitu 1 pasien
4. Kejadian tidak dilakukan IMD pada kelahiran SC bulan April 2026 yaitu 7 pasien, meningkat dibandingkan bulan Maret 2026 yaitu 6 pasien, sedangkan bulan Februari yaitu 8 pasien,
5. Bayi yang tidak dilakuan IMD dikarenakan tidak memenuhi kriteria untuk dilakukannya IMD dikarenakan membutuhkan penanganan lebih lanjut.
6. Berikut ini bayi yang tidak dilakukan IMD pada bulan April 2026

NO	NAMA BAYI	DIAGNOSA	PERAWATAN BBL
----	-----------	----------	---------------

Persalinan Normal			
	Ny Sofiatin	NCB + BBLR	Infant warmer
	Ny Sufiati Ulfa	RDS ok HMD DD Neonatal Pneumonia, BBLASR	Inkubator, CPEP
	Ny Dwi Nur	NCB + BBLR	Infant warmer
	Ny Fitri Hamidah	NCB + BBLR	Infant warmer
	Ny Siti Arba'yah	RDS ok MAS DD Neonatal Pneumonia	Inkubator, CPEP
	Ny Wulan Diah	NCB + BBLR	Infant warmer
	Ny Nina	NCB + IUGR	Infant warmer
SC			
	Ny Wulida	NCB + BBLR	Cuvis
	Ny Siti Mukaromah	NKB + BBLR	Cuvis
	Ny Maisaroh Fitri	NKB + BBLR	Cuvis
	Ny fidara	NCB + BBLR	Cuvis
	Ny Agustin	NCB + BBLR	Infant warmer
	Ny Syakinah	HMD, BBLR, Pneumonia	Inkubator, CPEP
	Ny Cholifatul	NCB + RDS	Inkubator, CPEP

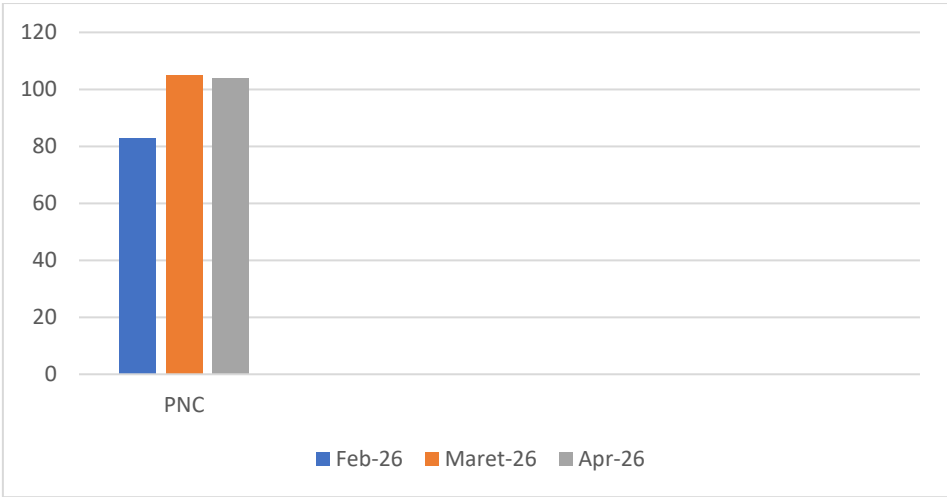
Rencana dan Tindak Lanjut :

1. Melakukan skrining sebelum dilakukan tindakan inisiasi menyusui dini (IMD) pada bayi baru lahir, apakah sesuai dengan syarat ataukah tidak
2. Mempertahankan Konsistensi Pelaksanaan IMD
3. Peningkatan Kualitas Pelaksanaan IMD
4. Edukasi sejak ANC tentang manfaat IMD dan ASI eksklusif.

3.7.14 Pelayanan Post Natal Care (PNC)
Tabel Pelayanan Post Natal (PNC) Ponек April 2026

No	Jenis Pelayanan	Jumlah		
		Bulan Februari 2026	Bulan Maret 2026	Bulan April 2026
1	PNC	83	105	104

Grafik Jumlah Pelayanan Post Natal Care di RS Prima Husada Bulan April 2026



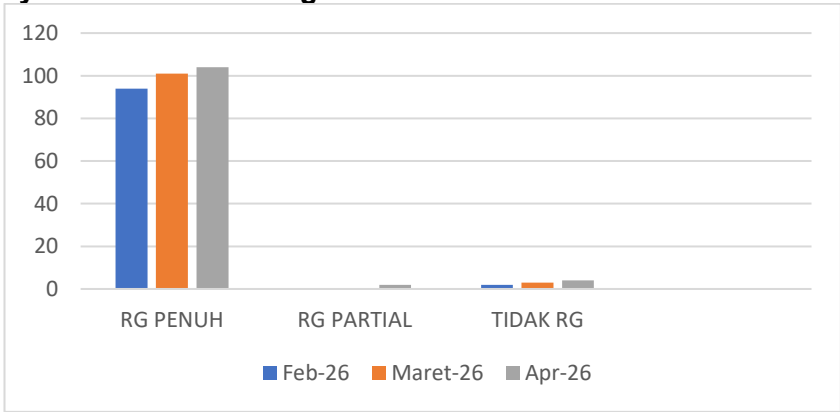
Analisis :
Pelayanan PNC pada bulan April 2026 yaitu 104 pasien, sedikit menurun jika dibandingkan dengan bulan Maret 2026 yaitu 105 pasien, sedangkan bulan Februari yaitu 83 pasien

- Rencana dan Tindak Lanjut :**
1. Melakukan Edukasi pasien dan keluarga Jadwal kontrol nifas (KF1: 6–48 jam, KF2: 3–7 hari, KF3: 8–28 hari, KF4: 29–42 hari)
 2. Melakukan edukasi tanda bahaya nifas
 3. Melakukan edukasi pentingnya KB pasca salin

3.1.2.2.1.5 Pelayanan Rawat Gabung
Tabel Pelayanan Rawat Gabung Ponek April 2026

No	Uraian	Jumlah Pasien		
		Bulan Februari 2026	Bulan Maret 2026	Bulan April 2026
1	Rawat gabung penuh	94	101	104
2	Rawat gabung partial	0	0	2
3	Tidak Rawat gabung	2	3	4

Grafik Pelayanan Rawat Gabung di Rumah Sakit Prima Husada Bulan April 2026



- Analisis :**
1. Jumlah bayi yang dilakukan rawat gabung pada bulan April 2026 yaitu 104 bayi meningkat jika dibandingkan dengan bulan Maret 2026 yaitu 101 bayi, sedangkan bulan Februari 2026 yaitu 94 pasien. Jumlah bayi yang dilakukan rawat gabung dengan syarat bayi dan ibu dalam kondisi sehat

- Bayi yang tidak dilakukan rawat gabung pada bulan Ma 2026 yaitu 3 bayi, meningkat jika dibandingkan dengan bulan Maret 2026 yaitu 3 bayi, dan Februari 2026 yaitu 2 bayi.
- Berikut bayi yang tidak dilakukan rawat gabung

Nama	Diagnosa	Perawatan BBL
Ny Cholifatul	NCB + RDS	CPEP + inkubator
Ny Sufiati Ulfa	RDS ok HMD DD neonatal pneumonia, BBLASR	CPEP + inkubator
Ny Siti Arba'yah	RDS ok MAS DD Neonatal Pneumonia, BBLR	CPEP + inkubator
Ny Syakinah	HMD, BBLR, Pneumonia	CPEP + inkubator

- Bayi yang tidak dilakukan rawat gabung adalah bayi yang membutuhkan perawatan khusus yaitu diletakkan di cuvis atau incubator karena berat bayi < 2500 gram atau masih belum memungkinkan dilakukan rawat gabung karena masih menggunakan alat bantu pernafasan dan observasi.

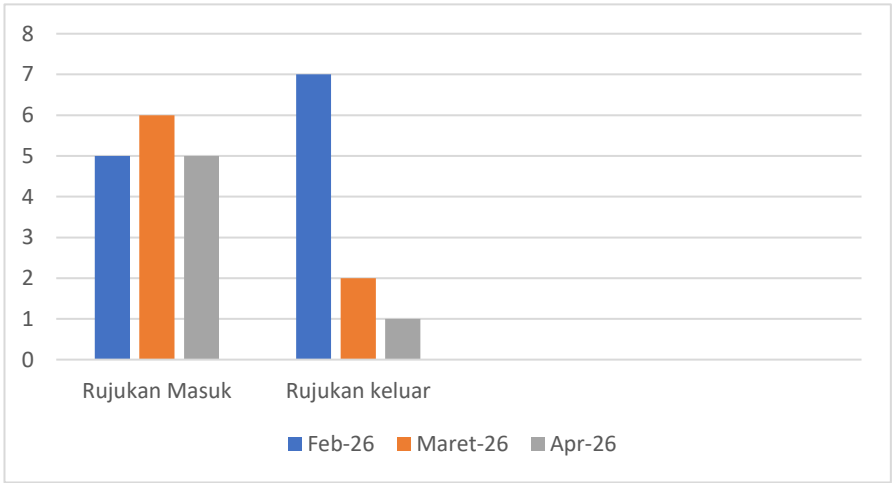
Rencana dan Tindak Lanjut :

- Setelah kondisi bayi stabil segera dilakukan rawat gabung atau kontak ibu-bayi.
- Fasilitasi ibu untuk memerah ASI sedini mungkin (1–2 jam setelah persalinan)
- Kunjungan ibu ke ruang perinatologi / NICU (jika memungkinkan)
- Pelaksanaan **Kangaroo Mother Care (KMC)** pada bayi BBLR yang sudah stabil.

3.1.2.2.1.6 Pelayanan Jejaring Rujukan
Tabel Pelayanan Jejaring Rujukan Ponек April 2026

Rujukan	Bulan Februari 2026	Bulan Maret 2026	Bulan April 2026
Rujukan Masuk	5	6	5
Rujukan keluar	7	2	1

Grafik Pelayanan Rujukan RS Prima Husada Bulan April 2026



Evaluasi :

1. Jumlah rujukan masuk pada bulan April 2026 menurun jika dibandingkan dengan bulan yang lalu, yaitu 5 rujukan, sedangkan pada bulan Maret 2026 sebanyak 6 rujukan, dan bulan Februari 2026 sebanyak 5 rujukan.
2. Jumlah rujukan keluar pada bulan April 2026 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 1 rujukan, sedangkan pada bulan Maret 2025 sebanyak 2 rujukan, dan Februari 2025 sebanyak 7 rujukan keluar.

Rencana dan Tindak Lanjut

1. Bekerja sama dengan tim PKRS untuk melakukan promosi kesehatan dan mengajak BPM, Puskesmas, Klinik dan RS setempat untuk bekerja sama.
2. Menambah jumlah pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, sehingga meminimalisasikan untuk dilakukan rujukan keluar.

3.1.2.2.1.6.1 Rujukan Masuk
Tabel Rujukan Masuk Ponек April 2026

Bulan Februari 2026			
1	By Ny Febriyanti	RDS	RS Enggal Dangan
2	Ny Riya Uliyana	G4 P2002 Ab001 UK 38-39 minggu dengan KIFA	Klinik Mutiara Sehat
3	Ny Fitriyah Nur F	Ruptur perineum grade 3	PKM Singosari
4	Ny Angely Reza	G1 P0000 Ab000 UK 40-41 minggu dengan kala 2	PKM Ardimulyo
5	Ny Bella Sari	G2 P1001 Ab000 UK 40-41 minggu dengan kala 2 lama	PKM Ardimulyo
Bulan Maret 2026			
1	Ny Wiwik Puji A	G5 P2002 Ab200 UK 39-40 minggu dengan KPD + letak Obliq	PMB Munawaroh
2	Ny Heny S	Anemia + AUB	Dr.Rifatul
3	Ny Rika S	G2 P1001 Ab000 UK 39-40 minggu dengan KIFA	Klinik Mutiara Sehat
4	Ny Irma S	G1 P0000 Ab000 UK 40-41 minggu dengan KPD + susp CPD	PMB Titik S
5	Ny Lelly Priga	G1 P0000 Ab000 UK 38-39 minggu dengan KPD	PMB Titik S
6	Ny Cello velinda	G1 P0000 Ab000 UK 38-39 minggu dengan KPD + HT gestasional+ letak Obliq	PMB Lilik A
Bulan April 2026			
1	Ny Chusna W	G1 P0000 Ab000 UK 38-39 minggu dengan KIFA	PKM Singosari
2	NY Dwi Oktavianti	G4 P0000 Ab300 UK 38-39 minggu dengan KET	RSUD Lawang
3	Ny Siti fatonah	G2 P1001 Ab000 UK 37-38 minggu dengan Kala 2 + letsu	PMB Lilik
4	Ny Darwati	Syok hipovolemik ec AUB ec Mioma uteri	PKM Lawang
5	Ny Nina	G1 P0000 Ab000 UK 41-42 minggu dengan Kala 2	PKM Jabung

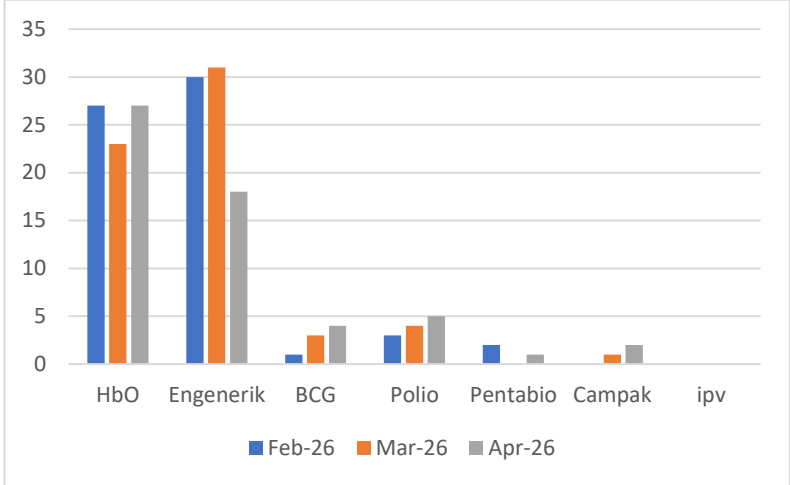
3.1.2.2.7.2 Rujukan Keluar
Tabel Rujukan Keluar Ponpek April 2026

No	Nama	Usia	Unit	Diagnosa	Alasan Rujukan	Tujuan Rujukan
Bulan Februari 2026						
1	By Ny Mewah	1 hari	NICU	RDS+Neonatal bronchopneumonia + NEC	Pro Sub Spesialistik Neonatologi	RS Soepraoen
2	By Ny Nuriana	1 hari	NICU	NCB+ Multiple Congenital + susp PJB	Pro Sub Spesialistik Neonatologi	RS Saiful Anwar
3	By Ny Yeyen	1 hari	NICU	Atresia ani tanpa fistel + undensensus testis + susp DS	Pro bedah anak	RS Saiful Anwar
4	Ny Rizki Ika	32 tahun	Maternitas	G3 P2002 Ab000 UK 32-34 minggu dengan PPI	Penatalaksanaan lebih lanjut	RS Saiful Anwar
5	Ny Dyah Ayuning	26 tahun	Ponek	G1 P0000 Ab000 UK 26-28 minggu dengan Ppi + APB EC PLR	Penatalaksanaan lebih lanjut	RS Saiful Anwar
6	NY Ivatul Khoiria	40 tahun	Ponek	G4 P1001 AB200 UK 28-30 minggu dengan BSC + KPD preterm	Penatalaksanaan lebih lanjut	RS Saiful Anwar
7	Ny Vita Afifatul	27 tahun	Maternitas	G3 P2002 Ab000 UK 37-38 minggu dengan Letak lintang + BSC 2x + B20	Penatalaksanaan lebih lanjut	RS Saiful Anwar
Bulan Maret 2026						
1	By Ny Savira	1 hari	NICU	RDS ok Neonatal pneumonia dd MAS	Pro Sub Spesialistik Neonatologi	RS Soepraoen
2	NY Aisyah Kayla	30 th	Ponek	G1 P0000 Ab000 Uk 32-34 minggu dengan PEB	Penatalaksanaan lebih lanjut	RS Saiful Anwar
Bulan April 2026						
1	By Ny sufiati	1 hari	NICU	RDS ok HMD DD neonatal Pneumonia, BBLASR	Pro Sub Spesialistik Neonatologi	RS Saiful Anwar

3.1.2.2.12.8 Pelayanan Imunisasi
Tabel Pelayanan Imunisasi Ponpek April 2026

No	Jenis Pelayanan	Jumlah		
		Bulan Februari 2026	Bulan Maret 2026	Bulan April 2026
1	HbO	27	23	27
2	Engerix Junior	30	31	18
3	BCG	1	3	4
3	Polio	3	4	5
4	Pentabio	2	0	1
5	Campak	0	1	2
6	IPV	0	0	0

Grafik Pelayanan Imunisasi Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan April 2026



Analisis :

1. Bayi yang melakukan Imunisasi Hbo pada bulan April 2026 yaitu 27 pasien, meningkat jika dibandingkan dengan bulan Maret 2026 yaitu 23 pasien, sedangkan pada bulan Februari yaitu sebanyak 27 bayi, dikarenakan stok vaksin dari dinas Kesehatan kabupaten malang terbatas sehingga Puskesmas hanya bisa memberikan sedikit ke RS swasta, sehingga bayi yang baru lahir yang belum mendapat imunisasi HB0 diarahkan untuk imunisasi Hbo di Puskesmas wilayah masing-masing sebelum usia 7 hari atau pembelian vaksin Engerix Junior dengan edukasi Biaya Umum
2. Pada bulan April ada 18 bayi yang menggunakan vaksin Engerix Junior, menurun dibandingkan pada bulan Maret ada 31 bayi, sedangkan bulan Februari yaitu 30 bayi, Penggunaan vaksin Engerix Junior ini dikarenakan banyak nya bayi baru lahir yang tidak mendapatkan vaksin Hbo disebabkan persediaan Hbo yang sedikit, sehingga ditawarkan untuk pembelian Vaksin Engerix Junior.
3. Tidak ada bayi yang melakukan Imunisasi IPV Pada bulan April 2026 dan 2 bulan sebelumnya.
4. Ada 4 bayi yang melakukan Imunisasi BCG Pada bulan April 2026 dan meningkat dibandingkan dengan Maret yaitu 3 bayi, sedangkan bulan Februari 1 bayi.
5. Ada 2 bayi yang Imunisasi Campak bulan April 2026, sedangkan bulan Maret ada 1 bayi, dan di bulan Februari tidak ada.
6. Ada 5 bayi yang melakukan Imunisasi Polio Pada bulan April 2026, sedangkan bukan Maret ada 4 bayi, dan bulan Februari sebanyak 3 bayi.
7. Ada 1 bayi yang melakukan imunisasi Pentabio pada bulan April 2026, sedangkan pada bulan Maret tidak ada, dan pada bulan Februari ada 2 bayi. Imunisasi pentabio diberikan bersamaan dg rota dan PCV, sedangkan vaksin tersebut ada pembatasan dari puskesmas.

Rencana dan Tindak Lanjut

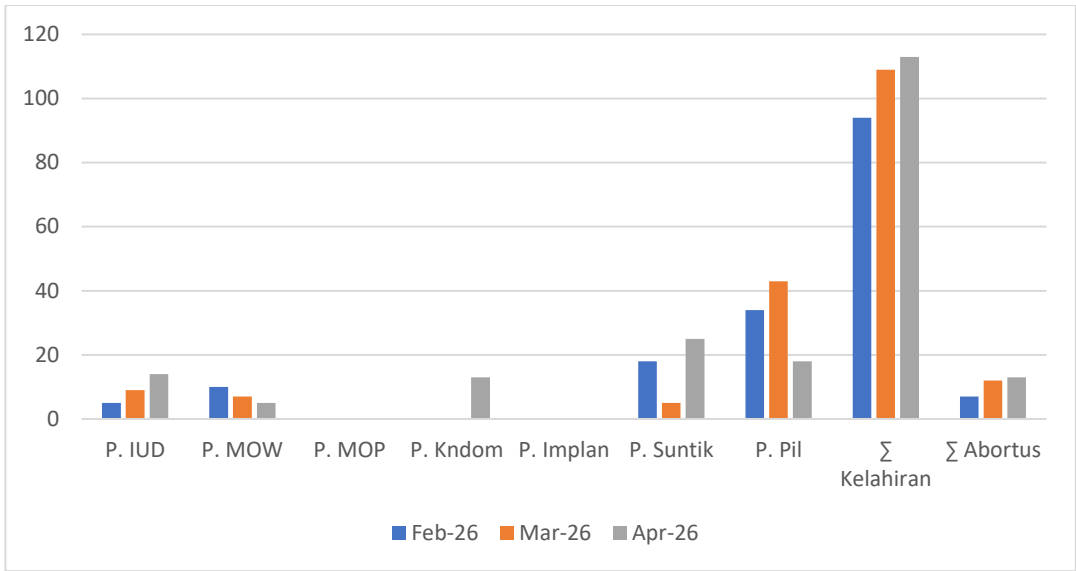
1. Membuat surat permintaan berupa laporan bulanan kepada puskesmas untuk pemenuhan kebutuhan vaksin di rumah sakit.
2. Melakukan promosi terkait pelayanan imunisasi, baik oleh bidan maupun dokter spesialis rumah sakit.

3.2.2.1.2.9 Pelayanan Keluarga Berencana (KB)
Tabel Pelayan Keluarga berencana (KB) Ponek April 2026

NO	JENIS	JUMLAH PASANG		
		FEB 2026	MAR 2026	APR 2026
1	IUD	5	9	14
2	MOW	10	7	5
3	MOP	0	0	0

4	Kondom	7	15	13
5	Implant	0	0	0
6	Suntikan	18	5	25
7	Pil	34	43	18
8	Σ Kelahiran	94	109	113
9	Σ Abortus	7	15	13

Grafik Pelayanan KB Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan April 2026



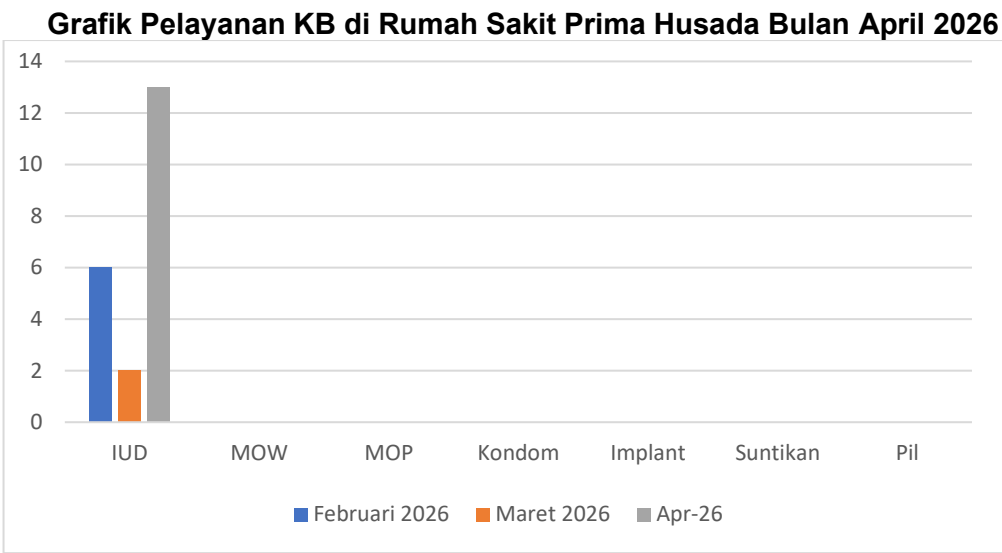
Aanalisis :

1. Pemasangan KB IUD pada bulan bulan April 2026 meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 14 akseptor, yang terdiri dari 7 akseptor IUD Nova T dan 7 akseptor IUD copper T, pemakaian KB belum maksimal dikarenakan KB IUD coper T pasca salin ada biaya jasa dokter Rp. 400.000, biaya gratis jika dipasang oleh bidan tetapi pasien tidak berkenan, memilih KB di faskes tingkat 1
2. Pasien yang menggunakan metode MOW pada bulan april 2026 sebanyak 5 pasien, sedangkan pada bulan Maret sebanyak 7 pasien, dan bulan Februari sebanyak 10 pasien. Untuk pemasangan KB MOW dilakukan sesuai dengan indikasi pasiennya, seperti pada pasien grande multipara dan primi tua sekunder. Tindakan MOW dilakukan jika ada indikasi dari DPJP.
3. Pasien yang menggunakan metode kondom pada bulan April 2025 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 13 pasien, sedangkan pada bulan Maret sebanyak 15 pasien, dan pada bulan Februari sebanyak 7 pasien.
4. Pasien yang menggunakan metode Pil pada bulan April 2026 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 18 pengguna, sedangkan pada bulan Maret sebanyak 43 pengguna, dan bulan Februari sebanyak 34 pengguna,.
5. Pasien yang menggunakan metode suntik pada bulan April meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 25 pengguna, sedangkan bulan Maret 2026 sebanyak 5 pengguna, dan Februari 2026 sebanyak 18 pengguna,

Rencana dan Tindak Lanjut :

Melakukan promosi terkait pelayanan KB baik dilakukan oleh bidan maupun dokter spesialis di rumah sakit.

Pelayanan Pelepasan KB di Rumah Sakit Prima Husada Bulan April 2026				
No	Jenis	Jumlah Lepas		
		Februari 2026	Maret 2026	April 2026
1	IUD	6	2	13
2	MOW	0	0	0
3	MOP	0	0	0
4	Kondom	0	0	0
5	Implant	0	0	0
6	Suntikan	0	0	0
7	Pil	0	0	0



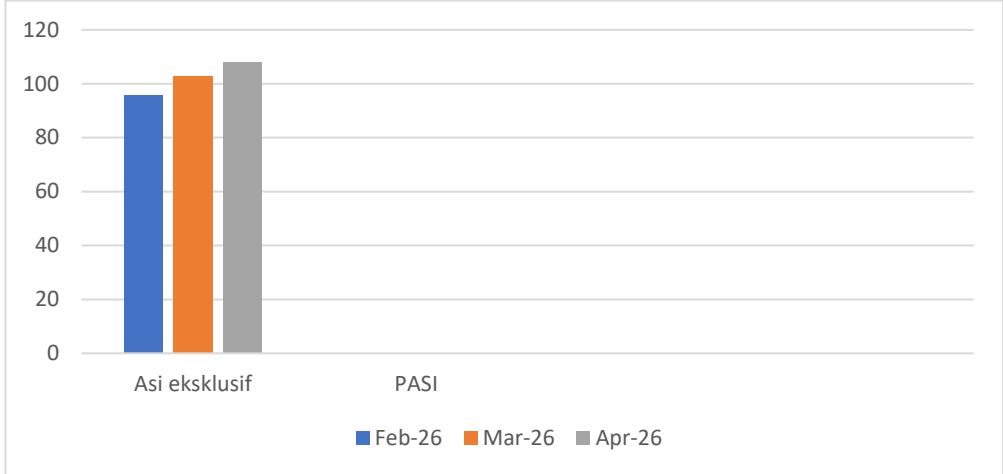
- Analisis :**
1. Pelepasan KB IUD pada bulan April 2026 meningkat yaitu 13 Akseptor, sedangkan pada bulan Maret 2026 yaitu 2 Akseptor, dan bulan Februari 2026 sebanyak 6 akseptor
 2. Pelepasan KB Implan pada bulan April 2026 dan 2 bulan sebelumnya tidak ada

Rencana dan Tindak Lanjut :
Melakukan promosi terkait pelayanan KB baik dilakukan oleh bidan maupun dokter spesialis di rumah sakit.

3.3 Pelayanan Pemberian ASI Eksklusif

Tabel Pelayanan Pemberian ASI Eksklusif April 2026				
No	Pemberian Asi	Jumlah Pasien		
		Bulan Februari 2026	Bulan Maret 2026	Bulan April 2026
1	Asi eksklusif	96	103	108
2	PASI	0	0	0

Grafik Pelayanan Pemberian Asi Eksklusif di RS Prima Husada Bulan April 2026



Analisis :

1. Pelayanan pemberian ASI eksklusif pada bulan April 2026 meningkat yaitu 108 bayi, dibandingkan bulan Maret 2026 yaitu 103 bayi, sedangkan Februari 2026 sebanyak 96 bayi. Hal ini dikarenakan meskipun ada bayi dengan BBLR juga tetap diberikan ASI eksklusif
2. Tidak ada bayi yang mendapat PASI pada bulan April 2026 dan 2 bulan sebelumnya. Bayi yang menggunakan susu formula pada bayi dengan kondisi tertentu, dan atas rekomendasi dari dokter spesialis anak.

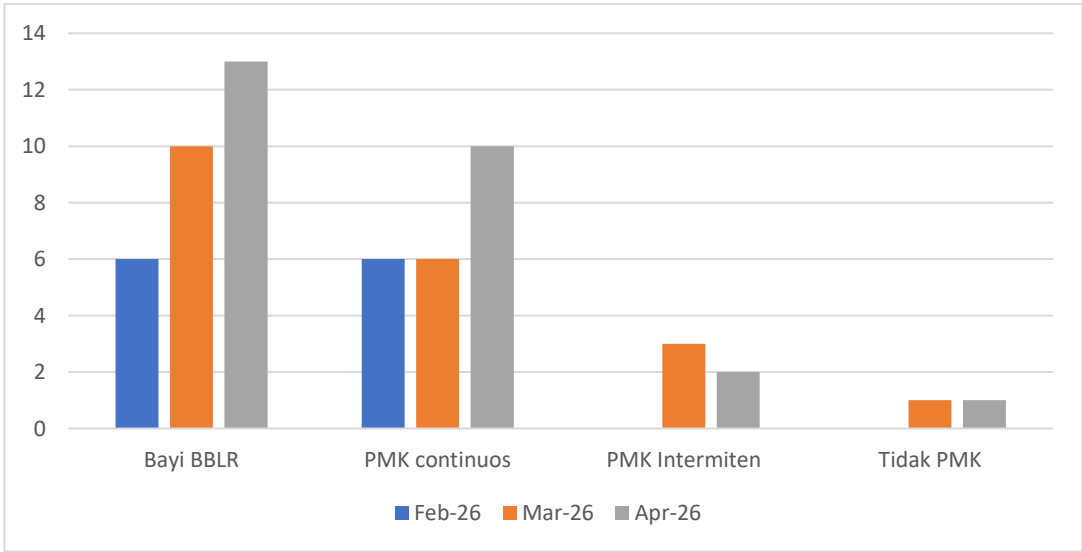
Rencana dan Tindak Lanjut :

1. Edukasi ASI eksklusif sejak antenatal
2. Melakukan konseling laktasi oleh dokter, bidan dan perawat

3.2.2.1.2.10 Pelayanan Perawatan Metode Kangguru (PMK) Pada BBLR
Tabel Pelayanan Perawatan metode kangguru (PMK) Pada BBLR di Ponek April 2026

No	Uraian	Jumlah Pasien		
		Bulan Februari 2025	Bulan Maret 2025	Bulan April 2025
1	Bayi BBLR	6	10	13
2	PMK continuos	6	6	10
3	PMK Intermiten	0	3	2
4	Tidak PMK	0	1	1

Grafik Perawatan Metode Kangguru (PMK) Pada BBLR di RS Prima Husada April 2026



Analisis :

- 1. Bayi yang dilakukan PMK continus dan PMK intermiten adalah bayi dengan berat badan <2500 gram.
- 2. Ada 2 pelayanan perawatan metode kangguru (PMK) dengan metode intermiten pada BBLR di bulan April 2026, sedangkan pada bulan Maret ada 3 bayi, dan Februari tidak ada. Hal ini dikarenakan bayi sesak memakai c-pap dan perawatan inkubator.
- 3. Sedangkan metode PMK continus pada bulan April 2026 sebanyak 10 bayi, sedangkan pada bulan Maret dan Februari sebanyak 6 bayi dengan BBLR kondisi bayi stabil.
- 4. Ada 1 bayi yang tidak dilakukan PMK pada bulan April dan Maret 2026, sedangkan pada bulan Februari tidak ada. Hal ini dikarenakan bayi dengan diagnosa RDS ok HMD DD Neonatal pneumonia, BBLASR dan bayi di rujuk ke RS lain.

1.1.2.2. TB DOT'S

3.1.2.2.2 Skrining Pasien

NO	JENIS SKRINING	JUMLAH PASIEN			KET
		APRIL	MEI	JUNI	
1.	Pemberian Masker pada Pasien Suspek TB/ Non TB	0			
2	Pemberian Masker pada Keluarga TB+	0			
3	Pemberian masker Pasien TB+ yang lupa membawa Masker/Perilaku tidak berubah	0			

Evaluasi :

- 1. Pada bulan April 2026 terdapat 0 pasien yang diberikan masker
- 2. Pada bulan Mei 2026 terdapat 0 pasien yang diberikan masker
- 3. Pada bulan Juni 2026 terdapat 0 pasien yang diberikan masker

Rencana dan Tindak Lanjut:

- 1. Memfasilitasi ketersediaan masker
- 2. Edukasi pemakaian masker (meliputi fungsi, waktu penggunaan, dan siapa saja yang perlu menggunakan)

3.1.2.2.1 Proporsi Pasien (Terduga dan Baru) Tekonfirmasi Bakteriologis Bulan Februari 2026

No	Pelaksanaan	Usia	Px Mantoux	TCM Bacteriologis	Foto X Ray	Hasil PA
1.	03/02/2026	39 th	-	Negatif	Positif	-
2	03/02/2026	14th	-	Positif	Positif	-
3	11/02/2026	23th	-	Negatif	Positif	-
4	11/02/2026	57th	-	Positif	Positif	-
5	21/02/2026	10th	-	Positif	Positif	-
6	26/02/2026	43th	-	Negatif	Positif	-
7						
8						

9						
10						
	Total		0	3	6	0

3.1.2.2.2 Proporsi Pasien (Terduga dan Baru) Tekonfirmasi Bakteriologis
Bulan Maret 2026

No	Pelaksanaan	Usia	Px Mantoux	TCM Bakteriologis	Foto X Ray	Hasil PA
1.	02/03/2026	49TH	-	Negatif	Positif	-
2	03/03/2026	46TH	-	Positif	Positif	-
3	04/03/2026	68TH	-	Positif	Positif	-
4	16/03/2026	24TH	-	Negatif	Negatif	Positif
5	16/03/2026	26TH	-	Negatif	Positif	-
6	07/03/2026	71TH	-	Positif	Negatif	-
7						
8						
9						
10						
	Total		0	3	4	1

3.1.2.2.2 Proporsi Pasien (Terduga dan Baru) Tekonfirmasi Bakteriologis
Bulan April 2026

No	Pelaksanaan	Usia	Px Mantoux	TCM Bakteriologis	Foto X Ray	Hasil PA
1.	01/04/2026	36 th	-	Positif	Positif	-
2	07/04/2026	24 th	-	Positif	Positif	-
3	08/04/2026	49th	-	Negatif	Positif	-
4	10/04/2026	71th	-	Positif	Positif	-
5	13/04/2026	76th	-	Negatif	Positif	-
6	14/04/2026	74th	-	Positif	Positif	-
7	25/04/2026	2th	Negatif	-	Negatif	Positif
8	29/04/2026	61th	-	Negatif	Positif	-
9						
10						
11						
12						
13						
	Total		1	4	7	1

Analisis :

1. Pada bulan April 2026 jumlah proporsi Pasien terduga TB 22 Pasien diambil data dari SITB. pasien positif sejumlah 8 pasien dan pasien negatif sejumlah 14 pasien
2. Pada bulan Mei 2026 jumlah proporsi Pasien terduga TB 0 Pasien diambil data dari SITB. pasien positif sejumlah 0 pasien dan pasien negative 0 pasien
3. Pada bulan Juni 2026 jumlah proporsi Pasien terduga TB 0 pasien diambil data dari SITB. Pasien positif sejumlah 0 pasien dan pasien negative 0 pasien

Rencana dan Tindak Lanjut :

Melakukan edukasi terhadap keluarga pasien dengan kontak TB untuk melakukan skrining TB

3.1.2.2.1 Penemuan Kasus TB

No	Unit	Jumlah Pasien		
		April	Mei	Juni
1.	Poli Paru	5		
2	Poli Bedah			
3	Poli IPD			
4	Poli Anak	1		
5	Irna 2C			
6	ICU			
7	IGD			
8	Irna 2A			
9	Irna 3C anak			
10	Irna 3A			
11	Irna 4A			
12	Maternitas 4C			
13	Irna 5C	2		
14	Irna 6A			
15	Irna 7A			
16	Irna 8A			
	Total	8		

Analisis :

1. Pada bulan April 2026 jumlah proporsi Pasien terduga TB 22 Pasien diambil data dari SITB. pasien positif sejumlah 8 pasien dan pasien negatif sejumlah 14 pasien
2. Pada bulan Mei 2026 jumlah proporsi Pasien terduga TB 0 Pasien diambil data dari SITB. pasien positif sejumlah 0 pasien dan pasien negative 0 pasien
3. Pada bulan Juni 2026 jumlah proporsi Pasien terduga TB 0 pasien diambil data dari SITB. Pasien positif sejumlah 0 pasien dan pasien negative 0 pasien

Rencana dan Tindak Lanjut:

Menginformasikan kepada pasein dan keluarga pasien untuk melakukan pengobatan dengan teratur dan sesuai jadwal, serta mengedukasi kepada keluarga pasien untuk melakukan skrinning TB di faskes terdekat.

3.1.2.2.2 Jumlah Kunjungan pasien TB

No	Kegiatan	Jumlah Pasien			Jumlah Total Pasien TB
		April	Mei	Juni	Total
1.	Pasien TB kunjungan keseluruhan	63			
2	Pasien RFC (OAT Protolan)	0			
3	Pasien RFT	8			

Analisis:

1. Jumlah keseluruhan kunjungan di poli pasien TBC di bulan April mencapai 63 pasien, di bulan Mei 0 pasien, dan di bulan Juni 0 pasien.
2. Jumlah keseluruhan kunjungan di poli pasien RFC di bulan April 0 pasien, di bulan Mei 0 pasien dan di bulan Juni 0 pasien.
3. Jumlah keseluruhan kunjungan di poli pasien RFT di bulan April 8 pasien, di bulan Mei 0 pasien dan di bulan Juni 0 pasien.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Meningkatkan kunjungan pasien

3.1.2.2.3 Pemberian Obat Pencegahan

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		APRIL	MEI	JUNI
1.	Pemberian obat pencegahan (INH)	8		

Analisis :

Tidak ada yang mendapat obat pencegahan (INH), hal ini dikarenakan kurang pengetahuannya pasien dan keluarga pasien mengenai pengobatan pencegahan (INH)

Rencana dan Tindak Lanjut

1. Memberikan edukasi kepada keluarga pasien bahwa jika ada salah satu keluarga yang terdiagnosa TB keluarga wajib melakukan skrining di faskes terdekat agar segera memeriksakan dan bersedia di berikan obat pencegahan (INH).
2. Pemberian obat INH ditujukan pada anak usia dibawah 5 tahun dan dewasa yang memiliki kontak erat dengan pasien TB aktif dan orang dengan HIV/AIDS yang tidak terdiagnosa TB.

3.1.2.2.4 Pemberian Imunisasi BCG

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		APRIL	MEI	JUNI
1.	Pemberian imunisasi BCG	4		

Evakuasi :

1. Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 4 pasien yang diimunisasi pada bulan April
2. Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 0 pasien yang diimunisasi pada bulan Mei
3. Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 0 pasien yang diimunisasi pada bulan Juni

Rencana dan Tindak Lanjut :

1. Dilakukan screening pasien dalam memberikan vaksin BCG
2. Setelah dilakukan vaksin BCG dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pemberian vaksin yang akan dilakukan pencatatan dan pelaporan tiap bulanya

3.1.2.2.5 Kepatuhan Dokter Terhadap PPK-CP Pasien TB Bulan April 2026

No	Kegiatan	Nama Pasien	Patuh	Tidak Patuh	Alasan
1.	dr. Andy, Sp. P(K)	Ny.I	V		
		Ny.H	V		
		Tn. R	V		
		Tn. I	V		
2.	dr. Catur Elvi p., Sp. P-ONK	Ny. S	V		
		Ny.K	V		
		Tn.D	V		
3.	dr. Fiona Paramitha. Sp.A				
3.	dr. Dicky.Sp.A.M.Biomed	An. A	V		

3.1.2.2.6 Kepatuhan Dokter Terhadap PPK-CP Pasien TB Bulan Mei 2026

No	Kegiatan	Nama Pasien	Patuh	Tidak Patuh	Alasan
1.	dr. Andy, Sp. P(K)				
2.	dr. Catur Elvi p., Sp. P-ONK				
3.	dr. Dicky.Sp.A.M.Biomed				
4.	dr. Ratih.Sp.A.M.Biomed				

3.1.2.2.7 Kepatuhan Dokter Terhadap PPK-CP Pasien TB Bulan Juni 2026

No	Kegiatan	Nama Pasien	Patuh	Tidak Patuh	Alasan
1.	dr. Andy, Sp. P(K)				
2.	dr. Catur Elvi p., Sp. P-ONK				
3					

Analisis :

Semua dokter sudah patuh akan PPK (Panduan Praktek Klinis) TB, baik dari anamnesis, kriteria diagnosis, pemeriksaan penunjang, dan Edukasi. Akan tetapi pada *point* edukasi sosial (pencarian kontak serumah) tidak dilakukan

Rencana dan Tindak Lanjut :

Mempertahankan kepatuhan dalam penggunaan APD di tiap bulanya

3.1.2.2.7 Kepatuhan Staf Dan Petugas Terhadap APD

No	Kegiatan	Jumlah Pasien		
		April	Mei	Juni
1.	Kepatuhan staf dan petugas terhadap APD- Masker N95	100%		
2	Kepatuhan staf dan petugas terhadap APD- Masker bedah	100%		
3	Kepatuhan Staf menggunakan APD Gaun/Skort	100%		

Analisis:

Semua staf sudah patuh dalam penggunaan APD, hal ini menunjukkan kesadaran bahwa sangat penting menjaga diri agar tidak tertular pasien.

Rencana dan Tindak Lanjut :

Mempertahankan kepatuhan dalam penggunaan APD di tiap bulanya

3.1.2.2.8 Penempatan Pasien TB

No	Penempatan Paien TB	Jumlah Pasien		
		April	Mei	Juni
1.	Penempatan pasien TB IGD	100%		
2	Penempatan pasien TB Poli Paru	100%		
3	Penempatan pasien TB di IRNA 5c	100%		

Analisis:

Semua pasien TB sudah ditempatkan di ruang IGD isolasi untuk di ruang IGD, di Poli TB untuk pasien TB dan Ruang Isolasi 5c untuk Pasien irna isolasi. hal ini menunjukkan kesadaran staff medis agar antar pasien satu dengan lainnya tidak tertular.

Rencana dan Tindak Lanjut :

Mempertahankan penempatan dengan benar

3.1.2.2.9 Pasien TB yang dirujuk di Fasyankes / RS Lebih Tinggi di Bulan April 2026

No	Unit	Nama Pasien	Baru	Lama	Bulan April	Tempat Rujukan	Alasan
1.	Poli Paru	Ny.S	V	-	1	PKM Karangploso	Pasien Memilih Lebih Dekat Dengan Rumahnya
	Poli Paru	Tn.D	V	-	1	PKM Singosari	Pasien Memilih Lebih Dekat Dengan

							Rumahnya
2	Poli Bedah						
3	Poli IPD						
4	Poli Anak						
5	Irna 2C						
6	ICU						
7	IGD						
8	Irna 2A						
9	Irna 3C anak						
10	Irna 3A						
11	Irna 4A						
12	Maternitas 4C						
13	Irna 5C						
14	Irna 6A						
15	Irna 7A						
16	Irna 8A						
	Total						

3.1.2.2.10 Pasien TB yang dirujuk di Fasyankes / RS Lebih Tinggi di Bulan Mei 2026

No	Unit	Nama Pasien	Baru	Lama	Bulan Mei	Tempat Rujukan	Alasan
1.	Poli Paru						
	Poli Paru						
2	Poli Bedah						
3	Poli IPD						
4	Poli Anak						
5	Irna 2C						
6	ICU						
7	IGD						
8	Irna 2A						
9	Irna 3C anak						
10	Irna 3A						
11	Irna 4A						
12	Maternitas 4C						
13	Irna 5C						
14	Irna 6A						
15	Irna 7A						
16	Irna 8A						
	Total						

3.1.2.2.11 Pasien TB yang dirujuk di Fasyankes / RS Lebih Tinggi di Bulan Juni 2026

No	Unit	Nama Pasien	Baru	Lama	Bulan Juni	Tempat Rujukan	Alasan
1.	Poli Paru						
2	Poli Bedah						
3	Poli IPD						
4	Poli Anak						
5	Irna 2C						
6	ICU						
7	IGD						
8	Irna 2A						
9	Irna 3C anak						
10	Irna 3A						
11	Irna 4A						
12	Maternitas 4C						
13	Irna 5C						
14	Irna 6A						
15	Irna 7A						
16	Irna 8A						
	Total						

Analisis :

- 1. Pada bulan April 2026 terdapat 2 pasien yang dirujuk ke FKTP karena pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya.
- 2. Pada bulan Mei 2026 terdapat 0 pasien yang dirujuk ke FKTP karena pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya.
- 3. Pada bulan Juni 2026 terdapat 0 pasien yang dirujuk ke FKTP karena memilih lebih dekat dengan rumahnya.

Rencana dan Tindak Lanjut :

Mempertahankan pelayanan yang terbaik untuk pasien sesuai pilihan pasien untuk berobat.

3.1.2.2.12 Stok OAT

No	Kegiatan	Jumlah Pasien			ED
		April	Mei	Juni	
1.	OAT Anak	3			01/27
2.	OAT Harian Dewasa	10			11/26
3.	Ethambutol 250 mg	0			0
4.	Ethambutol 400 mg	0			0
5.	Pirazinamid 500 mg	632			05/27
6.	Isoniazid 300 mg	404			08/26
7.	Rimfapicin 450 mg	1082			03/28
8.	Rimfapicin 300 mg	0			0

Analisis :
Setiap 1 bulan sekali farmasi akan melakukan pengadaan obat terkait permintaan ke Dinkes

Rencana dan Tindak Lanjut :
Menetapkan pengambilan obat dengan sesuai jadwal.

3.1.2.2.13 Pasien Paru dan Ekstra Paru

No	Unit	Jenis TB	Jumlah Pasien					
			April		Mei		Juni	
			Anak	Dewasa	Anak	Anak	Dewasa	Anak
1.		Pasien paru		7				
2.		Pasien Ekstra paru	1					

- Evaluasi :**
- 1. Pada bulan April 2026 terdapat 1 pasien ekstra paru dan 7 pasien paru
 - 2. Pada bulan Mei 2026 terdapat 0 pasien ekstra paru dan 0 pasien paru
 - 3. Pada bulan Juni 2026 terdapat 0 pasien ekstra paru dan 0 pasien paru

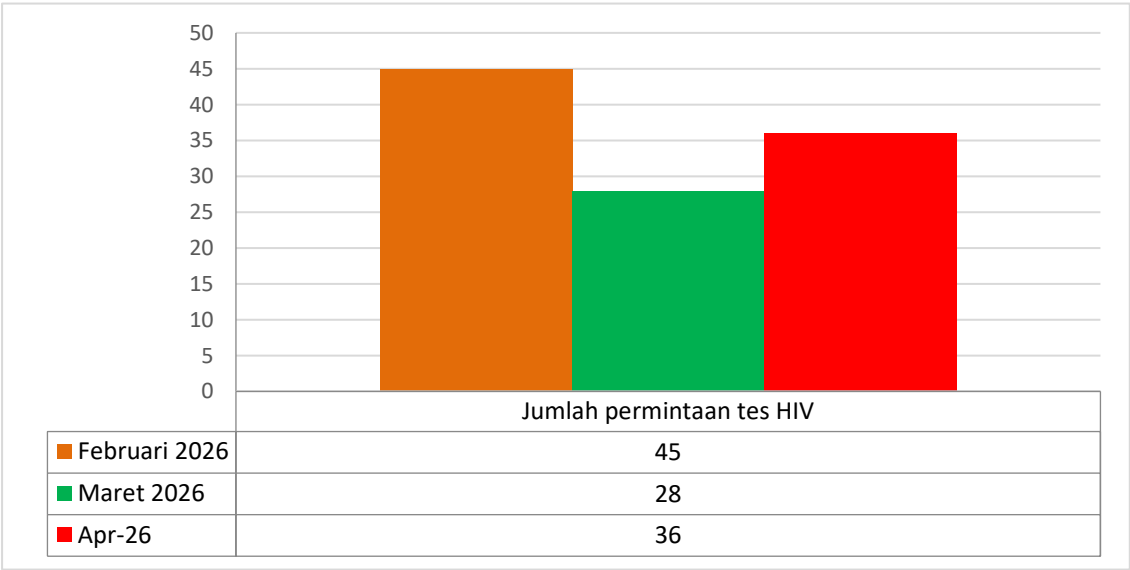
Rencana dan Tindak Lanjut :
Memberikan pengobatan yang sama pada ekstra paru meski pengobatannya akan lebih lama pada pasien ekstra paru

3.1.2.3 HIV

Jumlah Permintaan Tes HIV

No	URAIAN	BULAN		
		FEBRUARI 2026	MARET 2026	APRIL 2026
1	Permintaan Test HIV	45	28	36

Grafik Jumlah Permintaan Tes HIV Di Rumah Sakit Prima Husada
Bulan April 2026



Analisis :
Jumlah permintaan pelayanan HIV mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya. Pada Bulan februari 2026 sebanyak 45 pemeriksaan, pada bulan Maret 2026 sebanyak 28 pemeriksaan, sedangkan pada bulan April 2026 sebanyak 36 pemeriksaan yang berasal dari Asal permintaan test diantaranya dari poli paru, poli penyakit dalam, Poli

kulit dan kelamin, Poli anak, Poli kandungan, IGD, IGD PONEK, IRNA, dan ICU.

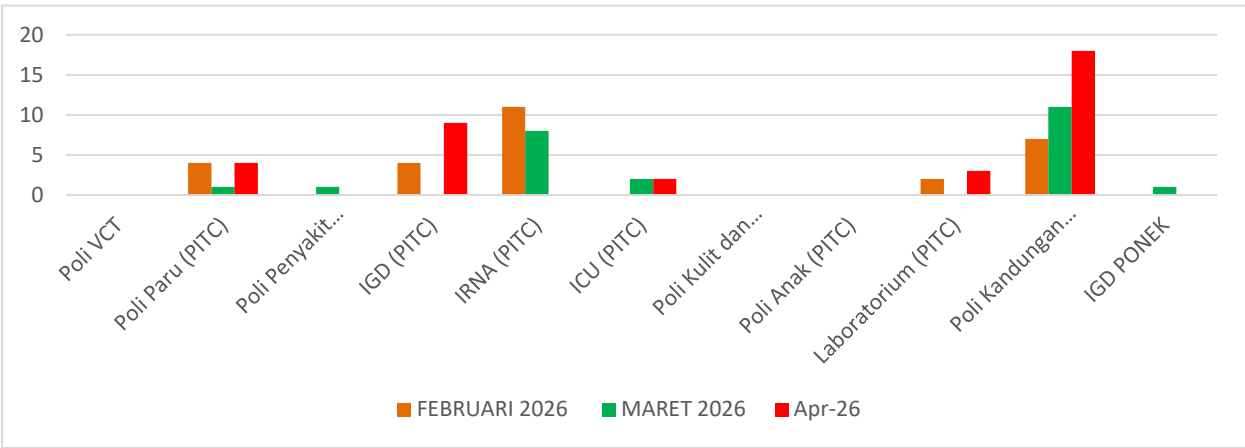
Rencana Tindak Lanjut :

Dilakukan skrining ulang pada pasien-pasien yang terduga HIV, pasien hamil trimester 3 dan juga pasien-pasien mandiri yang ingin dilakukan pemertiksaan HIV sesuai sukarela baik pasien IGD, rawat jalan maupun rawat inap.

3.7.15 Asal Permintaan Tes HIV

NO	UNIT / KLINIK ASAL PERMINTAAN	BULAN		
		FEBRUARI 2026	MARET 2026	APRIL 2026
1	Poli VCT	0	0	0
2	Poli Paru (PITC)	4	1	4
3	Poli Penyakit Dalam (PITC)	0	1	0
4	IGD (PITC)	4	0	9
7	IRNA (PITC)	11	8	0
8	ICU (PITC)	0	2	2
9	Poli Kulit dan kelamin (PITC)	0	0	0
10	Poli Anak (PITC)	0	0	0
11	Laboratorium (PITC)	2	0	3
	Total PITC	21	12	18
12	Poli Obgyn (PMTCT)	7	11	18
13	IGD PONEK	0	1	0
	Total PMTCT	7	12	18
	Total PITC + PMTCT	28	24	36

Grafik Jumlah Asal Permintaan Tes HIV di RS Prima Husada Bulan April 2026



Analisis :

- 1) Unit Asal permintaan Yang meminta pelayanan HIV di bulan April 2026 diantaranya dari poli paru, poli penyakit dalam, Poli kulit dan kelamin, Poli anak, Poli kandungan, IGD, IGD PONEK, IRNA, dan ICU.
- 2) Jumlah tertinggi permintaan pelayanan pemeriksaan HIV di bulan April 2026 yaitu dari poli Kandungan sebanyak 18 pasien. Hal ini dikarenakan sudah tersdianya Reagen HIV dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk program ibu hamil sehingga pasien dengan kriteria hamil trimester II sudah bisa dilakukan screening HIV dan pemeriksaan triple eliminasi.
- 3) Jumlah terendah permintaan pelayanan pemeriksaan HIV di bulan April 2026 yaitu dari poli VCT yaitu 0 tidak ada permintaan. Hal ini dikarenakan kurang tahunya masyarakat terkait pentingnya deteksi pemeriksaan HIV/AIDS
- 4) Poli terendah permintaan pelayanan pemeriksaan HIV yaitu dari poli VCT bisa dilakukan peningkatan permintaan pemeriksaan pelayanan HIV dengan dilakukanya edukasi terkait pentingnya screening HIV

- 5) Unit yang masuk PITC diantaranya, poli paru, poli penyakit dalam, Poli kulit dan kelamin, Poli anak, IGD, IRNA dan ICU dengan jumlah total di di bulan April 2026 sebanyak 18 pasien. Sedangkan yang masuk PMTCT diantaranya poli kandungan dan IGD PONEK dengan jumlah total di di bulan April 2026 sebanyak 18 pasien

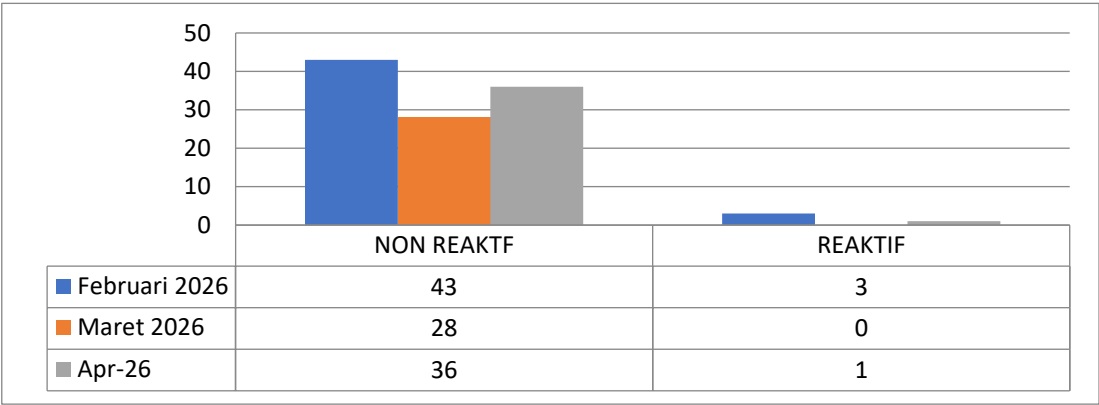
Rencana Tindak Lanjut :

Dilakukan sosialisasi terkait Permintaan testing HIV dilakukan baik di IGD, rawat jalan, maupun rawat jalan sesuai dengan kebutuhan pasien. Sehingga capaian permintaan testing HIV bisa berjalan.

3.1.2.3.2 Status HIV

No	URAIAN	BULAN		
		FEBRUARI 2026	MARET 2026	APRIL 2026
1	Non Reaktif	43	28	36
2	Reaktif	3	0	1

Grafik Status HIV April 2026



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan pasien dengan status HIV reaktif yang dilakukan pemeriksaan di RS prima Husada Malang pada pada bulan Februari 2026 terdapat 3 paisen dengan HIV reactif dari rawat inap, pada bulan Maret 2026 tidak ditemukan pasien yang reaktif HIV Sedangkan pada bulan April 2026 terdapat 1 pasien dengan HIV reaktif yang berasal dari ICU isolasi.

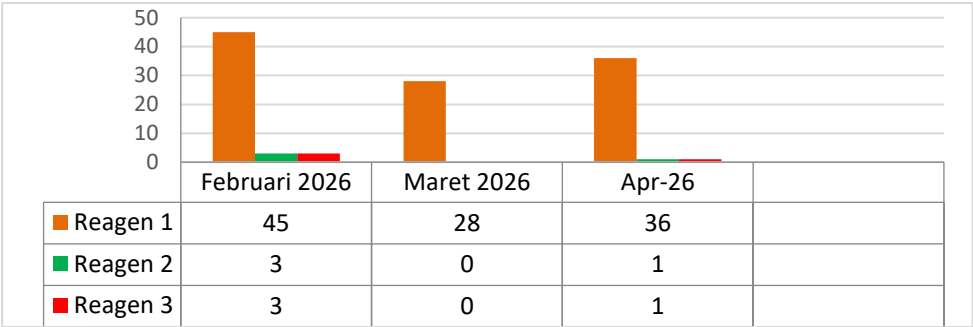
Rencana Tindak Lanjut :

Rumah sakt prima husada malang masih belum bisa melakukan pelayanan pasien dengan HIV/AIDS, apabila ditemukan pasien dengan HIV reaktif maka akan kami lakukan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah MOU dengan RS Prima Husada Malang.

3.7.16 Jumlah Pemakaian Reagen

No	URAIAN	BULAN		
		FEBRUARI 2026	MARET 2026	APRIL 2026
1	Reagen 1	45	28	36
2	Reagen 2	3	0	1
3	Reagen 3	3	0	1

Grafik Jumlah Pemakaian Reagen April 2026



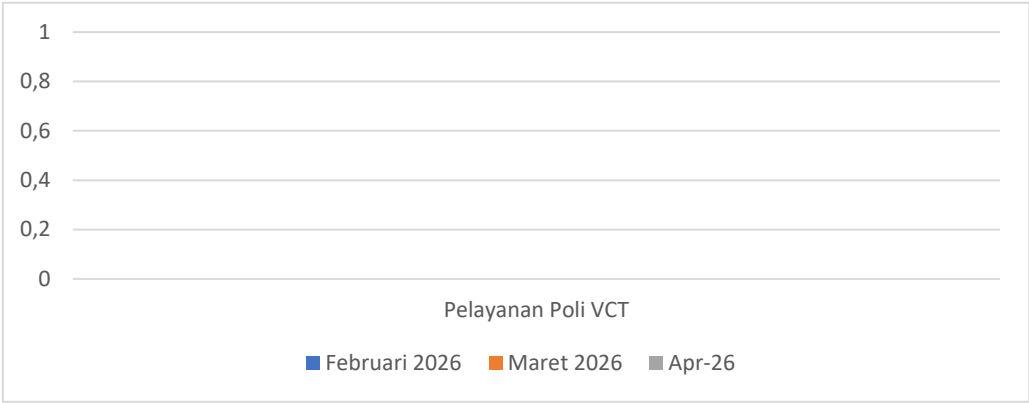
Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa pemakaian reagen pada bulan Februari 2026 memakai reagen 3 dikarenakan ada pasien reaktif sebanyak 3 pasien. pada bulan Maret 2026 hanya memakai reagen 1 saja sebanyak 28 reagen. Sedangkan pada bulan April 2026 memakai reagen 3 dikarenakan ada pasien reaktif sebanyak 1 pasien

Rencana Tindak Lanjut :
Pemakaian reagen HIV tergantung dari hasil pemeriksaan dengan Reagen 1. Apabila dilakukan pemeriksaan dengan Reagen 1 hasil Non Reaktif maka tidak dilanjutkan pemakaian Reagen 2 dan 3.
Tetapi apabila saat pemeriksaan dengan Reagen 1 ditemukan hasil Reaktif maka pemeriksaan dilanjutkan dengan penggunaan Reagen 2 dan Reagen 3

3.7.17 Pelayanan Poli VCT (Voluntary Conseling And Testing)

No	URAIAN	BULAN		
		FEBRUARI 2026	MARET 2026	APRIL 2026
1	Pelayanan Poli VCT	0	0	0

Grafik Pelayanan Poli VCT April 2026



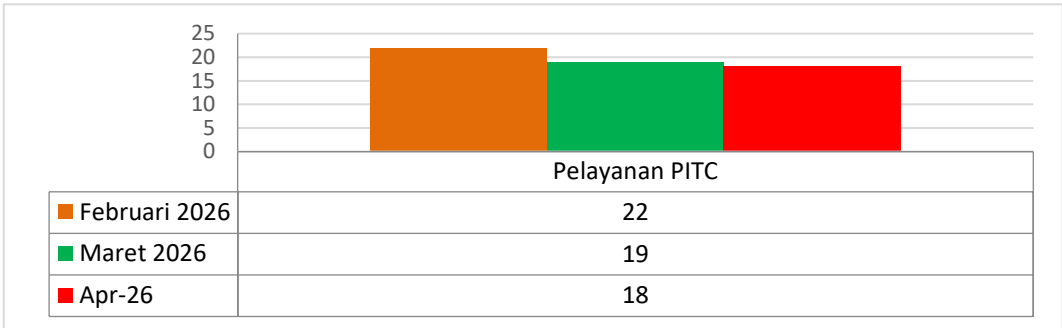
Analisis pelayanan Poli VCT
Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa tidak ada kunjungan di poli VCT di RS Prima Husada. Hal ini dikarenakan kurang tahunya masyarakat terkait pentingnya deteksi pemeriksaan HIV/AIDS

Rencana Tindak Lanjut
Pelayanan Poli VCT di Rumah Sakit Prima Husadabelum berdiri sendiri, melainkan masih bergabung dengan poli penyakit Dalam di Rawat jalan. Hal ini dikarenakan asih belum adanya kunjungan pasien ke poli VCT

3.7.18 Pelayanan PITC (Provider Initiated Testing and Counseling)

No	URAIAN	BULAN		
		FEBRUARI 2026	MARET 2026	APRIL 2026
1	Pelayanan PITC	22	19	18

Grafik Pelayanan PITC April 2026



Analisis :

Dari data diatas terdapat keimpulan bahwa telah dilakukan edukasi pemeriksaan HIV oleh petugas kesehatan untuk dilakukan testing HIV pada bulan februari 2026 sebanyak 22 pasien, pada bulan Maret 2026 sebanyak 19 pasien. Sedangkan pada bulan April 2026 sebanyak 18 pasien.

Hal ini dikarenakan testing dan konseling dilakukan saat pasien menunjukan gejala HIV dan dilakukanya sreening baik di ruangan maupun IGD

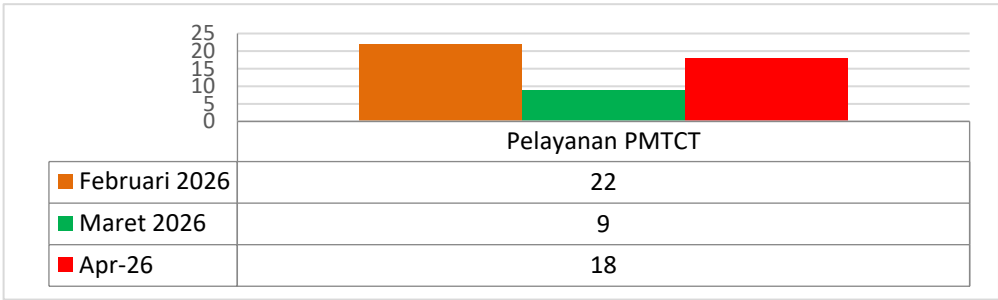
Rencana Tindak Lanjut :

Dilakukan peningkatan terkait penjarangan pasien dengan dialkukanya edukasi pasien tentang testing HIV kepada pengunjung atau masyarakat sehingga pasien paham tentang pentingnya dilakukan pemeriksaan HIV.

3.7.19 Pelayanan PMTCT (Prevention to Mother Of Child Transmision)

No	URAIAN	BULAN		
		FEBRUARI 2026	MARET 2026	APRIL 2026
1	Pelayanan PMTCT	22	9	18

Grafik Pelayanan PMTCT April 2026



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data pasien hamil yang dilakukan pemeriksaan HIV sebagai screening dan deteksi pencegahan penularan dari ibu ke Bayi. Pada bulan Februari 2026 sebanyak 22 pasien pada bulan Maret 2026 sebanyak 9 pasien. Sedangkan pada bulan April 2026 naik menjadi 18 pasien.

Hal ini dikarenakan pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan PMTCT dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang

pemeriksaanya. Sehingga pemeriksaan HIV di RS Prima Husada Malang untuk Prevention to Mother Of Child Transmision bias dilakukan.

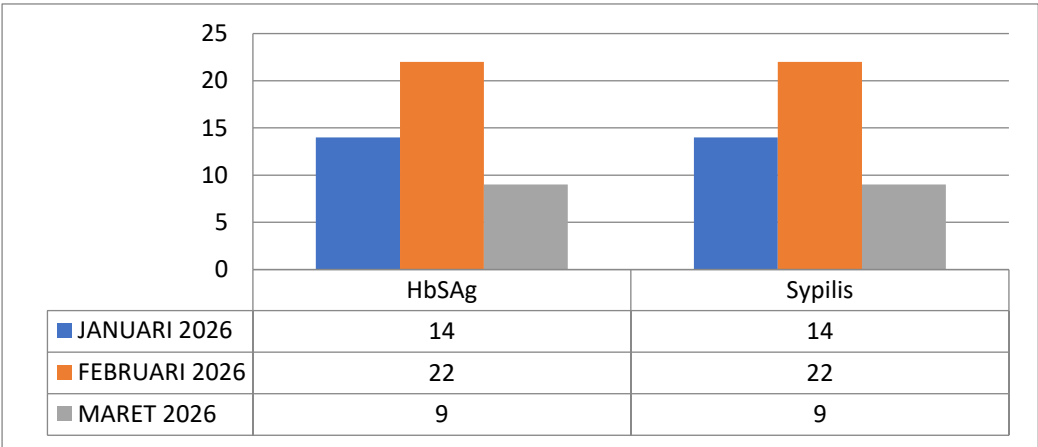
Rencana Tindak Lanjut :

Reagen pemeriksaan HIV yang diperoleh dari dinas kesehatan sudah tersedia di RS Prima Husada Malang sehingga Sehingga pemeriksaan HIV di RS Prima Husada Malang untuk Prevention to Mother Of Child Transmision bias dilakukan.

3.7.20 Pelayanan Pemeriksaan Triple Eiminasi Pada Ibu Hamil

No	URAIAN	BULAN		
		FEBRUARI 2026	MARET 2026	APRIL 2026
1	HbSAg	22	9	18
2	Sypilis	22	9	18

**Grafik Pelayanan Pemeriksaan Triple Eliminasi Pada Ibu Hamil
A2026**



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data pasien hamil yang dilakukan pemeriksaan HbSAg dan Sypilis pada bulan pada bulan Januari 2026 sebanyak 14 pasien pada bulan Februari 2026 sebanyak 22 pasien. Sedangkan pada bulan Maret 2026 sebanyak 9 pasien yang dilakukan pemeriksaan

Hal ini dikarenakan pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan triple eliminasi dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya. Sehingga pemeriksaan Triple eliminasi di RS Prima Husada Malang untuk pemeriksaan HbSAg dan Sypilis bisa dilakukan.

Rencana Tindak lanjut :

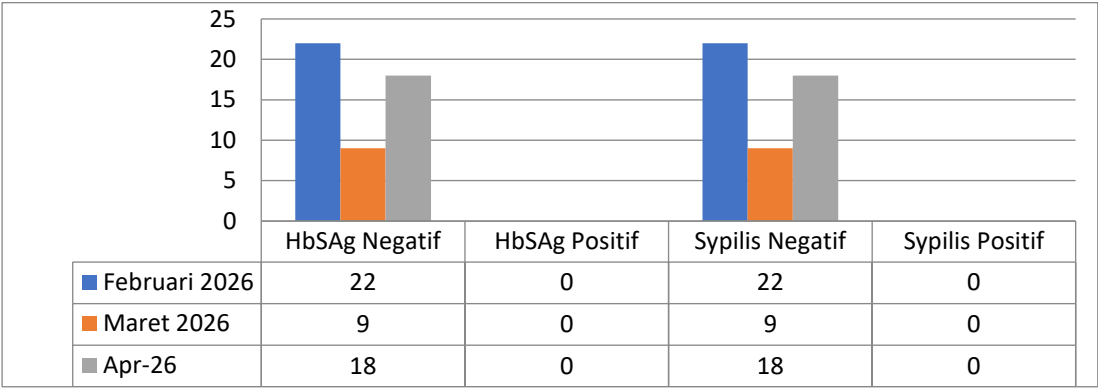
Pemeriksaan Triple eliminasi untuk ibu hamil bersifat wajib dan dilakukan 1 kali saat awal kehamilan. Di RS Prima Husada skrining pemeriksaan triple eliminasi sudah berjalan dan dilakukan saat kunjungan pada Trimester 2.

3.7.21 Status Pelayanan Pemeriksaan Triple Eiminasi Pada Ibu Hamil

No	URAIAN	BULAN		
		FEBRUARI 2026	MARET 2026	APRIL 2026
1	HbSAg			

	Negatif	22	9	18
	Positif	0	0	0
2	Sypilis			
	Negatif	22	9	18
	Positif	0	0	0

Grafik Status Pelayanan Pemeriksaan Triple Eliminasi Pada Ibu Hamil April 2026



Analisis :
 Dari hasil grafik diatas ditemukan data bahwa pada bulan februari, Maret dan April 2026 tidak ditemukan pasien dengan HbSAg maupun Shypilis dengan hasil positif

Rencana Tindak Lanjut :

- Pada pasien HbSAg

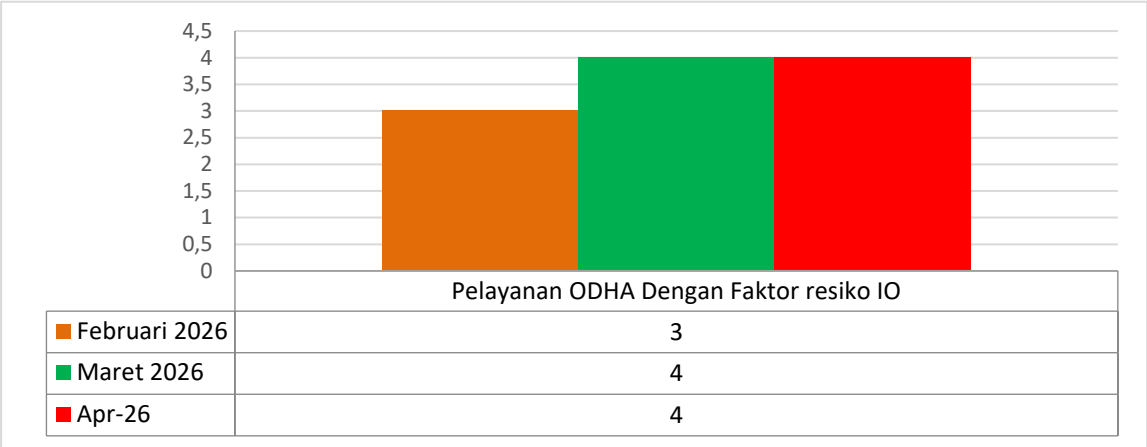
Saat kelahiran aka nada pemberian vaksin Hepatitis kepada bayi yaitu Hiper Heb dan juga Hb.O unijec yang diberikan saat bayi baru lahir sampai dengan maksimal 24 jam pemberian. Untuk ibu dengan HbSAg akan dilakukan pemberian vaksin hepatitis oleh Puskesmas sesuai domisili pasien.Penanganan pasien dengan HbSAg Rumah Sakit Prima Husada Malang Kolaborasi dengan puskesmas sesuai dengan domisili pasien.
- Pada pasien Sypilis

Di rumah sakit Prima Husada Malang sudah bisa melakukan pengobatan pasien dengan syphilis positif. Sehingga tidak lagi melakukan rujuk keluar.

3.7.22 Pelayanan Odha Dengan Factor Resiko Infeksi Oportunistik

NO	URAIAN	BULAN		
		FEBRUARI 2026	MARET 2026	APRIL 2026
1	Jumlah Pelayanan ODHA dg IO (Pasien TB Positif dilakukan pemeriksaan HIV	3	4	4
2	Pasien TB Positif dengan HIV positif	0	0	0

Grafik Pelayanan Odha dengan Faktor Resiko IO April 2026



Analisis :

- 1. Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa terdapat pasien TB yang dilakukan pemeriksaan HIV pada bulan Februari sebanyak 3 pasien, pada bulan Maret 2026 sebanyak 4 pasien. Sedangkan pada bulan April 2026 sebanyak 4 pasien
- 2. Hasil pemeriksaan HIV pasien TB Pada bulan februari s/d bulan April 2026 tidak ada yang positif HIV.

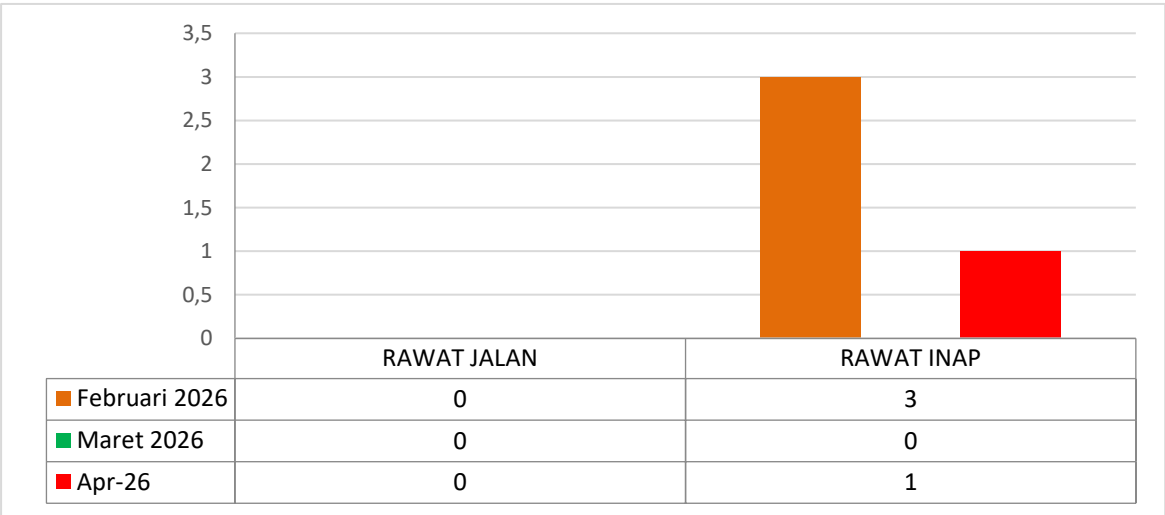
Rencana Tindak Lanjut :

Pasien-pasien dengan diagnose TB positif di Rumah Sakit Prima Husada Malang sudah patuh dilakukan screening pemeriksaan HIV/AIDS sesuai dengan SPO.
Diharapkan bisa saling kerjasama antar tim yaitu TIM TB dan Tim HIV.

3.7.23 Pelayanan Rujukan Pasien Dengan HIV/AIDS

No	URAIAN	BULAN		
		FEBRUARI 2026	MARET 2026	APRIL 2026
1	Rawat Jalan	0	0	0
2	Rawat Inap	3	0	1

Grafik Pelayanan Rujukan Pasien Dengan HIV/AIDS April 2026



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa Pada bulan Februari terdapat 3 pasien yang dirujuk dari rawat inap. pada bulan Maret 2026 tidak terdapat pasien yang dilakukan eujuk, baik dari rawat jalan maupun rawat inap. Sedangkan pada bulan April 2026 terapat 1 pasien yang dilakukan rujuk dari ICU isolasi
Pasien Dilakukan rujuk dikarenakan RS Prima husada malang belum bisa menangani

pasien yang ditemukan positif HIV .

Rencana Tindak Lanjut :

Pelaksanaan Rujukan dilakukan apabila hasil pemeriksaan HIV Reaktif. Rujukan dilakukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah bekerjasama dengan Rumah Sakit Prima Husada Malang.

3.1.2.4 Stunting & Wasting

1.1.2.4.1 Pelayanan Tim Penurunan Prevalensi Stunting dan Wasting

Tabel Pelayanan Tim Penurunan Prevalensi Stunting dan Wasting April 2026

NO	KEGIATAN POKOK	RINCIAN KEGIATAN
1	Peningkatan pemahaman dan kesadaran seluruh staf , pasien, dan keluarga tentang masalah stunting dan wasting	Melakukan promosi kesehatan dengan melaksanakan edukasi pasien dan sosialisasi kepada seluruh staff mengenai pentingnya pencegahan dan penanganan stunting dan wasting.
2	Program 1000 HPK	Pemberian Penyuluhan tentang pentingnya pengasuhan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) kepada pengunjung, pasien, dan keluarga pasien
3	Suplementasi Folat Pada Ibu hamil	Suplementasi Folat Pada ibu hamil dilaksanakan di poli kandungan di RS Prima Husada Malang
4	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada ibu hamil	Pemberian PMT pada ibu hamil dilaksanakan pada saat kegiatan senam hamil di RS Prima Husada Malang
5	Promosi dan konseling Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif	1. Kegiatan konseling IMD dilaksanakan sesaat setelah ibu melahirkan 2. Konseling IMD dan ASI eksklusif dilaksanakan pada saat ibu telah memasuki rawat inap maternitas 3. Penyuluhan tentang pentingnya IMD dan pemberian ASI eksklusif juga dilaksanakan di ruang tunggu poli anak dan poli kandungan
6	Pemantauan pertumbuhan (Pelayanan Tumbuh Kembang Bayi dan Balita)	Pemantauan pertumbuhan bayi dan balita dilaksanakan di ruang rawat inap dan melakukan pendampingan di poli anak RS prima husada
7	Pemberian imunisasi	Pemberian imunisasi dilaksanakan di poli anak RS prima husada malang sesuai dengan jadwal praktek dokter spesialis anak dan di rawat inap sesaat setelah bayi baru dilahirkan.
8	Pemberian Makanan Tambahan Balita Gizi Kurang	Pemberian makanan tambahan balita gizi kurang dilaksanakan apabila ditemui balita dengan gizi kurang di rawat inap
9	Penerapan Rumah Sakit sayang Ibu Bayi	1. Menyelenggarakan pelayanan konseling kesehatan maternal dan neonatal. 2. Konseling pemberian ASI eksklusif. 3. Penyediaan Pojok Laktasi untuk mendukung pemberian ASI eksklusif
10	Rumah Sakit sebagai pusat rujukan kasus stunting dan wasting	1. Penyusunan Pedoman Pencegahan dan Tata Laksana Gizi Stunting, Gizi Kurang, Gizi Buruk pada Balita 2. Memastikan kasus, penyebab dan tatalaksana lanjut oleh dokter spesialis anak. 3. Melakukan evaluasi pelayanan, audit kesakitan dan kematian, pencatatan dan pelaporan gizi buruk dan stunting.

11	Rumah Sakit sebagai pendamping klinis dan manajemen serta merupakan jejaring rujukan	Tidak terdapat kunjungan/ Pendampingan klinis kepada balita gizi kurang yang telah KRS dari RSPHM.
12	Program Pemantauan dan Evaluasi	Melakukan monitoring dan evaluasi terkait edukasi yang sudah diberikan, serta membuat laporan dan evaluasi kegiatan.

Analisis

- Melakukan tindakan pelayanan penurunan dan penanggulangan stunting dan wasting di Rumah Sakit.
- Melakukan edukasi mengenai pencegahan dan penanggulangan stunting dan wasting kepada pengunjung, pasien, dan keluarga pasien di rumah skait.

3.1.2.4.2 Kinerja Produktivitas
Tabel Peningkatan Efektifitas Intervensi Gizi Spesifik

Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Februari 2026	Maret 2026	April 2026
Program 1000 HPK	Penyuluhan mengenai 1000 hari pertama kehidupan	Pengunjung RS Prima Husada Malang	IRJA anak dan Kandungan	1x	1x	1x
Suplementasi Asam folat pada ibu hamil	1. Penyuluhan tentang pentingnya konsumsi asam folat pada ibu hamil	Ibu Hamil	Senam Hamil , Poli Kandungan, Hall gedung baru lantai 5	1x	1x	1x
	2. Pembagi an tablet tambah darah dan asam folat	Ibu Hamil	Poli kandungan	421 pasien	491 pasien	485 pasien
Pemberian PMT Ibu Hamil	1.Pemberian PMT pemulihan dengan tinggi kalori terutama pada ibu hamil terindikasi KEK	Ibu Hamil	Senam hamil	2x	2x	2x
	2.Pemberian PMT penyuluhan pada ibu hamil	Ibu Hamil	Senam hamil	1x	1x	1x
Promosi dan konseling Inisiasi Menyusu Dini	Penyuluhan mengenai pentingnya Inisiasi	Ibu hamil	IRJA anak dan kandu	96 pasien	105 pasien	108 pasien

(IMD) dan ASI eksklusif	Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif		ngan, irna matern itas			
Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA)	1. Penyuluhan tentang stunting, makanan sehat pada bayi dan balita	Pasien poli anak dan IRNA Anak	IRJA	2x	1x	1x
	2. Pemberian makanan Bayi dan Anak	Pasien IRNA Anak	IRNA	157 pasien	164 pasien	198 pasien
Pemantauan pertumbuhan (Pelayanan Tumbuh Kembang Bayi dan Balita)	Melakukan pencatatan dan pengukuran berat badan dan tinggi badan anak terdeteksi stunting/ wasting	Pasien IRNA Anak terdeteksi wasting/ stunting	IRJA anak	4	4	6
Pemberian Imunisasi	Memastikan ketersediaan imunisasi agar selalu tersedia di poli anak	Pasien anak dan Bayi baru lahir	IRJA anak	6 pasien	6 pasien	14 pasien
Pemberian vitamin A	Penyuluhan mengenai pentingnya pemberian vitamin A pada anak-anak	Pasien anak	IRJA anak	2x	2x	0x
Pemberian Makanan Tambahan Balita Gizi Kurang	Memberikan PMT tinggi kalori dengan membantu menyusun menu yang sesuai dengan ketersediaan bahan pangan di lingkungan	Pasien anak	Rawat Inap	5 pasien	5 pasien	pasien
Pemberian Taburia pada Baduta	Penyuluhan mengenai pemberian bubuk taburia	Pasien anak	Rawat Inap dan Rawat Jalan	1x	1x	0x
Pemberian Obat cacing	Penyuluhan mengenai	Ibu Hamil	Rawat Inap	1x	1x	0x

pada ibu hamil	pemberian obat cacing pada ibu hamil		dan Rawat Jalan			
----------------	--------------------------------------	--	-----------------	--	--	--

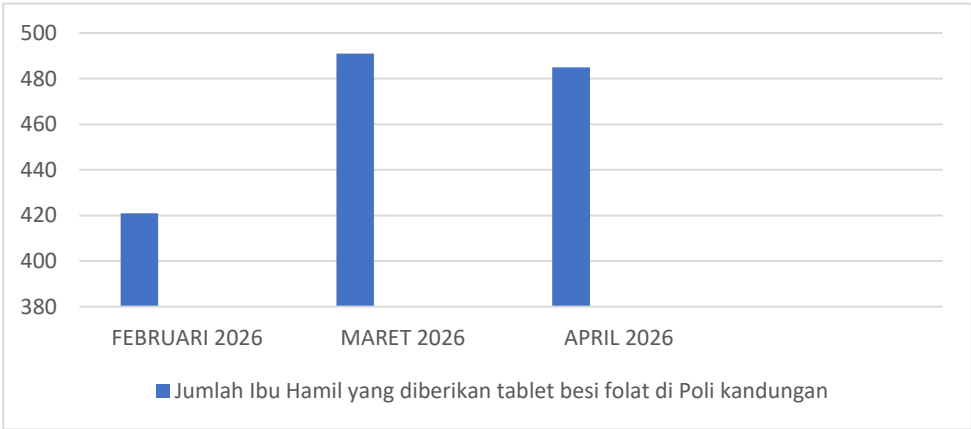
Analisis :
 Sebagian besar intervensi spesifik yang dapat dilaksanakan di rumah sakit telah dilaksanakan. Pemberian bubuk Taburia dan Mineral mix dilakukan pemberian kepada pasien apabila terdapat pasien rujukan dari puskesmas. Karena bubuk taburia dan mineral mix hanya terdapat di puskesmas, Rumah Sakit hanya memberikan dalam bentuk PMT penyuluhan.

Rencana Tindak Lanjut :
 Bekerjasama dengan puskesmas setempat agar dapat melakukan pendampingan intervensi spesifik di posyandu disekitar wilayah rumah sakit dan melakukan pemantauan kepada balita stunting.

3.1.2.4.3 Pemberian Tablet Besi Folat Bagi Ibu Hamil
Tabel Distribusi Tablet Besi Folat pada Ibu Hamil di RS Prima Husada Malang

BULAN	FEBRUARI 2026	MARET 2026	APRIL 2026
Jumlah Ibu Hamil yang diberikan tablet besi folat di Poli kandungan	421	491	485

Grafik Jumlah Pemberian Tablet Besi Folat Pada Ibu Hamil April 2026



Analisis :
 Pemberian asam folat diberikan kepada ibu hamil pada usia kandungan trimester pertama. Sedangkan pemberian tablet zat besi diberikan pada usia kandungan trimester 2 dan 3. Jumlah pemberian tablet besi folat turun dari sebelumnya 491 di bulan Maret menjadi 485 pada bulan April yang mendapat tablet besi folat untuk ibu hamil.

Rencana Tindak Lanjut:

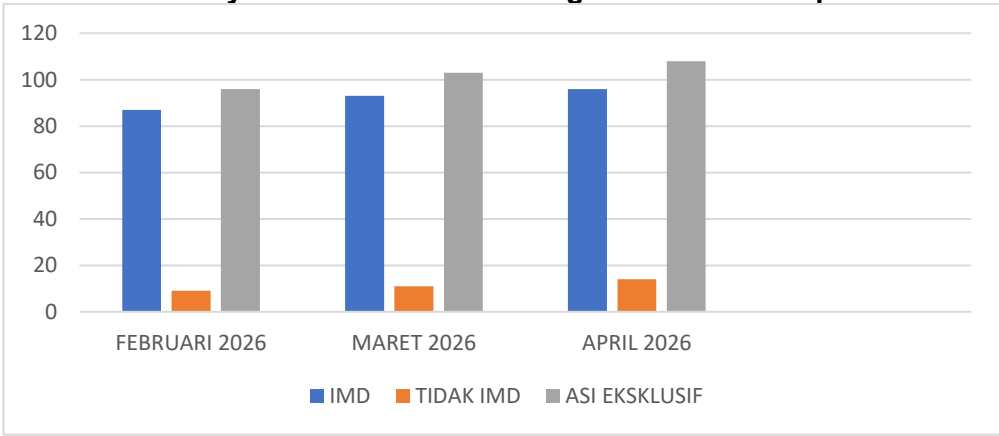
1. Koordinasi dengan tim farmasi untuk mendukung penyediaan tablet tambah darah, agar program suplementasi tablet tambah darah kepada ibu hamil terus berlanjut
2. Koordinasi dengan tim humas rumah sakit agar ibu hamil yang bergabung semakin banyak agar program suplementasi tablet besi folat semakin baik.

3.1.2.4.4 Jumlah Ibu Melahirkan yang Mendapat Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif

Tabel Jumlah Ibu Melahirkan yang Mendapat Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN FEBRUARI 2026	BULAN MARET 2026	BULAN APRIL 2026
1	IMD	87	93	96
2	Tidak IMD	9	11	14
3	Mendapat Konseling ASI Eksklusif	96	103	108

Grafik Pelayanan IMD dan Konseling ASI Eksklusif April 2026



Analisis :

- 1. Bayi yang dilakukan IMD pada bulan April sebanyak 96 bayi.
- 2. Kasus tidak dilakukan IMD pada bulan April 2026 meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 14 bayi. Hal ini terjadi diiringi dengan penurunan jumlah pasien
- 3. Pada bayi yang tidak dilakukan IMD memang tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan IMD dikarenakan BBLR yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
- 4. 100% ibu melahirkan telah mendapatkan edukasi menyusui. Untuk mendukung pemberian ASI secara eksklusif. Jumlah Ibu mendapat konseling ASI Eksklusif meningkat pada bulan April 2026 yaitu sebanyak 108 pasien.

Rencana Tindak Lanjut:

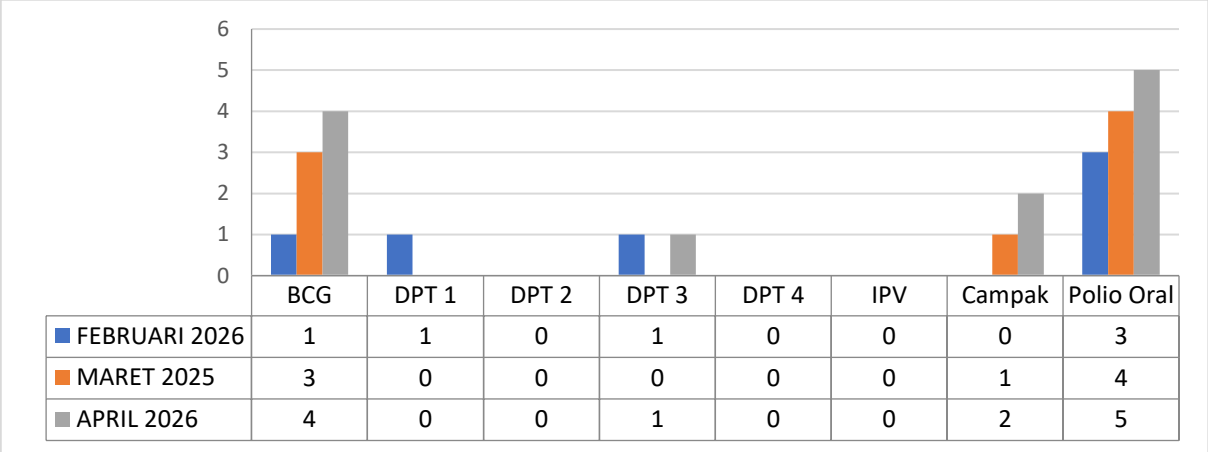
Tingkatkan koordinasi dengan dokter kandungan dan bidan rumah sakit dalam pemberian edukasi tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif serta mendokumentasikan bukti telah melakukan edukasi kepada ibu melahirkan pada lembar edukasi.

3.1.2.4.5 Jumlah Balita yang Mendapat Imunisasi

Tabel Jumlah Balita yang Mendapat Imunisasi

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		BULAN FEBRUARI 2026	BULAN MARET 2026	BULAN APRIL 2026
1	BCG	1	3	4
2	DPT 1	1	0	0
3	DPT 2	0	0	0
4	DPT 3	1	0	1
5	DPT 4	0	0	0
5	IPV	0	0	0
6	Campak	0	1	2
7	Polio Oral	3	4	5

Grafik Pelayanan Imunisasi di Rumah Sakit Prima Husada April 2026



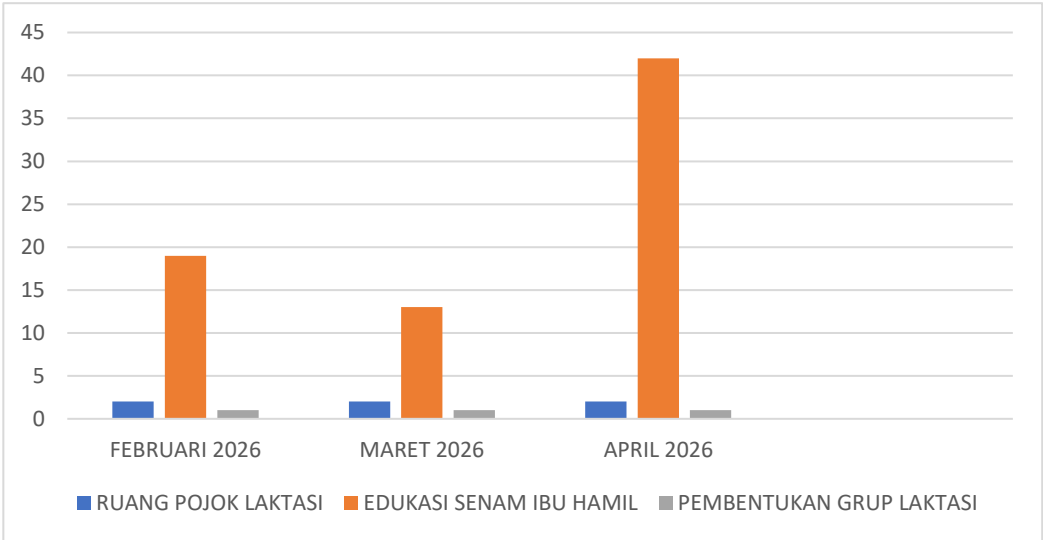
- Analisis:**
- 1. Pada bulan April sebanyak 4 balita melakukan imunisasi BCG.
 - 2. Sebanyak 1 balita melakukan imunisasi DPT 3 di Prima Husada Malang pada bulan April.
 - 3. Pada bulan April tidak ada yang melakukan imunisasi DPT 1, DPT 2, DPT IV, dan IPV.
 - 4. Terdapat 1 pasien PCV dan Rota pada bulan April 2026.

Rencana Tindak Lanjut :
Melakukan promosi terkait pelayanan imunisasi, baik oleh bidan maupun dokter spesialis rumah sakit. Bekerjasama dengan pihak puskesmas untuk keersediaan vaksin di RS.

3.1.2.4.6 Penerapan Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi
Tabel Penerapan Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi

KEGIATAN PENERAPAN RUMAH SAKIT SAYANG IBU DAN BAYI	FEBRUARI 2026	MARET 2026	APRIL 2026
Ruang Pojok Laktasi	2	2	2
Senam Hamil	19	13	42
Pembentukan Grup Laktasi	1	1	1

Grafik Senam Hamil di Rumah Sakit Prima Husada April 2026



Analisis :

- 1. Pojok laktasi sudah tersedia untuk ibu dan bayi yang akan menyusui di wilayah Rumah Sakit Prima Husada Malang sebanyak 2 ruangan, di lantai 1 dan di lantai 2.
- 2. Grup Laktasi dibentuk untuk memberikan tips menyusui.
- 3. Pada bulan Februari edukasi pada ibu hamil dilakukan dengan memberikan penyuluhan 1000 HPK dan KEK pada Ibu Hamil sebanyak 42 peserta, penyuluhan dilakukan di senam hamil.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Mengajukan perlengkapan untuk keperluan menyediakan pojok laktasi yang nyaman bagi bayi, balita, dan ibu menyusui seperti pampers dan tissue basah jika terdapat pasien atau pengunjung yang membutuhkan.
- 2. Melakukan edukasi mengenai pentingnya mengikuti senam ibu hamil pada ibu hamil yang tidak memiliki kondisi penyulit saat hamil.

3.1.2.4.7 Pelayanan Jejaring Rujukan Kasus Stunting Dan Wasting
Tabel Penerapan Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi

Rujukan Masuk				
Bulan	Nama PX	Usia	Diagnosa	Asal Rujukan
Februari	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-
April	-	-	-	-
Rujukan Keluar				
Bulan	Nama PX	Usia	Diagnosa	Tujuan Rujukan
Februari	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-
April	-	-	-	-

Grafik Pelayanan Jejaring Rujukan Kasus Stunting dan Wasting Bulan April 2026



Analisis :

Tidak Terdapat pasien stunting atau wasting yang dirujuk keluar RS maupun rujuk masuk RS pada bulan April

Rencana Tindak Lanjut:

Perlu diadakan kerjasama lagi dengan puskesmas dan klinik faskes pertama untuk bekerjasama dalam menjangkir pasien stunting dan wasting.

3.1.2.4.8 Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis Dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan

Tabel Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis Dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan

BULAN	FEBRUARI 2026	MARET 2026	APRIL 2026
Jumlah Pasien Stunting	4	2	6
Jumlah Pasien Wasting	2	3	6

Grafik Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan



Analisis :

Pada bulan April 2026 ditemukan sebanyak 6 balita berat badan kurang dengan stunting. Permasalahan yang ditemukan rata-rata balita kurang bervariasi dalam pola makannya, dan porsi makan tidak adekuat namun balita aktif. Selain itu, terdapat balita yang sakit dalam kurun waktu lama sehingga mengalami BB turun

Pemberian makanan tinggi energi dan tinggi protein di rumah sakit. Edukasi terhadap orang tua bagaimana dalam memberikan makanan gizi seimbang sesuai usia. Dan kolaborasi terhadap Ahli Gizi dan DPJP terus dilakukan

Rencana Tindak Lanjut :

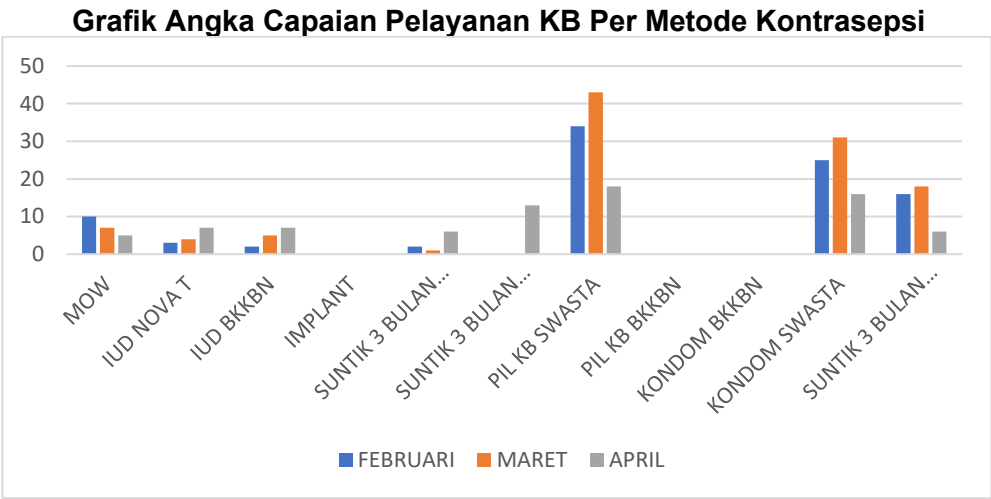
Tim Stunting dan Wasting RS Prima Husada lebih gencar dalam melakukan pengukuran dan pelaporan pasien anak baik di rawat inap maupun rawat jalan. Penginputan pasien stunting dan wasting di aplikasi eppgbm. Pemberian diet Tinggi Kalori dan Tinggi Protein (TKTP). Kolaborasi antar ahli gizi, DPJP, serta Ahli gizi puskesmas balita.

3.1.2.5 KBRs

3.7.24 Angka Capaian Pelayanan KB per Metode Kontrasepsi

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Pasien			Target sasaran per metode kontrasepsi dalam satu tahun
		Bulan Februari 2026	Bulan Maret 2026	Bulan April 2026	
1	MOW	10	7	5	26
2	IUD Nova T	3	4	7	49
3	IUD BKKBN	2	5	7	
4	IMPLANT	0	0	0	111
5	SUNTIK 3	2	1	6	

	BULAN KOMBINASI				
6	SUNTIK 3 BULAN PROGESTIN BKKBN	0	0	13	187
7	SUNTIK 3 BULAN PROGESTIN SWASTA	16	18	6	
8	PIL KB BKKBN	0	0	0	135
9	PIL KB SWASTA	34	43	18	
10	KONDOM BKKBN	0	0	0	30
11	KONDOM SWASTA	25	31	16	



Evaluasi :

1. Peserta MOW pada bulan Februari naik (10) Maret turun (7) April turun (5)
2. Peserta IUD Nova T pada bulan Februari turun (3) Maret naik (4) April naik (7)
3. Peserta IUD BKKBN pada bulan Februari turun (2) Maret naik (5) April naik (7)
4. Peserta KB suntik 3 bulan kombinasi, pada bulan Februari naik (2) Maret turun(1) April naik (6)
5. Peserta KB suntik progestin bkkbn pada bulan Februari turun (0) Maret tetap (0) April naik (13)
6. Karena stok suntik 3 bulan progestin BKKBN kosong,maka Peserta KB menggunakan Suntik 3 bulan progestin swasta Februari sebanyak (16) Maret Naik (18) April turun (6)
7. Peserta KB pil kombinasi karena stok habis pada bulan Februari (0) Maret (0) karena barang masing kosong dari BKKBN,April tetap (0)
8. Karena stok pil kombinasi BKKBN kosong,Maka peserta KB menggunakan pil kombinasi swasta Februari (34) dan Maret (43) peserta April turun (18)
9. Peserta KB Kondom BKKBN pada bulan karena stok habis Februari t (0) Maret (0) April karena kosong dari BKKBN
10. Peserta KB Kondom swasta Januari (27) dan februari sebanyak (25) Maret naik (31) April (16) disediakan karena stok kondom dari BKKBN kosong

Analisis :

1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien poli obgyn dan poli KB salah satunya dengan mengadakan promosi lewat sosial media.
2. Melakukan edukasi tentang pentingnya KB pada pasangan usia subur dengan rutin melakukan penyuluhan.
3. Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 poli kandungan tentang pentingnya KB lewat penyuluhan.
4. Melakukan edukasi individu kepada pasien bersalin tentang pentingnya KB

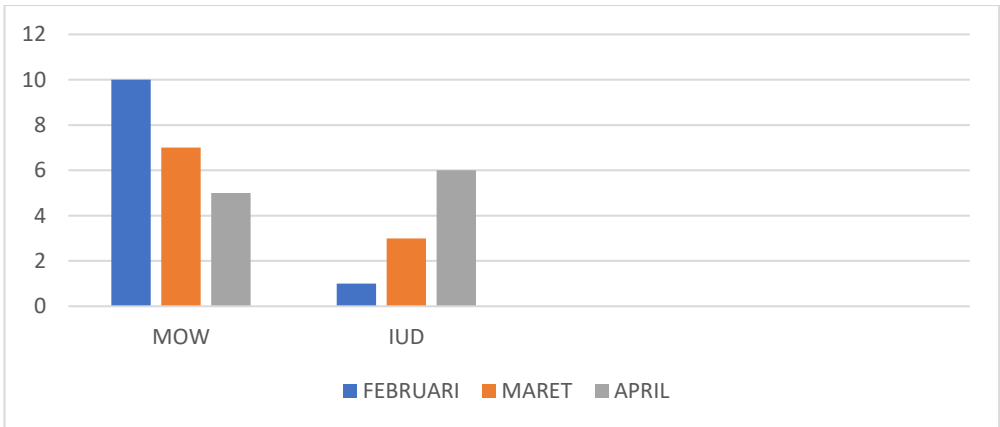
Rencana Tindak Lanjut :

Demi meningkatkan capaian KB maka rumah sakit akan melakukan pelatihan internal bagi para bidan dalam pemasangan IUD,Implan serta pemasangan IUD pasca plasenta,dan diadakan Pelayanan KB oleh bidan setiap hari Senin-Jumat

Angka Capaian Pelayanan KB Pasca Persalinan Dan Pasca Persalinan

No	Jenis Pelayanan pasca persalinan	Jumlah Pasien KB Bulan Februari 2026	Jumlah pasien bersalin bulan Februari 2026	Jumlah Pasien KB Bulan Maret 2026	Jumlah pasien bersalin bulan Maret 2026	Jumlah Pasien KB Bulan April 2026	Jumlah pasien bersalin bulan April 2026
1	MOW	10	103	7	93	5	101
2	IUD	1	103	3	93	6	101

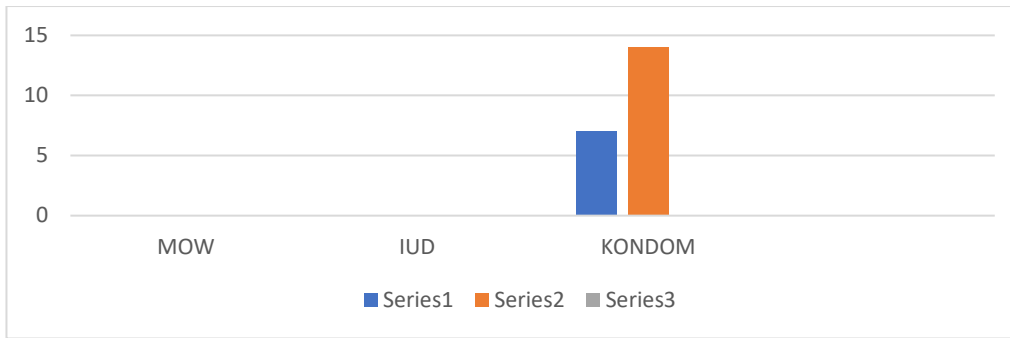
Grafik Angka Capaian Pelayanan KB Pasca Persalinan



Angka Capaian Pelayanan KB Pasca Persalinan Dan Pasca Keguguran

No	Jenis Pelayanan pasca keguguran	Jumlah Pasien kb Bulan Februari 2026	Jumlah pasien abortus Bulan Februari 2026	Jumlah Pasien kb Bulan Maret 2026	Jumlah pasien abortus Bulan Maret 2026	Jumlah Pasien kb Bulan April 2026	Jumlah pasien abortus Bulan April 2026
1	MOW	0	7	0	14	0	12
2	IUD	0		0		0	
3	KONDOM	7		14		12	

Grafik Angka Capaian Pelayan KB Pasca Keguguran



Evaluasi :

1. Angka capaian pelayanan KB pasca persalinan pada bulan Februari-Maret-April meningkat tapi belum memenuhi target dengan alasan pasien ingin segera hamil lagi dan pasien ingin berKB difaskes satu yang gratis
2. Angka capaian pelayanan KB pasca keguguran pada bulan Februari-Maret-April menetap tapi belum memenuhi target dengan alasan pasien ingin segera hamil lagi dan pasien ingin berKB difaskes satu yang gratis

Analisis :

1. Peningkatan jumlah sasaran pada triwulan pertama kemungkinan didapatkan karena sasaran KB sudah mengetahui pentingnya KB dari pengetahuan yang didapatkan saat sosialisasi yang dilakukan tim setiap bulannya.
2. Capaian pelayanan KB pasca keguguran menetap dikarenakan peserta mempunyai alasan ingin segera hamil lagi dan pasien ingin berKB difaskes satu yang gratis

Rencana dan Tindak Lanjut :

1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien poli obgyn salah satunya dengan mengadakan promosi lewat sosial media.
2. Melakukan edukasi tentang pentingnya KB pada pasangan usia subur dengan rutin melakukan penyuluhan.
3. Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 poli kandungan tentang pentingnya KB lewat penyuluhan.
4. Melakukan edukasi individu kepada pasien bersalin diruang maternitas tentang pentingnya berKB

3.2.3 Tim PPRA

3.2.3.1 Audit Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif Triwulan 2026

3.2.3.1.1 Tabel Data Primer Audit Penggunaan Antibiotik Secara Kuantitatif Bulan Februari 2026

No.	Nama	Jenis Kelamin /umur	Dokter	No. RM	Diagnosis KRS	Tgl MRS	Tgl KRS	LOS (Hari)	Antibiotik	Jumlah Antibiotik	Dosis (gram)	Total Dosis (gram)	ATC	DDD
1	Emilda	P/32	dr. Humaira, Sp.OG	059432	Post SC + BSC	01/02/2026	04/02/2026	4	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1	2	0,5
2	Siskamarini	P/49	dr. Humaira, Sp.OG	231628	Post Op Histerektomi	02/02/2026	05/02/2026	4	Ceftriaxone	2	1x2	2	2	1
									Cefadroxile		2x0,5	1	2	0,5
3	Adinda Eka P	P/21	dr. Humaira, Sp. OG	242643	Post Partum	03/02/2026	04/02/2026	2	Amoxicillin	1	3x0,5	1,5	1,5	1
4	Rusyana	P/29	dr. Aida, Sp.OG	243328	Post SC + KPD	07/02/2026	09/02/2026	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1,5	2	0,75
5	Nike Ayu K	P/27	dr. Humaira, Sp.OG	087345	Post SC + BSC	11/02/2026	14/02/2026	4	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1,5	2	0,75
6	Dwi Aryani	P/24	dr. Humaira, Sp.OG	245241	Post SC + Oligohidramnion	16/02/2026	18/02/2026	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1	2	0,5
7	Rizky Amalia	P/28	dr. Humaira, Sp.OG	238182	Gravida SC	20/02/2026	22/02/2026	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1	2	0,5
8	Sri Indah	P/54	dr. Aida, Sp. OG	245507	Anemia Gravis + Hiperplasia Endometrium	20/02/2026	22/02/2026	3	Ceftriaxone	1	2x1	4	2	2
9	Dewi Mardiyah	P/28	dr. Humaira, Sp.OG	244121	Post SC + Gemeli + Oligohidramnion	25/02/2026	27/02/2026	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1	2	0,5
10	Diniah C	P/26	dr. Aida, Sp. OG	206748	Post Partum	27/02/2026	28/02/2026	2	Amoxicillin	1	3x0,5	1,5	1,5	1
11		L/37	dr. Oka,Sp.OT.	124077		31/01/2026	02/02/2026	3	Cefazolin	2	1x2	2	3	0,67

	Sujarwoto Winarno				Open wound of wrist and hand part, parts unspecified				Cefazolin		2x1	2	3	0,67
12	Safi'i	L/34	dr. Oka, Sp.OT.	244284	Spontaneous rupture of extensor tendons hand	31/01/2026	02/02/2026	3	Cefazolin	2	1x2	2	3	0,67
									Cefazolin		2x1	2	3	0,67
13	Panca Widya	P/56	dr. Oka, Sp.OT.	232628	Removal of fracture plate and other internal fixation device	06/02/2026	08/02/2026	3	Cefazolin	2	1x2	2	3	0,67
									Cefazolin		2x1	2	3	0,67
14	Mochammad Hendra	L/24	dr. Arianto, Sp.OT.	242844	Fracture of other toe, pro remove implant	09/02/2026	11/02/2026	3	Ceftizoxime	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftizoxime		2x1	2	4	0,5
15	Dewi Kuswatun	P/50	dr. Anton, Sp.B.	176310	Benign lipomatous neoplasm of skin and subcutaneous tissue of limbs	10/02/2026	12/02/2026	3	Ceftizoxime	3	1x1	1	4	0,25
									Ceftizoxime		1x1	1	4	0,25
									Cefixime		2x0,1	0,4	0,4	1
16	Muhamad Setiyo	P/31	dr. Andi, Sp.B.	244833	Epidermal cyst	11/02/2026	13/02/2026	3	Ceftriaxone	1	1x1	1	2	0,5
17	Arya Abhiseka	L/17	dr. Anton, Sp.B.	080429	Necrotizing fascitis, ankle and foot	14/02/2026	16/02/2026	3	Picyn	3	1x1,5	1,5	6	0,25
									Picyn		3x1,5	4,5	6	0,75
									Metronidazole (PO)		3x0,25	1,25	2	0,63
18	Sakur	L/59	dr. Kuntadi, Sp.OT.	245210	Traumatic amputation of two or more fingers alone (complete)(partial)	15/02/2026	17/02/2026	3	Ceftriaxone	1	2x1	6	2	3
19	Wagini	P/53	dr. Anton, Sp.B.	088067	Necrotizing fascitis, lower leg	16/02/2026	18/02/2026	3	Picyn	3	1x1,5	1,5	6	0,25
									Picyn		3x1,5	7,5	6	1,25
									Metronidazole (PO)		3x0,25	1,5	2	0,75
20	Ria Rovita	P/23	dr. Oka, Sp.OT.	153823	Fracture of clavicle, closed	21/02/2026	23/02/2026	3	Cefazolin	2	1x2	2	3	0,67
									Cefazolin		2x1	2	3	0,67
21	Wartoyo	L/59	dr. Ardhan, Sp. Pd	025367	TF	05/02/2026	08/02/2026	4	Ceftriaxone	1	2x1	6	2	3
22	Meiyasa A	P/34	dr. Ardhi, Sp. Pd	240288	DF	08/02/2026	11/02/2026	4	Ciprofloxacin	1	2x0,5	3	1	3
23	Rosmawarni	P/51	dr. Heri, Sp. Pd	037536	Nefrolitiasis	08/02/2026	11/02/2026	4	Ceftriaxone	2	2x1	5	2	2,5
									Asam Pipemidat		2x0,4	2,8	0,8	3,5

24	Gloriyan R	L/33	dr. Aji, Sp. Pd	086157	Cholelithiasis	09/02/2026	13/02/2026	5	Cefotaxime	1	3x1	11	2	5,5
25	Hawa Miftakhul	P/30	dr. Elvi, Sp. P	240342	Asma	10/02/2026	12/02/2026	3	Ceftriaxone	1	2x1	5	2	2,5
26	Wijiono	L/54	Dr. Ardhi, Sp. Pd	245087	DM + CKD	14/02/2026	16/02/2026	3	Asam Pipemidat	1	2x0,4	0,8	0,8	1
27	Sumpah Kasiani	P/68	Dr. Andy, Sp. P	132666	COPD AE	14/02/2026	17/02/2026	4	Ceftriaxone	1	2x1	5	2	2,5
28	Abd. Khojin	L/62	dr. Andy, Sp. P	245187	Pneumoni	15/02/2026	17/02/2026	3	Ceftriaxone	1	2x1	5	2	2,5
29	Lutfazad	L/46	dr. Zora, Sp. Pd	202085	Pneumonia	15/02/2026	19/02/2026	5	Ceftriaxone	2	2x1	8	2	4
									Azitromycin		1x0,5	1,5	0,3	5
30	Eddy Kartono	L/71	dr. Farid, Sp. N	073755	Susp massa cerebellum + susp pneumonia	19/02/2026	26/02/2026	8	Cefoperazone	1	2x1	5	4	1,25

3.2.3.1.2 Tabel Data Primer Audit Penggunaan Antibiotik Secara Kuantitatif Bulan Maret 2026

No.	Nama	Jenis Kelamin /umur	Dokter	No. RM	Diagnosis KRS	Tgl MRS	Tgl KRS	LOS (Hari)	Antibiotik	Jumlah Antibiotik	Dosis (gram)	Total Dosis (gram)	ATC	DDD
1	Dian Kodrat	P/31	dr. Aida, Sp.OG	142487	Mio – adenomyoma	01/03/2026	04/03/2026	4	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
2	Silva Yuli	P/31	dr. Aida, Sp.OG	177196	Post SC + BSC	02/03/2026	04/03/2026	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1	2	0,75
3	Ayu Fidya	P/25	dr. Humaira, Sp.OG	224081	Gravida SC	14/03/2026	16/03/2026	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1,5	2	0,75
4	Puput Murniati	P/28	dr. Humaira, Sp.OG	246431	Post Curetage + Misseda Abortion	16/03/2026	17/03/2026	2	Ceftriaxone	2	1x1	1	2	0,5
									Amoxicillin		3x0,5	1	1,5	0,67
5	Uswatun Chasanah	P/35	dr. Humaira, Sp.OG	176626	Post SC + Plasenta Previa	16/03/2026	18/03/2026	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1	2	0,5
6	Aristianti A	P/30	dr. Aida, Sp.OG	240863	Post SC + KPD	16/03/2026	18/03/2026	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1	2	0,5
7	Irma Setyowati	P/22	dr. Aida, Sp.OG	246537	Post SC + KPD	18/03/2026	20/03/2026	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67

									Cefadroxile		2x0,5	1,5	2	0,75
8	Laili Nisfi	P/30	dr. Humaira, Sp.OG	223910	Post SC + Oligohidramnion	25/03/2026	27/03/2026	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1	2	0,5
9	Sunarti	P/40	dr. Humaira, Sp.OG	239363	Post Curetage Menometroragia	30/03/2026	31/03/2026	2	Ceftriaxone	2	1x1	1	2	0,5
									Amoxicillin		3x0,5	1,5	1,5	1
10	Lia Setianingrum	P/32	dr. Humaira, Sp. OG	113940	Post Partum	30/03/2026	31/03/2026	2	Amoxicillin	1	3x0,5	1,5	1,5	1
11	Budi Winarto	L/60	dr. Arianto,Sp.OT.	075676	Cruss injury manus (S) digiti 1	05/03/2026	07/03/2026	3	Ceftriaxone	2	1x1	1	2	0,2
									Ceftriaxone		2x1	2	2	1
12	Supingah	P/57	dr. Andi, Sp.B	246148	Peritonitis generalisata ec appendicitis perforasi	09/03/2026	11/03/2026	3	Ceftriaxone	1	1x2	2	2	2
13	Suriadi	L/51	dr. Pradana, Sp. U	229693	BPH	10/03/2026	12/03/2026	3	Ceftizoxime	1	1x2	2	4	0,5
14	Ahmad Taufiq	L/24	dr. Oka,Sp.OT.	246282	Partial ruptur tendon extensor	12/03/2026	14/03/2026	3	Cefazolin	2	1x2	2	3	0,67
									Cefazolin		2x1	2	3	0,67
15	Dani Abednego	L/21	dr. Oka,Sp.OT.	229394	Union radius fracture of lower end of radius	13/03/2026	15/03/2026	3	Cefazolin	2	1x2	2	3	0,67
									Cefazolin		2x1	2	3	0,67
16	Andry Muji A	L/44	Dr. Edi, Sp. U	110993	Batu Ureter	16/03/2026	18/03/2026	3	Ceftizoxime	1	1x2	2	4	0,5
17	Ediyanto	L/48	dr. Oka,Sp.OT.	192204	Ruptur quadriceps tendon	23/03/2026	25/03/2026	3	Cefazolin	2	1x2	2	3	0,67
									Cefazolin		2x1	2	3	0,67
18	Suparti	P/63	dr. Anton,Sp.B.	061659	Necrotizing fascitis S + DM Hiperglikemi	25/03/2026	27/03/2026	3	Picyn	3	1x1,5	1,5	6	0,25
									Picyn		3x1,5	4,5	6	0,75
									Metronidazole (PO)		3x0,25	1,25	2	0,63
19	Wiyung Krisbantoro	L/26	dr. Oka,Sp.OT.	230940	Traumatic amputation manus	27/03/2026	28/03/2026	2	Cefazolin	2	1x2	2	3	0,67
									Cefazolin		2x1	2	3	0,67
20	Sungkono	L/44	dr. Fachriy,Sp.BS.	246913	Multiple open wound parietal	28/03/2026	30/03/2026	3	Ceftriaxone	2	1x2	2	2	1
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
21	Moeljadi	L/86	dr. Andy, Sp. P	146401	Pneumonia + Takikardi + Sepsis	02/03/2026	05/03/2026	4	Meropenem	1	2x1	6	3	2
22	Atim	P/89	dr. Miryanti, Sp. JP	245949	HF + ISK	03/03/2026	05/03/2026	5	Ceftriaxone	1	2x1	4	2	2

23	Jamiah	P/59	dr. Zora, Sp. Pd	229778	DM Hiperglikemi + UTI	04/03/2026	07/03/2026	4	Ciprofloxacin	1	2x0,5	2,5	1	2,5
24	Djoko Utomo	L/53	dr. Ardhi, Sp.Pd	037689	Selulitis regio cruris dextra et sinistra	08/03/2026	11/03/2026	4	Ceftriaxone	2	2x1	6	2	3
									Levofloxacin PO		1x0,5	1,5	0,8	3,5
25	Kasan	L/77	dr. Farid, Sp.N	240824	CVA Infark + Parkinson'S Disease + Pneumonia	10/03/2026	12/03/2026	4	Ceftriaxone	2	2x1	2	2	1
									Azitromycin		1x0,5	1,5	0,3	5
26	Suyono	L/56	dr. Ardhan, Sp.Pd	218744	Fatty liver + Nephrolithiasis	10/03/2026	13/03/2026	4	Ceftriaxone	2	2x1	5	2	2,5
									Asam Pipemidat		2x0,4	1,6	0,8	2
27	Mujiono	L/58	dr. Heri, Sp. Pd	208041	DM Type 2 + Cystitis	12/03/2026	15/03/2026	4	Asam Pipemidat	1	2x0,4	1,6	0,8	2
28	Kastomo	L/70	dr. Andy, Sp. P	065312	COPD eksaserbasim akut + AF	17/03/2026	19/03/2026	3	Ceftriaxone	1	2x1	5	2	2,5
29	Farhan B	L/23	dr. Ardhi, Sp. Pd	105814	GEA + Diarrhea	23/03/2026	26/02/2026	4	Ciprofloxacin	1	2x0,5	3	1	3
30	Buari	L/73	dr. Elvi, Sp. P	246785	COPD AE	25/03/2026	27/03/2026	3	Ceftriaxone	1	2x1	5	2	2,5

3.2.3.1.3 Tabel Data Primer Audit Penggunaan Antibiotik Secara Kuantitatif Bulan April 2026

No.	Nama	Jenis Kelamin /umur	Dokter	No. RM	Diagnosis KRS	Tgl MRS	Tgl KRS	LOS (Hari)	Antibiotik	Jumlah Antibiotik	Dosis (gram)	Total Dosis (gram)	ATC	DDD
1	Dita Andriyani	P/33	dr. Aida, Sp. OG	231521	Multiple mioma uteri	31/03/2026	03/04/2026	4	Cefazoline	1	1x2	2	3	0,67
2	Qurotu Ngainina	P/18	dr. Aida, Sp. OG	246780	Colic abdomen ec ovrial cyst	01/04/2026	02/04/2026	2	Ceftriaxone	1	2x1	3	2	1,5
3	Dian Astutik	P/26	dr. Humaira, Sp. OG	008496	Gravida SC	01/04/2026	03/04/2026	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1,5	2	0,75
4	Fanny Kartika	P/35	dr. Aida, Sp. OG	132363	Post SC + BSC	02/04/2026	04/04/2026	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1,5	2	0,75

5	Poppy Annisa	P/32	dr. Humaira, Sp. OG	214099	Abortus incomplete post curet	10/04/2026	11/04/2026	2	Ceftriaxone	2	1x1	1	2	0,5
									Cefadroxile		2x0,5	1	2	0,5
6	Sufiati Ulfa	P/32	dr. Humaira, Sp. OG	073950	Gravida partus normal + post curetage	11/04/2026	12/04/2026	2	Ceftriaxone	2	1x1	1	2	0,5
									Cefadroxile		2x0,5	1	2	0,5
7	Siti Lutfiah	P/21	dr. Humaira, Sp. OG	236450	Post SC + KPD	14/04/2026	16/04/2026	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1,5	2	0,75
8	Siti Arba'yah	P/33	dr. Aida, Sp. OG	127022	Post Partum Normal	19/04/2026	20/04/2026	2	Amoxicillin	1	3x0,5	1,5	1,5	1
9	Richa Damayanti	P/320	dr. Humaira, Sp. OG	199190	Post Curetage + Misseda Abortion	22/04/2026	23/04/2026	2	Ceftriaxone	2	1x1	1	2	0,5
									Amoxicillin		3x0,5	1	1,5	0,67
10	Qurrotul Aini	P/32	dr. Humaira, Sp. OG	130109	Post Curetage + Misseda Abortion	26/04/2026	27/04/2026	2	Ceftriaxone	2	1x1	1	2	0,5
									Amoxicillin		3x0,5	1	1,5	0,67
11	Dendy hutama	L/32	dr. Oka, Sp. OT.	226731	Union Humerus Proximal Dextra	10/04/2026	12/04/2026	3	Cefazolin	2	1x2	2	3	0,67
									Cefazolin		2x1	2	3	0,67
12	Ferry K	L/45	dr. Oka, Sp. OT.	247577	Finger tip injury digiti 4 manus dextra	10/04/2026	12/04/2026	3	Cefazolin	2	2x1	6	3	2
13	Hadi kurniawan	L/42	dr. Pradana, Sp. U.	073780	Bt Ureter D	10/04/2026	12/04/2026	3	Ceftizoxime	1	1x2	2	4	0,5
14	Wahyu nanang	L/32	dr. Oka, Sp. OT.	247653	Crush injury dengan bone expose digit 4 pedis dextra	12/04/2026	13/04/2026	2	Cefazolin	2	1x2	2	3	0,67
									Cefazolin		2x1	1	3	0,33
15	Hartono	L/64	dr. Pradana, Sp. U.	157710	BPH	14/04/2026	16/04/2026	3	Ceftizoxime	1	1x2	2	4	0,5
16	Farida Maimunah	P/652	dr. Anton, Sp. B.	151192	Necrotizing fascitis pedis dextra	17/04/2026	19/04/2026	3	Picyn	3	1x1,5	1,5	6	0,25
									Picyn		3x1,5	4,5	6	0,75
									Metronidazole (PO)		3x0,25	1,25	2	0,63
17	Sumarmi	P/76	dr. Oka, Sp. OT.	011074	Fracture Humerus	18/04/2026	20/04/2026	3	Cefazolin	2	1x2	2	3	0,67
									Cefazolin		2x1	2	3	0,67
18	Suparman	L/75	dr. Edi, Sp. OT.	181099	BPH	20/04/2026	22/04/2026	3	Ceftizoxime	1	1x2	2	4	0,5
19	Supardi	P/54	dr. Oka, Sp. OT.	141301	Finger tip injury digiti 3 manus dextra	25/04/2026	26/04/2026	2	Cefazolin	2	2x1	2	3	0,67
20	Rosyidatul M	P/28	dr. Anton, Sp. B	144748	Appendicitis acute	28/04/2026	30/04/2026	3	Picyn	2	1x1,5	1,5	6	0,25

									Picyn		3x1,5	3	6	0,5
21	Nabila Aprilia	P/18	dr. Ard hany, Sp. Pd	234237	Nephrolithiasis	01/04/2026	03/04/2026	3	Asam pipemidat	1	2x0,4	3,2	0,8	4
22	Ahlul Fadli	L/45	dr. Ardhi, Sp. Pd	247243	Chronic diare + Anemia	03/04/2026	05/04/2026	3	Ciprofloxac in po	1	2x0,5	1,5	1	1,5
23	Ahlul Fadl	L/45	dr. Elvi, Sp. P	050074	COPD AE	03/04/2026	05/04/2026	3	Ceftriaxone	1	2x1	6	2	3
24	Okta Mili ani		dr. Zora, Sp. Pd	247272	GEA dehidras sedang diare	04/04/2026	06/04/2026	3	Ciprofloxac in po	1	2x0,5	2	1	2
25	Hartawan Hari	L/45	dr. Heri, Sp. Pd	247408	DF	07/04/2026	09/04/2026	3	Cefixime	1	2x0,1	0,5	0,4	1,25
26	Mualifin	L/58	dr. Mira, Sp. JP	247502	Chest Pain unspecified	09/04/2026	11/04/2026	3	Ceftriaxone	1	2x1	5	2	2,5
27	Sulastri	P/61	dr. Andy, Sp. P	056285	Pneumonia + CVA	14/04/2026	16/04/2026	3	Ceftriaxone	1	2x1	5	2	2,5
28	R. Noeriwan	L/53	Dr. Zora, Sp. Pd	245787	GEA + Vomiting	18/04/2026	20/04/2026	3	Ciprofoloxacin po	1	2x0,5	3	1	3
29	Sutrisnowati	P/31	dr. Ardhi, Sp. Pd	248189	Cholelithiasis	21/04/2026	23/04/2026	3	Ceftriaxone	1	2x1	7	2	3,5
30	Supadmi	P/71	dr. Andy, Sp. P	248372	Pneumonia psi 91 + COPD AE	25/04/2026	28/04/2026	4	Ceftriaxone	1	2x1	6	2	3

3.6.6 Tim Review RM (E-RM)-IT

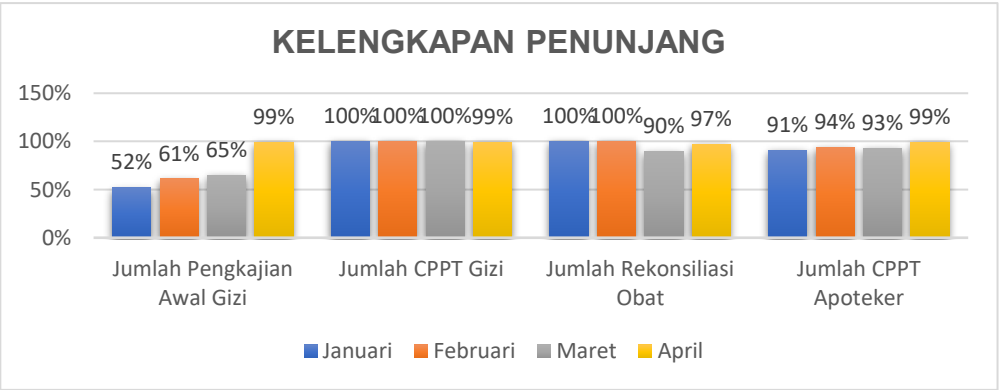
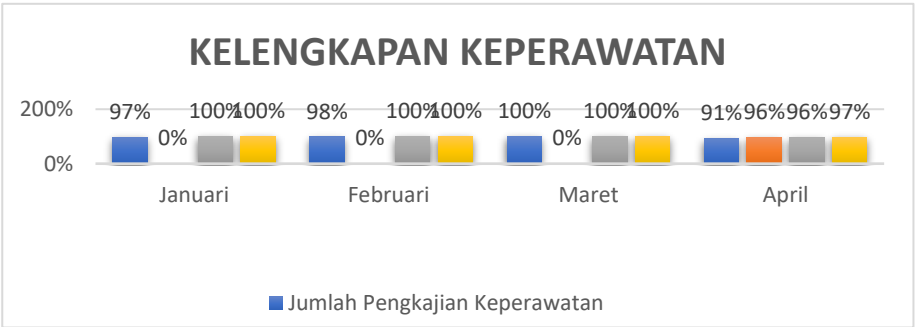
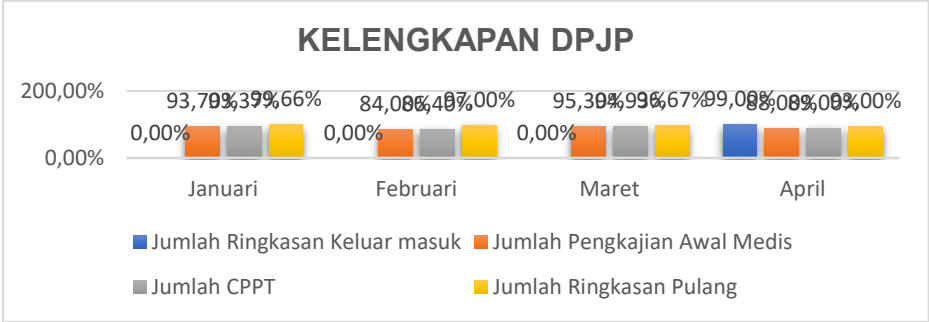
3.6.6.1 Tabel Audit Harian Dokumen Rekam Medis Rawat Inap 2026

KELENGKAPAN																
DPJP																
BULAN	Ringkasan Keluar Masuk				Pengkajian Awal Medis				CPPT				Ringkasan Pulang			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Januari	-	-	-	-	1090	93,70	61	6,30	1080	93,37	69	5,16	1147	99,66	4	0,34
Februari	-	-	-	-	920	84	119	16%	929	86,4	110	13,6	1005	97	34	3
Maret	-	-	-	-	1001	95,30	54	16	1000	94,93	55	5,07	1031	96,67	24	,33
April	1244	99	12	1	1070	88	149	12	1113	89	142	11	1162	93	94	7
Mei																
Juni																
Juli																
Agustus																
September																
Oktober																

KELENGKAPAN																
PERAWAT																
BULAN	Pengkajian Keperawatan				CPPT				Asuhan Keperawatan				Resume Keperawatan / SBAR			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Januari	1013	97,18	38	2,82	-	-	-	-	1051	100	0	0	1051	100	0	0
Februari	1008	98	27	2	-	-	-	-	1034	100	2	0,3	1036	100	0	0
Maret	1047	100	7	0	-	-	-	-	1043	100	11	0	1054	100	0	0
April	1148	91	107	9	1203	96	52	4	1203	96	52	4	1220	97	35	3
Mei																
Juni																
Juli																
Agustus																
September																
Oktober																

KELENGKAPAN																
BULAN	AHLI GIZI								APOTEKER							
	Pengkajian Awal Gizi				CPPT				Rekonsialisasi Obat				CPPT			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Januari	556	52	484	48	1040	100	0	0	1133	100	0	0	1010	91	123	9
Februari	528	61	398	39	926	100	0	0	1027	100	0	0	965	94	62	6
Maret	587	65	341	35	927	100	1	0,07	1034	90	13	10	291	33	756	67
April	564	99	99	3	1130	99	11	1	1206	97	42	3	1171	99	13	1
Mei																
Juni																
Juli																
Agustus																
September																
Oktober																

3.1.1.3 3.1.1.6 Grafik Audit Harian Dokumen Rekam Medis Rawat Inap Bulan April 2026



Analisis :

1. Kelengkapan rekam medis mengalami fluktuasi pada beberapa unit. Bulan April menunjukkan:
 - peningkatan signifikan pada Ahli Gizi dan Apoteker,
 - namun terjadi penurunan pada DPJP dan sebagian dokumentasi perawat.
 - Area yang masih perlu perhatian:
 - Pengkajian Awal Medis DPJP,
 - CPPT DPJP,
 - CPPT Apoteker,
 - Pengkajian Keperawatan bulan April.
2. Faktor penyebab kemungkinan: beban kerja tinggi, kedisiplinan dokumentasi, keterlambatan pengisian, kurangnya monitoring harian, belum optimalnya evaluasi oleh kepala ruangan/komite medis.

Rencana Tindak Lanjut :

-
1. ~~Sosialisasi kelengkapan rekam medis dan ketepatan pengisian CPPT.~~
 2. Monitoring dan evaluasi kelengkapan berkas setiap bulan.
 3. Reminder kepada DPJP untuk melengkapi berkas sebelum pasien pulang koordinasi dengan karu dan kabid pelayanan.
 4. Supervisi rutin pengisian dokumentasi keperawatan.
 5. Meningkatkan kepatuhan pengisian asesmen dan SBAR secara real time.
 6. Audit internal kelengkapan rekam medis oleh kepala ruangan.
 7. Mempertahankan kepatuhan pengkajian awal gizi.
 8. Monitoring kelengkapan asesmen pasien baru.
 9. Evaluasi rutin keterlambatan dokumentasi gizi.
 10. Monitoring harian pengisian CPPT farmasi dan rekonsiliasi obat.
 11. Evaluasi penyebab ketidaklengkapan dokumentasi.
 12. Optimalisasi kepatuhan dokumentasi pelayanan farmasi klinis.

3.7 Permasalahan Rumah Sakit

3.7.25 Permasalahan Instalasi Kamar Operasi (IKO)

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
A. Permasalahan Dari Unit			
1	Alur alat kotor membutuhkan jendela dari IKO untuk keluar ke CSSD	P	Identifikasi alur alat kotor sesuai akreditasi
		D	Untuk IKO 3, kursi dan meja nya ditiadakan untuk alat keluar dari IKO 3. Untuk IKO 2 diberi jendela untuk langsung keluar ke CSSD
		S	Dengan pertimbangan dan diskusi, tidak ada pendodolan alur alat keluar untuk saat ini
		A	Untuk perbaikan alur IKO 3, alat dari IKO 3 keluar lewat pintu poli anestesi. Untuk alat dari IKO 1 dan 2, tetap menggunakan box berjalan seperti saat ini
2	Suction IKO rusak , harus ada 3 yang stanby	P	Suction di IKO 2 rusak, masih perbaikan ke IPSRS

		D	Sudah pengajuan ke pengadaan sambil menunggu suction perbaikan
		S	Koordinasi dengan MFK untuk maintenance alat suction karena load operasi tinggi
		A	Follow up pengajuan alat sampai barang ready
3	DPJP komplain karena menginput ERM di laporan operasi sering hilang dan tidak bisa di edit untuk laporan operasi bagian atas (rencana tanggal operasi, komplikasi dll)	P	DPJP komplain karena menginput ERM di laporan operasi sering hilang dan tidak bisa di edit untuk laporan operasi bagian atas (rencana tanggal operasi, komplikasi dll)
		D	Koordinasi dengan programmer agar aksesnya bisa oleh dokter maupun perawat IKO
		S	Monitoring jika ada kendala penginputan, karena sudah ditindaklanjuti oleh programmer
		A	Koordinasi dengan tim IT untuk memastikan simrs di IKO update

3.7.26 Permasalahan Instalasi Gawat Darurat (IGD)

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
A. Permasalahan Dari Kabid/ Komite Terhadap Unit			
1	Kesalahan penulisan SBAR	P	Ditemukan ada 3 pasien yang isi SBAR nya tertukar dengan pasien lain
		D	Sudah dilakukan rapat IKP melibatkan komkep, komdik, kains, masuk dalam KNC
		S	Sosialisasi ulang pada unit agar meningkatkan ketelitian saat menyalin terapi dpjp dari WA, jangan sampai keliru pasien lain
		A	Tingkatkan monitoring dan supervisi karu igd
2	Evaluasi dr Ganesa (dokter orientasi)	P	Dr Ganesa menjalani masa orientasi 2 bulan mulai Maret-April 2026
		D	Dari hasil evaluasi, hasilnya kurang cepat tanggap dalam penentuan diagnosa dan penanganan pasien di IGD
		S	Dr Ganesa sudah diberi kesempatan untuk memperdalam diagnosa di casemix selama 2 minggu, saat dikembalikan ke IGD, belum menunjukkan perubahan yang signifikan, cenderung masih ragu-ragu, bingung dan kurang fokus
		A	Dengan 2 bulan penilaian tidak menunjukkan perubahan, maka kontrak tidak diperpanjang
3	Pasien rencana rujuk yang tidak diperkenankan menunggu di IGD	P	Pasien advice rujuk dari awal dan DPJP minta untuk tidak boleh pindah ruangan karena takut klaim menjadi rawat jalan
		D	Koordinasi antara dokter casemix dan DPJP agar pasien diidentifikasi permasalahan yang bisa diatasi oleh RS
		S	Koordinasi agar pasien distabilkan dan tidak terburu-buru rujuk karena pertimbangan tidak langsung diterima atau bisa dirujuk penuh per poli
		A	Koordinasi dengan Dokter casemix dan PIPP

			dilibatkan karena pasien termasuk dalam kriteria kompleks
5	Tempat sampah infeksius ada 2 di IGD	P	Tempat sampah infeksius ada 2 di IGD dengan penempatan yang berdekatan
		D	Efisiensi tempat sampah dan kreseknya, atur lagi terkait pembuangan sampah sehingga tidak perlu ada 2 tempat sampah
		S	Koordinasi dengan CS terkait pembuangan dan pembersihan tempat sampah maupun sketcher yang ada di igd
		A	Tingkatkan monitoring dan supervisi karu igd

3.7.27 Permasalahan Rawat Inap

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Absensi visite DPJP	P	Absensi visite kadang tidak muncul tarifnya
		D	Sebagian pasien tidak tervalidasi oleh perawat sehingga tidak muncul di tagihan
		S	Koordinasi dengan programmer untuk mengidentifikasi kendala selama proses absensi
		A	Follow up tindaklanjut dari programmer dan eksekusi saat ada case
2.	HP ruangan sering tidak terhubung dengan WIFI, sehingga tidak mendukung proses tanda tangan digital pada ERM.	P	HP ruangan sering tidak terhubung dengan WIFI, sehingga tidak mendukung proses tanda tangan digital pada ERM
		D	Komunikasi dan koordinasi dengan IT dan Kabid umum, agar internet di NS harus stabil
		S	Apabila internet dan HP tidak support, harus diberikan alternatif lain seperti penginstallan di HP pribadi (Karu . PJ shift) hanya untuk back up tanda tangan jika jaringan lemah
		A	Monitoring dan supervisi dari bagian IT untuk kestabilan internet di seluruh ruangan NS rawat inap
3.	Saat visite pagi, petugas gizi dan apoteker datang bersamaan, sehingga penggunaan komputer harus bergantian. Hal ini kadang menghambat pelaporan kondisi pasien atau hasil penunjang.	P	Komputer rawat inap untuk fasilitas ERM adalah 2 tiap ruangan
		D	Visite oleh apoteker dan gizi adalah elektif dan bisa dikondisikan agar tidak bersamaan dengan visite DPJP
		S	Koordinasi dengan karu gizi dan kains apoteker agar bisa akses ERM lewat komputer selain di NS.
		A	Alternatif lain untuk computer, bisa kerjasama dengan Karu poli, karena beberapa poli ada yang tidak digunakan sehingga bisa untuk mencicil mengerjakan ERM

3.7.28 Permasalahan Rawat Jalan

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Fragmentasi di rawat jalan meningkat	P	Kunjungan rawat jalan yang masuk dalam fragmentasi dengan satu bulan ada 2-3 x kunjungan
		D	Koordinasi dengan verifikator dan dpjp untuk

			menjawab konfirmasi pending
		S	Koordinasi dengan pendaftaran dan poli agar bisa memilih salah satu poli yang paling urgent untuk di tangani, selebihnya harus PRB
		A	Monitoring dan evaluasi terkait kunjungan pasien rawat jalan dengan 2 rujukan
2	Kebijakan konsul internal	P	Pasien poli yang mempunyai rujukan lebih dari satu, untuk kunjungan selanjutnya harus dilakukan konsul internal
		D	Potensi fragmentasi jika diidentifikasi pasien menggunakan 2 rujukan untuk kontrol ke RSPHM
		S	Jika pasien kronis, maka salah satu harus di PRB, jika pasien membutuhkan 2 DPJP sekaligus diberlakukan konsul internal (kecuali rujukan poli gigi), dan monitoring target untuk PRB atau stabilnya kapan
		A	Pasien yang mempunyai 2 rujukan, di list di grup pelayanan yang isinya PDF, Poli , farmasi dan Asce. Diharapkan jika ada pasien dengan 2 rujukan, salah satu harus ditarget dan di warning ke DPJP untuk PRB. Jika tidak bisa di PRB, harus disertakan alasannya.
3	Riwayat penyakit penyerta pasien lodingan tidak terkaji di poli ortopedi	P	Pasien JKK dengan rencana tindakan remove implant, tidak terkaji Riwayat penyakit penyerta : Hipertiroid
		D	Saat durante op, pasien mengalami mengalami penurunan kondisi sehingga dilakukan intubasi di ICU
		S	Pasien raber dengan IPD untuk penanganan hipertiroid
		A	Sosialisasi kembali dan tingkatkan operan antara perawat poli dan rawat inap terkait RPD karena dokter anastesi harus tahu untuk penambahan terapi maupun profilaksis

3.8

Profil SDM

3.8.1 Ketenagaan (Distribusi Tenaga, Kualifikasi, Jabatan dan Kebutuhan)

NO	UNIT	PENDIDIKAN	TOTAL	JUMLAH	TETAP	TIDAK TETAP	RESIGN
1	Direktur	Dokter Umum	1	1	1	0	0
2	Kabid Pelayanan Medis	D3 Kebidanan	1	1	1	0	0
3	Kabid Penunjang Medis	S1 Kesehatan Lingkungan	1	1	1	0	0
4	Kabid Keperawatan	Profesi Ners	0	0	0	0	0
5	Kabid Umum	Dokter Gigi Umum	1	1	0	1	0
6	Casemix Manager	SMK	1	1	1	0	0
7	Farmasi	Profesi Apoteker	38	12	6	6	0
		S1 Farmasi		3	2	1	0
		D3 Analis Farmasi dan Makanan		1	1	0	0
		D3 Farmasi		21	14	7	0
		SMK		0	0	0	0
		S1 Manajemen		1	1	0	0
8	Asuransi Center	D3 Asuransi Kesehatan	10	1	1	0	0

		D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		8	7	1	0
		SMK		0	0	0	0
		SMA		1	1	0	0
9	CSSD	D3 Keperawatan	3	2	1	1	0
		SMA		1	1	0	0
		SMK		0	0	0	0
10	Fisioterapi	S1 Fisioterapi	5	1	0	1	0
		D3 Fisioterapi		3	2	1	0
		D3 Terapi Wicara		1	0	1	0
11	Gizi	S1 Ilmu Gizi	16	2	2	0	0
		D4 Gizi dan Dietetika		2	2	0	0
		D3 Ahli Gizi		2	2	0	0
		SMK		6	0	6	0
		SMA		1	0	1	0
		SMP		3	2	1	0
12	Humas & Marketng	D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	2	1	0	1	0
		S1 Teknik Informatika		1	0	1	0
13	ICU dan HCU	Profesi Ners	10	5	5	0	0
		D3 Keperawatan		4	2	2	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
14	IGD	Profesi Ners	23	10	8	2	0
		D3 Keperawatan		9	7	2	0
		D4 Kebidanan		2	2	0	0
		D3 Kebidanan		2	2	0	0
15	IKO	Profesi Ners	11	7	7	0	0
		D3 Keperawatan		4	4	0	0
		D3 Kebidanan		0	0	0	0
16	IPCN	Profesi Ners	2	2	2	0	0
17	IPSRs	S1 Tenik Elektro	6	1	1	0	0
		S1 Kesehatan Masyarakat		1	1	0	0
		D3 Teknik Elektromedis		1	0	1	0
		SMK		3	3	0	0
18	IRJA	Profesi Ners	28	7	7	0	0
		D3 Keperawatan		15	14	1	0
		D4 Keperawatan Gigi		2	1	1	0
		Profesi Kebidanan		1	0	1	0
		D3 Kebidanan		3	3	0	0
19	IRNA 2C	Profesi Ners	6	4	4	0	0
		D3 Keperawatan		2	2	0	0
20	IRNA 2A, 3A, & 4A	Profesi Ners	16	7	7	0	0
		D3 Keperawatan		9	6	3	0
21	IRNA 3C Anak	Profesi Ners	12	4	2	2	0
		D3 Keperawatan		8	7	1	0
		D3 Kebidanan		0	0	0	0
22	IRNA 5C	Profesi Ners	8	2	1	1	0
		D3 Keperawatan		6	4	2	0
23	IRNA 6A, 7A, & 8A	Profesi Ners	21	8	4	4	0
		D3 Keperawatan		13	10	3	0
24	Maternitas	Profesi Kebidanan	10	1	0	1	0

		D4 Kebidanan		2	2	0	0
		D3 Kebidanan		7	7	0	0
25	Neonatologi	Profesi Ners	8	3	2	1	0
		D3 Keperawatan		4	4	0	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
26	Keuangan & Akuntansi	S1 Ekonomi	8	2	2	0	1
		S1 Akuntansi		1	0	1	0
		S1 Manajemen		1	1	0	0
		SMK		1	1	0	0
		SMA		3	3	0	0
27	Laboratorium	D4 Analis Kesehatan	8	1	0	1	0
		D3 Analis Kesehatan		7	6	1	0
28	Laundry	SMK	5	2	1	1	0
		SMA		2	1	1	0
		SMP		1	0	1	0
29	Rekam Medis	D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	8	8	8	0	0
30	Pendaftaran	S1 Sastra Inggris	13	0	0	0	0
		S1 Kesehatan Masyarakat		1	1	0	0
		D3 Asuransi Kesehatan		1	0	1	0
		D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		6	5	1	0
		D1 Administrasi Perkantoran		1	1	0	0
		SMK		1	1	0	0
		SMA		3	3	0	0
31	PIPP & MPP	Profesi Ners	4	0	0	0	0
		D4 Kebidanan		1	1	0	0
		D3 Keperawatan		1	1	0	0
		D3 Kebidanan		2	2	0	0
32	PMKP	Profesi Ners	1	1	1	0	0
33	Radiologi	D3 Radiodiagnostik & Radioterapi	6	6	4	2	0
34	SDM	S1 Sosial	1	1	1	0	0
35	Sekretaris	S1 Administrasi Publik	1	1	1	0	0
36	SIMRS & IT	S1 Teknik Informatika	3	3	3	0	0
37	Umum & Rumah Tangga	S1 Ekonomi	1	1	1	0	0
38	Cleaning Service	SMK	40	13	7	6	0
		SMA		22	18	4	0
		SMP		5	5	0	0
39	Security	SMK	10	4	2	2	0
		SMA		6	5	1	0
40	Driver	D1 Administrasi Perkantoran	6	1	1	0	0
		SMA		4	3	1	0
		SMP		1	1	0	0
41	Gudang Umum	SMP	1	1	1	0	0
42	Staf Orientasi	Profesi Ners	11	5	0	5	0
		D3 TVF		2	0	2	0
		D3 Analis Kesehatan		1	0	1	0
		SMK		3	0	3	0
Total Karyawan			367	367	274	93	2

43	Dokter IGD	Dokter Umum	8	8	0	8	0
44	Dokter Casemix	Dokter Umum	1	1	0	1	0
45	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Pendidikan Dokter Spesialis	5	5	1	4	0
46	Dokter Spesialis Anak	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
47	Dokter Spesialis Bedah Umum	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
48	Dokter Spesialis Bedah Plastik	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
49	Dokter Spesialis Bedah Saraf	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
50	Dokter Spesialis Obsitetri dan Ginekologi	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
51	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
52	Dokter Spesialis Mata	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
53	Dokter Spesialis THT	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
54	Dokter Spesialis Paru	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
55	Dokter Spesialis Saraf	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
56	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
57	Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatology	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
58	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
59	Dokter Spesialis Urologi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
60	Dokter Spesialis Anestesi	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	1	2	0
61	Dokter Spesialis Radiologi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
62	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
63	Dokter Spesialis Patologi Klinik	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
64	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
65	Dokter Spesialis Gigi Periodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
66	Dokter Spesialis Gigi Pedodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
67	Dokter Spesialis Gigi Orthodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
68	Dokter Spesialis Konservasi Gigi	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
Total Dokter			64	64	2	62	0
Total Keseluruhan			431	431	276	155	1

Keterangan :
Pada bulan April tidak terdapat staf resign.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

RS Prima Husada Malang yang selalu berbenah untuk meningkatkan pelayanan baik dari sisi Sumber Daya Manusia ataupun dari sisi sarana dan prasarannya. Dimana masih terdapat beberapa Sumber Daya manusia yang masih belum tertib baik dari kelompok tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang masih belum tertib secara administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimulai dengan penataan SDM yang disesuaikan dengan alur dan tata letak Gedung yang baru, maka dilakukan juga penambahan tenaga khususnya perawat untuk memenuhi kebutuhan setelah dilakukan evaluasi dan Analisa beban kerja. Proporsi antara karyawan kontrak/tidak tetap dengan karyawan tetap, dimana masih banyak karyawan kontrak/tidak tetap di RS Prima Husada Malang diperkirakan bisa mempengaruhi kualitas pelayanan di Rumah sakit

Kepatuhan DPJP dalam memvisite pasien dan melengkapi dokumen Rekam medis yang masih jauh dari standar juga mempengaruhi kualitas pelayanan di RS Prima Husada Malang dan menghambat proses klaim. Kinerja RS dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal Rumah Sakit. Jumlah kunjungan di RS Prima Husada Malang masih didominasi oleh kunjungan pasien lama dari BPJS Kesehatan. Pelayanan di beberapa unit yang belum optimal dikerenakan salah satu dampak kekurangan tenaga kerja membawa akibat pada pelayanan.

B. SARAN

1. Meningkatkan ketertiban administrasi di Unit SDM terutama ketertiban absensi dengan memanfaatkan SIM SDM yang baru
2. Membentuk dan mengoptimalkan kinerja dari komite – komite yang ada di RS Prima Husada Malang
3. Meningkatkan kepatuhan visite DPJP dengan mencatat dan melaporkan waktu visite DPJP serta mentertribkan DPJP dalm pengisian Dokumen Rekam Medis
4. Memperbaiki proses rekrutmen staf sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan
5. Meningkatkan skill dan pengetahuan SDM dengan giat mengaktifkan diklat dan pelatihan internal serta mengikuti pelatihan secara eksternal
6. Meningkatkan marketing dan promosi untuk meningkatkan kunjungan ke RS Prima Husada Malang
7. Menjalin lebih banyak kerjasama dengan stakeholder dari luar RS Prima Husada Malang

BAB V
PENUTUP

Demikian laporan bulan Meil 2026 ini kami buat sebagai bahan pertanggungjawaban atas kinerja Rumah Sakit Prima Husada Malang pada April 2026, masih ada beberapa target yang belum tercapai sesuai standard namun upaya selalu kami lakukan secara terus menerus. Perbaikan dan pengembangan pelayanan akan terus kami lakukan seoptimal mungkin.

Malang, 10 Mei 2026
Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang



dr. Resti Lestantini, M. Kes

LAMPIRAN

NO	NAMA PKS	JENIS INSTANSI	MULAI BERLAKU	TANGGAL EXPIRED	KETERANGAN	NOMOR PKS RUMAH SAKIT	NOMOR PKS INSTANSI
1	ASURANSI DAYIN MITRA	ASURANSI	05 Februari 2015	05 Desember 2017	PELAYANAN KESEHATAN	PH/IKS/269/XII/2014	003/MKT/HLT/PKS/I/2015
2	Batas Media 99	PERUSAHAAN	05 Juni 2024	05 Juni 2027	Pelayanan Kesehatan	158/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024	-
3	BPJS KESEHATAN	ASURANSI	01 Januari 2025	31 Desember 2025	Pelayanan Kesehatan	2035/E-PKS/DIR/XII/2024	651/KTR/VII-05/1224
4	CV AUMERTA ANGGUN	PERUSAHAAN	28 Agustus 2023	28 Agustus 2026	PELAYANAN KESEHATAN	164.1/DPM/E-PKS/DIR/VIII/2023	-
5	ESWEJE Aesthetic Center	INSTANSI KESEHATAN	01 Maret 2024	01 Maret 2027	Sterilisasi alat kesehatan	079/DPM/E-PKS/DIR/III/2024	9,1202E+12
6	Pelayanan Bimbingan Rohaniawan Agama Hindu	AKRE	05 Desember 2022	04 Desember 2025	Bimbingan Rohaniawan Agama Hindu	1754/E-PKS/DIR/XII/2022	-
7	Indonesia Smelting Technology	PERUSAHAAN	01 Juni 2024	01 Juni 2026	Rujukan Pelayanan	194/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024	005/HRGA-IST/V/2024
8	Instruktur Zumba	AKRE	23 Februari 2024	23 Februari 2025	Instruktur Zumba	067/DPM/E-PKS/DIR/II/2024	-
9	Klinik Mutiara Sehat (Karanglo, Lawang, Karangploso)	INSTANSI KESEHATAN	02 Agustus 2021	02 Agustus 2026	Pelayanan Laboratorium	429.77/I-PKS/DIR/VIII/2021	069/PKS/PDP/VIII/2021
10	Klinik Endisa Husada	INSTANSI KESEHATAN	01 Agustus 2023	01 Agustus 2026	Rujukan Pelayanan	148.3/DPM/E-PKS/DIR/VII/2023	PK/01/VII/2023-KEH
11	Klinik Losari Medika	INSTANSI KESEHATAN	06 Februari 2024	06 Februari 2027	Rujukan Pelayanan	-	021/DPM/E-PKS/DIR/II/2024
12	Klinik Pratama Beauty Medika Singosari	INSTANSI KESEHATAN	25 Mei 2024	25 Mei 2027	Rujukan Pelayanan	145/DPM.E-PKS/DIR/V/2024	001/PKS/12/2024
13	Klinik Rawat Jalan Mitra Prima Care	INSTANSI KESEHATAN	02 Desember 2024	02 Desember 2027	Pelayanan Kesehatan	346/DPM/E-PKS/DIR/XII/2024	025/MPC/E-PKS/KA/XII/2024
14	Klinik Utama Medika	INSTANSI	24	24 September	Rujukan Pasien	299/DPM/E-	-

		KESEHATAN	September 2024	2027		PKS/DIR/IX/2024	
14	Klinik Utama Rawat Jalan Akasia	INSTANSI KESEHATAN	25 April 2024	25 April 2027	Pelayanan Kesehatan	116/DPM/E- PKS/DIR/IV/2024	011/KUA/E-PKS/HMS/III/2024
15	Penerjemah Bahasa Isyarat untuk Difabel	AKRE	14 September 2022	13 September 2025	Penerjemah Bahasa Isyarat Untuk Difabel	1378/E- PKS/DIR/X/2022	-
16	Penerjemah Bahasa Madura	AKRE	01 Agustus 2022	02 Agustus 2025	Penerjemah Bahasa Madura	1305/E- PKS/DIR/IX/2022	-
17	Penerjemah Bahasa Asing	AKRE	01 Agustus 2022	01 Agustus 2025	Penerjemah Bahasa Inggris	1288/E- PKS/DIR/IX/2022	-
18	Persada Hospital	INSTANSI KESEHATAN	10 Oktober 2022	10 Oktober 2027	Pelayanan Kesehatan	152.45//DPM/E- PKS/DIR/XI/2022	1083.b.HS/MOU/X/PH-2022
19	PMI Kabupaten Malang	INSTANSI KESEHATAN	19 Agustus 2024	19 Agustus 2026	Penyediaan Darah	246/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2024	0904/02.06.28/UTD/VIII/2024
20	PMI Kabupaten Malang	INSTANSI KESEHATAN	01 Juni 2023	30 Juni 2023	Rujukan Pelayanan	-	768/E-PKS/DIR/V/2023
21	PMI Kota Malang	INSTANSI KESEHATAN	01 Desember 2023	01 Desember 2025	Penyediaan Darah	1790/E- PKS/DIR/XI/2023	2214/02.06.27/UTD/XI/2023
22	PRAKTEK BIDAN MANDIRI NIA IRAWATI, S.TR.KEB	INSTANSI KESEHATAN	07 Februari 2024	26 Februari 2027	Rujukan dan Pelayanan Penunjang	081/DPM/E- PKS/DIR/III/2024	-
23	PT AA International Indonesia	ASURANSI	02 September 2019	02 September 2020	Pelayanan Kesehatan Grab	-	-
24	PT Administrasi Medika	ASURANSI	01 Juli 2024	01 Juli 2027	Asuransi		071/PKS/AdM/ManagedCare/VII2024
25	PT AIA Financial	ASURANSI	04 November 2020	Perpanjangan Otomatis	Asuransi	No.069/DPM/E- PKS/DIR/X/2020	No. 639/AIA/-DPM/XI/2020
26	PT AJ Central Asia Raya	ASURANSI	02 Juni 2017	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	277/RSPH/E- IKS/DIR/VI/2017	DIR/PKS-RS/1455/VI/2017
27	PT AJINOMOTO SALES INDONESIA	PERUSAHAAN	01 Mei 2012	30 APRIL 2013 (selanjutnya)	PELAYANAN KESEHATAN		

				perpanjang otomatis)			
28	PT Alfiza Medika Utama	INSTANSI KESEHATAN	07 Maret 2024	07 Maret 2028	Pelayanan Kesehatan	090/DPM/E- PKS/DIR/III/2024	018/MOU/KAMU/07/III/2024
29	PT Aloita Prima (Harris Hotel Malang)	PERUSAHAAN	29 Juli 2024	29 Juli 2026	Pelayanan Kesehatan	221/DPM/E- PKS/DIR/VII/2024	-
30	PT ANTARMITRA SEMBADA CAB. MALANG	PERUSAHAAN	01 Desember 2024	01 Desember 2017	PELAYANAN KESEHATAN	304.1.DPM/E- PKS/DIR/X/2024	344/MLG/AMS/XII/2024
31	PT APLIKANUSA LINTASARTA	ASURANSI	25 Februari 2015	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	PH/IKS/100/II/2015	095/LA/MOU/00300/2015
32	PT ASABRI	ASURANSI	13 Desember 2023	12 Desember 2026	PELAYANAN KESEHATAN	1902/E- PKS/DIR/XII/2023	PEFJ-182/HK.02.01/HBL.H/XII/2023
33	PT ASURANSI ADIRA DINAMIKA	ASURANSI	12 Oktober 2023	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	PH/E- PKS/171/X/2013	499B/AAD-LEG-AGR/X/2013
34	PT Asuransi Allianz Life Indonesia	ASURANSI	12 Desember 2017	Perpanjangan Otomatis	Asuransi	-	729/AZLI-LGL/AG/XII/2017
35	PT ASURANSI ALLIANZ LIFE SYARIAH INDONESIA	ASURANSI	18 November 2024	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	698.21/DPM/I- PKS/DIR/IX/2024	391/ALLISYA-LGL/AG/XI/2024
36	PT ASURANSI ASTRA BUANA	ASURANSI	01 September 2020	31 Agustus 2023	PELAYANAN KESEHATAN	1033/RSPHS/E- PKS/DIR/VIII/2020	26/HID-PM/ASURANSIASTRA/IX/2020
37	PT ASURANSI DAYIN MITRA	ASURANSI	05 Februari 2015	05 Desember 2017	PELAYANAN KESEHATAN	PH/IKS/269/XII/2014	003/MKT/HLT/PKS/I/2015
38	PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia	ASURANSI	01 Oktober 2023	01 Oktober 2028	Asuransi	183.3/DPM/E- PKS/DIR/X/2023	157/GI/OPS/Prov-PKS/X/2023
39	PT Asuransi Jiwa In Health Indonesia (Mandiri Inhealth)	ASURANSI	01 Februari 2023	31 Januari 2025	Asuransi	028.2/DPM/E- PKS/DIRR/11/2023	0.32/AJII.KOP-SBY/PKS/0123
40	PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA	ASURANSI	01 Desember 2024	01 Desember 2025	PELAYANAN KESEHATAN	361/DPM/E- PKS/DIR/XII/2024	331-11/EB-CONT/2024

41	PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA TBK (ASURANSI MAG)	ASURANSI	28 Januari 2020	27 Januari 2024	RAWAT INAP DAN RAWAT JALAN	015/DPM/E- PKS/DIR/XI/2019	PKS-0097/XI/2019/MAG-R2
42	PT Asuransi Reliance Indonesia	ASURANSI	06 November 2024	06 November 2027	Asuransi	338/DPM/E- PKS/DIR/XI/2024	024/LGL-ARI/PKS-RS-IB/XI/2024
43	PT ASURANSI RELIANCE INDONESIA	ASURANSI	07 September 2020	07 September 2025	PELAYANAN KESEHATAN	368/DPM/I- PKS/DIR/VIII/2020	163/LGL-ARI/PKS/RS-COB/IX/2020
44	PT ASURANSI SINARMAS	ASURANSI	01 September 2019	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	010/DPM/E- PKS/DIR/IX/2019	364/PKS-RS/PH.RI.ASM/IX/2019
45	PT ASURANSI SINARMAS MSIG	ASURANSI	10 September 2012	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN		063/PKS-AJSMSIG-RS/IX/2012
46	PT ASURANSI TAFAKUL KELUARGA	ASURANSI	02 Januari 2017	01 Januari 2020	PELAYANAN KESEHATAN	508/RSPH/E- IKS/DIR/XI/2016	0642/PKS-RS-01/I/2017
47	PT ASURANSI TUGU KRESNA PRATAMA	ASURANSI	30 Oktober 2021	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	612/RSPHS/E- PKS/DIR/X/2019	300/PKS/DIR/TKP/X/2019
48	PT AXA SERVICES INDONESIA (ADMEDIKA)	ASURANSI	15 Agustus 2013	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN		067/AGR-LEG/ASI/VIII/2013
49	PT Bestari Murni Anugrah	PERUSAHAAN	04 Juni 2024	04 Juni 2027	rujukan pelayanan	159/DPM/E- PKS/DIR/VI/2024	-
50	PT BNI LIFE INSURANCE	ASURANSI	25 Juli 2016	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	082/RSPH/E- IKS/DIR/II/2016	274.PKS.BL.DIR.0716
51	PT CAKRA SURYA HUSADA	PERUSAHAAN	02 Agustus 2022	02 Agustus 2025	ASUHAN PASIEN & PELAYANAN PENUNJANG	112.1/DPM/E- PKS/DIR/VII/2022	138/MOU/VIII/CSH/2022
52	PT Citra Karsa Dinamika	PERUSAHAAN	01 Juli 2024	01 Juli 2026	Pelayanan Kesehatan	196/DPM/E- PKS/DIR/VI/2024	-
53	PT Docdoc Healthcare Indonesia	ASURANSI	12 Desember 2024	Perpanjangan Otomatis	Asuransi	-	-
54	PT Equity Life Indonesia	ASURANSI	14 Oktober 2019	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	-	091/ELI/LGL/X/19

55	PT EQUITY LIFE INDONESIA	ASURANSI	14 Oktober 2019	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN		090/ELI/LGL/X/19
56	PT Fullerton Health Indonesia	ASURANSI	26 Agustus 2019	Perpanjangan Otomatis		-	640/IP-OP/PKS/FHI/VIII/2019
57	PT Global Assistance & Healthcare	ASURANSI	26 Agustus 2019	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	-	640/IP-OP/PKS/GAH/VIII/2019
58	PT Green Mountains Natural Food	PERUSAHAAN	07 Agustus 2024	07 Agustus 2027	Pelayanan Kesehatan	225/DPM/E-PKS/DIR/VII/2024	01/GMN/KS/VI/2024
59	PT HANWA LIFE INSURANCE INDONESIA	ASURANSI	16 Maret 2015	15 Maret 2016	PELAYANAN KESEHATAN		0088/HLI-GH/PKS-RS/03-2015
60	PT Indo Aneka Atsiri	PERUSAHAAN	07 Agustus 2024	06 Agustus 2027	Pelayanan Kesehatan	222/DPM/E-PKS/DIR/VII/2024	066/IAA/HRGA/VI/2024
61	PT INDOLAKTO PANDAAN	PERUSAHAAN	10 Januari 2014	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN		
62	PT Indonesia Marine	PERUSAHAAN	10 September 2024	10 September 2027	Pelayanan Kesehatan	-	-
63	PT INTERNATIONAL SERVICES PASIFIC CROSS	VENDOR	03 Oktober 2022	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	150/DPM/E-PKS/DIR/X/2022	953/ISPC/PKS/X/2022
64	PT JASA RAHARJA	ASURANSI	04 Juli 2022	04 Juli 2027	PENAGANAN DAN PENYELESAIAN SATUAN KORBAN KECELAKAAN PENUMPANG ANGKUTAN UMUM DAN LALU LINTAS JALAN	912.1/E-PKS/DIR/VII/2022	P/13/SP/2022
65	PT Java Smartindo	PERUSAHAAN	01 Agustus 2020	Perpanjangan Otomatis	Jasa Pengelolaan Administrasi Kesehatan	364/DPM/I-PKS/DIR/VIII/2020	PKS.TPA-JSMART.290/VIII/20/RS.SW.C
66	PT JAYA OBAYASI	PERUSAHAAN	01 Juli 2020	01 Juli 2025	PELAYANAN KESEHATAN	360/DPM/I-PKS/DIR/VIII/2020	
67	PT Kartika Bina Medikatama (Medika Plaza)	ASURANSI	17 Juli 2020	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	034/DPM/E-PKS/DIR/VII/2020	092/KBM-DPM/PKS/VII/2020
68	PT LABBIOGEN ARTHA MEGA	INSTANSI KESEHATAN	02 September 2024	01 September 2027		262/DPM/E-PKS/DIR/VIII/2024	B-MKT 01/001/623/VII/2024

69	PT MALANG INTERMEDIA PERS	PERUSAHAAN	01 Juli 2020	01 Juli 2025	PELAYANAN KESEHATAN	025/DPM/E- PKS/DIR/VII/2020	103.1/PKS/DIR/JPRM/VIII/2020
70	PT Medilink Digital Media	ASURANSI	22 Maret 2024	22 Maret 2027	Pelayanan Kesehatan	09/DPM/E- PKS/DIR/IV/2024	229/L/PKS/MDM-DPM/III/2024
71	PT MEDLINX ASIA TEKNOLOGI	ASURANSI	28 November 2016	Perpanjangan Otomatis	APLIKASI LAYANAN KESEHATAN	150/PKS- RSPRIMAHUSADA- MAT/DIR/XI/2016	
72	PT MOOR SUKSES INTERNASIONAL	ASURANSI	08 Juli 2024	08 Juli 2027	PELAYANAN KESEHATAN	200/DPM/E- PKS/DIR/2024	001/MSI/VI/2024
73	PT PAN PACIFIC INSURANCE	ASURANSI	31 Agustus 2020	31 Agustus 2023	PELAYANAN PERAWATAN DAN PENGOBATAN	017/DPM/E- PKS/DIR/VII/2020	0593-01/PKS/PRV-PANFIC/RS- PHMS/VIII/2020
74	PT PANCAMAS ELITE	PERUSAHAAN	12 Juni 2024	12 Juni 2027	Pelayanan Kesehatan	172/DPM/E- PKS/DIV/VI/2024	-
75	PT PANCAMAS ELITE	PERUSAHAAN	01 Juli 2020	01 Juli 2025	PELAYANAN KESEHATAN	032/DPM/E- PKS/DIR/VII/2020	
76	PT PLN (Persero)	ASURANSI	02 Juli 2024	31 Desember 2025		261/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2024	0017.Add/HKM.02.01/F010800300/2022
77	PT Prima Sarana Jasa - Asuransi SOS	ASURANSI	17 September 2018	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	735/E- PKS/DIR/IX/2018	296/GAN/PT-6/HOSP/SEP/2018
78	PT Prudential Life Assurance	ASURANSI	28 Januari 2021	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	047/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2020	1578/PMN-PLA/XI/2020
79	PT Suprima Mitra Adihusada	ASURANSI	26 Agustus 2019	Perpanjangan Otomatis	Asuransi	-	640/IP-OP/PKS/TIRTA/VIII/2019
80	PT TASPEN (PERSERO)	ASURANSI	11 Juni 2024	10 Juni 2026	Program Jaminan Kecelakaan Kerja	110/DPM/E- PKS/DIR/IV/2024	JAN-09/C.5.1/2024
81	PT TASPEN (PERSERO)	ASURANSI	01 Januari 2023	31 Desember 2025	Program Jaminan Kecelakaan Kerja	008/E- PKS/DIR/I/2023	JAN-01/DIR/2023
82	PT TIRTA INVESTAMA	PERUSAHAAN	31 Agustus 2020	31 Agustus 2025	PELAYANAN KESEHATAN		
83	PT Tonggak Ampuh	PERUSAHAAN	31 Agustus 2024	31 Agustus 2027	Pelayanan Kesehatan	263/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2024	-
84	PT TOYOTA BOSHOKU INDONESIA	PERUSAHAAN	01 Agustus	31 Juli 2026	Pelayanan Kesehatan	150.2/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2023	050/AK/2/VII/TBINA-Kenaf/2023

			2023				
85	PT TOYOTA BOSHOKU INDONESIA PASURUAN PLANT	PERUSAHAAN	27 Oktober 2020	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	1076/RSPHS/E-PKS/DIR/IX/2020	002/AK/10/V/TBINA-Kenaf/2020
86	PT Unggul Anugrah Sejahtera	PERUSAHAAN	04 Juni 2024	04 Juni 2027	Rujukan Pelayanan	160/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024	-
87	PT Uniplastindo Interbuana	PERUSAHAAN	29 Juli 2024	29 Juli 2027	Pelayanan Kesehatan	224/DPM/E-PKS/DIR/VII/2024	-
88	PT YAMAHA ELECTRONICS MANUFACTURING INDONESIA	PERUSAHAAN	04 Januari 2021	04 Januari 2024	PELAYANAN KESEHATAN	303/DPM/I-PKS/DIR/VI/2021	002/PKS-COB/I/2021
89	PT YAMAHA ELECTRONICS MANUFACTURING INDONESIA	PERUSAHAAN	22 Maret 2024	22 Maret 2027	PELAYANAN KESEHATAN	183/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024	014/PKS-COB/III/2024
90	PT YAMAHA MUSICAL PRODUCTS INDONESIA (YMPI)	PERUSAHAAN	01 Juni 2022	01 Juni 2025	PELAYANAN KESEHATAN	004/DPM/E-PKS/VI/2022	/YMPI/HI/PKS/VI/2022
91	PT Yanmar Diesel Indonesia	PERUSAHAAN	15 April 2024	15 April 2027	Pelayanan Kesehatan	108/DPM/E-PKS/DIR/IV/2024	107/YADIN/Pdn/Pga/IV/2024
92	PT Zurich Asuransi Indonesia TBK	ASURANSI	25 Juni 2024	24 Juni 2029	Asuransi	151/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024	268/ZAI-LEG-AGR/VI/2024
93	RS Islam UNISMA Malang	INSTANSI KESEHATAN	01 Januari 2024	31 Desember 2026	Rujukan Pelayanan	222.11/DPM/E-PKS/DIR/XI/2023	08/PKS/RSI-4/I/2024
94	RS Lavalette	INSTANSI KESEHATAN	07 Agustus 2024	07 Agustus 2027		236/DPM/E-PKS/DIR/VIII/2024	DA01-ADDNM-BB/P-B/24-07-16/138
95	RS Prima Husada Sukorejo	INSTANSI KESEHATAN	01 Oktober 2022	01 Oktober 2025	Pelayanan Kesehatan	1376/E-PKS/DIR/X/2022	1608/RSPJS/E-PKS/DIR/X/2022
96	RS Siti Miriam Lawang	INSTANSI KESEHATAN	31 Agustus 2024	31 Agustus 2027	Pelayanan Kesehatan	264/DPM/E-PKS/DIR/VII/2024	566/HMS/RSSM/VIII/2024
97	RSIA Puri Bunda	INSTANSI KESEHATAN	06 Februari 2024	06 Februari 2026	Rujukan Pelayanan	020/DPM/E-PKS/DIR/II/2024	001/PKS/PB/I/2024
98	RSUD Bangil	INSTANSI	22 Juli	22 Juli 2027	Rujukan Pelayanan	222/DPM/E-	400.7.5.2/1531.1/424.072.01/2024

		KESEHATAN	2024			PKS/DIR/VII/2024	
99	Yayasan Bhakti Luhur	AKRE	05 Desember 2022	04 Desember 2025	Pelayanan Rohaniawan Agama Kristen	1753/E- PKS/DIR/XII/2022	-
100	RS PANTI NIRMALA	INSTANSI KESEHATAN	07 Oktober 2022	06 Oktober 2025	PELAYANAN RUJUKAN	152.44/DPM/E- PKS/DIR/XI/2022	3740/069/RSPN/X/2022
101	PKM SINGOSARI	INSTANSI KESEHATAN	12 April 2022	12 April 2027	TUBERKULOSIS DENGAN STRATEGI DOTS	593/I- PKS/DIR/IV/2022	440/894/35.07.103.135.2022
102	KLINIK IDAMAMUK	INSTANSI KESEHATAN	16 Juni 2021	PERPANJANG OTOMATIS	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PEMERIKSAAN PENUNJANG	347/DPM/I- PKS/DIR/VII/2021	/005/VI/2021
103	KLINIK RAWAT INAP MUSLIMAT SINGOSARI	INSTANSI KESEHATAN	15 April 2023	15 April 2026	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PEMERIKSAAN PENUNJANG	107.1/DPM/E- PKS/DIR/IV/2023	031.A/A.1/M/RSMS/02/IV/2023
104	KLINIK TIRTO HUSADA	INSTANSI KESEHATAN	18 September 2023	18 September 2026	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PELAYANAN PENUNJANG	176.3/DPM/E- PKS/DIR/IX/2023	015.004/KTH/IX/2023
105	KLINIK UTAMA JANTUNG HUSNA MEDIKA MALANG	INSTANSI KESEHATAN	01 Desember 2023	32/11/26	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PELAYANAN PENUNJANG	241.2/DPM/E- PKS/DIR/XII/2023	023/PKS/DIR-HMMMALANG/XII/2023
106	DOKTER PRAKTEK MANDIRI DR NIA ANITA	INSTANSI KESEHATAN	02 Desember 2024	02 Desember 2029	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	347/DPM/E- PKS/DIR/2024	
107	DOKTER PRAKTEK MANDIRI DR INDRAWAN DWANTORO	INSTANSI KESEHATAN	02 Desember 2024	02 Desember 2029	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	348/DPM/E- PKS/DIR/XII/2024	
108	RSJ DR RADJIMAN WEDIODONONGRAT LAWANG	INSTANSI KESEHATAN	30 Oktober 2023	30 Oktober 2026	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	220.1/DPM/E- PKS/DIR/X/2023	HK.03.01/D.XXXVII/12226A/2023
109	RSUD DR SAIFUL ANWAR	INSTANSI KESEHATAN	01 November 2024	01 November 2026	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	234/DPM/E- PKS/VIII/2024	400.14.5/7499.1/102.7/2024
110	KLINIK PRATAMA RAWAT JALAN MAWAR WASKITHA HUSADA	INSTANSI KESEHATAN	23 Januari 2024	22 Januari 2027	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PELAYANAN PENUNJANG	001.34/DPM/E- PKS/DIR/I/2024	
111	PRAKTEK BIDAN MANDIRI RIZA KHUTMI, S.S.T	INSTANSI KESEHATAN	05 Agustus 2024	05 Februari 2027	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PELAYANAN PENUNJANG	221/DPM/E- PKS/DIR/VII/2024	
112	RSU UNIVERSITAS	INSTANSI	05	22 Agustus	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	248/DPM/E-	081/SK_PKS/RSU-UMM/VIII/2024

	MUHAMMADIYAH MALANG	KESEHATAN	Agustus 2024	2027		PKS/DIR/VIII/2024	
113	IBAZZ AESTHETIC MEDICAL CENTER BY DR UMMAH	INSTANSI KESEHATAN	14 Juni 2024	14 Juni 2027	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	180/DPM/E- PKS/DIR/VI/2024	
114	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. MALANG	INSTANSI KESEHATAN	02 Januari 2025	02 Januari 2026	PELAYANAN KELUARGA BERENCANA IUD & IMPLANT	2053/E- PKS/DIR/XII/2024	100-3-7/103/35-07-313/2025